



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROFIL INDIKATOR MUTU
RS. PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

**PROFIL INDIKATOR MUTU
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026**

Profil Indikator mutu sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan program mutu di unit kerja RS Prima Husada Sukorejo

Disetujui,

Oleh

Direktur PT Disa Prima Medika

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

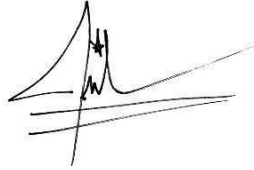
LEMBAR PENGESAHAN

Profil Indikator Mutu RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2026

Profil Indikator mutu sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan program mutu di unit kerja RS Prima Husada Sukorejo

Disusun oleh:

Komite PMKP RS Prima Husada Sukorejo



(Lidia Puspita Kencana, S.K.M.)

Disetujui oleh:

Authorized Person



(Dr.dr. Aslichah M.Kes., AFP)

Disetujui oleh:

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga profil Indikator Mutu RS. Prima Husada Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan profil ini sebagai bagian dari salah satu program kerja Komite PMKP RS Prima Husada Sukorejo dan merupakan kelanjutan dari proses pemilihan dan penentuan mutu Prioritas Rumah Sakit dan Mutu Prioritas Unit tahun 2026 di RS Prima Husada Sukorejo. Selanjutnya, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menyumbangkan ide, pemikiran dan saran sehingga profil indikator mutu ini dapat diselesaikan untuk menjadi gambaran singkat indikator mutu yang berlaku di RS Prima Husada Sukorejo.

Kami menyadari bahwa profil indikator mutu RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026 ini masih kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap dukungan / saran dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan profil indikator mutu RS Prima Husada Sukorejo kedepannya.

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.2.1. Tujuan Umum	1
1.2.2. Tujuan Khusus	1
1.3. Ruang Lingkup	1
1.4. Landasan Hukum	1
BAB II	3
2.1. Dimensi Mutu	3
2.2. Profil Indikator Mutu	4
2.3. Mutu dalam Akreditasi Rumah Sakit	4
BAB III	6
3.1. Judul Indikator Mutu Nasional	6
3.1.1. Profil Indikator Mutu Nasional	7
3.2. Judul Indikator Mutu Prioritas RS	26
2.2.1. Profil Indikator Mutu Prioritas RS	28
3.3. Indikator Mutu Prioritas Unit	43
3.3.1. Instalasi Gawat Darurat	43
3.3.2. Instalasi Rawat Jalan	62
3.3.3. Instalasi Rawat Inap 2A	77
3.3.4. Instalasi Rawat Inap 2B	101
3.3.5. Instalasi Rawat Inap 3A	122
3.3.6. Instalasi Rawat Inap 3B	143
3.3.7. Instalasi Kamar Operasi Bedah	164
3.3.8. Instalasi Kamar Operasi Anestesi	193
3.3.9. Maternitas	204
3.3.10. Ponsek	229
3.3.11. Neonatologi	251
3.3.12. ICU	274
3.3.13. Radiologi	290
3.3.14. Laboratorium	304
3.3.15. Rehab Medis	324
3.3.16. Farmasi	337
3.3.17. Gizi	354
3.3.18. Rekam Medis	369
3.3.19. Limbah K3RS	387
3.3.20. SDM	392

3.3.21. Kesekretariatan	399
3.3.22. Driver	404
3.3.23. Pemulasaraan Jenazah	408
3.3.24. ATEM-IPSRs	415
3.3.25. Laundry	424
3.3.26. CSSD	431
3.3.27. Cleaning Service	444
3.3.28. Keamanan	454
3.3.29. Gudang Umum	462
3.3.30. PPI	466
3.3.31. PKRS	481
3.3.32. Verifikator	489
3.3.33. Humas & Marketing	502
3.3.34. CSO	505
3.3.35. MOD-MPP-PIPP	506
3.3.36. TB di IRJA	512
3.3.37. Tim HIV	515
3.3.38. KB	516
3.3.39. Stunting	521
3.3.40. Geriatri	526
3.3.41. IT	531
3.3.42. Hemodialisa	535
3.3.43. BPJS	552

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengurangi risiko dan menjamin kualitas pelayanan, maka RS Prima Husada Sukorejo merencanakan dan melaksanakan program Mutu dan Keselamatan Pasien. Program ini dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam merencanakan, merancang, mengukur, menganalisis dan meningkatkan proses klinis serta manajerial dalam sebuah kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur.

Mutu merupakan suatu elemen dalam memenuhi harapan dari pelanggan yang selalu berubah / dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Karena itu, mutu harus direncanakan dan dipahami sebelum dilakukan pengelolaan secara sistematis dari mengukur, menilai, dan melakukan perbaikan jika tujuan belum tercapai untuk kemudian dilakukan pengukuran ulang terhadap capaian mutu.

Pengelolaan manajemen mutu secara sistematis memerlukan pedoman dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan pemantauan / pengukuran mutu tersebut, maka diperlukan penyusunan profil indikator dari masing-masing indikator yang kemudian terkumpul menjadi Profil indikator mutu. Profil indikator ini dijadikan sebagai tolak ukur dan arah dalam melaksanakan pemantauan dan pengukuran data. Kemudian data yang sudah dikumpulkan di analisis dan dilakukan validasi bila perlu sebelum data tersebut dituangkan kedalam laporan dan dilaporkan ke Direktur RS Prima Husada Sukorejo.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Untuk memberikan pedoman dalam upaya pengelolaan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Sebagai panduan dalam mengontrol mutu pelayanan
2. Memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam memahami indikator mutu yang dimaksud
3. Menyamakan persepsi yang sama kepada PIC Unit sehingga menghasilkan data yang akurat

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup profil indikator peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini meliputi jenis dan macam indikator yang tertuang dalam program PMKP Tahun 2026, antara lain:

1. Indikator Mutu Nasional (IMN)
2. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)
3. Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit)

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Profil indikator mutu ini didasarkan pada berbagai regulasi sebagai berikut:

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit

-
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

2.1. Dimensi Mutu

Mutu merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen baik internal maupun eksternal. Mutu juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang bertahap dan terus menerus (Al- Assaf dalam Imam, 2017). Hal ini berarti bahwa mutu akan tergantung dari sudut pandang pengguna atau pelakunya. Mutu dapat di ilustrasikan sebagai berikut (Elizabeth dalam Imam 2017) :

1. Menurut pasien atau masyarakat mutu adalah empati, menghargai, keramahan petugas, dan sesuai dengan kebutuhannya
2. Menurut petugas kesehatan mutu adalah bebas melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan peralatan yang memenuhi standar
3. Menurut manajer / administrator mutu adalah mendorong manajer untuk mengatur staf dan pasien dengan baik
4. Menurut pemilik mutu adalah menuntut pemilik agar memiliki tenaga profesional yang bermutu dan cukup

Berbicara mengenai mutu, terdapat beberapa pendapat ahli dan pakar membagi dimensi mutu menjadi 6 kelompok yaitu :

1. **Aksessibilitas**
Artinya layanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi dan bahasa. Akses geografis diukur dengan jarak, lamanya perjalanan, biaya perjalanan, jenis transportasi, dan/atau hambatan fisik lain yang dapat menghalangi seseorang memperoleh layanan kesehatan
2. **Efektivitas**
Layanan kesehatan harus efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit dan berkembang/meluasnya penyakit yang ada. Efektivitas layanan kesehatan ini bergantung pada bagaimana standar layanan kesehatan itu digunakan dengan tepat, konsisten dan sesuai dengan situasi setempat
3. **Efisiensi**
Sumber daya kesehatan sangat terbatas. Oleh karena itu dimensi efisiensi kesehatan sangat penting dalam layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan masyarakat. Layanan kesehatan yang tidak efisien umumnya berbiaya mahal, kurang nyaman bagi pasien, memerlukan waktu lama, dan menimbulkan resiko yang lebih besar pada pasien
4. **Keselamatan dan keamanan**
Perawatan bertujuan untuk membantu pasien bukan menyakiti mereka. Pasien tidak boleh dilukai oleh perawatan yang dimaksudkan untuk membantu mereka, juga sebaiknya tidak merugikan orang yang bekerja melayani kesehatan (kedua pihak harus merasa aman)
5. **Kesinambungan pelayanan**
Dimensi kesinambungan layanan kesehatan artinya pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak perlu. Karena riwayat penyakit pasien terdokumentasi dengan lengkap, akurat dan terkini, layanan kesehatan rujukan yang diperlukan pasien dapat terlaksana dengan tepat, waktu dan tempatnya
6. **Berorientasi pada pasien**
Pemberi pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pilihan setiap individu. Dalam hal ini *provider* harus melibatkan pasien dan keluarga dalam menentukan dan memutuskan pelayanan yang akan diberikan.

2.2. Profil Indikator Mutu

Profil indikator mutu merupakan buku acuan yang memuat kumpulan berbagai indikator yang telah ditetapkan beserta profil indikator dari masing-masing indikator terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Berikut merupakan deskripsi mengenai profil indikator yang berlaku untuk setiap indikator :

Judul indikator	Nama indikator
Dasar pemikiran	Alasan pemilihan indikator mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Dimensi mutu	6 Dimensi mutu WHO (aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kesinambungan pelayanan, berorientasi pada pasien)
Tujuan	Sesuatu hasil yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran terhadap indikator
Definisi operasional	Batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan pengukuran indikator untuk menghindari kerancuan
Jenis indikator	Sesuai dengan judul indikator yang dinyatakan dalam pengukuran <i>input, proses, outcome</i> dan <i>proses & outcome</i> . <i>Input</i> : pengukuran sumber daya yang digunakan untuk aktifitas <i>Proses</i> : menggambarkan komponen kegiatan <i>Outcome</i> : mengukur hasil yang tercapai dari layanan atau aktivitas yang dilakukan. <i>Proses & outcome</i> : mengukur produk yang dihasilkan untuk menunjang hasil layanan.
Satuan Pengukuran	sesuatu yang digunakan untuk mengukur atau menyatakan besaran suatu objek, fenomena, atau aktivitas
Numerator	Besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator
Denominator	Besaran sebagai nilai penyebut dalam rumus indikator
Target capaian	Capaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan / SPM atau hasil diskusi kepala ruang / kepala bidang
Kriteria - Inklusi	Batasan yang termasuk dalam cakupan pengukuran indikator
- Eksklusi	Batasan yang tidak termasuk dalam cakupan pengukuran indikator
Formula	Rumus yang menghasilkan indikator $N/D \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu <i>Concurrent</i> : pengumpulan data yang diambil secara langsung
Sumber data	Sumber atau tempat dimana keseluruhan data akan digunakan untuk mengambil data
Instrumen pengambilan data	Nama formulir pengambilan data
Sampel	Jabaran metode sampling dan besar sampel sesuai kaidah statistik
Periode pengumpulan data	Merujuk pada rentang waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian, evaluasi, atau kegiatan analisis lainnya.
Periode analisis dan pelaporan data	Rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan
Penyajian data	Diagram garis untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung jawab	Pejabat yang bertanggungjawab terhadap capaian indikator mutu

2.3. Mutu dalam Akreditasi Rumah Sakit

1. Indikator Mutu Nasional (IMN)

Indikator nasional mutu (INM) yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional

2. Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)

Indikator mutu prioritas rumah sakit yaitu indikator yang dipilih untuk pengukuran yang berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit mencakup:

- a. Indikator sasaran keselamatan pasien
- b. Indikator pelayanan klinis prioritas
- c. Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit
- d. Indikator terkait perbaikan sistem
- e. Indikator terkait manajemen risiko

3. Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit)

Indikator mutu prioritas unit adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit.

BAB III
PROFIL INDIKATOR MUTU

3.1. Judul Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator	Standar	Unit
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Laboratorium 3. Radiologi 4. Maternitas 5. Instalasi Care Unit 6. Instalasi Rawat Inap 2A 7. Instalasi Rawat Inap 2B 8. Instalasi Rawat Inap 2D 9. Instalasi Rawat Inap 3A 10. Instalasi Rawat Inap 3B 11. Instalasi Kamar Operasi 12. Instalasi Rawat Jalan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Laboratorium 3. Radiologi 4. Maternitas 5. Instalasi Care Unit 6. Instalasi Rawat Inap 2A 7. Instalasi Rawat Inap 2B 8. Instalasi Rawat Inap 2D 9. Instalasi Rawat Inap 3A 10. Instalasi Rawat Inap 3B 11. Instalasi Kamar Operasi 12. Instalasi Rawat Jalan 13. Farmasi 14. Gizi & Dapur 15. Laundry 16. B3 17. CS
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 2A 4. Instalasi Rawat Inap 2B 5. Instalasi Rawat Inap 2D 6. Instalasi Rawat Inap 3A 7. Instalasi Rawat Inap 3B 8. Instalasi Kamar Operasi 9. Instalasi Care Unit 10. Ponsek 11. Maternitas 12. Neonatologi 13. Laboratorium 14. Radiologi 15. Rehab Medis 16. Farmasi 17. Hemodialisa
4.	Waktu tanggap operasi Sesarea emergency ≤ 30 menit	≥80%	1. Maternitas 2. Ponsek
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit	≥80%	1. Instalasi Rawat Jalan

No	Judul Indikator	Standar	Unit
6.	Penundaan Operasi Elektif $\geq$ 60 menit	$\leq 5\%$	1. Instalasi Kamar Operasi
7.	Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB)	$\geq 80\%$	1. Maternitas 2. Instalasi Care Unit 3. Instalasi Rawat Inap 2A 4. Instalasi Rawat Inap 2B 5. Instalasi Rawat Inap 2D 6. Instalasi Rawat Inap 3A 7. Instalasi Rawat Inap 3B 8. Neonatologi
8.	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium $\leq$ 30 menit	100%	1. Laboratorium
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	$\geq 80\%$	1. Farmasi
10.	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	$\geq 80\%$	1. Instalasi Rawat Inap 2A 2. Instalasi Rawat Inap 2B 3. Instalasi Rawat Inap 2D 4. Instalasi Rawat Inap 3A 5. Instalasi Rawat Inap 3B 6. Maternitas 7. Neonatologi Instalasi Care Unit
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh Pada Pasien Rawat Inap	100%	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Maternitas 4. Instalasi Care Unit 5. Instalasi Rawat Inap 2A 6. Instalasi Rawat Inap 2B 7. Instalasi Rawat Inap 2D 8. Instalasi Rawat Inap 3A 9. Instalasi Rawat Inap 3B 10. Instalasi Kamar Operasi 11. Rehab Medis
12	Kecepatan Respon Terhadap Komplain	$\geq 80\%$	MOD-MPP-PIPP
13	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	$\geq 76.61\%$	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 2A 4. Instalasi Rawat Inap 2B 5. Instalasi Rawat Inap 2D 6. Instalasi Rawat Inap 3A 7. Instalasi Rawat Inap 3B 8. Maternitas 9. Humas Dan Marketing

3.1.1. Profil Indikator Mutu Nasional

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah

	ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti :

	• Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

4. Kepatuhan Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

Judul Indikator	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, mengamanatkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Menekankan pentingnya respon cepat dalam penanganan kondisi kritis untuk mencegah Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) - Bab PONEK: Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 jam wajib memiliki standar waktu tanggap untuk operasi cito guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya pelayanan kegawatdaruratan operasi seksio sesarea yang cepat dan tepat sehingga mampu mengoptimalkan upaya menyelamatkan ibu dan bayi.
Definisi Operasional	1. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi adalah waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi sejak diputuskan operasi sampai dimulainya insisi operasi di kamar operasi yaitu ≤ 30 menit. 2. Seksio sesarea emergensi adalah tindakan seksio sesarea yang bertujuan untuk menyelamatkan ibu dan/atau bayi dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. 3. Seksio sesarea emergensi kategori I adalah tindakan seksio sesarea pada keadaan di mana terdapat ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu atau janin. 4. Pengukuran indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi dilakukan oleh rumah sakit yang memberikan pelayanan seksio sesaria.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit (Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan medis setelah keputusan dibuat)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I (satu) yang mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi ≤ 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seksio sesarea emergensi kategori I Misalnya: fetal distress menetap, prolaps tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal vakum/forsep, ruptur uteri imminent, ruptur uteri, perdarahan ante partum dengan perdarahan aktif. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I (satu) yang mendapatkan tindakan seksio sesarea emergensi } \leq 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah pasien yang diputuskan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I}} \times 100\%$

Metode pengumpulan data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data Sekunder dari rekam medik, Laporan operasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Waktu Tanggap Seksio Sesarea Emergensi
Sampel	Total Sampling
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

5. Kepatuhan Waktu Tunggu Rawat Jalan

Judul Indikator	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan pada aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. 2. Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 (SPM Rumah Sakit): Menetapkan standar waktu tunggu di rawat jalan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan termasuk di unit rawat jalan. Walaupun tidak dalam kondisi gawat maupun darurat namun tetap harus dilayani dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien akan rencana diagnosis dan pengobatan. Waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dan keterlambatan diagnosis maupun pengobatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya waktu pasien menunggu di pelayanan sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat waktu dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu rawat jalan adalah waktu yang dibutuhkan mulai saat pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/dokter spesialis. 2. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan dan mencatat/menginput data sebagai pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftaran online. a. Pasien datang langsung, maka dihitung sejak pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. b. pasien mendaftar online, maka dihitung sejak pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran sesuai jam pelayanan pada pendaftaran online sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. c. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak bukti pendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai

	mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit (Waktu tunggu mulai dari kedatangan pasien di fasilitas rawat jalan hingga dimulainya pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang berobat di rawat jalan
• Eksklusi	1. Pasien medical check up 2. Pasien yang mendaftar online atau anjungan mandiri datang lebih dari 60 menit dari waktu yang sudah ditentukan 3. Pasien yang ada tindakan pasien sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu} \leq 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Sumber data sekunder antara lain dari: 1. Catatan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Rekam Medik Pasien Rawat Jalan 3. Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan

6. Penundaan Operasi Elektif

Judul Indikator	Penundaan Operasi Elektif
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang efisien dan bermutu. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Penundaan operasi dapat menyebabkan kecemasan pasien, peningkatan biaya perawatan (LOS), dan risiko medis jika kondisi pasien memburuk selama masa tunggu.

	3. Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAB (Pelayanan Anestesi dan Bedah): Rumah sakit harus memastikan jadwal operasi terkelola dengan baik untuk mengoptimalkan utilisasi kamar operasi. 4. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Menilai jumlah dan penyebab penundaan operasi elektif, serta meningkatkan manajemen waktu dan pengorganisasian jadwal operasi untuk meminimalkan penundaan yang tidak perlu, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan medis dan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari operasi elektif yang ditunda lebih dari 24 jam dari jadwal yang telah ditentukan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda ≥ 1 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien operasi elektif
Target Pencapaian	$\leq 5\%$
Kriteria:	
• Inklusi	Semua operasi elektif yang dijadwalkan, baik yang bersifat minor maupun mayor.
• Eksklusi	Penundaan operasi atas indikasi medis
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda } \geq 1 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien operasi elektif}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien yang dijadwalkan operasi dan data pelaksanaan operasi.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir penundaan operasi elektif
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah

7. Kepatuhan Waktu Visit Dokter (06.00 - 14.00 WIB)

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). 3. Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. 4. Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. 2. Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. 1. Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). 2. Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan	Formulir pencatatan waktu visite dokter

Data	
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Judul Indikator	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis laboratorium
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil laboratorium kritis sangat penting dalam kelanjutan tata laksana pasien. Hasil kritis menunjukkan kondisi pasien yang membutuhkan keputusan klinis yang segera untuk upaya pertolongan pasien dan mencegah komplikasi akibat keterlambatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium 2. Tergambarnya sistem yang menunjukkan bagaimana nilai kritis dilaporkan dan didokumentasikan untuk menurunkan risiko keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan segera. 2. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu yang dibutuhkan sejak hasil pemeriksaan keluar dan telah dibaca oleh dokter/analis yang diberi kewenangan hingga dilaporkan hasilnya kepada dokter yang meminta pemeriksaan. 3. Standar waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu pelaporan ≤ 30 menit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit atau Jam: Mengukur waktu dari saat tes laboratorium dilakukan hingga hasilnya dilaporkan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan < 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kritis
Target Pencapaian	100 %
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemeriksaan laboratorium yang memenuhi target hasil kritis
• Eksklusi	Semua pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium yang bukan Kritis dan tidak termasuk <i>RED Category Condition</i> ; hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik kritis yang sudah dapat dilihat oleh DPJP/perujuk melalui sistem informasi dan sudah ditindaklanjuti.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan} < 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kritis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i>
Sumber data	Catatan data Instalasi Laboratorium , Rekam Medik
Instrumen Pengambilan Data	Formulir sensus harian
Sampel	Total populasi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Formularium Nasional. 3. Kepatuhan terhadap formularium dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan obat-obatan. 4. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan masukan-masukan pemberi layanan, dan pemilihannya berdasarkan kepada mutu obat, rasio risiko dan manfaat, berbasis bukti, efektivitas dan efisiensi. Pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada formularium rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium nasional
Definisi Operasional	1. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) penggunaan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional terhadap total obat yang digunakan

Numerator (pembilang)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional
Denominator (penyebut)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Resep yang dilayani di RS 1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi dibutuhkan pasien dan telah mendapatkan persetujuan komite medik dan direktur. 2. Bila dalam resep terdapat obat di luar FORNAS karena stok obat nasional berdasarkan e-katalog habis/kosong.
Formula	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh

Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). - Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. - Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. - Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. - Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. - Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Judul Indikator	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang informatif dan jujur serta hak untuk mengadu. - PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Apabila selama perawatan pasien merasa bahwa rumah sakit belum menunaikan kewajiban tersebut maka pasien memiliki hak untuk mengajukan komplain. - Untuk itu rumah sakit perlu memiliki unit yang merespon dan menindaklanjuti keluhan tersebut dalam waktu yang telah ditetapkan agar keluhan pasien dapat segera teratasi.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan rumah sakit dalam merespon keluhan pasien agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk sebagai bentuk pemenuhan hak pasien.
Definisi Operasional	1. Kecepatan waktu tanggap komplain adalah rentang waktu Rumah sakit dalam menanggapi keluhan tertulis, lisan atau melalui media massa melalui tahapan identifikasi, penetapan grading risiko, analisis hingga tindak lanjutnya. 2. Grading risiko dan standar waktu tanggap komplain: - Grading Merah (ekstrim) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 1 x 24 jam sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan polisi, pengadilan, kematian, mengancam sistem/ kelangsungan organisasi, potensi kerugian material, dan lain-lain. - Grading Kuning (tinggi) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 3 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: cenderung berhubungan dengan pemberitaan media, potensi kerugian immaterial, dan lain-lain. - Grading Hijau (rendah) ditanggapi dan ditindaklanjuti maksimal 7 hari sejak keluhan disampaikan oleh pasien/ keluarga/pengunjung. Kriteria: tidak menimbulkan kerugian berarti baik material maupun immaterial.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Waktu (dalam jam atau hari) yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menyelesaikan komplain
Numerator (pembilang)	Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan grading
Denominator (penyebut)	Jumlah komplain yang disurvei
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua komplain yang diterima oleh rumah sakit dari pasien atau pengunjung yang memiliki keluhan terkait pelayanan atau fasilitas rumah sakit. (lisan, tertulis, dan media massa) - Komplain yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit (misalnya, komplain yang berkaitan dengan masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan oleh rumah sakit). - Komplain yang tidak lengkap atau tidak dapat diproses karena alasan administratif (misalnya, tidak ada informasi kontak atau data yang jelas).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komplain yang ditanggapi dan ditindaklanjuti sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan grading}}{\text{Jumlah komplain yang disurvei}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan Komplain
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir Komplain 2. Laporan Tindak Lanjut Komplain
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling

	yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas / unit prngaduan / bagian yang menangani complain

13. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

3.2. Judul Indikator Mutu Prioritas RS

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Standar	Unit
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	- Mengidentifikasi pasien dengan benar: - Kepatuhan Identifikasi pasien	100%	- IGD - IRJA - IRNA 2A - IRNA 2B - IRNA 3A - IRNA 3B - IKO - Maternitas - Neonatologi - Ponek - ICU - Laboratorium - Radiologi - Gizi

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Standar	Unit
				15. Farmasi
		2. Meningkatkan komunikasi yang efektif: a. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	1. IGD 2. IRNA 2A 3. IRNA 2B 4. IRNA 3A 5. IRNA 3B 6. Maternitas 7. Neonatologi 8. ICU
		3. Meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diwaspadai (<i>High Alert Medications</i>): a. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert	100%	1. Farmasi 2. IGD 3. IRNA 2A 4. IRNA 2B 5. IRNA 3A 6. IRNA 3B 7. Maternitas 8. Neonatologi 9. IKO 10. ICU
		4. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar: a. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	1. IGD 2. IRJA 3. ICU 4. IKO 5. IRNA 2A 6. IRNA 2B 7. IRNA 3A 8. IRNA 3B 9. Maternitas 10. Neonatologi
		5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan: a. Kepatuhan Kebersihan Tangan	100%	1. IGD 2. IRJA 3. IRNA 2A 4. IRNA 2B 5. IRNA 3A 6. IRNA 3B 7. ICU 8. Maternitas 9. Neonatologi 10. IKO
		6. Mengurangi risiko cedera akibat pasien jatuh: a. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	All Unit Pelayanan
2	Pelayanan Klinis	1. Kepatuhan	80%	1. All IRNA

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Standar	Unit
	Prioritas	PPK/CP DM Gangren/Ulcus dengan Tindakan Debridement		
3	Renstra RS	1. Prosentase Pasien Komplain	0%	All Unit
		2. Waktu Tunggu IGD ke Rawat Inap yakni ≤ 6 jam	80%	IGD
4	Perbaikan Sistem	1. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat jadi < 30 menit	80%	Farmasi
		2. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat racikan < 60 menit	80%	Farmasi
5	Manajemen Risiko	1. Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan Staf menjalankan SPO	0%	Radiologi

2.2.1. Profil Indikator Mutu Prioritas RS

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. - Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	- Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. - Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. - Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan).

	4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

b. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	• Inklusi 1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. • Eksklusi 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah

	komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

c. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert

Judul Indikator	Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat (<i>medication error</i>) merupakan ancaman serius bagi keselamatan pasien. Obat kategori LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) dan <i>High Alert</i> memiliki risiko tinggi menyebabkan <i>harm</i> jika terjadi kesalahan, sehingga identifikasi visual melalui stiker sangat krusial.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian staf farmasi dalam memberikan penandaan obat untuk mencegah kesalahan pengambilan dan pemberian obat kepada pasien.
Definisi Operasional	1. Kepatuhan: Tindakan staf menempelkan stiker sesuai standar. 2. Stiker LASA: Penanda untuk obat dengan nama, ucapan, atau rupa mirip. 3. Stiker High Alert: Penanda untuk obat dengan risiko tinggi (misal: elektrolit pekat, insulin). 4. Penempelan: Stiker terpasang pada kemasan obat tanpa menutupi informasi penting (ED>Nama Obat).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah obat LASA dan High Alert yang ditemukan terpasang stiker dengan benar sesuai standar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh obat LASA dan High Alert yang diobservasi / disampling dalam satu bulan.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Seluruh sediaan obat yang masuk dalam daftar LASA dan High Alert di depo/instalasi farmasi.
• Eksklusi	1. Obat-obatan yang stikernya sudah tercetak langsung dari pabrik (pre-labeled).

Formula	$\frac{\text{Jumlah obat LASA dan High Alert yang ditemukan terpasang stiker dengan benar sesuai standar dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh obat LASA dan High Alert yang diobservasi / disampling dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Sumber data	1. Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir Checklist kepatuhan labeling obat
Sampel	Total sampling atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi Kepala Ruang Anestesi dan Tim Anestesi
Referensi	1. PMK No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS. 2. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) - Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 3).

d. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	Kesalahan lokasi operasi (<i>wrong-site surgery</i>) adalah kejadian yang tidak seharusnya terjadi (<i>never event</i>). Penandaan lokasi yang dilakukan oleh operator sangat penting untuk memastikan prosedur dilakukan pada sisi dan bagian tubuh yang benar sesuai rencana tindakan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan lokasi operasi dan memastikan prosedur dilakukan pada pasien, lokasi, dan sisi tubuh yang benar.
Definisi Operasional	Penandaan Lokasi Operasi (Surgical Site Marking) adalah pemberian tanda menggunakan simbol/tanda yang seragam dan permanen (tidak luntur saat dicuci dengan antiseptik) pada sisi tubuh pasien yang akan dioperasi. Tanda harus dibuat oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan saat pasien masih dalam keadaan sadar (jika memungkinkan) sebelum di pindah ke kamar operasi.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang telah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar oleh dokter operator sebelum tindakan dimulai dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang direncanakan menjalani prosedur operasi yang memerlukan penandaan lokasi dalam satu bulan yang sama.

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien yang akan menjalani operasi yang melibatkan: 1. Perbedaan sisi (lateralitas: kanan/kiri). 2. Struktur multipel (jari tangan, jari kaki, lesi). 3. Tingkatan level (tulang belakang/vertebra). 1. Operasi pada organ tunggal (misal: Caesar, Jantung, Apendektomi). 2. Prosedur endoskopi/intervensi radiologi. 3. Kasus gawat darurat yang mengancam nyawa. 4. Prosedur pada luka terbuka atau fraktur terbuka yang lokasinya sudah jelas.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang ditandai secara benar}}{\text{Jumlah total pasien yang wajib ditandai}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) dan Audit Rekam Medis.
Sumber data	1. Asesmen pra bedah 2. Surgical Safety Checklist 3. Laporan Operasi
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir <i>Checklist</i> Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi.
Sampel	Total Sampling (Jika jumlah operasi < 30 per bulan) atau Sampling representatif sesuai rumus Slovin.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Rumah Sakit.

e. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu
----------------------	--

	observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

f. Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas

a. Kepatuhan PPK/CP DM Gangren/Ulcus dengan Tindakan Debridement

Judul Indikator	Kepatuhan PPK/Clinical Pathway DM Gangren/Ulcus dengan Tindakan Debridement
Dasar pemikiran	Penanganan DM Gangren memerlukan pendekatan multidisiplin yang terstandar. Kepatuhan terhadap <i>Clinical Pathway</i> memastikan pasien mendapatkan terapi yang tepat (antibiotik, kontrol gula darah, dan debridement tepat waktu) untuk mencegah amputasi lebih lanjut dan mempercepat penyembuhan luka.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan klinis yang standar, efektif, dan efisien di rumah sakit guna memberikan hasil klinis yang optimal bagi pasien DM Gangren.
Definisi Operasional	Kepatuhan PPK/CP adalah kesesuaian seluruh tahapan pelayanan yang diberikan kepada pasien (mulai dari asesmen, pemeriksaan penunjang, terapi obat, tindakan debridement, hingga rencana pemulangan) dengan dokumen <i>Clinical Pathway</i> yang telah ditetapkan RS untuk diagnosa DM Gangren/Ulcus.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien DM Gangren/Ulcus dengan tindakan debridement yang pelayanannya patuh/sesuai dengan <i>Clinical Pathway</i> dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien DM Gangren/Ulcus dengan tindakan debridement yang masuk dalam alur <i>Clinical Pathway</i> dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien rawat inap dengan diagnosa utama DM Gangren/Ulcus yang menjalani tindakan debridement di kamar operasi. 1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri sebelum prosedur selesai. 2. Pasien dengan komplikasi berat yang memerlukan alur pelayanan di luar CP (misal: syok septik berat). 3. Pasien rujukan balik yang hanya menjalani perawatan luka tanpa debridement.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien DM Gangren yang patuh terhadap CP}}{\text{Jumlah total pasien DM Gangren/ Ulcus yang masuk terhadap CP}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	<i>Retrospektif</i>

Data	
Sumber data	Rekam Medis (Lembar <i>Clinical Pathway</i> , Laporan Operasi, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi/CPPT).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit <i>Clinical Pathway</i> .
Sampel	Total sampling (jika populasi sedikit) atau menggunakan sampel minimal sesuai kaidah statistik (misal: 30-50 sampel per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite Medik / Ketua Kelompok Staf Medis (KSM) Bedah atau Penyakit Dalam.

3. Indikator Berdasarkan Rencana Strategis Rumah Sakit

a. Prosentase Pasien Komplain

Judul Indikator	Prosentase Pasien Komplain
Dasar pemikiran	Komplain merupakan indikator adanya kesenjangan (<i>gap</i>) antara harapan pasien dengan realita pelayanan yang diterima. Pemantauan jumlah komplain membantu rumah sakit mengidentifikasi titik lemah layanan dan mencegah terjadinya sengketa medik atau penurunan citra RS.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya tingkat ketidakpuasan pelanggan terhadap mutu pelayanan dan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
Definisi Operasional	Komplain adalah ungkapan ketidakpuasan yang disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien secara lisan maupun tertulis (melalui unit pengaduan, kotak saran, media sosial resmi, atau aplikasi) terkait pelayanan medis, keperawatan, administrasi, maupun sarana prasarana rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah seluruh komplain pasien/keluarga yang masuk dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah total kunjungan pasien (Rawat Jalan + Rawat Inap + IGD) pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	0%
Kriteria: Inklusi	Semua keluhan/komplain resmi yang disampaikan melalui saluran pengaduan rumah sakit terkait proses pelayanan.

Eksklusi	1. Saran atau masukan yang bersifat apresiasi/pujian. 2. Komplain dari pihak eksternal non-pasien (misal: vendor atau instansi lain).
Formula	$\frac{\text{Jumlah total komplain masuk}}{\text{Total kunjungan pasien pada periode tersebut}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Pencatatan harian melalui Unit Pengaduan / Humas).
Sumber data	Logbook Pengaduan Pasien, Formulir Komplain, Aplikasi Pengaduan RS.
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Rekapitulasi Komplain Pasien
Sampel	Total Sampling (Seluruh komplain yang masuk dihitung).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan & Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala MOD-MPP-PIPP

4. Indikator Perbaikan Sistem

a. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat jadi < 30 menit

Judul Indikator	Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat jadi < 30 menit
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Kecepatan pelayanan farmasi merupakan indikator kepuasan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit 3. Mengurangi penumpukan pasien di area tunggu farmasi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan efisiensi pelayanan farmasi dalam menyiapkan obat jadi untuk pasien.
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep di loket penerimaan sampai dengan pasien menerima obat jadi yang sudah siap diserahkan oleh petugas farmasi.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah resep obat jadi yang diselesaikan dalam waktu < 30 menit pada periode tersebut
Denominator	Total jumlah resep obat jadi yang masuk dan dilayani pada periode yang sama.
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria :	
Inklusi	1. Semua resep obat jadi (obat yang tersedia dalam bentuk siap pakai, tanpa memerlukan proses peracikan).
Eksklusi	1. Resep obat racikan. 2. Resep yang memerlukan konfirmasi ulang kepada dokter

	karena ketidakjelasan penulisan atau ketersediaan stok.
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat jadi yang dilayani} < 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh resep obat jadi yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif atau <i>Concurrent</i> (Real-time).
Sumber data	logbook farmasi dan Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Sampel	<i>Probability Sampling</i> (Minimal 30-50 sampel resep per bulan) atau Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi / Koordinator Farmasi Rawat Jalan

b. Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat racikan < 60 menit

Judul Indikator	Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat racikan < 60 menit			
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 2. Proses peracikan memerlukan ketelitian ekstra namun tetap harus memperhatikan efisiensi waktu agar pasien segera mendapatkan terapi. 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan			
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan efisiensi petugas farmasi dalam proses peracikan obat hingga siap diserahkan kepada pasien secara tepat waktu.			
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep di loket penerimaan sampai dengan pasien menerima obat racikan (pulveres, kapsul, salep racikan, dll) yang sudah siap diserahkan.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat racikan yang diselesaikan dalam waktu < 60 menit pada bulan tersebut.			
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh resep obat racikan yang dilayani pada bulan yang sama.			
Target Pencapaian	≥80%			
Kriteria:				
• Inklusi	1. Semua resep yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut (seperti penggerusan tablet menjadi puyer, pengisian kapsul, atau pencampuran sediaan topikal).			
• Eksklusi	1. Resep obat jadi. 2. Resep yang tertunda karena masalah administrasi/keuangan pasien 3. Resep yang stok obatnya sedang kosong dan harus			

	dipesan terlebih dahulu.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Resep Racikan yang Dilayani} < 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah Total Seluruh Resep Racikan Masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif atau <i>Concurrent</i> (Real-time).
Sumber data	logbook farmasi dan Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Sampel	<i>Probability Sampling</i> (Minimal 30-50 sampel resep per bulan) atau Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi / Koordinator Farmasi Rawat Jalan

5. Indikator Manajemen Resiko

a. Prosentase Berkas Pending Klaim

Judul Indikator	Prosentase Berkas Pending Klaim
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan. 2. Menjaga kelancaran arus kas (<i>cash flow</i>) Rumah Sakit. 3. Efisiensi tata kelola administrasi rekam medis dan penagihan biaya pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Meminimalkan jumlah berkas klaim yang dikembalikan oleh pihak penjamin (BPJS/Asuransi). 2. Mengidentifikasi kendala dalam kelengkapan administrasi dan medis secara dini.
Definisi Operasional	Berkas pending klaim adalah berkas tagihan biaya pelayanan pasien yang sudah diajukan ke pihak penjamin namun dikembalikan/ditunda pembayarannya karena ketidaklengkapan administrasi, ketidaksesuaian koding, atau ketiadaan dokumen pendukung medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas klaim yang dinyatakan "Pending" atau dikembalikan oleh pihak penjamin dalam satu periode bulan pengajuan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh jumlah berkas klaim yang diajukan ke pihak penjamin pada periode bulan yang sama.
Target Pencapaian	0 %
Kriteria:	Seluruh berkas klaim pasien rawat inap dan rawat jalan

• Inklusi • Eksklusi	(BPJS, Asuransi Swasta, Kerjasama Perusahaan). Berkas pasien umum (bayar mandiri) yang tidak melalui proses klaim penjamin.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Berkas Pending Klaim}}{\text{Jumlah Total berkas klaim yang diajukan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Retrospektif (Telaah data laporan klaim).
Sumber data	Laporan Verifikasi Klaim (LVK) dari BPJS/Penjamin atau Logbook Bagian Kasir/Casemix.
Instrumen Pengambilan Data	Data rekapitulasi status klaim bulanan.
Sampel	Total Sampling (Seluruh berkas yang diajukan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit Verifikator

b. Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan Staf menjalankan SPO

Judul Indikator	Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan Staf menjalankan SPO
Dasar pemikiran	1. PMK No. 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan 2. Kerusakan alat akibat salah prosedur (<i>human error</i>) meningkatkan biaya perbaikan dan menghambat pelayanan. 3. Standar Akreditasi RS terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Meminimalkan frekuensi kerusakan alat medis yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian. 2. Meningkatkan kedisiplinan staf dalam mengikuti SPO pemakaian dan pemeliharaan alat.
Definisi Operasional	Kerusakan alat akibat ketidakpatuhan staf adalah kondisi di mana alat kesehatan mengalami kegagalan fungsi atau kerusakan fisik yang setelah diinvestigasi oleh teknisi/IPSRs dinyatakan terjadi karena penggunaan yang tidak sesuai SPO (misal: tidak dikalibrasi harian, salah pembersihan, atau <i>overload</i>).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kerusakan alat medis yang dinyatakan rusak karena kesalahan pengoperasian/ketidakpatuhan staf dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total jumlah laporan kerusakan alat medis (baik karena usia alat maupun kesalahan staf) yang masuk dalam bulan yang sama.

Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua alat medis di unit pelayanan (seperti ventilator, bedside monitor, infus pump, alat laboratorium, dll) yang dilaporkan rusak. 1. Kerusakan akibat usia teknis alat (<i>wear and tear</i>) 2. Kerusakan akibat bencana alam atau gangguan listrik gedung (di luar kendali staf).
Formula	$\frac{\text{Jumlah kerusakan alat karena salah prosedur}}{\text{Total seluruh laporan kerusakan alat}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Retrospektif (Telaah laporan kerusakan alat).
Sumber data	Laporan kerusakan alat dari unit ke IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana RS) dan hasil investigasi teknis.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Kerusakan Alat dan Catatan Medik Teknis (CMT).
Sampel	Total Sampling (Seluruh laporan kerusakan alat medis).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala ATEM / Kepala Bidang Umum

3.3. Indikator Mutu Prioritas Unit

3.3.1. Instalasi Gawat Darurat

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Judul Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan Upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Kepatuhan petugas terhadap	100%	Indikator Mutu Prioritas

	komunikasi efektif menggunakan SBAR		Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
7.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas IGD	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
8.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
9.	Waktu Tunggu Transfer Pasien dari IGD ke Rawat Inap ≤ 6 jam	≥ 80 %	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Rencana Strategis Rumah Sakit
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
10.	Waktu Tunggu pasien sebelum masuk triage <5 menit setelah pasien datang	100%	UNIT
11.	Kelengkapan pengisian pengkajian Awal medis E-Rm.	100%	UNIT
12.	Kelengkapan pengisian pengkajian Awal keperawatan E-Rm.	100%	UNIT
13.	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit	100%	UNIT

3.3.1.1 Profil Indikator Mutu Unit Instalasi Gawat Darurat

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara

	benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan

	Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: - Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. - Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. - Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. - Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. - Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan

	8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN)

	yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.

Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. - Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) - Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan

Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

6. Kepatuhan petugas terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien.
• Eksklusi	1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait

	kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi $\frac{\text{Jumlah komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

7. Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas IGD

Judul Indikator	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas IGD
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 282 & 283: Menyebutkan bahwa Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan mengutamakan keselamatan pasien. Kesalahan pemberian obat akibat kelalaian identifikasi merupakan pelanggaran terhadap hak pasien atas keamanan pelayanan 2. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) Ke-3: Meningkatkan keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). 3. PMK No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Menegaskan bahwa sediaan farmasi dengan nama, tampilan, dan ucapan mirip (LASA) tidak boleh diletakkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan (<i>picking error</i>) yang dapat berakibat fatal

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian petugas IGD dalam mengidentifikasi dan menandai obat berisiko tinggi guna mencegah kejadian tidak diharapkan (KTD)
Definisi Operasional	1. <i>Crosscheck</i> Ulang: Proses verifikasi oleh dua orang petugas (atau satu orang dengan pengecekan ganda secara mandiri yang terdokumentasi) terhadap kebenaran obat. 2. Stiker LASA/High Alert: Penandaan khusus sesuai standar RS (Stiker merah untuk <i>High Alert</i> , kuning/biru untuk LASA). 3. Kepatuhan: Tindakan petugas IGD menempelkan stiker dengan tepat pada ampul/vial/blister setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap daftar obat di troli emergensi atau lemari stok obat IGD.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah obat LASA dan <i>High Alert</i> di IGD yang ditemukan terverifikasi dan tertempel stiker sesuai standar dalam periode observasi.
Denominator (penyebut)	Seluruh sampel obat LASA dan <i>High Alert</i> yang diperiksa di ruang IGD pada periode observasi.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua obat yang masuk dalam daftar <i>High Alert</i> (seperti elektrolit pekat, insulin, heparin) dan daftar LASA yang tersedia di IGD
• Eksklusi	Obat-obatan yang sudah berlabel dari farmasi pusat dalam kemasan satuan kecil yang tidak memungkinkan penempelan stiker tambahan (namun tetap wajib diverifikasi).
Formula	$\frac{\text{Jumlah obat LASA dan High Alert di IGD yang ditemukan terpasang stiker dengan benar sesuai standar dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh obat LASA dan High Alert yang diobservasi di Ruang IGD dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Sumber data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Checklist kepatuhan labeling obat
Sampel	Total sampling atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang IGD dan Penanggung Jawab Farmasi IGD.

8. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	Kesalahan lokasi operasi (<i>wrong-site surgery</i>) adalah kejadian yang tidak seharusnya terjadi (<i>never event</i>). Penandaan lokasi yang dilakukan oleh operator sangat penting untuk memastikan prosedur dilakukan pada sisi dan bagian tubuh yang benar sesuai rencana tindakan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan lokasi operasi dan memastikan prosedur dilakukan pada pasien, lokasi, dan sisi tubuh yang benar.
Definisi Operasional	Penandaan Lokasi Operasi (Surgical Site Marking) adalah pemberian tanda menggunakan simbol/tanda yang seragam dan permanen (tidak luntur saat dicuci dengan antiseptik) pada sisi tubuh pasien yang akan dioperasi. Tanda harus dibuat oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan saat pasien masih dalam keadaan sadar (jika memungkinkan) sebelum dipindah ke kamar operasi.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang telah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar oleh dokter operator sebelum tindakan dimulai dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang direncanakan menjalani prosedur operasi yang memerlukan penandaan lokasi dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien yang akan menjalani operasi yang melibatkan: 1. Perbedaan sisi (lateralitas: kanan/kiri). 2. Struktur multipel (jari tangan, jari kaki, lesi). 3. Tingkatan level (tulang belakang/vertebra). 1. Operasi pada organ tunggal (misal: Caesar, Jantung, Apendektomi). 2. Prosedur endoskopi/intervensi radiologi. 3. Kasus gawat darurat yang mengancam nyawa. 4. Prosedur pada luka terbuka atau fraktur terbuka yang lokasinya sudah jelas.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang ditandai secara benar}}{\text{Jumlah total pasien yang wajib ditandai}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) dan Audit Rekam Medis.
Sumber data	1. Asesmen pra bedah 2. Surgical Safety Checklist 3. Laporan Operasi

Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>Checklist</i> Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi.
Sampel	Total Sampling (Jika jumlah operasi < 30 per bulan) atau Sampling representatif sesuai rumus Slovin.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah Rumah Sakit.

9. Waktu Tunggu Transfer Pasien dari IGD ke Rawat Inap ≤ 6 jam

Judul Indikator	Waktu Tunggu Transfer Pasien IGD ke Rawat Inap ≤ 6 jam
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien atas pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu. - PMK No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan: Mengatur alur pelayanan pasien dari IGD untuk menjamin kontinuitas asuhan. - Menghindari penumpukan pasien di IGD (<i>overcrowding</i>) yang berisiko pada keselamatan pasien (<i>patient safety</i>).
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	- Mengurangi penumpukan pasien di IGD yang dapat mengganggu pelayanan kegawatdaruratan. - Memastikan pasien segera mendapatkan perawatan spesifik sesuai diagnosis di ruang rawat inap. - Meningkatkan alur keluar masuk pasien (<i>bed management</i>) yang efektif.
Definisi Operasional	Waktu tunggu transfer pasien adalah rentang waktu sejak Keputusan Rawat Inap ditetapkan oleh dokter (DPJP/Dokter Jaga) sampai pasien masuk dan diterima di ruang rawat inap. - Mulai: Saat dokter menuliskan instruksi rawat inap di rekam medis. - Selesai: Saat pasien serah terima di ruang rawat inap (transfer selesai). - Standar: Harus tercapai dalam waktu ≤ 6 jam.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien IGD yang ditransfer ke Ruang Rawat Inap dengan waktu tunggu ≤ 6 jam sejak keputusan rawat inap ditetapkan.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien IGD yang diputuskan untuk rawat inap pada periode tersebut.
Target Capaian	≥ 80 %
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh pasien IGD (umum, asuransi, JKN) yang mendapatkan instruksi rawat inap.
• Eksklusi	- Pasien yang menolak rawat inap atau memilih pulang atas permintaan sendiri. - Pasien yang masih memerlukan stabilisasi intensif di IGD sebelum dinyatakan layak transfer. - Pasien yang menunggu ketersediaan kelas kamar khusus

	atas permintaan keluarga (naik kelas/permintaan kamar tertentu yang sedang penuh).
Formula	Jumlah pasien IGD yang ditransfer ke Ruang Rawat Inap dengan waktu tunggu ≤ 6 jam sejak keputusan rawat inap ditetapkan. $\frac{\text{Jumlah seluruh pasien pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit.}}{\text{Jumlah seluruh pasien pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Sensus harian
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pengumpulan data <i>emergency response time</i> Formulir Rekapitulasi Bulanan
Sampel	Sampel yang dianalisis adalah semua pasien yang datang ke unit gawat darurat pada periode analisis
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Penanggung Jawab Mutu Unit 2. Kepala Instalasi Gawat Darurat 3. Kepala Bidang Pelayanan
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

10. Waktu Tunggu Pasien Sebelum Masuk Triage < 5 Menit Setelah Pasien Datang

Judul Indikator	Waktu Tunggu Pasien Sebelum Masuk Triage < 5 Menit Setelah Pasien Datang
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kegawatdaruratan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian atau kecatatan 2. PMK No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan: Mengatur standar pelayanan di IGD di mana triage harus dilakukan segera setelah pasien tiba di rumah sakit. 3. Prinsip <i>Patient Safety</i>: Keterlambatan triage berisiko menyebabkan perburukan kondisi pasien yang tidak teridentifikasi (<i>unrecognized clinical deterioration</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan setiap pasien yang datang ke IGD segera mendapatkan penilaian klinis awal (triage). 2. Mencegah terjadinya penumpukan pasien di area <i>drop-off</i> atau ruang tunggu IGD tanpa pengawasan medis. 3. Mempercepat penentuan prioritas penanganan berdasarkan berat ringannya kasus.

Definisi Operasional	Waktu tunggu sebelum triage adalah rentang waktu sejak pasien tiba di pintu masuk IGD (kedatangan) sampai pasien dilakukan prosedur triage oleh petugas kesehatan yang berwenang. 1. Waktu Datang: Saat pasien pertama kali menyentuh area IGD (diantar petugas/mandiri). 2. Waktu Triage: Saat petugas memulai penilaian (anamnesis singkat, cek kesadaran, atau tanda vital awal). 3. Standar: Harus terlaksana dalam waktu < 5 menit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mendapatkan tindakan triage dalam waktu < 5 menit sejak kedatangan.
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada periode tersebut.
Target Capaian	100 %
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh pasien yang datang ke IGD (baik melalui ambulans maupun datang sendiri).
• Eksklusi	Pasien yang dinyatakan sudah meninggal saat tiba di IGD (<i>Death on Arrival</i> - DOA).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang mendapatkan tindakan triage dalam waktu < 5 menit sejak kedatangan}}{\text{Jumlah total seluruh pasien yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada periode tersebut.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Sensus harian
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pengumpulan data <i>emergency response time</i> Formulir Rekapitulasi Bulanan
Sampel	Sampel yang dianalisis adalah semua pasien yang datang ke unit gawat darurat pada periode analisis
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Penanggung Jawab Mutu Unit 2. Kepala Instalasi Gawat Darurat 3. Kepala Bidang Pelayanan

11. Kelengkapan pengisian pengkajian medis ERM

Judul Indikator	Kelengkapan pengisian pengkajian medis ERM
Dasar pemikiran	Kelengkapan pengisian pengkajian medis dalam ERM (Electronic Medical Record) merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pengkajian medis yang lengkap dan tepat dapat mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik, mencegah kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Selain itu, data yang lengkap memungkinkan pemantauan kondisi

	pasien secara lebih akurat, serta memudahkan koordinasi antar tim medis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan ☒
Tujuan	Menilai sejauh mana pengisian pengkajian medis dalam <i>Electronic Medical Record</i> (ERM) telah dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Indikator ini mengukur sejauh mana komponen pengkajian medis dalam ERM terisi dengan lengkap sesuai standar yang berlaku, termasuk data identitas pasien, riwayat medis, pemeriksaan fisik, diagnosis, dan rencana perawatan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien dengan pengkajian medis yang terisi lengkap dalam <i>Electronic Medical Record</i> (ERM), sesuai dengan standar pengisian yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang membutuhkan pengisian pengkajian medis di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM dalam periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang menjalani pemeriksaan medis di fasilitas yang menggunakan ERM. 2. Pasien yang telah menjalani pengkajian medis lengkap, sesuai dengan protokol medis yang berlaku. 1. Pasien yang hanya membutuhkan pelayanan darurat dan tidak memerlukan pengisian pengkajian medis lengkap. 2. Pasien dengan kondisi tertentu yang tidak memerlukan pengisian pengkajian medis (misalnya, pasien dengan prosedur medis terbatas).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien dengan pengkajian medis lengkap}}{\text{Jumlah total pasien yang membutuhkan pengisian pengkajian medis di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM dalam periode pengumpulan data.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit untuk memeriksa kelengkapan pengisian.
Sampel	Pasien yang menjalani pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Menggunakan Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu

Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Rekam Medis 2. Kepala Bidang Penunjang
------------------	--

12. Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan ERM

Judul Indikator	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan ERM
Dasar pemikiran	Kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan pada sistem Electronic Medical Record (ERM) sangat penting untuk mendukung kualitas perawatan pasien yang komprehensif. Pengkajian keperawatan yang lengkap memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi pasien, memastikan tindakan keperawatan yang tepat, serta memungkinkan evaluasi hasil intervensi yang dilakukan. Selain itu, pengisian yang lengkap memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antar anggota tim medis, yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi perawatan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Untuk menilai kelengkapan pengisian pengkajian keperawatan dalam <i>Electronic Medical Record</i> (ERM) dengan tujuan memastikan bahwa seluruh informasi terkait kondisi pasien yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan telah terisi dengan lengkap dan akurat.
Definisi Operasional	Indikator ini mengukur tingkat kelengkapan pengisian data pengkajian keperawatan dalam ERM yang mencakup identitas pasien, riwayat medis, status fisik, masalah keperawatan, rencana keperawatan, intervensi yang diberikan, dan evaluasi hasil. Pengisian dianggap lengkap jika semua komponen yang diperlukan telah diisi sesuai dengan protokol standar keperawatan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang pengkajian keperawatannya terisi lengkap dalam Electronic Medical Record (ERM), sesuai dengan standar pengisian yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang memerlukan pengisian pengkajian keperawatan di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM dalam periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Pasien yang menjalani pemeriksaan medis di fasilitas yang menggunakan ERM. 2. Pasien yang memerlukan pengkajian keperawatan lengkap berdasarkan protokol medis yang ada. 1. Pasien yang hanya menjalani tindakan medis darurat tanpa pengkajian keperawatan lengkap. 2. Pasien yang kondisi klinisnya tidak memerlukan pengisian pengkajian keperawatan (misalnya, pasien dalam prosedur bedah yang sederhana).
Formula	Jumlah pasien dengan pengkajian keperawatan lengkap —————X 100% Jumlah total pasien yang membutuhkan pengisian pengkajian keperawatan di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM dalam periode pengumpulan data.

Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit untuk memeriksa kelengkapan pengisian.
Sampel	Pasien yang menjalani pengkajian keperawatan di fasilitas kesehatan yang menggunakan ERM selama periode pengumpulan data
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Menggunakan Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Rekam Medis 2. Kepala Bidang Keperawatan

13. Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas pasien dari pasien mendaftar sampai terpasang di pasien < 15 menit

Judul Indikator	Waktu Tunggu Pemasangan Gelang Identitas Pasien dari Pasien Mendaftar Sampai Terpasang < 15 Menit
Dasar pemikiran	Pemasangan gelang identitas pasien merupakan langkah penting dalam proses identifikasi yang akurat di fasilitas kesehatan. Gelang identitas membantu dalam memastikan identitas pasien yang tepat, mengurangi risiko kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien. Waktu tunggu yang cepat dalam pemasangan gelang identitas, dalam hal ini kurang dari 15 menit, penting untuk mempercepat proses pendaftaran dan memulai perawatan atau pemeriksaan yang diperlukan dengan efisien. Mempercepat pemasangan gelang identitas akan berkontribusi pada efisiensi operasional rumah sakit dan meningkatkan kepuasan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur seberapa cepat gelang identitas pasien dapat dipasang sejak pasien mendaftar, dengan target waktu tunggu pemasangan < 15 menit, guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan identifikasi.
Definisi Operasional	Indikator ini mengukur waktu yang diperlukan dari saat pasien terdaftar (berhasil masuk dalam sistem) hingga gelang identitas pasien terpasang. Pemasangan gelang identitas harus dilakukan dalam waktu kurang dari 15 menit sejak pasien mendaftar di fasilitas kesehatan. Waktu tunggu dihitung dari proses pendaftaran hingga gelang identitas terpasang di tangan pasien.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang gelang identitasnya dipasang dalam waktu kurang dari 15 menit setelah pendaftaran.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang terdaftar dan memerlukan pemasangan gelang identitas di fasilitas kesehatan selama

	periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang mendaftar di fasilitas kesehatan dan memerlukan pemasangan gelang identitas (rawat inap, rawat jalan, atau pasien darurat) Pasien yang sudah mengenakan gelang identitas sebelumnya (misalnya, pasien yang kembali ke fasilitas setelah keluar rumah sakit).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang gelang identitasnya dipasang dalam waktu kurang dari 15 menit setelah pendaftaran}}{\text{Jumlah total pasien yang terdaftar dan memerlukan pemasangan gelang identitas pada periode yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Checklist atau Formulir Pengumpulan Data yang mencatat waktu pendaftaran dan waktu pemasangan gelang identitas untuk setiap pasien.
Sampel	Pasien yang datang untuk mendaftar dan memerlukan pemasangan gelang identitas pada periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Menggunakan Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung jawab	1. Kepala Instalasi IGD 2. Supervisor IGD

3.3.2. Instalasi Rawat Jalan

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional

INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
7.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
8.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat jalan	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
9.	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
10.	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan yang tidak sesuai dengan jadwal praktik dokter	0%	UNIT

3.3.2.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Rawat Jalan

1. Kepatuhan identifikasi pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit.

	- Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. - Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan kebersihan tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah

	ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.

Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Waktu tunggu rawat jalan

Judul Indikator	Waktu Tunggu Rawat Jalan
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan pada aksesibilitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. - Kepmenkes No. 129 Tahun 2008 (SPM Rumah Sakit): Menetapkan standar waktu tunggu di rawat jalan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. - Rumah sakit harus menjamin ketepatan pelayanan kesehatan termasuk di unit rawat jalan. Walaupun tidak dalam kondisi gawat maupun darurat namun tetap harus dilayani dalam waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pasien akan rencana diagnosis dan pengobatan. Waktu tunggu yang lama dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien dan keterlambatan diagnosis maupun pengobatan pasien.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan

Tujuan	Tergambarnya waktu pasien menunggu di pelayanan sebagai dasar untuk perbaikan proses pelayanan di unit rawat jalan agar lebih tepat waktu dan efisien sehingga meningkatkan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu rawat jalan adalah waktu yang dibutuhkan mulai saat pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/dokter spesialis. 2. Kontak dengan petugas pendaftaran adalah proses saat petugas pendaftaran menanyakan dan mencatat/menginput data sebagai pasien atau pada saat pasien melakukan konfirmasi kehadiran untuk pendaftaran online. d. Pasien datang langsung, maka dihitung sejak pasien kontak dengan petugas pendaftaran sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. e. pasien mendaftar online, maka dihitung sejak pasien melakukan konfirmasi kehadiran kepada petugas pendaftaran sesuai jam pelayanan pada pendaftaran online sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis. f. Pasien anjungan mandiri, maka dihitung sejak bukti pendaftaran tercetak pada anjungan mandiri sampai mendapat pelayanan dokter/ dokter spesialis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit (Waktu tunggu mulai dari kedatangan pasien di fasilitas rawat jalan hingga dimulainya pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Pasien yang berobat di rawat jalan 1. Pasien medical check up 2. Pasien yang mendaftar online atau anjungan mandiri datang lebih dari 60 menit dari waktu yang sudah ditentukan 3. Pasien yang ada tindakan pasien sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat jalan dengan waktu tunggu } \leq 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah pasien rawat jalan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Sumber data sekunder antara lain dari: 1. Catatan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 2. Rekam Medik Pasien Rawat Jalan 3. Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Waktu Tunggu Rawat Jalan
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode Pengumpulan Data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Rawat Jalan
------------------	------------------------------

6. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	a) Efisiensi b) Efektivitas ☒ c) Aksesibilitas d) Keselamatan ☒ e) Fokus kepada pasien f) Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan

	tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

7. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan

	kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
Inklusi	1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien.
Eksklusi	1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. <i>Review</i> rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

8. Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat jalan

Judul Indikator	Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Rawat Jalan
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). - Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat jalan telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. - Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat jalan dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: - Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). - Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. - Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan High Alert sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Jalan. - Pasien yang tidak dapat melakukan pemeriksaan HbA1c (misalnya, pasien dengan gangguan ginjal berat atau yang tidak mengikuti jadwal kontrol). - Obat-obatan umum yang tidak masuk dalam daftar LASA/High Alert.
Formula	Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i>

	$\frac{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}}{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	1. Lembar Checklist Monitoring Farmasi.
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & High Alert.
Sampel	
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Ruang Rawat Jalan

9. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban perlindungan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 (SKP 4): Penandaan lokasi operasi (<i>Site Marking</i>) secara jelas dan konsisten sangat krusial untuk mencegah insiden <i>Wrong Site Surgery</i> (Operasi salah sisi/lokasi). 3. KTD Fatal: Operasi pada lokasi yang salah adalah kejadian <i>sentinel</i> yang tidak boleh terjadi di Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan lokasi pembedahan melalui penandaan yang jelas pada organ tubuh pasien yang akan dioperasi, terutama pada organ yang memiliki sisi (kanan/kiri) atau struktur multipel (jari, tulang belakang).
Definisi Operasional	1. Penandaan Lokasi Operasi: Pemberian tanda menggunakan spidol permanen pada area tubuh yang akan dilakukan tindakan bedah. 2. Petugas: Dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan pembedahan. 3. Kepatuhan: Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dan diverifikasi saat <i>Sign In</i> .
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien operasi yang sudah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar sesuai standar RS sebelum tindakan dimulai.
Denominator (penyebut)	Seluruh pasien yang direncanakan tindakan operasi yang memerlukan penandaan (sisi kanan/kiri, organ ganda, atau tingkat multipel).
Target Pencapaian	100%

Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien operasi yang memiliki lateralitas (kanan/kiri), struktur multipel (jari tangan/kaki), atau tingkat multipel (level tulang belakang).
	1. Operasi organ tunggal (misal: Seksio Sesarea, Apendektomi). 2. Kasus emergensi mengancam nyawa.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien operasi yang sudah dilakukan penandaan operasi secara benar sesuai standar RS}}{\text{Jumlah Seluruh Pasien yang direncanakan tindakan operasi yang wajib ditandai}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien, Formulir Penandaan Lokasi Operasi, Laporan Kamar Operasi.
Instrumen Pengambilan Data	1. Daftar tilik (<i>Checklist</i>) Pemantauan Penandaan Lokasi Operasi.
Sampel	Total Sampling (seluruh pasien operasi dalam periode tersebut).
Periode pengumpulan data	Bulanan.
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan 2. Kepala Ruang Instalasi Kamar Operasi

10. Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan yang tidak sesuai dengan jadwal praktik dokter

Judul Indikator	Angka keterlambatan dokter di poli rawat jalan yang tidak sesuai dengan jadwal praktik dokter
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang tepat waktu. 2. PMK No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS: Menetapkan standar waktu tunggu rawat jalan 3. Efisiensi Pelayanan: Keterlambatan dokter memicu efek domino pada antrean perawat, farmasi, dan kasir, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap RS. 4. Keterlambatan dokter mempengaruhi kualitas pengalaman pasien, meningkatkan waktu tunggu, dan berdampak pada kepuasan pasien. Tepat waktu adalah aspek penting yang menunjukkan kualitas manajemen waktu dan perencanaan jadwal yang efektif.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur seberapa sering keterlambatan terjadi dalam pelayanan dokter rawat jalan. 2. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan untuk perbaikan dalam pengelolaan jadwal dan alur pelayanan. 3. Meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pasien dalam rawat jalan.

Definisi Operasional	Keterlambatan dokter rawat jalan adalah kondisi di mana dokter spesialis mulai memberikan pelayanan kepada pasien pertama di poliklinik melewati jam jadwal praktik yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Dokter dinyatakan terlambat apabila pelayanan dimulai pada menit ke-1 (satu) setelah jadwal resmi (misal: jadwal pukul 08.00, maka mulai pelayanan pukul 08.01 sudah terhitung sebagai keterlambatan), kecuali terdapat bukti verifikasi adanya tindakan medis darurat (<i>cito</i>) atau operasi yang tidak terjadwal sebelumnya.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas dokter yang terlambat pada periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan dokter yang dinas pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Seluruh dokter spesialis yang memiliki jadwal praktik tetap di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur tentang Jadwal Praktik Dokter. - Seluruh pelayanan poliklinik spesialis (Pagi, Sore, maupun Eksekutif) yang beroperasi pada hari kerja maupun hari libur sesuai jadwal yang ditentukan. - Pelayanan konsultasi pasien pertama pada setiap sesi praktik dokter. - Dokter spesialis yang sedang melakukan tindakan medis darurat (<i>Cito</i>) di Kamar Operasi atau Ruang Bersalin yang terverifikasi oleh laporan tindakan. - Dokter spesialis yang sedang melakukan <i>visite</i> pasien kondisi kritis di ICU/HCU/NICU/PICU pada saat jam praktik dimulai (dibuktikan dengan catatan medik pasien).
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokter yang terlambat pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah keseluruhan dokter yang dinas pada periode waktu yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> : pengumpulan data yang diambil secara langsung
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) untuk absensi dokter
Instrumen Pengambilan Data	Form Laporan harian
Sampel	Total Sampel
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Penanggung jawab data unit - Kepala Instalasi Rawat Jalan - Kepala Bidang Pelayanan

3.3.3. Instalasi Rawat Inap 2A

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi	100%	Indikator Mutu Nasional &

	pasien		Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	$\geq 85 \%$	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	$\geq 76,61\%$	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤ 14.00 WIB	$\geq 80 \%$	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	$\geq 80 \%$	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
8.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
9	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
10	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
11	Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0.24 \%$	UNIT
12	Kejadian pulang paksa	100%	UNIT
13	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	100%	UNIT
14	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis RI oleh DPJP ≤ 24 Jam	100%	UNIT
15	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box/kranjang Obat Pasien	100%	UNIT
16	Kepatuhan pelepasan APD di ruang antenum	100%	UNIT

17	Kepatuhan Penempatan pasien sesuai standar	100 %	UNIT
----	--	-------	------

3.3.3.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Rawat Inap 2A

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah

	kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: - Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. - Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. - Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain- lain. - Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. - Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan

Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). - Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. - Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. - Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. - Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. - Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan.
• Eksklusi	1. Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. 2. Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	1. Survei langsung setelah perawatan medis selesai.

Data	2. Pengisian kuisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). 3. Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. 4. Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	1. Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh

• Inklusi	dokter pada hari tertentu di rumah sakit. 2. Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama.
• Eksklusi	1. Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). 2. Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visite dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/ <i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/ <i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i>
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya
------------------	---

7. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

8. Kepatuhan Perawat terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒

Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	- Inklusi - Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. - Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. - Eksklusi - Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. - Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung <i>Review</i> rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	- Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis - Rekam Medis Pasien - Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

9. Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap
- | | |
|-----------------|---|
| Judul Indikator | Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan |
|-----------------|---|

	High Alert oleh Petugas Rawat Inap
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). 3. Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat inap telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. 2. Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat inap dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: 1. Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). 2. Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. 3. Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan High Alert sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Inap. 1. Obat-obatan yang dibawa sendiri oleh pasien dari rumah (namun tetap harus diproses sesuai prosedur rekonsiliasi obat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan } crosscheck}{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	1. Lembar Checklist Monitoring Obat Beresiko Tinggi
Instrumen Pengambilan Data	2. Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & High Alert.
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rawat Inap 2. Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban perlindungan pasien. - PMK No. 11 Tahun 2017 (SKP 4): Penandaan lokasi operasi (<i>Site Marking</i>) secara jelas dan konsisten sangat krusial untuk mencegah insiden <i>Wrong Site Surgery</i> (Operasi salah sisi/lokasi). - KTD Fatal: Operasi pada lokasi yang salah adalah kejadian <i>sentinel</i> yang tidak boleh terjadi di Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan lokasi pembedahan melalui penandaan yang jelas pada organ tubuh pasien yang akan dioperasi, terutama pada organ yang memiliki sisi (kanan/kiri) atau struktur multipel (jari, tulang belakang).
Definisi Operasional	- Penandaan Lokasi Operasi: Pemberian tanda menggunakan spidol permanen pada area tubuh yang akan dilakukan tindakan bedah. - Petugas: Dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan pembedahan. - Kepatuhan: Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dan diverifikasi saat <i>Sign In</i>.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien operasi yang sudah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar sesuai standar RS sebelum tindakan dimulai.
Denominator (penyebut)	Seluruh pasien yang direncanakan tindakan operasi yang memerlukan penandaan (sisi kanan/kiri, organ ganda, atau tingkat multipel).
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua pasien operasi yang memiliki lateralitas (kanan/kiri), struktur multipel (jari tangan/kaki), atau tingkat multipel (level tulang belakang). - Operasi organ tunggal (misal: Seksio Sesarea, Apendektomi). - Kasus emergensi mengancam nyawa.
Formula	Jumlah Pasien operasi yang sudah dilakukan penandaan operasi secara benar sesuai standar RS _____X 100% Jumlah Seluruh Pasien yang direncanakan tindakan operasi yang wajib ditandai

Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien, Formulir Penandaan Lokasi Operasi, Laporan Kamar Operasi.
Instrumen Pengambilan Data	1. Daftar tilik (<i>Checklist</i>) Pemantauan Penandaan Lokasi Operasi.
Sampel	Total Sampling (seluruh pasien operasi dalam periode tersebut).
Periode pengumpulan data	Bulanan.
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Instalasi Rawat Inap 2A 2. Kepala Ruang Instalasi Kamar Operasi

11. Kematian pasien > 48 jam

Judul Indikator	Kematian Pasien > 48 Jam			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman. 2. Kematian > 48 jam menunjukkan efektivitas tindakan medis dan asuhan keperawatan setelah fase kritis awal terlewati.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan			
Tujuan	Menilai tingkat kematian pasien yang terjadi dalam 48 jam pertama setelah masuk rumah sakit untuk mengevaluasi respons pelayanan medis terhadap pasien kritis.			
Definisi Operasional	Kematian pasien yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah masuk rumah sakit. Pasien yang meninggal dalam 48 jam dihitung sebagai kematian dalam indikator ini, terlepas dari sebab kematian.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam setelah diterima di rumah sakit.			
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.			
Target Pencapaian	≤ 0,24%			
Kriteria:				
• Inklusi	1. Pasien yang diterima di rumah sakit dengan kondisi kritis atau darurat. 2. Pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam sejak diterima di rumah sakit.			
• Eksklusi	1. Pasien IGD 2. Pasien yang meninggal karena alasan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis rumah sakit (misalnya, pasien yang ditransfer dari rumah sakit lain dalam kondisi terminal).			
Formula	Jumlah Pasien Meninggal > 48 Jam X 100%			

	Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu 2. Data dapat dikumpulkan melalui sistem rekam medis elektronik (SIMRS)
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sampel	Semua pasien yang diterima dengan kondisi kritis atau darurat selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Tim Medis Rumah Sakit 3. Kepala Bidang Pelayanan

12. Kejadian pulang paksa

Judul Indikator	Kejadian Pulang Paksa
Dasar pemikiran	1. Kejadian pulang paksa merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika pasien memilih atau terpaksa meninggalkan rumah sakit tanpa menyelesaikan perawatan yang disarankan oleh tenaga medis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan, masalah biaya, atau masalah pribadi. Kejadian ini penting untuk dipantau karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan pasien. Dalam beberapa kasus, pulang paksa dapat meningkatkan risiko komplikasi atau memperburuk kondisi pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian pulang paksa di rumah sakit untuk mengetahui faktor penyebab dan mengidentifikasi upaya perbaikan dalam pelayanan kesehatan agar kejadian tersebut dapat diminimalkan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Kejadian pulang paksa adalah peristiwa ketika pasien meninggalkan rumah sakit dengan keinginan atau keputusan sendiri sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, tanpa izin dari pihak rumah sakit atau tenaga medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pulang paksa yang terjadi dalam periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien rawat inap di rumah sakit dalam periode waktu yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian

Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien yang memilih atau terpaksa pulang sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang disarankan oleh tenaga medis. 2. Pasien yang tercatat dalam sistem rumah sakit sebagai pasien rawat inap. 1. Pasien yang sudah keluar rumah sakit dan tidak memenuhi definisi pulang paksa (misalnya, pasien yang keluar dengan izin medis yang sah).
Formula	Jumlah Kejadian Pulang Paksa
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memonitor setiap kejadian pulang paksa yang tercatat di rumah sakit. Data diperoleh dari rekam medis pasien dan laporan dari staf medis atau administrasi rumah sakit. 2. Pemantauan juga dilakukan melalui survei kepuasan pasien dan analisis keluhan pasien.
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekam medis atau catatan kejadian pulang paksa
Sampel	Semua pasien yang mengalami kejadian pulang paksa dalam periode waktu yang sama.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan

13. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat, khususnya ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien, dapat menyebabkan efek samping yang serius dan membahayakan keselamatan pasien. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kesalahan petugas dalam cross cek antara isi obat dan etiket, kesalahan administrasi, ketidakakuratan dalam pencatatan atau pemindahan informasi, atau ketidakpahaman dalam pengelolaan data pasien. Dengan adanya sistem e-tiket, rumah sakit berusaha untuk meminimalisir kesalahan ini, namun tetap perlu dilakukan pemantauan yang cermat untuk memastikan keberhasilan implementasi dan kualitas pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pemberian obat di rumah sakit.

Definisi Operasional	Kejadian kesalahan pemberian obat antara isi dan e-tiket pasien tidak sesuai terjadi ketika obat yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan informasi yang tercatat pada e-tiket pasien, baik jenis obat, dosis, atau frekuensi pemberian obat.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian obat yang teridentifikasi antara isi obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang menerima obat selama periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang menerima pengobatan berdasarkan e-tiket pasien. - Semua jenis obat yang diberikan kepada pasien (oral, injeksi, dll). - Kejadian kesalahan pemberian obat yang tercatat dalam sistem rumah sakit. - Kasus yang tidak teridentifikasi dalam laporan kesalahan pemberian obat.
Formula	Jumlah Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Metode Pengumpulan Data	1. Data dikumpulkan melalui laporan kesalahan yang diidentifikasi baik oleh tenaga medis maupun melalui sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Laporan insiden atau laporan kesalahan pemberian obat
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan insiden atau kesalahan pemberian obat
Sampel	Pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat antara e-tiket dan obat yang diberikan.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Farmasi - Komite Medis Rumah Sakit - Komite Mutu Rumah Sakit - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Penunjang

14. Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pengisian Pengkajian Awal Medis oleh DPJP ≤24 Jam
Dasar pemikiran	Pengkajian awal medis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit merupakan bagian penting dari proses pelayanan medis. Pengkajian yang dilakukan dengan tepat waktu dapat memastikan penanganan yang cepat dan akurat terhadap kondisi pasien, serta membantu dalam perencanaan terapi yang lebih baik. Keterlambatan dalam pengisian pengkajian awal medis dapat menghambat diagnosa dan penanganan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien diterima di rumah sakit untuk memastikan penanganan medis yang cepat dan tepat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 jam adalah Prosentase pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu 24 jam setelah masuk rumah sakit, dibandingkan dengan total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah masuk rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang membutuhkan pengkajian awal medis dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang masuk rumah sakit dengan status rawat inap. 2. Semua pasien yang memerlukan pengkajian awal medis oleh DPJP. 1. Pasien yang sudah mendapat pengkajian medis sebelum masuk rumah sakit (misalnya, pasien yang dipindahkan dari rumah sakit lain dengan pengkajian yang sudah dilakukan).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien dengan Pengkajian Awal Medis } \leq 24 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pemantauan dapat dilakukan secara manual oleh petugas rekam medis atau menggunakan sistem informasi rumah sakit (SIRS) untuk mengidentifikasi waktu pengisian pengkajian medis.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Pengkajian Awal Medis ≤ 24 Jam
Sampel	Pasien yang memerlukan pengkajian medis yang sesuai dengan kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite Medis Rumah Sakit 2. Komite Mutu Rumah Sakit 3. Kepala Bidang Pelayanan

15. Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Penempatan Etiket Identitas Pasien pada Box
-----------------	---

	Obat
Dasar pemikiran	Penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah salah satu langkah penting dalam memastikan keselamatan pasien terkait pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal, terutama apabila obat yang diberikan tidak sesuai dengan identitas pasien yang tepat. Etiket identitas yang terpasang dengan benar pada box obat membantu tenaga medis untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pasien yang dimaksud, meminimalisir kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam penempatan etiket identitas pasien pada box obat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan pemberian obat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah Prosentase jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah total box obat yang membutuhkan penempatan etiket.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total box obat yang memerlukan penempelan etiket identitas pasien selama periode pengumpulan data..
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua box obat yang akan diberikan kepada pasien di rumah sakit. 2. Box obat yang memerlukan penempatan etiket identitas pasien. 3. Semua unit layanan yang melibatkan pemberian obat (terutama rawat inap) 1. Box obat yang tidak perlu diberi etiket identitas pasien (misalnya, obat yang tidak dibagikan langsung ke pasien).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Box Obat dengan Etiket Identitas Pasien yang Tepat}}{\text{Jumlah Total box obat yang memerlukan etiket}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa rekam medis dan box obat yang akan diberikan pada pasien, untuk memastikan bahwa etiket identitas pasien ditempelkan dengan benar.
Sumber data	1. Formulir Pengecekan box obat dengan etiket Identitas Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pengawasan kepatuhan penempatan etiket identitas pasien
Sampel	Sampel acak box obat yang diperiksa selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Instalasi Rawat Inap 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Keperawatan

16. Kepatuhan Petugas dalam Pelepasan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur di Ruang Anteroom.

Judul Indikator	Kepatuhan Petugas dalam Pelepasan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Prosedur di Ruang Anteroom.
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 401): Mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan standar mutu pelayanan kesehatan dan menjamin keselamatan pasien serta tenaga medis/kesehatan. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Menyatakan bahwa setiap fasyankes harus menerapkan prinsip kewaspadaan standar, di mana penggunaan dan pelepasan APD merupakan komponen kunci untuk memutus rantai penularan infeksi. 3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Pasal 5): Mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan standar keselamatan pasien, termasuk pencegahan risiko infeksi nosokomial.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Menjamin keselamatan petugas kesehatan dari paparan agen infeksius 2. Mencegah penyebaran mikroorganisme keluar dari ruang isolasi ke area bersih.
Definisi Operasional	Kepatuhan pelepasan APD adalah perilaku petugas dalam melepas seluruh komponen APD di ruang anteroom dengan urutan yang benar (misal: sarung tangan, <i>gown</i> , pelindung mata, masker) serta melakukan kebersihan tangan sesuai standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%).
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang diobservasi patuh melepas APD sesuai urutan dan prosedur di ruang anteroom dalam periode satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh petugas yang diobservasi saat melakukan pelepasan APD di ruang anteroom dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh staf (Medis, Keperawatan, Penunjang, dan Cleaning Service) yang bertugas di area isolasi dan keluar melalui ruang anteroom
• Eksklusi	Petugas yang tidak masuk ke area isolasi/tidak menggunakan APD lengkap.
Formula	Jumlah petugas yang patuh melepas APD sesuai urutan dan prosedur di ruang anteroom

	X 100% Jumlah Total petugas yang diobservasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) secara mendadak atau terencana oleh auditor
Sumber data	Lembar observasi kepatuhan PPI.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>Checklist</i> Monitoring Pelepasan APD (berisi poin urutan pelepasan dan teknik <i>hand hygiene</i>).
Sampel	Total sampling atau <i>Non-probability sampling</i> (kuota sampling minimal 30 observasi per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite PPI 2. Kepala Unit IRNA 2A

17. Kepatuhan Penempatan Pasien Sesuai Standar

Judul Indikator	Kepatuhan Penempatan Pasien sesuai Standar Kewaspadaan Isolasi
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Pasal 172): Mengenai perlindungan pasien dan petugas dari risiko infeksi di fasilitas kesehatan. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang PPI: Mewajibkan penempatan pasien berdasarkan transmisi (kontak, droplet, <i>airborne</i>) untuk memutus rantai infeksi. 3. Pedoman PPI Tahun 2025 di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dimana pasien dengan infeksi menular harus dipisahkan dari pasien non-infeksius melalui sistem kohorting atau ruang isolasi bertekanan negatif/ventilasi alami yang adekuat.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan (<i>Healthcare Associated Infections/HAIs</i>). 2. Melindungi pasien lain, pengunjung, dan staf dari paparan agen infeksius sesuai rute penularannya.
Definisi Operasional	Kepatuhan penempatan pasien adalah kesesuaian tindakan petugas dalam menempatkan pasien berdasarkan jenis infeksiusnya (Kewaspadaan Transmisi) sejak pasien masuk hingga dirawat, meliputi penggunaan ruang isolasi tunggal, sistem kohorting (pengelompokan pasien dengan kuman yang sama), serta jarak antar tempat tidur minimal 1 meter.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%).
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang ditempatkan sesuai dengan standar kewaspadaan transmisi (isolasi/kohorting) dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh pasien dengan penyakit infeksi menular yang diobservasi dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	

• Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien yang didiagnosa atau suspek penyakit infeksi menular (misal: TB Paru, Measles, Varicella, MRSA, COVID-19, dll). Pasien tanpa penyakit infeksi menular (pasien umum/non-infeksius).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien yang ditempatkan sesuai standar}}{\text{Jumlah Total pasien infeksi yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) dan tinjauan rekam medis (<i>Retrospektif</i>).
Sumber data	Laporan surveilans IPCN Catatan Keperawatan / Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Penempatan Pasien
Sampel	Total sampling atau <i>Non-probability sampling</i> (kuota sampling minimal 30 observasi per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite PPI 2. Kepala Unit IRNA 2A 3. Kepala Unit IGD

3.3.4. Instalasi Rawat Inap 2B

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			

8.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
9	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
10	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
11	Kematian pasien ≤ 48 jam	≤ 0.24 %	UNIT
12	Kejadian pulang paksa	100%	UNIT
13	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	100%	UNIT
14	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	100%	UNIT
15	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	UNIT

3.3.4.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Rawat Inap 2B

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.

	3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
-----------------	-----------------------------

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah

	kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan} \times 100\%}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}}$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban

	Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤ 14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). - Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. - Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00 - 14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	- Inklusi - Eksklusi 1. Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. 2. Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. 1. Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). 2. Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visite dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

7. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya

	berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

8. Kepatuhan Perawat terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	• Inklusi 1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. • Eksklusi 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah

	komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

9. Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Rawat Inap

Judul Indikator	Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Rawat Inap
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). 3. Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat inap telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. 2. Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat inap dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: 1. Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). 2. Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. 3. Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan <i>High Alert</i> sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Inap. 1. Obat-obatan yang dibawa sendiri oleh pasien dari rumah (namun tetap harus diproses sesuai prosedur rekonsiliasi obat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan crosscheck}}{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	1. Lembar Checklist Monitoring Obat Beresiko Tinggi
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & <i>High Alert</i> .
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rawat Inap 2. Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban perlindungan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 (SKP 4): Penandaan lokasi operasi (<i>Site Marking</i>) secara jelas dan konsisten sangat krusial untuk mencegah insiden <i>Wrong Site Surgery</i> (Operasi salah sisi/lokasi). 3. KTD Fatal: Operasi pada lokasi yang salah adalah kejadian <i>sentinel</i> yang tidak boleh terjadi di Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan lokasi pembedahan melalui penandaan yang jelas pada organ tubuh pasien yang akan dioperasi, terutama pada organ yang memiliki sisi (kanan/kiri) atau struktur multipel (jari, tulang belakang).
Definisi Operasional	1. Penandaan Lokasi Operasi: Pemberian tanda menggunakan spidol permanen pada area tubuh yang akan dilakukan tindakan bedah. 2. Petugas: Dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan pembedahan. 3. Kepatuhan: Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dan diverifikasi saat <i>Sign In</i> .

Definisi Operasional	Kematian pasien yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah masuk rumah sakit. Pasien yang meninggal dalam 48 jam dihitung sebagai kematian dalam indikator ini, terlepas dari sebab kematian.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam setelah diterima di rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	≤ 0,24%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang diterima di rumah sakit dengan kondisi kritis atau darurat. - Pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam sejak diterima di rumah sakit. - Pasien IGD - Pasien yang meninggal karena alasan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis rumah sakit (misalnya, pasien yang ditransfer dari rumah sakit lain dalam kondisi terminal).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien Meninggal > 48 Jam}}{\text{Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu - Data dapat dikumpulkan melalui sistem rekam medis elektronik (SIMRS)
Sumber data	- Rekam medis pasien - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sampel	Semua pasien yang diterima dengan kondisi kritis atau darurat selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Rawat Inap - Tim Medis Rumah Sakit - Kepala Bidang Pelayanan

12. Kejadian pulang paksa

Judul Indikator	Kejadian Pulang Paksa
Dasar pemikiran	Kejadian pulang paksa merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika pasien memilih atau terpaksa meninggalkan rumah sakit tanpa menyelesaikan perawatan yang disarankan oleh tenaga medis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan, masalah biaya, atau masalah pribadi. Kejadian ini penting untuk dipantau karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan pasien. Dalam beberapa kasus, pulang paksa dapat meningkatkan risiko komplikasi atau memperburuk kondisi pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian pulang paksa di rumah sakit untuk mengetahui faktor penyebab dan mengidentifikasi upaya perbaikan dalam pelayanan kesehatan agar kejadian tersebut dapat diminimalkan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Kejadian pulang paksa adalah peristiwa ketika pasien meninggalkan rumah sakit dengan keinginan atau keputusan sendiri sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, tanpa izin dari pihak rumah sakit atau tenaga medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pulang paksa yang terjadi dalam periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien rawat inap di rumah sakit dalam periode waktu yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang memilih atau terpaksa pulang sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang disarankan oleh tenaga medis. 2. Pasien yang tercatat dalam sistem rumah sakit sebagai pasien rawat inap. 2. Pasien yang sudah keluar rumah sakit dan tidak memenuhi definisi pulang paksa (misalnya, pasien yang keluar dengan izin medis yang sah).
Formula	Jumlah Kejadian Pulang Paksa
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memonitor setiap kejadian pulang paksa yang tercatat di rumah sakit. Data diperoleh dari rekam medis pasien dan laporan dari staf medis atau administrasi rumah sakit. 2. Pemantauan juga dilakukan melalui survei kepuasan pasien dan analisis keluhan pasien.
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekam medis atau catatan kejadian pulang paksa
Sampel	Semua pasien yang mengalami kejadian pulang paksa dalam periode waktu yang sama.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan

13. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat, khususnya ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien, dapat menyebabkan efek samping yang serius dan membahayakan keselamatan pasien. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kesalahan petugas dalam cross cek antara isi obat dan etiket, kesalahan administrasi, ketidakakuratan dalam pencatatan atau pemindahan informasi, atau ketidakpahaman dalam pengelolaan data pasien. Dengan adanya sistem e-tiket, rumah sakit berusaha untuk meminimalisir kesalahan ini, namun tetap perlu dilakukan pemantauan yang cermat untuk memastikan keberhasilan implementasi dan kualitas pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pemberian obat di rumah sakit.
Definisi Operasional	Kejadian kesalahan pemberian obat antara isi dan e-tiket pasien tidak sesuai terjadi ketika obat yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan informasi yang tercatat pada e-tiket pasien, baik jenis obat, dosis, atau frekuensi pemberian obat.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian obat yang teridentifikasi antara isi obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang menerima obat selama periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Pasien yang menerima pengobatan berdasarkan e-tiket pasien. 2. Semua jenis obat yang diberikan kepada pasien (oral, injeksi, dll). 3. Kejadian kesalahan pemberian obat yang tercatat dalam sistem rumah sakit. 1. Kasus yang tidak teridentifikasi dalam laporan kesalahan pemberian obat.
Formula	Jumlah Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Metode Pengumpulan Data	1. Data dikumpulkan melalui laporan kesalahan yang diidentifikasi baik oleh tenaga medis maupun melalui sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Laporan insiden atau laporan kesalahan pemberian obat
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan insiden atau kesalahan pemberian obat
Sampel	Pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat antara e-tiket dan obat yang diberikan.

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Penunjang

14. Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pengisian Pengkajian Awal Medis oleh DPJP ≤24 Jam
Dasar pemikiran	Pengkajian awal medis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit merupakan bagian penting dari proses pelayanan medis. Pengkajian yang dilakukan dengan tepat waktu dapat memastikan penanganan yang cepat dan akurat terhadap kondisi pasien, serta membantu dalam perencanaan terapi yang lebih baik. Keterlambatan dalam pengisian pengkajian awal medis dapat menghambat diagnosa dan penanganan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien diterima di rumah sakit untuk memastikan penanganan medis yang cepat dan tepat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 jam adalah Prosentase pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu 24 jam setelah masuk rumah sakit, dibandingkan dengan total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah masuk rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang membutuhkan pengkajian awal medis dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua pasien yang masuk rumah sakit dengan status rawat inap. 2. Semua pasien yang memerlukan pengkajian awal medis oleh DPJP.
• Eksklusi	1. Pasien yang sudah mendapat pengkajian medis sebelum masuk rumah sakit (misalnya, pasien yang dipindahkan dari rumah sakit lain dengan pengkajian yang sudah dilakukan).

Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien dengan Pengkajian Awal Medis } \leq 24 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pemantauan dapat dilakukan secara manual oleh petugas rekam medis atau menggunakan sistem informasi rumah sakit (SMIRS) untuk mengidentifikasi waktu pengisian pengkajian medis.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Pengkajian Awal Medis ≤ 24 Jam
Sampel	Pasien yang memerlukan pengkajian medis yang sesuai dengan kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite Medis Rumah Sakit 2. Komite Mutu Rumah Sakit 3. Kepala Bidang Pelayanan

15. Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Penempatan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat
Dasar pemikiran	Penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah salah satu langkah penting dalam memastikan keselamatan pasien terkait pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal, terutama apabila obat yang diberikan tidak sesuai dengan identitas pasien yang tepat. Etiket identitas yang terpasang dengan benar pada box obat membantu tenaga medis untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pasien yang dimaksud, meminimalisir kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam penempatan etiket identitas pasien pada box obat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan pemberian obat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah Prosentase jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah total box obat yang membutuhkan penempatan etiket.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total box obat yang memerlukan penempelan etiket identitas pasien selama periode pengumpulan data..
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	

• Inklusi	1. Semua box obat yang akan diberikan kepada pasien di rumah sakit. 2. Box obat yang memerlukan penempatan etiket identitas pasien. 3. Semua unit layanan yang melibatkan pemberian obat (terutama rawat inap)
• Eksklusi	1. Box obat yang tidak perlu diberi etiket identitas pasien (misalnya, obat yang tidak dibagikan langsung ke pasien).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Box Obat dengan Etiket Identitas Pasien yang Tepat}}{\text{Jumlah Total box obat yang memerlukan etiket}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa rekam medis dan box obat yang akan diberikan pada pasien, untuk memastikan bahwa etiket identitas pasien ditempelkan dengan benar.
Sumber data	1. Formulir Pengecekan box obat dengan etiket Identitas Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pengawasan kepatuhan penempatan etiket identitas pasien
Sampel	Sampel acak box obat yang diperiksa selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Instalasi Rawat Inap 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Keperawatan

3.3.5. Instalasi Rawat Inap 3A

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan	100%	Indikator Mutu Nasional

	Penggunaan Alat Pelindung Diri		
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
8.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
9	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
10	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
11	Kematian pasien > 48 jam	$\leq 0.24 \%$	UNIT
12	Kejadian pulang paksa	100%	UNIT
13	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	100%	UNIT
14	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 Jam	100%	UNIT
15	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	UNIT

3.3.5.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Rawat Inap 3A

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan

	minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan

	6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi <i>form</i> kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). - Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. - Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	- Inklusi - Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. - Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. - Eksklusi - Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). - Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visite dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup clinical pathway yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan <i>Clinical Pathway</i>
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

7. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya

	berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

8. Kepatuhan Perawat terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	• Inklusi 1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. • Eksklusi 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah

	komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik

9. Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap

Judul Indikator	Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Rawat Inap
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). 3. Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat inap telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. 2. Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat inap dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: 1. Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). 2. Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. 3. Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan High Alert sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Inap. 1. Obat-obatan yang dibawa sendiri oleh pasien dari rumah (namun tetap harus diproses sesuai prosedur rekonsiliasi obat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan crosscheck}}{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	1. Lembar Checklist Monitoring Obat Beresiko Tinggi
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & <i>High Alert</i> .
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rawat Inap 2. Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban perlindungan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 (SKP 4): Penandaan lokasi operasi (<i>Site Marking</i>) secara jelas dan konsisten sangat krusial untuk mencegah insiden <i>Wrong Site Surgery</i> (Operasi salah sisi/lokasi). 3. KTD Fatal: Operasi pada lokasi yang salah adalah kejadian <i>sentinel</i> yang tidak boleh terjadi di Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan lokasi pembedahan melalui penandaan yang jelas pada organ tubuh pasien yang akan dioperasi, terutama pada organ yang memiliki sisi (kanan/kiri) atau struktur multipel (jari, tulang belakang).
Definisi Operasional	1. Penandaan Lokasi Operasi: Pemberian tanda menggunakan spidol permanen pada area tubuh yang akan dilakukan tindakan bedah. 2. Petugas: Dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan pembedahan. 3. Kepatuhan: Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dan diverifikasi saat <i>Sign In</i> .

Definisi Operasional	Kematian pasien yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah masuk rumah sakit. Pasien yang meninggal dalam 48 jam dihitung sebagai kematian dalam indikator ini, terlepas dari sebab kematian.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam setelah diterima di rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	≤ 0,24%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang diterima di rumah sakit dengan kondisi kritis atau darurat. - Pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam sejak diterima di rumah sakit. - Pasien IGD - Pasien yang meninggal karena alasan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis rumah sakit (misalnya, pasien yang ditransfer dari rumah sakit lain dalam kondisi terminal).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien Meninggal > 48 Jam}}{\text{Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu - Data dapat dikumpulkan melalui sistem rekam medis elektronik (SIMRS)
Sumber data	- Rekam medis pasien - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sampel	Semua pasien yang diterima dengan kondisi kritis atau darurat selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Rawat Inap - Tim Medis Rumah Sakit - Kepala Bidang Pelayanan

12. Kejadian pulang paksa

Judul Indikator	Kejadian Pulang Paksa
Dasar pemikiran	Kejadian pulang paksa merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika pasien memilih atau terpaksa meninggalkan rumah sakit tanpa menyelesaikan perawatan yang disarankan oleh tenaga medis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan, masalah biaya, atau masalah pribadi. Kejadian ini penting untuk dipantau karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan pasien. Dalam beberapa kasus, pulang paksa dapat meningkatkan risiko komplikasi atau memperburuk kondisi pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian pulang paksa di rumah sakit untuk mengetahui faktor penyebab dan mengidentifikasi upaya perbaikan dalam pelayanan kesehatan agar kejadian tersebut dapat diminimalkan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Kejadian pulang paksa adalah peristiwa ketika pasien meninggalkan rumah sakit dengan keinginan atau keputusan sendiri sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, tanpa izin dari pihak rumah sakit atau tenaga medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pulang paksa yang terjadi dalam periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien rawat inap di rumah sakit dalam periode waktu yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang memilih atau terpaksa pulang sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang disarankan oleh tenaga medis. 2. Pasien yang tercatat dalam sistem rumah sakit sebagai pasien rawat inap. 1. Pasien yang sudah keluar rumah sakit dan tidak memenuhi definisi pulang paksa (misalnya, pasien yang keluar dengan izin medis yang sah).
Formula	Jumlah Kejadian Pulang Paksa
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memonitor setiap kejadian pulang paksa yang tercatat di rumah sakit. Data diperoleh dari rekam medis pasien dan laporan dari staf medis atau administrasi rumah sakit. 2. Pemantauan juga dilakukan melalui survei kepuasan pasien dan analisis keluhan pasien.
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekam medis atau catatan kejadian pulang paksa
Sampel	Semua pasien yang mengalami kejadian pulang paksa dalam periode waktu yang sama.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan

13. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat, khususnya ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien, dapat menyebabkan efek samping yang serius dan membahayakan keselamatan pasien. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kesalahan petugas dalam cross cek antara isi obat dan etiket, kesalahan administrasi, ketidakakuratan dalam pencatatan atau pemindahan informasi, atau ketidakpahaman dalam pengelolaan data pasien. Dengan adanya sistem e-tiket, rumah sakit berusaha untuk meminimalisir kesalahan ini, namun tetap perlu dilakukan pemantauan yang cermat untuk memastikan keberhasilan implementasi dan kualitas pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pemberian obat di rumah sakit.
Definisi Operasional	Kejadian kesalahan pemberian obat antara isi dan e-tiket pasien tidak sesuai terjadi ketika obat yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan informasi yang tercatat pada e-tiket pasien, baik jenis obat, dosis, atau frekuensi pemberian obat.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian obat yang teridentifikasi antara isi obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang menerima obat selama periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang menerima pengobatan berdasarkan e-tiket pasien. 2. Semua jenis obat yang diberikan kepada pasien (oral, injeksi, dll). 3. Kejadian kesalahan pemberian obat yang tercatat dalam sistem rumah sakit. 1. Kasus yang tidak teridentifikasi dalam laporan kesalahan pemberian obat.
Formula	Jumlah Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai
Metode Pengumpulan Data	1. Data dikumpulkan melalui laporan kesalahan yang diidentifikasi baik oleh tenaga medis maupun melalui sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Laporan insiden atau laporan kesalahan pemberian obat
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan insiden atau kesalahan pemberian obat
Sampel	Pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat antara e-tiket dan obat yang diberikan.

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Penunjang

14. Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pengisian Pengkajian Awal Medis oleh DPJP ≤24 Jam
Dasar pemikiran	Pengkajian awal medis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit merupakan bagian penting dari proses pelayanan medis. Pengkajian yang dilakukan dengan tepat waktu dapat memastikan penanganan yang cepat dan akurat terhadap kondisi pasien, serta membantu dalam perencanaan terapi yang lebih baik. Keterlambatan dalam pengisian pengkajian awal medis dapat menghambat diagnosa dan penanganan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien diterima di rumah sakit untuk memastikan penanganan medis yang cepat dan tepat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 jam adalah Prosentase pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu 24 jam setelah masuk rumah sakit, dibandingkan dengan total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah masuk rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang membutuhkan pengkajian awal medis dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua pasien yang masuk rumah sakit dengan status rawat inap. 2. Semua pasien yang memerlukan pengkajian awal medis oleh DPJP.
• Eksklusi	1. Pasien yang sudah mendapat pengkajian medis sebelum masuk rumah sakit (misalnya, pasien yang dipindahkan dari rumah sakit lain dengan pengkajian yang sudah dilakukan).

Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien dengan Pengkajian Awal Medis} \leq 24 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pemantauan dapat dilakukan secara manual oleh petugas rekam medis atau menggunakan sistem informasi rumah sakit (SIRS) untuk mengidentifikasi waktu pengisian pengkajian medis.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Pengkajian Awal Medis ≤ 24 Jam
Sampel	Pasien yang memerlukan pengkajian medis yang sesuai dengan kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite Medis Rumah Sakit 2. Komite Mutu Rumah Sakit 3. Kepala Bidang Pelayanan

15. Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Penempatan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat
Dasar pemikiran	Penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah salah satu langkah penting dalam memastikan keselamatan pasien terkait pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal, terutama apabila obat yang diberikan tidak sesuai dengan identitas pasien yang tepat. Etiket identitas yang terpasang dengan benar pada box obat membantu tenaga medis untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pasien yang dimaksud, meminimalisir kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam penempatan etiket identitas pasien pada box obat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan pemberian obat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah Prosentase jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah total box obat yang membutuhkan penempatan etiket.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total box obat yang memerlukan penempelan etiket identitas pasien selama periode pengumpulan data..
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	

• Inklusi	1. Semua box obat yang akan diberikan kepada pasien di rumah sakit. 2. Box obat yang memerlukan penempatan etiket identitas pasien. 3. Semua unit layanan yang melibatkan pemberian obat (terutama rawat inap)
• Eksklusi	1. Box obat yang tidak perlu diberi etiket identitas pasien (misalnya, obat yang tidak dibagikan langsung ke pasien).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Box Obat dengan Etiket Identitas Pasien yang Tepat}}{\text{Jumlah Total box obat yang memerlukan etiket}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa rekam medis dan box obat yang akan diberikan pada pasien, untuk memastikan bahwa etiket identitas pasien ditempelkan dengan benar.
Sumber data	1. Formulir Pengecekan box obat dengan etiket Identitas Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pengawasan kepatuhan penempatan etiket identitas pasien
Sampel	Sampel acak box obat yang diperiksa selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Kepala Instalasi Rawat Inap 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Keperawatan

3.3.6. Instalasi Rawat Inap 3B

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan	100%	Indikator Mutu Nasional

	Penggunaan Alat Pelindung Diri		
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
8.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
9	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
10	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
11	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	UNIT
12	Kejadian pulang paksa	100%	UNIT
13	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai	100%	UNIT
14	Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam	100%	UNIT
15	Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat	100%	UNIT

3.3.6.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Rawat Inap 3B

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan

	minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan

	6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assesment awal risiko jatuh b. Assesment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besar sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). - Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. - Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	- Inklusi - Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. - Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. - Eksklusi - Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). - Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visit dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup clinical pathway yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

7. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya

	berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

8. Kepatuhan Perawat terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	• Inklusi 1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. • Eksklusi 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah

	komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

9. Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas rawat inap

Judul Indikator	Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Rawat Inap
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). 3. Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat inap telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. 2. Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat inap dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: 1. Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). 2. Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. 3. Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan High Alert sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Inap. Obat-obatan yang dibawa sendiri oleh pasien dari rumah (namun tetap harus diproses sesuai prosedur rekonsiliasi obat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan } crosscheck}{\text{Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	Lembar Checklist Monitoring Obat Beresiko Tinggi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & High Alert.
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Ruang Rawat Inap - Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban perlindungan pasien. - PMK No. 11 Tahun 2017 (SKP 4): Penandaan lokasi operasi (<i>Site Marking</i>) secara jelas dan konsisten sangat krusial untuk mencegah insiden <i>Wrong Site Surgery</i> (Operasi salah sisi/lokasi). - KTD Fatal: Operasi pada lokasi yang salah adalah kejadian <i>sentinel</i> yang tidak boleh terjadi di Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan lokasi pembedahan melalui penandaan yang jelas pada organ tubuh pasien yang akan dioperasi, terutama pada organ yang memiliki sisi (kanan/kiri) atau struktur multipel (jari, tulang belakang).
Definisi Operasional	- Penandaan Lokasi Operasi: Pemberian tanda menggunakan spidol permanen pada area tubuh yang akan dilakukan tindakan bedah. - Petugas: Dilakukan oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan pembedahan. - Kepatuhan: Penandaan dilakukan sebelum pasien dipindahkan ke kamar operasi dan diverifikasi saat <i>Sign In</i>.

Definisi Operasional	Kematian pasien yang terjadi dalam waktu 48 jam setelah masuk rumah sakit. Pasien yang meninggal dalam 48 jam dihitung sebagai kematian dalam indikator ini, terlepas dari sebab kematian.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam setelah diterima di rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	≤ 0,24%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang diterima di rumah sakit dengan kondisi kritis atau darurat. - Pasien yang meninggal dalam waktu > 48 jam sejak diterima di rumah sakit. - Pasien IGD - Pasien yang meninggal karena alasan yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis rumah sakit (misalnya, pasien yang ditransfer dari rumah sakit lain dalam kondisi terminal).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien Meninggal > 48 Jam}}{\text{Jumlah total pasien (hidup + mati) yang diterima di rumah sakit dalam periode yang sama.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu - Data dapat dikumpulkan melalui sistem rekam medis elektronik (SIMRS)
Sumber data	- Rekam medis pasien - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Sistem informasi rumah sakit (SIMRS)
Sampel	Semua pasien yang diterima dengan kondisi kritis atau darurat selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Rawat Inap - Tim Medis Rumah Sakit - Kepala Bidang Pelayanan

12. Kejadian pulang paksa

Judul Indikator	Kejadian Pulang Paksa
Dasar pemikiran	Kejadian pulang paksa merupakan salah satu peristiwa yang terjadi ketika pasien memilih atau terpaksa meninggalkan rumah sakit tanpa menyelesaikan perawatan yang disarankan oleh tenaga medis. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakpuasan terhadap pelayanan, masalah biaya, atau masalah pribadi. Kejadian ini penting untuk dipantau karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan pasien. Dalam beberapa kasus, pulang paksa dapat meningkatkan risiko komplikasi atau memperburuk kondisi pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian pulang paksa di rumah sakit untuk mengetahui faktor penyebab dan mengidentifikasi upaya perbaikan dalam pelayanan kesehatan agar kejadian tersebut dapat diminimalkan, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Kejadian pulang paksa adalah peristiwa ketika pasien meninggalkan rumah sakit dengan keinginan atau keputusan sendiri sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, tanpa izin dari pihak rumah sakit atau tenaga medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pulang paksa yang terjadi dalam periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien rawat inap di rumah sakit dalam periode waktu yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang memilih atau terpaksa pulang sebelum menyelesaikan perawatan atau pengobatan yang disarankan oleh tenaga medis. 2. Pasien yang tercatat dalam sistem rumah sakit sebagai pasien rawat inap. 1. Pasien yang sudah keluar rumah sakit dan tidak memenuhi definisi pulang paksa (misalnya, pasien yang keluar dengan izin medis yang sah).
Formula	Jumlah Kejadian Pulang Paksa
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memonitor setiap kejadian pulang paksa yang tercatat di rumah sakit. Data diperoleh dari rekam medis pasien dan laporan dari staf medis atau administrasi rumah sakit. 2. Pemantauan juga dilakukan melalui survei kepuasan pasien dan analisis keluhan pasien.
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekam medis atau catatan kejadian pulang paksa
Sampel	Semua pasien yang mengalami kejadian pulang paksa dalam periode waktu yang sama.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Rawat Inap 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan

13. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat antara isi dan E-tiket Pasien tidak sesuai

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai		
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat, khususnya ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien, dapat menyebabkan efek samping yang serius dan membahayakan keselamatan pasien. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh kesalahan petugas dalam cross cek antara isi obat dan etiket, kesalahan administrasi, ketidakakuratan dalam pencatatan atau pemindahan informasi, atau ketidakpahaman dalam pengelolaan data pasien. Dengan adanya sistem e-tiket, rumah sakit berusaha untuk meminimalisir kesalahan ini, namun tetap perlu dilakukan pemantauan yang cermat untuk memastikan keberhasilan implementasi dan kualitas pelayanan.		
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan	☒ ☒ ☒	
Tujuan	Mengukur frekuensi kejadian ketidaksesuaian antara obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pemberian obat di rumah sakit.		
Definisi Operasional	Kejadian kesalahan pemberian obat antara isi dan e-tiket pasien tidak sesuai terjadi ketika obat yang diberikan kepada pasien tidak sesuai dengan informasi yang tercatat pada e-tiket pasien, baik jenis obat, dosis, atau frekuensi pemberian obat.		
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)		
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian obat yang teridentifikasi antara isi obat yang diberikan dengan yang tercatat pada e-tiket pasien.		
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang menerima obat selama periode pengumpulan data.		
Target Pencapaian	0 kejadian		
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang menerima pengobatan berdasarkan e-tiket pasien. 2. Semua jenis obat yang diberikan kepada pasien (oral, injeksi, dll). 3. Kejadian kesalahan pemberian obat yang tercatat dalam sistem rumah sakit. 1. Kasus yang tidak teridentifikasi dalam laporan kesalahan pemberian obat.		
Formula	Jumlah Kejadian Kesalahan Pemberian Obat Antara Isi dan E-Tiket Pasien Tidak Sesuai		
Metode Pengumpulan Data	1. Data dikumpulkan melalui laporan kesalahan yang diidentifikasi baik oleh tenaga medis maupun melalui sistem informasi rumah sakit (SIMRS)		
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Laporan insiden atau laporan kesalahan pemberian obat		
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan insiden atau kesalahan pemberian obat		
Sampel	Pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat antara e-tiket dan obat yang diberikan.		

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Komite Medis Rumah Sakit 3. Komite Mutu Rumah Sakit 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Penunjang

14. Angka Kepatuhan Pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤24 Jam

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Pengisian Pengkajian Awal Medis oleh DPJP ≤24 Jam
Dasar pemikiran	Pengkajian awal medis oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien masuk rumah sakit merupakan bagian penting dari proses pelayanan medis. Pengkajian yang dilakukan dengan tepat waktu dapat memastikan penanganan yang cepat dan akurat terhadap kondisi pasien, serta membantu dalam perencanaan terapi yang lebih baik. Keterlambatan dalam pengisian pengkajian awal medis dapat menghambat diagnosa dan penanganan lebih lanjut, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒ ☒ ☒ ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah pasien diterima di rumah sakit untuk memastikan penanganan medis yang cepat dan tepat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan pengisian pengkajian awal medis oleh DPJP ≤ 24 jam adalah Prosentase pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu 24 jam setelah masuk rumah sakit, dibandingkan dengan total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang pengkajian awal medisnya telah diisi oleh DPJP dalam waktu ≤ 24 jam setelah masuk rumah sakit.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang membutuhkan pengkajian awal medis dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi 1. Semua pasien yang masuk rumah sakit dengan status rawat inap. 2. Semua pasien yang memerlukan pengkajian awal medis oleh DPJP. • Eksklusi 1. Pasien yang sudah mendapat pengkajian medis sebelum masuk rumah sakit (misalnya, pasien yang dipindahkan dari rumah sakit lain dengan pengkajian yang sudah dilakukan).	

Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien dengan Pengkajian Awal Medis} \leq 24 \text{ Jam}}{\text{Jumlah Total pasien yang memerlukan pengkajian awal medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pemantauan dapat dilakukan secara manual oleh petugas rekam medis atau menggunakan sistem informasi rumah sakit (SIRS) untuk mengidentifikasi waktu pengisian pengkajian medis.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Pengkajian Awal Medis ≤ 24 Jam
Sampel	Pasien yang memerlukan pengkajian medis yang sesuai dengan kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Komite Medis Rumah Sakit 2. Komite Mutu Rumah Sakit 3. Kepala Bidang Pelayanan

15. Kepatuhan Penempelan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat

Judul Indikator	Angka Kepatuhan Penempatan Etiket Identitas Pasien pada Box Obat
Dasar pemikiran	Penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah salah satu langkah penting dalam memastikan keselamatan pasien terkait pemberian obat. Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal, terutama apabila obat yang diberikan tidak sesuai dengan identitas pasien yang tepat. Etiket identitas yang terpasang dengan benar pada box obat membantu tenaga medis untuk memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan pasien yang dimaksud, meminimalisir kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan dalam penempatan etiket identitas pasien pada box obat untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan pemberian obat.
Definisi Operasional	Angka kepatuhan penempatan etiket identitas pasien pada box obat adalah Prosentase jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku, dibandingkan dengan jumlah total box obat yang membutuhkan penempatan etiket.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah box obat yang telah ditempelkan etiket identitas pasien dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total box obat yang memerlukan penempelan etiket identitas pasien selama periode pengumpulan data..
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	

- Inklusi - Eksklusi	- Semua box obat yang akan diberikan kepada pasien di rumah sakit. - Box obat yang memerlukan penempatan etiket identitas pasien. - Semua unit layanan yang melibatkan pemberian obat (terutama rawat inap) - Box obat yang tidak perlu diberi etiket identitas pasien (misalnya, obat yang tidak dibagikan langsung ke pasien).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Box Obat dengan Etiket Identitas Pasien yang Tepat}}{\text{Jumlah Total box obat yang memerlukan etiket}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa rekam medis dan box obat yang akan diberikan pada pasien, untuk memastikan bahwa etiket identitas pasien ditempelkan dengan benar.
Sumber data	1. Formulir Pengecekan box obat dengan etiket Identitas Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pengawasan kepatuhan penempatan etiket identitas pasien
Sampel	Sampel acak box obat yang diperiksa selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Farmasi - Kepala Instalasi Rawat Inap - Komite Mutu Rumah Sakit - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan

3.3.7. Instalasi Kamar Operasi Bedah

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Penundaan Operasi Elektif ≥60 menit	≤5%	Indikator Mutu Nasional
5.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
7.	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical</i>	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran

	<i>safety checklist</i> sesuai standart		Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
8.	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)
9.	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Pelayanan Klinis Prioritas
10.	Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor	≥ 90 %	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Pelayanan Klinis Prioritas
11.	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Perbaikan Sistem
12.	Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Perbaikan Sistem
13.	Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Perbaikan Sistem
14.	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran	0 kejadian	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Manajemen Risiko
15.	Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Manajemen Risiko
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
16	Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)	100%	Unit
17	Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	100%	Standar Pelayanan Minimal (SPM)
18	Kejadian Kematian di meja Operasi	0 kejadian	Unit
19	Kejadian operasi salah sisi	0 kejadian	Unit
20	Kejadian operasi salah orang	0 kejadian	Unit
21	Kejadian salah tindakan pada operasi	0 kejadian	Unit
22	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	0 kejadian	Unit

3.3.7.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Kamar Operasi Bedah

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
-----------------	-------------------------------

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien.

	b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assesment awal risiko jatuh b. Assesment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh.

Eksklusi	1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Penundaan Operasi Elektif ≥60 menit

Judul Indikator	Penundaan Operasi Elektif
Dasar pemikiran	1. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Rumah sakit harus menjamin ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan termasuk tindakan operasi, sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mendapatkan hasil pelayanan seperti yang diinginkan dan menghindari komplikasi akibat keterlambatan operasi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Menilai jumlah dan penyebab penundaan operasi elektif, serta meningkatkan manajemen waktu dan pengorganisasian jadwal operasi untuk meminimalkan penundaan yang tidak perlu, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan medis dan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Operasi elektif adalah operasi yang waktu pelaksanaannya terencana atau dapat dijadwalkan. 2. Penundaan operasi elektif adalah tindakan operasi yang tertunda lebih dari 1 jam dari jadwal operasi yang ditentukan
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari operasi elektif yang ditunda lebih dari 24 jam dari jadwal yang telah ditentukan.

Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda ≥ 1 jam
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien operasi elektif
Target Pencapaian	$\leq 5\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua operasi elektif yang dijadwalkan, baik yang bersifat minor maupun mayor. Penundaan operasi atas indikasi medis
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang jadwal operasinya tertunda} \geq 1 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien operasi elektif}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien yang dijadwalkan operasi dan data pelaksanaan operasi.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir penundaan operasi elektif
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Bedah

5. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	- Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	- Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. - Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. - Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. - Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran

	secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

6. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

7. Kepatuhan pelaksanaan *surgical safety checklist* sesuai standart

Judul Indikator	Kepatuhan pelaksanaan <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart
Dasar pemikiran	Surgical Safety Checklist (SSC) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam prosedur bedah. Keberhasilan pelaksanaan SSC dapat mengurangi kejadian adverse events, seperti infeksi, komplikasi, atau bahkan kematian pasca-operasi. Kepatuhan dalam melaksanakan checklist ini memiliki peran penting dalam mencapai standar keselamatan pasien yang tinggi. Oleh karena itu, pengukuran kepatuhan pelaksanaan SSC perlu dilakukan secara berkala.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan <i>Surgical Safety Checklist</i> di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang melaksanakan prosedur bedah untuk memastikan keselamatan pasien dan meminimalkan risiko kejadian yang tidak diinginkan selama atau setelah operasi.
Definisi Operasional	Kepatuhan dalam pelaksanaan Surgical Safety Checklist berarti bahwa setiap tahap dari checklist (pre-anestesi, pre-surgery, intra-surgery, dan post-surgery) telah dipenuhi dengan benar oleh semua pihak yang terlibat dalam prosedur bedah (dokter bedah, anestesi, perawat, dan tim medis lainnya).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator (pembilang)	Jumlah prosedur bedah yang dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap setiap tahapan dalam Surgical Safety Checklist.
Denominator (penyebut)	Jumlah total prosedur bedah yang dilaksanakan selama periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	- Semua jenis prosedur bedah yang dilaksanakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan terkait. - Prosedur bedah yang dilakukan dengan menggunakan checklist standar yang telah ditetapkan. - Kasus di mana pasien tidak dapat diawasi sesuai dengan standar (misalnya, pasien tidak sadar atau tidak dapat berkomunikasi).
Formula	$\frac{\text{Jumlah prosedur bedah yang sesuai dengan Surgical Safety Checklist}}{\text{Jumlah total prosedur bedah yang dilaksanakan selama periode pengumpulan data}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Surgical Safety Checklist Form yang digunakan selama prosedur bedah.
Sampel	Semua prosedur bedah yang dilakukan selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Instalasi Kamar Operasi - Kepala Bidang Pelayanan

8. Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi

Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilakukannya Penandaan pada Pasien Operasi
Dasar pemikiran	Penandaan pasien sebelum operasi adalah langkah kritis dalam memastikan keselamatan pasien dan mencegah kesalahan medis, seperti sisi operasi yang salah, organ yang salah, atau prosedur yang salah. Proses ini merupakan bagian dari standar prosedur operasi untuk menjamin identifikasi yang tepat dan menghindari kejadian yang dapat membahayakan pasien. Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk kematian. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengukur kejadian ini sebagai indikator keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi untuk memastikan pelaksanaan prosedur yang aman dan mematuhi standar keselamatan pasien.

Definisi Operasional	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi berarti bahwa tidak ada tanda yang jelas pada pasien untuk menunjukkan lokasi atau sisi yang tepat pada tubuh pasien yang akan dioperasi, atau tanda tersebut tidak sesuai dengan prosedur standar.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien sebelum prosedur bedah.
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien sebelum prosedur bedah.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani prosedur bedah yang memerlukan penandaan situs operasi (misalnya operasi dengan risiko kesalahan sisi atau lokasi). 2. Semua jenis prosedur bedah yang memerlukan penandaan sesuai dengan standar. 1. Kasus di mana pasien tidak dapat diawasi sesuai dengan standar (misalnya, pasien tidak sadar atau tidak dapat berkomunikasi).
Formula	Jumlah kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien sebelum prosedur bedah.
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Form <i>Checklist</i> supevisi
Sampel	Pasien yang menjalani prosedur bedah
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Kamar Operasi 2. Kepala Bidang Pelayanan

9. Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB

Judul Indikator	Ketepatan pemberian MgSO4 Pada Pasien PEB (Preeklampsia dan Eklampsia Berat)
Dasar pemikiran	Magnesium sulfat (MgSO4) adalah obat utama yang digunakan untuk mencegah kejang pada pasien dengan preeklampsia dan eklampsia berat. Pemberian MgSO4 yang tepat dosis dan waktunya sangat penting untuk mengurangi risiko kejang dan komplikasi serius lainnya yang dapat membahayakan ibu dan janin. Ketepatan dalam pemberian dosis MgSO4 sesuai dengan indikasi klinis merupakan faktor krusial dalam meningkatkan keselamatan pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap ketepatan pemberian MgSO4 untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi yang sesuai dengan kondisi medisnya.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur ketepatan pemberian Magnesium Sulfat (MgSO ₄) pada pasien dengan Preeklampsia dan Eklampsia Berat untuk memastikan bahwa pemberian obat sesuai dengan pedoman klinis yang ditetapkan, guna meningkatkan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Ketepatan pemberian MgSO ₄ pada pasien PEB adalah kesesuaian antara dosis, jenis pemberian (intravena atau intramuskular), waktu pemberian, dan indikasi klinis yang sesuai dengan protokol pengobatan yang ditetapkan oleh rumah sakit atau pedoman klinis nasional/internasional.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) ketepatan pemberian MgSO ₄ pada pasien preeklampsia dan eklampsia berat.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien dengan PEB yang menerima dosis dan cara pemberian MgSO ₄ sesuai dengan pedoman klinis yang berlaku.
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien dengan PEB yang diberikan MgSO ₄ selama periode analisis.
Target Pencapaian	100% pasien dengan PEB yang diberikan MgSO ₄ sesuai dengan pedoman klinis yang berlaku.
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang didiagnosis dengan preeklampsia berat atau eklampsia berat yang memerlukan pemberian MgSO ₄ . 2. Semua pasien yang menerima MgSO ₄ di rumah sakit sesuai dengan protokol yang berlaku. 3. Pasien yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit pada periode analisis. 1. Pasien yang tidak memenuhi kriteria diagnosis PEB (misalnya, hipertensi ringan atau pasien dengan kondisi medis lain yang kontraindikasi terhadap MgSO ₄). 2. Pasien yang menolak pemberian MgSO ₄ atau memiliki alergi terhadap MgSO ₄ . 3. Pasien yang mendapatkan pengobatan di luar protokol rumah sakit.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien dengan PEB yang menerima dosis dan cara pemberian MgSO}_4 \text{ sesuai dengan pedoman klinis yang berlaku}}{\text{Jumlah total pasien dengan PEB yang diberikan MgSO}_4 \text{ selama periode analisis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> Pemeriksaan rekam medis pasien untuk mengevaluasi apakah pemberian MgSO ₄ dilakukan sesuai dengan waktu, dosis, dan indikasi yang tepat.
Sumber data	Rekam medis pasien yang mencatat diagnosis, dosis, waktu, dan cara pemberian MgSO ₄ .
Instrumen Pengambilan Data	Formulir checklist pemberian MgSO ₄ untuk memeriksa dosis, cara pemberian, dan waktu yang tepat.
Sampel	Pasien yang terdiagnosis dengan preeklampsia berat atau eklampsia berat selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan

Penyajian Data	Analisis dilakukan setiap tiga bulan untuk evaluasi tren ketepatan pemberian MgSO4.
Penanggung Jawab	1. Kepala Instalasi Obstetri dan Ginekologi (Obgyn). 2. Tim medis yang menangani pasien dengan PEB (dokter, perawat, dan apoteker).

10. Ketepatan Indikasi dan Pelaksanaan Operasi Soft Tissue Tumor

Judul Indikator	Ketepatan Indikasi dan pelaksanaan operasi soft tissue tumor			
Dasar pemikiran	Tumor jaringan lunak (soft tissue tumor) adalah neoplasma yang berkembang di jaringan selain tulang, termasuk otot, lemak, pembuluh darah, dan jaringan ikat lainnya. Penanganan yang tepat dan sesuai indikasi pada pasien dengan tumor jaringan lunak sangat penting untuk memastikan hasil yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi pasca-operasi. Ketepatan indikasi dan pelaksanaan operasi menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan terapi dan prognosis pasien. Oleh karena itu, penting untuk memiliki indikator yang dapat memantau ketepatan keputusan medis dalam hal indikasi dan pelaksanaan operasi pada pasien tumor jaringan lunak.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan		☒ ☒ ☒	
Tujuan	Untuk mengukur ketepatan indikasi dan pelaksanaan operasi pada pasien dengan tumor jaringan lunak guna memastikan bahwa setiap keputusan medis dan tindakan bedah dilakukan berdasarkan bukti klinis yang tepat, serta meningkatkan hasil perawatan pasien.			
Definisi Operasional	Indikator ini mengukur Prosentase pasien tumor jaringan lunak yang menjalani operasi dengan indikasi yang tepat berdasarkan pedoman medis yang ada dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan standar teknik bedah.			
Jenis Indikator	Struktur ☒	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien dengan tumor jaringan lunak yang menjalani operasi dengan indikasi yang sesuai dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur medis yang ditetapkan.			
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien dengan diagnosis tumor jaringan lunak yang menjalani operasi dalam periode analisis.			
Target Pencapaian	Tingkat ketepatan indikasi dan pelaksanaan operasi $\geq 90\%$ dari total pasien yang menjalani operasi tumor jaringan lunak.			
Kriteria:				
• Inklusi	1. Pasien yang didiagnosis dengan tumor jaringan lunak yang memerlukan operasi berdasarkan indikasi medis. 2. Pasien yang menjalani operasi sebagai bagian dari pengobatan untuk tumor jaringan lunak. 3. Pasien yang memiliki dokumentasi medis lengkap mengenai indikasi dan pelaksanaan operasi.			
• Eksklusi	1. Pasien yang tidak menjalani operasi meskipun memiliki tumor jaringan lunak yang memerlukan intervensi bedah. 2. Pasien yang menolak operasi setelah mendapat penjelasan medis yang cukup 3. Kasus-kasus di mana ada kegagalan dokumentasi indikasi atau pelaksanaan operasi.			
Formula	Jumlah Pasien dengan indikasi dan pelaksanaan operasi yang tepat $\times 100\%$			

	Jumlah Total Pasien yang Menjalani Operasi Tumor Jaringan Lunak
Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau rekam medis pasien, termasuk indikasi untuk operasi, laporan prosedur bedah, dan hasil pemeriksaan praoperatif.
Sumber data	1. Rekam medis pasien 2. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 3. Catatan medis bedah dan laporan prosedur
Instrumen Pengambilan Data	1. Checklist Asesmen Bedah untuk memverifikasi bahwa prosedur bedah sesuai dengan standar operasional dan teknik yang benar. 2. Rekam Medis dan Laporan Operasi untuk memastikan adanya dokumentasi yang lengkap tentang keputusan medis dan prosedur yang dilakukan.
Sampel	Sampel terdiri dari pasien yang menjalani operasi tumor jaringan lunak di rumah sakit atau klinik yang terlibat.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Dokter Spesialis Bedah 2. Kepala Instalasi Kamar Operasi 3. Kepala Bidang Pelayanan

11. Kejadian ketidaksesuaian diagnosa pre dan post operasi

Judul Indikator	Kejadian Ketidaksesuaian Diagnosa Pre dan Post Operasi			
Dasar pemikiran	Ketidaksesuaian diagnosa antara pre-operasi dan post-operasi dapat mengarah pada penanganan medis yang tidak tepat, yang berpotensi menambah komplikasi atau memperburuk kondisi pasien. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan dalam identifikasi diagnosis sebelum operasi yang tidak terdeteksi atau terverifikasi dengan benar selama prosedur bedah. Oleh karena itu, pengukuran kejadian ketidaksesuaian diagnosa sangat penting untuk meningkatkan akurasi dalam penanganan medis, meminimalkan kesalahan medis, dan meningkatkan keselamatan pasien.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒ ☒ ☒			
Tujuan	Mengukur jumlah kejadian ketidaksesuaian diagnosa antara pre-operasi dan post-operasi untuk memastikan akurasi dalam proses diagnosis dan penanganan pasien yang menjalani prosedur bedah.			
Definisi Operasional	Kejadian ketidaksesuaian diagnosa pre dan post operasi merujuk pada situasi di mana diagnosis yang diberikan sebelum operasi berbeda atau bertentangan dengan diagnosis yang ditemukan setelah prosedur bedah dilakukan, baik itu karena temuan klinis yang berbeda, diagnosis yang terlewat, atau kesalahan dalam interpretasi hasil pemeriksaan.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah Kejadian			

Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian ketidaksesuaian diagnosa antara pre-operasi dan post-operasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian ketidaksesuaian diagnosa antara pre-operasi dan post-operasi.
Target Pencapaian	0 kejadian ketidaksesuaian diagnosa pre dan post operasi.
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua pasien yang menjalani prosedur bedah yang memerlukan diagnosa medis yang jelas sebelum dan setelah operasi. - Semua jenis prosedur bedah yang memerlukan evaluasi medis yang komprehensif baik sebelum maupun setelah tindakan bedah. - Prosedur bedah darurat yang dilakukan tanpa evaluasi diagnosa yang lengkap sebelum operasi. - Pasien dengan kondisi yang sangat kompleks atau tidak dapat dievaluasi secara komprehensif karena keterbatasan kondisi medis (misalnya pasien dengan gangguan mental atau ketidaksadaran).
Formula	Jumlah kejadian ketidaksesuaian diagnosa antara pre-operasi dan post-operasi.
Metode Pengumpulan Data	Audit medis yang dilakukan oleh tim audit klinis untuk memeriksa konsistensi diagnosis antara fase pre dan post operasi.
Sumber data	- Rekam medis pasien (diagnosa pre dan post operasi). - Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	- Formulir audit medis untuk mendokumentasikan temuan diagnosa pre dan post operasi. <i>Checklist</i> verifikasi diagnosa oleh tim audit untuk memastikan semua data diagnosa diverifikasi dengan benar.
Sampel	Semua pasien yang menjalani prosedur bedah yang terpilih selama periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Dokter Spesialis Bedah - Kepala Instalasi Kamar Operasi - Kepala Bidang Pelayanan

12. Angka kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO

Judul Indikator	Angka Kelengkapan Laporan Operasi yang Dilakukan di IKO
Dasar pemikiran	Laporan operasi yang lengkap adalah salah satu faktor kunci dalam proses perawatan dan pengobatan pasien setelah prosedur bedah. Kelengkapan laporan operasi penting untuk mendokumentasikan semua informasi terkait prosedur yang dilakukan, komplikasi yang mungkin terjadi, serta rencana perawatan lanjutan. Laporan yang tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahan dalam perawatan pasca-operasi, mempengaruhi kualitas komunikasi antar tim medis, dan berisiko bagi keselamatan pasien. Oleh karena itu, pengukuran angka kelengkapan laporan operasi di Instalasi Khusus Operasi (IKO) merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dokumentasi medis.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kelengkapan laporan operasi yang dilakukan di IKO untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperlukan dalam laporan tercatat dengan akurat dan sesuai standar.
Definisi Operasional	Angka kelengkapan laporan operasi merujuk pada Prosentase laporan operasi yang mencakup semua elemen penting sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti identifikasi pasien, diagnosis, jenis tindakan, hasil prosedur, komplikasi (jika ada), dan rencana perawatan pasca-operasi.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kelengkapan laporan operasi
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan operasi yang lengkap sesuai dengan elemen-elemen yang diperlukan.
Denominator (penyebut)	Jumlah total laporan operasi yang dilakukan di IKO selama periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua laporan operasi yang dilakukan di Instalasi Kamar Operasi (IKO) selama periode yang ditentukan. 2. Semua jenis prosedur bedah yang memerlukan dokumentasi lengkap, baik bedah mayor maupun minor. 1. Laporan yang tidak dapat diverifikasi oleh tim audit medis.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Laporan Operasi yang lengkap}}{\text{Jumlah Total Laporan Operasi pada periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis untuk memastikan apakah setiap elemen laporan tercatat sesuai dengan standar.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Rekam Medis Pasien yang Mencatat Setiap Langkah dalam Prosedur Bedah
Instrumen Pengambilan Data	1. <i>Checklist</i> atau formulir audit yang memeriksa kelengkapan laporan operasi berdasarkan standar yang berlaku (misalnya, mencakup data pasien, diagnosa, tindakan bedah, hasil operasi, komplikasi, dan rencana perawatan pasca-operasi).
Sampel	Semua laporan operasi yang terpilih selama periode audit atau sampel acak jika periode audit sangat panjang.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Dokter Spesialis Bedah 2. Kepala Instalasi Kamar Operasi 3. Kepala Bidang Pelayanan

13. Angka kelengkapan asesmen pra bedah sebelum operasi

Judul Indikator	Angka Kelengkapan Asesmen Pra Bedah Sebelum Operasi
Dasar pemikiran	Asesmen pra bedah adalah langkah penting untuk memastikan kondisi pasien sebelum menjalani tindakan operasi. Kelengkapan asesmen ini membantu tim medis dalam pengambilan keputusan klinis yang aman dan rasional, serta mengurangi risiko komplikasi intra dan pasca bedah. Monitoring kelengkapan asesmen mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengetahui Prosentase kelengkapan pengkajian pra bedah sebagai dasar perbaikan mutu layanan bedah dan peningkatan keselamatan pasien
Definisi Operasional	Asesmen pra bedah dikatakan lengkap jika seluruh elemen yang disyaratkan telah diisi dan ditandatangani oleh tenaga kesehatan yang berwenang (dokter operator, perawat, dan anastesi) sebelum pelaksanaan tindakan operasi.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kelengkapan laporan operasi
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memiliki asesmen pra bedah yang lengkap sebelum operasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang menjalani tindakan operasi elektif pada periode pengumpulan data.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Pasien yang menjalani operasi elektif.
• Eksklusi	1. Pasien tindakan bedah emergensi. 2. Pasien pulang atas permintaan sendiri sebelum tindakan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Asesmen pasien yang lengkap}}{\text{Jumlah Total pasien operasi elektif periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen rekam medis pasien yang menjalani tindakan operasi.
Sumber data	1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 2. Daftar operasi dari kamar bedah
Instrumen Pengambilan Data	1. Checklist audit asesmen pra bedah 2. Formulir rekapitulasi data indikator mutu
Sampel	Bila jumlah terlalu besar, gunakan teknik sampling acak minimal 30 rekam medis per bulan.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Dokter Spesialis Bedah 2. Kepala Instalasi Kamar Operasi 3. Kepala Bidang Pelayanan

14. Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran

Judul Indikator	Kejadian Pasien Operasi yang Terluka Akibat Alat Kedokteran
-----------------	---

Dasar pemikiran	Penggunaan alat kedokteran dalam tindakan operasi merupakan hal yang esensial, namun memiliki potensi risiko cedera pada pasien jika tidak digunakan dengan tepat. Cedera akibat alat kedokteran (seperti luka potong, luka bakar, tusukan, kompresi, atau trauma lainnya) merupakan bentuk insiden keselamatan pasien yang dapat dicegah. Pemantauan indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan tim bedah dan memastikan penerapan standar keamanan dalam penggunaan alat medis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur dan memantau jumlah kejadian cedera pada pasien operasi akibat penggunaan alat kedokteran, sebagai dasar perbaikan sistem dan pencegahan kejadian berulang.
Definisi Operasional	Kejadian pasien operasi yang terluka akibat alat kedokteran adalah setiap luka atau cedera baru yang terjadi pada pasien selama proses pembedahan (pra, intra, atau pasca operasi di kamar operasi) yang disebabkan oleh alat medis seperti pisau bedah, kauter, aspirator, retraktor, lampu operasi, atau alat lainnya.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien operasi yang mengalami cedera atau luka akibat alat kedokteran selama proses operasi dalam satu periode tertentu.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang menjalani operasi (elektif dan emergensi) dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan operasi (elektif dan emergensi) 2. Cedera terjadi selama proses operasi, termasuk persiapan dan penutupan luka 1. Cedera atau luka yang sudah ada sebelum tindakan operasi 2. Komplikasi luka operasi yang bukan disebabkan langsung oleh alat kedokteran (misalnya infeksi, dehisensi)
Formula	Jumlah pasien terluka akibat alat kedokteran
Metode Pengumpulan Data	Identifikasi dari laporan insiden keselamatan pasien
Sumber data	1. Laporan insiden keselamatan pasien
Instrumen Pengambilan Data	1. Formulir laporan insiden 2. Checklist audit keselamatan operasi
Sampel	Total sampling terhadap seluruh pasien operasi dalam periode pengumpulan data
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	1. Dokter Spesialis Bedah 2. Kepala Instalasi Kamar Operasi 3. Kepala Bidang Pelayanan
------------------	--

15. Kepatuhan maintenance alat medis di IKO sesuai jadwal

Judul Indikator	Kepatuhan Maintenance Alat Medis di IKO Sesuai Jadwal			
Dasar pemikiran	Alat medis di kamar operasi memiliki peran krusial dalam menunjang keberhasilan tindakan pembedahan dan keselamatan pasien. Maintenance (pemeliharaan) rutin yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai jadwal sangat penting untuk memastikan fungsi alat tetap optimal, mencegah kerusakan saat digunakan, dan menghindari insiden yang tidak diharapkan. Monitoring indikator ini membantu memastikan bahwa unit terkait menjalankan program pemeliharaan preventif secara disiplin.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi	☒		
	2. Efektivitas	☒		
	3. Aksesibilitas	☒		
	4. Keselamatan	☒		
	5. Fokus kepada pasien			
	6. Kesiambungan			
Tujuan	Tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap jadwal <i>maintenance</i> preventif alat medis di IKO guna menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan alat medis serta keselamatan pasien			
Definisi Operasional	Kepatuhan pelaksanaan <i>maintenance</i> preventif alat medis adalah Prosentase alat medis yang telah dilakukan <i>maintenance</i> preventif sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh unit pemeliharaan sarana prasarana (IPSRs) atau pihak ketiga yang ditunjuk, dalam periode waktu tertentu. Alat medis di sini mencakup seluruh peralatan medis yang digunakan di IKO yang memiliki jadwal <i>maintenance</i> preventif rutin (misalnya, mesin anestesi, lampu operasi, meja operasi, elektrokauter, monitor pasien, dll.)			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	☒	Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah alat medis di IKO yang telah dilakukan <i>maintenance</i> preventif sesuai jadwal pada periode tertentu.			
Denominator (penyebut)	Total jumlah alat medis di IKO yang seharusnya dilakukan <i>maintenance</i> preventif pada periode yang sama.			
Target Pencapaian	100%			
Kriteria:				
• Inklusi	1. Semua alat medis yang berada di lingkungan IKO. 2. Alat medis yang memiliki jadwal <i>maintenance</i> preventif rutin yang telah ditetapkan			
• Eksklusi	1. Alat medis yang sedang dalam perbaikan besar (<i>overhaul</i>) atau tidak dapat dioperasikan. 2. Alat medis yang sudah rusak total dan tidak dapat diperbaiki.			
Formula	Jumlah alat medis yang dilakukan maintenance sesuai jadwal 			

Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>checklist</i> atau lembar kerja pengumpul data yang mencatat status <i>maintenance</i> setiap alat medis berdasarkan jadwal.
Sampel	Seluruh alat medis yang berada di IKO dan memiliki jadwal <i>maintenance</i> preventif.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Grafik atau <i>line chart</i> untuk melihat tren dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Koordinator IKO (pengumpulan dan verifikasi data). 2. Kepala IPSRS (penyediaan data dan pelaksanaan <i>maintenance</i>). 3. Kepala Bidang Umum dan Keuangan (analisis dan pelaporan).

16. Kepatuhan pembersihan ruang IKO antar jeda waktu operasi (30 menit)

Judul Indikator	Kepatuhan Pembersihan Ruang Operasi di IKO Antar Jeda Waktu Operasi (Kurang dari 30 Menit)
Dasar pemikiran	Pembersihan ruang operasi secara cepat dan menyeluruh antar jeda operasi sangat krusial untuk memutus rantai infeksi dan mencegah penyebaran mikroorganisme patogen dari satu pasien ke pasien lain. Lingkungan yang bersih dan steril di IKO merupakan prasyarat utama untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas layanan bedah. Penundaan pembersihan dapat memperpanjang waktu tunggu pasien dan mengurangi efisiensi IKO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar waktu pembersihan ruang operasi di IKO antar jeda operasi untuk meminimalkan risiko infeksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang operasi
Definisi Operasional	Kepatuhan pembersihan ruang operasi antar jeda waktu operasi adalah Prosentase ruang operasi yang berhasil dibersihkan dan disiapkan kembali dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 menit setelah satu operasi selesai dan sebelum operasi berikutnya dimulai. Pembersihan mencakup dekontaminasi permukaan, pembuangan limbah, penggantian linen, dan persiapan area steril sesuai standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah jeda waktu antar operasi di IKO di mana pembersihan ruang operasi berhasil diselesaikan dalam waktu ≤ 30 menit pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	Total jumlah jeda waktu antar operasi yang diukur di IKO pada periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: Inklusi	1. Semua jeda waktu antar operasi (pergantian pasien) di seluruh ruang operasi IKO.

• Eksklusi	2. Pembersihan rutin setelah kasus bedah selesai (bukan pembersihan terminal/akhir hari)
	1. Kasus bedah yang membutuhkan pembersihan khusus atau dekontaminasi ekstensif (misalnya, kasus infeksi menular tertentu).
Formula	$\frac{\text{Jumlah jeda waktu operasi dengan pembersihan} \leq 30 \text{ menit}}{\text{Total jeda waktu operasi yang diukur}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan pencatatan waktu.
Sumber data	1. Logbook/Catatan Waktu Operasi IKO (waktu <i>out</i> pasien sebelumnya dan waktu <i>in</i> pasien berikutnya). 2. Formulir Observasi Pembersihan Ruang Operasi.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>checklist</i> observasi yang mencatat waktu mulai dan selesai pembersihan, serta identitas ruang operasi dan tanggal.
Sampel	Minimal 30 observasi jeda waktu operasi per bulan secara acak di ruang operasi IKO
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Grafik atau <i>line chart</i> untuk melihat tren dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Koordinator IKO (pengumpulan data). 2. Kepala Ruang Operasi (Pengumpul data observasi) 3. Komite PPI (Monitoring Kepatuhan SPO Kebersihan)

17. Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari

Judul Indikator	Waktu Tunggu Operasi Elektif ≤ 2 Hari
Dasar pemikiran	Waktu tunggu operasi yang terlalu lama dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis pasien, memperburuk kondisi penyakit tertentu, serta mengurangi efisiensi dan kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Penentuan target waktu tunggu operasi elektif (non-darurat) merupakan salah satu indikator penting dalam manajemen antrean bedah yang menunjukkan efisiensi proses pendaftaran hingga pelaksanaan operasi, serta ketersediaan sumber daya (dokter, perawat, ruang operasi). Standar waktu tunggu yang singkat menunjukkan tata kelola yang baik dan berorientasi pada pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya waktu tunggu operasi elektif yang singkat, yaitu ≤ 2 hari, untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan bedah, efisiensi penjadwalan, dan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	Waktu tunggu operasi elektif adalah rentang waktu dalam hari, dihitung mulai dari saat pasien dinyatakan siap operasi (persetujuan tindakan bedah, hasil pemeriksaan penunjang lengkap, dan jadwal operasi telah disepakati) hingga pasien menjalani tindakan operasi di IKO. Operasi elektif adalah tindakan bedah yang direncanakan dan tidak bersifat darurat, memungkinkan pasien untuk mempersiapkan diri.

Jenis Indikator	Struktur	Proses	☑	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)				
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien operasi elektif yang menjalani tindakan operasi dalam waktu ≤ 2 hari sejak pasien dinyatakan siap operasi pada periode tertentu				
Denominator (penyebut)	Total jumlah pasien operasi elektif pada periode yang sama				
Target Pencapaian	100%				
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang terdaftar untuk operasi elektif di IKO. 2. Pasien yang telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan pra-operasi dan dinyatakan <i>fit</i> untuk operasi oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan dokter anestesi.				
	1. Pasien operasi <i>cito</i> (darurat). 2. Pasien yang menunda operasi atas permintaan sendiri atau keluarga.				
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien operasi elektif dengan waktu tunggu} \leq 2 \text{ hari}}{\text{Total pasien operasi elektif}} \times 100\%$				
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (menggunakan data rekam medis dan jadwal operasi).				
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien. 2. Buku Register Operasi IKO.				
Instrumen Pengambilan Data	Tanggal pasien dinyatakan siap operasi (misalnya, tanggal persetujuan operasi ditandatangani dan kelengkapan pra-operasi).				
Sampel	Seluruh populasi pasien operasi elektif pada periode pengumpulan data. Jika populasi sangat besar, dapat diambil sampel acak yang representatif (misalnya, 30-50 kasus per bulan)				
Periode pengumpulan data	Bulanan				
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan				
Penyajian data	Grafik atau <i>line chart</i> untuk melihat tren dari waktu ke waktu.				
Penanggung Jawab	1. Koordinator IKO (pengumpulan data). 2. Kepala Ruang Operasi (Pengumpul data observasi)				

18. Kejadian Kematian di meja Operasi

Judul Indikator	Kejadian Kematian di Meja Operasi
Dasar pemikiran	Kematian di meja operasi merupakan indikator sentinel yang menunjukkan adanya risiko tinggi atau komplikasi serius selama prosedur bedah. Kejadian ini memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah, baik yang berkaitan dengan kondisi pasien, proses pra-operasi, teknik bedah, anestesi, ketersediaan alat, atau respon tim. Pemantauan indikator ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan di Instalasi Kamar Operasi (IKO). Meskipun angka ini idealnya nol, kejadian ini tetap dipantau untuk pembelajaran dan perbaikan sistem.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menurunkan angka kejadian kematian di meja operasi hingga mencapai standar yang aman dan dapat diterima, serta mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut untuk perbaikan berkelanjutan.
Definisi Operasional	Kematian di meja operasi adalah kondisi meninggalnya pasien selama tindakan operasi berlangsung atau dalam waktu 24 jam setelah operasi selesai, yang terjadi di dalam area IKO atau saat pasien masih dalam pengawasan langsung tim bedah/anestesi di IKO. Kejadian ini harus dibedakan dari kematian pasca-operasi yang terjadi setelah pasien dipindahkan dari IKO (misalnya, di ruang rawat inap atau ICU setelah 24 jam).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang meninggal di meja operasi pada periode tertentu
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah di IKO. 1. Kematian pasien yang terjadi sebelum tindakan operasi dimulai. 2. Kematian pasien yang terjadi setelah 24 jam pasca-operasi dan pasien sudah dipindahkan ke luar IKO.
Formula	Jumlah pasien yang meninggal di meja operasi pada periode tertentu
Metode Pengumpulan Data	laporan insiden/kejadian sentinel
Sumber data	1. Formulir Laporan Kematian/Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Google spreadsheet
Sampel	Seluruh populasi pasien yang menjalani operasi pada periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Laporan individual untuk setiap kasus insiden (RCA), mencakup faktor-faktor penyebab dan rekomendasi perbaikan.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

19. Kejadian operasi salah sisi

Judul Indikator	Kejadian Operasi Salah Sisi
-----------------	-----------------------------

Dasar pemikiran	Operasi salah sisi adalah salah satu <i>never event</i> atau insiden keselamatan pasien yang sangat serius dan tidak seharusnya terjadi. Kejadian ini dapat mengakibatkan cedera permanen, kecacatan, bahkan kematian pada pasien, serta merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit. Pemantauan ketat terhadap indikator ini, disertai dengan analisis akar masalah yang mendalam (<i>Root Cause Analysis</i> - RCA) untuk setiap insiden, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan bedah universal (misalnya, <i>time out</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Menghilangkan kejadian operasi salah sisi di Instalasi Kamar Operasi (IKO) melalui implementasi dan pengawasan ketat terhadap protokol keselamatan bedah, sehingga menjamin keselamatan dan hak pasien.
Definisi Operasional	Kejadian operasi salah sisi adalah tindakan bedah yang dilakukan pada bagian tubuh atau ekstremitas yang salah (misalnya, operasi pada kaki kiri padahal seharusnya kaki kanan) dari pasien yang seharusnya dioperasi. Kejadian ini dianggap sebagai <i>never event</i> dan membutuhkan investigasi menyeluruh.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus kejadian operasi salah sisi yang terjadi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah di IKO, baik elektif maupun cito. 1. Prosedur non-invasif yang tidak melibatkan sayatan bedah (misalnya, pemasangan kateter).
Formula	Jumlah kasus kejadian operasi salah sisi yang terjadi pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	laporan insiden/kejadian sentinel
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / Laporan <i>Sentinel Event</i> .
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden.
Sampel	Seluruh populasi operasi yang dilakukan di IKO pada periode pengumpulan data. Setiap kejadian harus segera dilaporkan.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Laporan individual untuk setiap kasus insiden (RCA), mencakup faktor-faktor penyebab dan rekomendasi perbaikan.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP

	3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan
--	--

20. Kejadian operasi salah orang

Judul Indikator	Kejadian Operasi Salah Orang
Dasar pemikiran	Operasi salah orang adalah salah satu <i>never event</i> atau insiden keselamatan pasien yang paling parah dan tidak dapat diterima. Kejadian ini mencerminkan kegagalan fundamental dalam proses identifikasi pasien dan verifikasi pra-operasi, yang dapat menyebabkan konsekuensi fatal bagi pasien yang seharusnya dioperasi dan juga bagi pasien yang salah dioperasi. Pemantauan ketat indikator ini, disertai dengan investigasi mendalam (<i>Root Cause Analysis</i> - RCA) untuk setiap insiden, sangat penting untuk memperkuat sistem identifikasi pasien dan memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan bedah universal
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Menghilangkan kejadian operasi salah orang di Instalasi Kamar Operasi (IKO) melalui implementasi dan pengawasan ketat terhadap prosedur identifikasi pasien yang akurat dan verifikasi sebelum tindakan bedah.
Definisi Operasional	Kejadian operasi salah orang adalah situasi di mana tindakan bedah dilakukan pada pasien yang bukan merupakan individu yang seharusnya menjalani operasi tersebut, atau pasien yang seharusnya dioperasi tidak dioperasi. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam proses identifikasi pasien di berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran hingga verifikasi di IKO.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus kejadian operasi salah sisi yang terjadi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah di IKO, baik elektif maupun cito. 1. Kesalahan identifikasi pasien yang tidak menyebabkan tindakan bedah pada orang yang salah (misalnya, hanya kesalahan penulisan nama di dokumen).
Formula	Jumlah kasus kejadian operasi salah sisi yang terjadi pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	laporan insiden/kejadian sentinel
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / Laporan <i>Sentinel Event</i> .
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden.
Sampel	Seluruh populasi operasi yang dilakukan di IKO pada periode pengumpulan data. Setiap kejadian harus segera dilaporkan.

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Laporan individual untuk setiap kasus insiden (RCA), mencakup faktor-faktor penyebab dan rekomendasi perbaikan.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

21. Kejadian salah tindakan pada operasi

Judul Indikator	Kejadian Salah Tindakan pada Operasi
Dasar pemikiran	Kejadian salah tindakan pada operasi adalah <i>never event</i> yang serius dan menunjukkan kegagalan dalam proses verifikasi prosedur bedah yang akan dilakukan. Insiden ini dapat mengakibatkan cedera serius, komplikasi, bahkan kematian pada pasien, serta menimbulkan kerugian materi dan non-materi bagi pasien dan rumah sakit. Pemantauan indikator ini secara ketat, disertai dengan investigasi mendalam (<i>Root Cause Analysis</i> - RCA) untuk setiap kejadian, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan bedah universal (misalnya, <i>time out</i>) dan memastikan bahwa pasien menerima prosedur yang benar sesuai dengan rencana tindakan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Menghilangkan kejadian salah tindakan pada operasi di Instalasi Kamar Operasi (IKO) melalui implementasi dan pengawasan ketat terhadap verifikasi prosedur bedah, sehingga menjamin keselamatan dan hak pasien.
Definisi Operasional	Kejadian salah tindakan pada operasi adalah situasi di mana prosedur bedah yang dilakukan di IKO tidak sesuai dengan rencana tindakan yang telah disepakati dan diverifikasi, atau tindakan bedah yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang diindikasikan untuk kondisi pasien tersebut. Ini berbeda dengan salah sisi atau salah orang. Contohnya termasuk melakukan appendektomi padahal seharusnya kolesistektomi, atau melakukan prosedur yang lebih invasif dari yang disepakati tanpa alasan medis yang jelas dan tanpa persetujuan baru.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus kejadian salah tindakan pada operasi yang terjadi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: Inklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah di IKO, baik elektif maupun <i>cito</i> .
Eksklusi	1. Komplikasi yang terjadi akibat tindakan yang benar

	(misalnya, perdarahan yang merupakan risiko dari prosedur yang sudah benar).
Formula	Jumlah kasus kejadian salah tindakan pada operasi yang terjadi pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	laporan insiden/kejadian sentinel
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / Laporan <i>Sentinel Event</i> .
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden.
Sampel	Seluruh populasi operasi yang dilakukan di IKO pada periode pengumpulan data. Setiap kejadian harus segera dilaporkan
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Laporan individual untuk setiap kasus insiden (RCA), mencakup faktor-faktor penyebab dan rekomendasi perbaikan.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

22. Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

Judul Indikator	Kejadian Tertinggalnya Benda Asing pada Tubuh Pasien Setelah Operasi
Dasar pemikiran	Tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi (<i>Retained Surgical Item</i> - RSI) adalah salah satu <i>never event</i> yang paling serius dan dapat dicegah dalam pelayanan bedah. Insiden ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti infeksi, nyeri kronis, pembentukan abses, perforasi organ, perlunya operasi ulang, bahkan kematian. Kejadian ini juga berdampak besar pada kepercayaan pasien dan reputasi rumah sakit. Pemantauan ketat indikator ini dan investigasi mendalam (<i>Root Cause Analysis</i> - RCA) untuk setiap insiden sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol keselamatan bedah, terutama prosedur hitung instrumen, kasa, dan jarum, serta penggunaan pencitraan intraoperatif bila diperlukan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiinambungan
Tujuan	Menghilangkan kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi di Instalasi Kamar Operasi (IKO) melalui implementasi dan pengawasan ketat terhadap prosedur hitung instrumen, kasa, dan jarum, serta <i>time out</i> yang efektif.
Definisi Operasional	Kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi adalah ditemukannya benda asing (misalnya, kasa, <i>sponge</i> , instrumen bedah, jarum, fragmen kateter) di dalam tubuh pasien setelah prosedur bedah selesai dan insisi kulit telah ditutup. Benda asing ini dapat terdeteksi segera setelah operasi (misalnya, melalui X-ray sebelum pasien meninggalkan IKO) atau baru ditemukan di kemudian hari (misalnya, setelah pasien pulang, melalui keluhan pasien dan pemeriksaan

	pencitraan).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah di IKO, baik elektif maupun <i>cito</i> . 1. Benda asing yang sengaja ditinggalkan untuk tujuan terapeutik (misalnya, drain, stent, implan, kateter, <i>packing</i> yang direncanakan dan didokumentasikan).
Formula	Jumlah kasus kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	Pelaporan insiden (pasif) dan retrospektif dari rekam medis atau laporan audit internal jika ditemukan.
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / Laporan <i>Sentinel Event</i> . 2. Hasil investigasi RCA jika insiden terjadi. 3. Laporan keluhan pasien atau hasil pemeriksaan ulang.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden.
Sampel	Seluruh populasi operasi yang dilakukan di IKO pada periode pengumpulan data. Setiap kejadian harus segera dilaporkan
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Laporan individual untuk setiap kasus insiden (RCA), mencakup faktor-faktor penyebab dan rekomendasi perbaikan.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

3.3.8.Instalasi Kamar Operasi Anestesi

3.3.8.1 Profil Indikator Mutu Instalasi Kamar Operasi Bedah

INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi Sesuai SPO	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
2.	Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis	≤ 6 %	Unit
3.	Kejadian reaksi anestesi	≤ 6 %	Unit

4.	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	Unit
5.	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	Unit
6.	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	Unit
7.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	Unit
8.	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	Unit

1. Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi

Judul Indikator	Kepatuhan Pemusnahan Obat Sisa Anestesi Sesuai SPO
Dasar pemikiran	Obat sisa anestesi, terutama narkotika dan psikotropika, merupakan golongan obat yang memiliki potensi penyalahgunaan dan dampak negatif jika tidak dikelola dengan benar. Pemusnahan obat sisa anestesi yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan risiko hukum, risiko lingkungan, dan risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Kepatuhan terhadap prosedur pemusnahan yang benar sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur pemusnahan obat sisa anestesi, terutama golongan narkotika dan psikotropika, untuk mencegah penyalahgunaan, memastikan keamanan, dan memenuhi regulasi yang berlaku.
Definisi Operasional	Kepatuhan pemusnahan obat sisa anestesi adalah Prosentase formulir pemusnahan obat sisa anestesi (khususnya narkotika dan psikotropika) yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dua orang saksi (sesuai SPO yang berlaku, biasanya perawat anestesi dan perawat sirkuler/kepala ruangan) dan dilakukan segera setelah prosedur selesai atau sesuai jadwal yang ditentukan, pada periode tertentu.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah <i>form</i> pemusnahan obat sisa anestesi narkotika/psikotropika yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dua saksi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	Total <i>form</i> penggunaan obat anestesi narkotika/psikotropika yang membutuhkan pemusnahan sisa pada periode yang sama.
Target Pencapaian	100%

Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua kasus operasi di IKO yang menggunakan obat anestesi golongan narkotika atau psikotropika. 2. Setiap kali ada sisa obat anestesi golongan narkotika/psikotropika yang harus dimusnahkan.
	1. Obat anestesi yang habis terpakai dan tidak ada sisa untuk dimusnahkan. 2. Obat anestesi selain golongan narkotika dan psikotropika yang tidak memerlukan pemusnahan khusus sesuai regulasi.
Formula	$\frac{\text{Jumlah form pemusnahan obat sisa anestesi yang patuh}}{\text{Jumlah Total Form Penggunaan Obat Anestesi yang butuh dilakukan pemusnahan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dari dokumentasi rekam medis dan <i>form</i> pemusnahan obat
Sumber data	1. Buku register penggunaan obat anestesi/logbook obat narkotika/psikotropika. 2. Formulir pemusnahan obat sisa anestesi.
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> atau lembar kerja pengumpul data yang mencatat kelengkapan <i>form</i> pemusnahan (ada <i>form</i> , lengkap, ada tanda tangan dua saksi).
Sampel	Seluruh populasi penggunaan obat anestesi narkotika/psikotropika yang menghasilkan sisa dan memerlukan pemusnahan pada periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Petugas Farmasi (penyediaan <i>form</i> , verifikasi, dan monitoring stok obat). 3. Komite PMKP 4. Kepala Bidang Pelayanan 5. Kepala Bidang Penunjang

2. Kejadian komplikasi anestesi karena overdosis

Judul Indikator	Kejadian Komplikasi Anestesi Akibat Overdosis Obat
Dasar pemikiran	Komplikasi anestesi akibat overdosis obat merupakan insiden keselamatan pasien yang serius (<i>serious adverse event</i>) yang dapat menyebabkan morbiditas signifikan, kerusakan organ permanen, atau bahkan kematian. Kejadian ini mencerminkan kegagalan dalam proses perhitungan dosis, verifikasi obat, atau pemantauan pasien selama anestesi. Pemantauan ketat indikator ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, meningkatkan praktik pemberian anestesi yang aman, serta melindungi keselamatan pasien di Instalasi Kamar Operasi (IKO).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menekan angka kejadian komplikasi anestesi akibat overdosis obat hingga seminimal mungkin (mendekati nol) melalui

	peningkatan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional (SPO) pemberian obat, perhitungan dosis yang akurat, verifikasi ganda, dan pemantauan ketat pasien selama anestesi.
Definisi Operasional	Komplikasi anestesi akibat overdosis obat adalah timbulnya efek samping atau reaksi merugikan yang signifikan pada pasien, yang secara klinis dapat dikaitkan dengan pemberian dosis obat anestesi (misalnya, anestesi umum, regional, lokal, sedasi) yang melebihi batas terapeutik yang direkomendasikan untuk kondisi pasien tersebut. Komplikasi ini harus didokumentasikan dengan jelas dalam rekam medis dan dievaluasi oleh dokter anestesi sebagai akibat langsung dari overdosis. Contoh komplikasi meliputi depresi pernapasan berat yang memerlukan resusitasi berkepanjangan, hipotensi berat yang tidak responsif, aritmia jantung yang mengancam jiwa, atau koma yang tidak sesuai dengan durasi obat.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus pasien yang mengalami komplikasi anestesi akibat overdosis obat pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua pasien yang menjalani tindakan anestesi di IKO. - Terjadi komplikasi yang secara klinis didiagnosis oleh dokter anestesi sebagai akibat dari overdosis obat anestesi. - Komplikasi yang terjadi akibat kondisi pra-anestesi pasien yang sudah buruk atau penyakit penyerta yang mendasari (misalnya, gagal jantung mendadak yang tidak berhubungan langsung dengan dosis obat).
Formula	Jumlah kasus pasien yang mengalami komplikasi anestesi akibat overdosis obat pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dari rekam medis dan laporan insiden.
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden untuk setiap kejadian yang ditemukan.
Sampel	Seluruh populasi pasien yang menjalani anestesi di IKO pada periode pengumpulan data. Setiap kejadian harus dilaporkan.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala Ruang IKO - Komite PMKP - Kepala Bidang Pelayanan - Kepala Bidang Keperawatan

3. Kejadian reaksi anestesi

Judul Indikator	Kejadian Reaksi Anestesi (Efek Samping dan Reaksi Obat Anestesi)
Dasar pemikiran	Reaksi anestesi, meskipun seringkali tidak dapat sepenuhnya dicegah karena variasi respons individu pasien terhadap obat, tetap menjadi fokus penting dalam keselamatan pasien. Pemantauan kejadian reaksi anestesi membantu tim medis memahami pola reaksi, mengidentifikasi obat atau teknik yang mungkin memicu reaksi tertentu, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan respon terhadap kejadian tersebut. Data ini sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam praktik anestesi dan pemilihan regimen anestesi yang lebih aman.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Memantau dan mengidentifikasi jenis serta frekuensi kejadian reaksi anestesi yang tidak diinginkan, guna meningkatkan kewaspadaan, manajemen risiko, dan pengembangan protokol untuk meminimalkan dampak reaksi tersebut pada pasien.
Definisi Operasional	Reaksi anestesi adalah setiap respons atau efek yang tidak diinginkan dan tidak terduga pada pasien yang timbul sebagai akibat langsung dari pemberian obat atau teknik anestesi (umum, regional, lokal, sedasi). Reaksi ini harus didokumentasikan dengan jelas oleh dokter anestesi atau perawat anestesi yang bertugas. Contoh reaksi meliputi: • Reaksi alergi/anafilaksis: Gatal-gatal, ruam, bronkospasme, hipotensi, syok. • Hipotensi/Hipertensi mendadak: Penurunan atau peningkatan tekanan darah yang signifikan dan membutuhkan intervensi. • Bradikardia/Takikardia: Gangguan irama jantung yang signifikan. • Mual dan muntah pasca-operasi (PONV) berat: Mual/muntah yang memerlukan intervensi farmakologis berulang atau menyebabkan komplikasi (misalnya, dehidrasi, aspirasi). • Depresi pernapasan/apnea berkepanjangan: Membutuhkan ventilasi bantuan lebih lama dari yang diharapkan. • Hipertermia Maligna (susp. atau terkonfirmasi): Peningkatan suhu tubuh yang cepat dan ekstrem. • Reaksi <i>drug-specific</i> lainnya: Misalnya, sindrom shivering hebat, <i>awareness</i> intraoperatif.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami reaksi anestesi yang terdokumentasi pada periode tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi	1. Semua pasien yang menjalani prosedur anestesi di IKO. 2. Pasien yang mengalami salah satu atau lebih dari reaksi anestesi yang didefinisikan secara klinis dan terdokumentasi.

• Eksklusi	1. Komplikasi yang jelas-jelas bukan akibat obat atau teknik anestesi (misalnya, perdarahan akibat tindakan bedah, nyeri pasca-operasi yang wajar).
Formula	Jumlah pasien yang mengalami reaksi anestesi yang terdokumentasi pada periode tertentu.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dari rekam medis dan laporan insiden.
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden untuk setiap kejadian yang ditemukan.
Sampel	Seluruh populasi pasien yang menjalani anestesi di IKO pada periode pengumpulan data.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

4. Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi

Judul Indikator	Kejadian Ketidaklengkapan Pengisian Assessment Praanestesi
Dasar pemikiran	Assessment praanestesi yang lengkap dan akurat merupakan langkah krusial dalam menjamin keselamatan pasien sebelum menjalani tindakan anestesi. Ketidaklengkapan pengisian asesmen dapat berisiko terhadap identifikasi masalah pasien, perencanaan anestesi yang tidak optimal, dan peningkatan risiko komplikasi. Indikator ini bertujuan untuk memantau dan meningkatkan kualitas proses asesmen praanestesi demi keselamatan dan mutu pelayanan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan staf medis dalam melakukan pengisian assessment praanestesi secara lengkap.
Definisi Operasional	Ketidaklengkapan pengisian assessment praanestesi adalah tidak terpenuhinya seluruh komponen wajib dalam formulir assessment praanestesi yang telah ditetapkan oleh standar rumah sakit/fasilitas kesehatan, sebelum pasien menjalani tindakan anestesi. Komponen wajib meliputi, namun tidak terbatas pada: riwayat penyakit, riwayat alergi, riwayat operasi/anestesi sebelumnya, pemeriksaan fisik, hasil laboratorium/penunjang, dan rencana anestesi.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang assessment praanestesinya tidak lengkap dalam periode pengamatan.
Denominator (penyebut)	-
Target	0 kejadian

Pencapaian	
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Seluruh pasien yang akan menjalani tindakan anestesi (baik bedah maupun non-bedah) yang memerlukan asesmen praanestesi. 1. Pasien gawat darurat yang memerlukan tindakan anestesi segera tanpa sempat dilakukan assessment praanestesi lengkap (dicatat sebagai pengecualian dalam rekam medis). 2. Pasien yang menolak dilakukan asesmen praanestesi (dicatat dalam rekam medis).
Formula	Jumlah pasien yang asesmen praanestesinya tidak lengkap dalam periode pengamatan.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif: Penelusuran rekam medis pasien yang telah menjalani tindakan anestesi.
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Cheklist Audit Kelengkapan Asesmen Pra-Anestesi.
Sampel	Metode: Random sampling atau sensus (jika jumlah populasi kecil).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

5. Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi

Judul Indikator	Kejadian Konversi Regional Anestesi ke General Anestesi
Dasar pemikiran	Anestesi regional seringkali menjadi pilihan yang lebih aman dan menguntungkan bagi pasien dibandingkan anestesi umum, karena dapat mengurangi risiko komplikasi pasca-operasi, mempercepat pemulihan, dan mengurangi kebutuhan akan analgesik opiat. Namun, pada beberapa kasus, anestesi regional mungkin tidak memberikan efek yang memadai, gagal, atau timbul komplikasi yang memerlukan konversi mendesak ke anestesi umum. Tingginya angka konversi dapat mengindikasikan adanya isu dalam proses pemilihan pasien, teknik regional yang kurang optimal, atau penatalaksanaan komplikasi yang tidak efektif. Pemantauan indikator ini penting untuk mengevaluasi kualitas praktik anestesi regional dan meningkatkan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur angka konversi dari anestesi regional ke anestesi umum. 2. Mengidentifikasi penyebab utama konversi untuk dilakukan tindakan perbaikan. 3. Meningkatkan keberhasilan dan keamanan tindakan anestesi regional. 4. Meningkatkan kompetensi tim anestesi dalam pelaksanaan

	dan manajemen anestesi regional
Definisi Operasional	Konversi Regional Anestesi ke General Anestesi adalah perubahan rencana atau teknik anestesi dari regional (misalnya spinal, epidural, blok saraf perifer) menjadi anestesi umum pada pasien yang awalnya direncanakan dan telah menerima anestesi regional, baik sebelum atau selama tindakan bedah, karena alasan klinis (misalnya, anestesi regional tidak adekuat, blok gagal, timbul komplikasi, atau pasien tidak kooperatif).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan anestesi regional yang mengalami konversi menjadi anestesi umum dalam periode waktu tertentu.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani tindakan bedah atau diagnostik yang awalnya direncanakan dan telah menerima tindakan anestesi regional (spinal, epidural, blok saraf perifer, dll.) 1. Pasien yang memang sudah direncanakan untuk kombinasi anestesi regional dan umum (misalnya epidural dan general anestesi untuk bedah toraks).
Formula	Jumlah tindakan anestesi regional yang mengalami konversi menjadi anestesi umum dalam periode waktu tertentu.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif: Penelusuran rekam medis dan catatan anestesi.
Sumber data	1. Catatan Anestesi (Formulir Anestesi, Catatan Pra-Anestesi, Catatan Pasca-Anestesi).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Cheklist Audit Konversi Anestesi.
Sampel	Metode: Sensus (disarankan untuk mengumpulkan semua data untuk mendapatkan gambaran akurat). Jika populasi sangat besar, bisa menggunakan <i>random sampling</i> dengan ukuran sampel yang memadai (misalnya, minimal 30-50 kasus per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan 4. Kepala Bidang Keperawatan

6. Angka efek samping selama sedasi moderat

Judul Indikator	Angka efek samping selama sedasi moderat
Dasar pemikiran	Tindakan sedasi moderat memiliki risiko depresi saluran napas, gangguan kardiovaskular, dan aspirasi. Pemantauan efek samping sangat penting untuk memastikan prosedur dilakukan secara aman dan kompeten

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Tergambarnya kualitas pelayanan anestesi dan sedasi serta memastikan tingkat keamanan pasien yang menjalani tindakan di luar kamar operasi
Definisi Operasional	Efek samping sedasi moderat adalah kejadian tidak diharapkan yang terjadi selama prosedur berlangsung, meliputi: 1. Desaturasi oksigen ($SpO_2 < 90\%$) selama >60 detik. 2. Apnea atau depresi pernapasan berat. 3. Hipotensi atau hipertensi berat (perubahan > 30% dari <i>baseline</i>) 4. Bradikardia atau takikardia signifikan 5. Aspirasi paru
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami satu atau lebih efek samping selama tindakan sedasi moderat dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang menjalani tindakan sedasi moderat dalam bulan yang sama.
Target Pencapaian	0%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua pasien (anak maupun dewasa) yang menjalani tindakan medis dengan sedasi moderat (misalnya: endoskopi, radiologi intervensi, bedah minor).
• Eksklusi	1. Pasien dengan sedasi ringan (<i>anxiolysis</i>) atau sedasi dalam/anestesi umum 2. Pasien yang sudah dalam kondisi tidak stabil (terintubasi) sebelum sedasi dimulai
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien dengan efek samping selama tindakan sedasi moderat}}{\text{Jumlah total pasien yang menjalankan tindakan sedasi moderat dalam bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif atau <i>Concurrent</i> (berjalan).
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
Instrumen Pengambilan Data	Form laporan insiden internal atau formulir pemantauan indikator mutu klinis.
Sampel	Total Populasi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan

7. Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi

Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilakukannya Proses Monitoring Status Fisiologis Selama Anestesi
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamankan perlindungan pasien dan pemenuhan standar mutu. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Setiap tindakan medis harus meminimalkan risiko KTD 3. Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAB 5.3: Monitoring status fisiologis memberikan informasi mengenai status pasien selama prosedur anestesi (umum, spinal, regional) dan membantu mendeteksi kejadian komplikasi segera.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan setiap pasien yang menjalani anestesi mendapatkan pemantauan standar secara kontinu untuk mencegah cedera atau kematian.
Definisi Operasional	Tindakan anestesi (umum, spinal, atau regional) yang dilakukan tanpa disertai catatan pemantauan status fisiologis secara periodik (minimal tiap 5 menit atau sesuai protokol) di lembar anestesi. Komponen yang wajib dimonitor meliputi: 1. Oksigenasi (Saturasi SpO₂) 2. Ventilasi (Frekuensi napas/EtCO₂) 3. Sirkulasi (Tekanan darah, Nadi, EKG).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan anestesi yang tidak dilakukan monitoring status fisiologis sesuai standar dalam 1 bulan.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Seluruh pasien yang menjalani tindakan pembedahan atau prosedur lain dengan anestesi umum, spinal, maupun blok regional. 1. Tindakan dengan anestesi lokal tanpa pendampingan tim anestesi (MAC/Sedasi tidak termasuk dalam indikator spesifik anestesi ini jika sudah ada indikator sedasi terpisah).
Formula	Jumlah tindakan anestesi yang tidak dilakukan monitoring status fisiologis sesuai standar dalam 1 bulan.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis).
Sumber data	Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Indikator Mutu Unit Anestesi.
Sampel	Total Populasi (Sensus Harian).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan

8. Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi

Judul Indikator	Kejadian Tidak Dilakukannya Proses Monitoring Pemulihan Pasca Anestesi
Dasar pemikiran	1. UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban fasyankes memberikan pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Pencegahan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada fase kritis. 3. Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAB 6: Monitoring pasca-anestesi di ruang pemulihan (PACU) sangat krusial karena sebagian besar komplikasi respirasi dan kardiovaskular terjadi segera setelah anestesi dihentikan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Memastikan keselamatan pasien selama fase pemulihan dari pengaruh anestesi dan mencegah terjadinya komplikasi pasca-bedah yang tidak terdeteksi.
Definisi Operasional	kejadian di mana pasien yang selesai menjalani tindakan anestesi (umum/regional) dipindahkan ke bangsal atau dipulangkan tanpa adanya catatan pemantauan status fisiologis dan penilaian skor pemulihan di Ruang Pemulihan (PACU) atau area observasi.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien pasca-anestesi yang tidak dilakukan monitoring pemulihan sesuai standar (tidak ada catatan monitoring/skor pemulihan) dalam 1 bulan.
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien yang menjalani prosedur pemasangan alat medis invasif atau tindakan medis invasif di IKO (misalnya, intubasi, pemasangan CVC, blok regional, dll.). 1. Kesulitan penempatan yang terjadi namun berhasil dikoreksi segera tanpa menyebabkan <i>outcome</i> merugikan pada pasien.
Formula	Jumlah pasien pasca-anestesi yang tidak dilakukan monitoring pemulihan sesuai standar (tidak ada catatan monitoring/skor pemulihan) dalam 1 bulan.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis).
Sumber data	Rekam Medis (Lembar Observasi Pasca-Anestesi / Catatan Ruang Pemulihan)

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Monitoring Pasca-Anestesi.
Sampel	Total Populasi (Sensus Harian).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang IKO

3.3.9. Maternitas

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
8.	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
9.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
10.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
11.	Kepatuhan DPJP	100%	UNIT

	dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi		
12.	Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi	0 kejadian	UNIT
13.	Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam	0 kejadian	UNIT
14.	Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam	0 kejadian	UNIT
15.	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	UNIT
16.	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia	0 kejadian	UNIT
17.	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	UNIT
18.	Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis	100%	UNIT
19.	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature	100%	UNIT

3.3.9.1 Profil Indikator Mutu Maternitas

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit.

	3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan kebersihan tangan

Judul Indikator	Kepatuhan kebersihan tangan
-----------------	-----------------------------

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan

	tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien.

	2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan pasien

Judul Indikator	Kepuasan pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	- Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. - Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. - Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. - Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. - Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. - Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan

Tujuan	1. Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. 2. Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. 2. Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. 1. Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). 2. Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visite dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (*Clinical Pathway*)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	1. Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. 2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.

Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

7. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan

	tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

8. Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 menit

Judul Indikator	Waktu tanggap Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional (IMN) 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (PONEK 24 Jam) 4. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui percepatan penanganan kegawatdaruran obstetri di RS
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kecepatan respon tim medis dalam melakukan tindakan seksio sesarea emergensi sejak keputusan operasi ditetapkan hingga tindakan dimulai, guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi
Definisi Operasional	Prosentase tindakan seksio sesarea emergensi yang dilakukan dalam waktu ≤30 menit sejak keputusan operasi ditetapkan (decision) hingga insisi pertama dilakukan (<i>incision</i>) Kategori I: Ancaman langsung terhadap nyawa ibu atau janin (misal: bradycardia janin, ruptura uteri)
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan seksio sesarea emergensi dengan waktu tanggap ≤30 menit (dari keputusan operasi sampai insisi)
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh tindakan seksio sesarea emergensi dalam periode pengamatan
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien hamil dengan indikasi SC Emergensi Kategori I (Urgency Kategori I) 1. SC Emergensi Kategori II, III, dan IV 2. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor pasien/keluarga (menolak tindakan atau menunda tanda tangan persetujuan/Informed Consent) 3. Kondisi klinis pasien yang memerlukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum operasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah SC emergensi kategori I dengan waktu tanggap } \leq 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah total SC Emergensi Kategori I dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Review rekam medis (waktu keputusan dan waktu insisi) 2. <i>Real-time / Concurrent</i> (jika memungkinkan)

Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku Register Persalinan (VK) dan Register Kamar Operasi (OK) 3. Formulir Laporan Operasi dan Catatan Anestesi
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Formulir Pemantauan Waktu Tanggap SC (Checklist Jam Keputusan vs Jam Insisi)
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Petugas IGD 2. Kepala ruang IKO 3. Kepala Bidang Pelayanan

9. Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (<i>Situation, Background, Assessment, Recommendation</i>) secara lengkap dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. - Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. - Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. - Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi $\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung - Review rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	- Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis - Rekam Medis Pasien - Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

10. Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap

Judul Indikator	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature
Dasar pemikiran	- PNPK Tata Laksana Persalinan Prematur (POGI) - WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes - Kortikosteroid antenatal terbukti secara signifikan menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatus akibat ketidakmatangan organ (terutama paru) - Ketepatan pemberian pada jendela waktu yang sesuai sangat menentukan luaran kesehatan bayi

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan seluruh ibu hamil yang berisiko melahirkan prematur mendapatkan terapi pematangan paru janin sesuai standar prosedur operasional
Definisi Operasional	Kepatuhan pemberian kortikosteroid adalah pemberian terapi steroid (Deksametason 6 mg per 12 jam sebanyak 4 dosis atau Betametason 12 mg per 24 jam sebanyak 2 dosis) secara intramuskular kepada ibu hamil yang didiagnosa akan bersalin prematur
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ibu hamil yang melahirkan prematur dan telah mendapatkan minimal satu dosis kortikosteroid sebelum persalinan
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh ibu hamil yang melahirkan prematur (usia kehamilan 24 hingga < 34 minggu)
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Semua ibu hamil yang melahirkan pada usia kehamilan 24 minggu hingga < 34 minggu (atau sesuai kebijakan RS, beberapa protokol hingga < 37 minggu) - Inklusi - Eksklusi - Ibu dengan infeksi berat (Sepsis atau Korioamnionitis) yang merupakan kontraindikasi penundaan persalinan - Pasien yang datang dalam kondisi pembukaan lengkap (kala II) sehingga tidak sempat diberikan dosis pertama - Ibu dengan riwayat alergi kortikosteroid
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien premature yang mendapat kortikosteoid}}{\text{Jumlah total seluruh pasien persalinan prematur}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Lembar Pemberian Obat/CPPT) 2. Buku Register Persalinan (VK)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Terapi Steroid Antenatal
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang maternitas 2. Kepala bidang pelayanan 3. Komite PMKP

11. Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi

Judul Indikator	Kepatuhan DPJP dalam pengunaan MgSO4 pada pasien pre
-----------------	--

	eklamsi/ eklamsi
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) Tata Laksana Pre-eklampsia 3. MgSO4 adalah obat pilihan utama (<i>drug of choice</i>) untuk pencegahan dan terapi kejang pada pre-eklampsia berat dan eclampsia 4. Penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai dosis dapat membahayakan keselamatan pasien (risiko toksisitas atau kejang yang tidak teratasi)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan seluruh pasien dengan Pre-eklampsia Berat dan Eklampsia mendapatkan terapi MgSO4 sesuai standar operasional untuk mencegah komplikasi kejang dan kematian ibu.
Definisi Operasional	Kepatuhan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dinilai dari ketepatan instruksi pemberian MgSO4 yang meliputi: 1. Loading Dose (Dosis Awal) yang tepat 2. Maintenance Dose (Dosis Pemeliharaan) yang tepat 3. Pemantauan syarat pemberian (RR > 16x/mnt, Reflek Patella (+), Urin > 0,5cc/kgBB/jam)
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien PEB/Eklampsia yang mendapatkan terapi MgSO4 sesuai dengan standar protokol RS dalam 1 bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien dengan diagnosa PEB/Eklampsia pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang didiagnosa Pre-eklampsia Berat (PEB) atau Eklampsia oleh DPJP 1. Pasien dengan kontraindikasi pemberian MgSO4 (misal: Myasthenia Gravis, gagal ginjal berat) 2. Pasien yang datang sudah dalam keadaan <i>In Partu</i> kala II atau rujukan yang sudah mendapatkan dosis lengkap di faskes sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien PEB/eklamsi yang mendapat MgSO4 sesuai standar}}{\text{Jumlah total pasien PEB/eklamsi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Catatan Integrasi Penatalaksanaan Pasien / CPPT) 2. Lembar Observasi Khusus MgSO4 3. Register Rawat Inap / VK
Instrumen Pengambilan Data	Formulir audit kepatuhan penggunaan MgSO4

Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

12. Kejadian pasien Preeklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi

Judul Indikator	Kejadian pasien pre eklamsia yang mengalami perburukan menjadi eklamsi
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PNPK Tata Laksana Pre-eklamsia (POGI) 3. Eklamsia adalah kegawatdaruratan medis yang meningkatkan risiko kematian ibu dan janin secara signifikan 4. Perburukan dari pre-eklamsia menjadi eklamsia seharusnya dapat dicegah dengan pemantauan ketat dan pemberian terapi profilaksis (MgSO4) yang tepat
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menurunkan angka kejadian eklamsia di rumah sakit melalui pengawasan dan penanganan pre-eklamsia yang optimal
Definisi Operasional	Kejadian perburukan adalah kondisi di mana pasien yang terdiagnosis Pre-eklamsia (baik ringan maupun berat) saat masuk rumah sakit atau selama perawatan, mengalami kejang (Eklamsia) yang bukan disebabkan oleh kelainan neurologis lain
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien Pre-eklamsia yang mengalami kejang (Eklamsia) selama dalam perawatan di rumah sakit
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnosa Pre-eklamsia yang dirawat
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien hamil, bersalin, atau nifas yang didiagnosa Pre-eklamsia (Ringan/Berat) 1. Pasien yang datang ke IGD sudah dalam kondisi Eklamsia (kejang di luar RS) 2. Pasien dengan riwayat kejang karena penyakit lain (misal: Epilepsi atau Meningitis)
Formula	Jumlah pasien pre eklamsi yang menjadi eklamsi
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)

Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku Register Kebidanan / PONEK
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Pre-eklamsia
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang maternitas 2. Kepala Bidang Pelayanan

13. Kejadian pasien dengan kasus Preeklamsi berat aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam

Judul Indikator	Kejadian pasien dengan kasus pre eklamsi berta aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PNPK Tata Laksana Pre-eklamsia (POGI): Pada usia kehamilan ≥ 37 minggu, terminasi adalah terapi definitive 3. Penundaan persalinan pada PEB aterm meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal secara signifikan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan ketepatan waktu pengambilan keputusan dan pelaksanaan terminasi pada pasien PEB aterm guna mencegah komplikasi lebih lanjut
Definisi Operasional	Kejadian pasien PEB Aterm yang dilahirkan > 24 jam adalah jumlah pasien dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat pada usia kehamilan ≥ 37 minggu yang waktu persalinannya (bayi lahir) melebihi 24 jam sejak keputusan terminasi diambil atau sejak pasien masuk RS dalam kondisi stabil
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien PEB Aterm (≥ 37 mgg) yang proses persalinannya (lahir) memakan waktu > 24 jam sejak masuk RS/keputusan terminasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien PEB Aterm (≥ 37 mgg) yang dirawat dalam periode 1 bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria:	Semua pasien hamil dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat (PEB) dengan usia kehamilan ≥ 37 minggu
• Inklusi	1. Pasien PEB Pre-term (< 37 minggu) yang masih diupayakan konservatif/ekspektatif
• Eksklusi	2. Pasien yang memerlukan stabilisasi kondisi medis penyerta yang rumit (misal: gagal jantung atau gangguan koagulasi berat) sehingga terminasi harus

	ditunda secara klinis
Formula	Jumlah pasien dengan kasus PEB aterm yang dilahirkan dalam waktu > 24 jam
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Laporan Persalinan/Operasi) 2. Buku Register Kebidanan / PONEK 3. Lembar Observasi Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Ketepatan Waktu Terminasi PEB
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang maternitas 2. Kepala Bidang Pelayanan

14. Kejadian pasien dengan Eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam

Judul Indikator	Kejadian pasien dengan eklamsia yang dilahirkan dalam waktu > 12 jam
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PNPK Tata Laksana Pre-eklamsia/Eklamsia (POGI): Eklamsia adalah indikasi absolut untuk terminasi segera tanpa memandang usia kehamilan 3. Semakin lama janin berada dalam rahim setelah serangan eklamsia, semakin tinggi risiko edema serebri, gagal ginjal, dan kematian ibu/janin
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menjamin percepatan proses persalinan pada kasus eklamsia untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas maternal serta perinatal
Definisi Operasional	Kejadian pasien eklamsia yang dilahirkan > 12 jam adalah kondisi di mana pasien dengan diagnosa Eklamsia (kejang) yang proses persalinannya (bayi lahir) memakan waktu lebih dari 12 jam dihitung sejak kejang terakhir terjadi atau sejak pasien masuk ke rumah sakit
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien Eklamsia yang waktu persalinannya (bayi lahir) memakan waktu > 12 jam dalam periode satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnosa Eklamsia pada periode yang sama

Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien hamil, bersalin, atau nifas yang mengalami Eklamsia (kejang) Pasien yang memerlukan stabilisasi hemodinamik atau perawatan intensif (ICU) yang sangat kompleks sebelum tindakan operasi dapat dilakukan secara aman
Formula	Jumlah pasien eklamsia yang lahir > 12 jam
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	- Rekam Medis (Catatan Persalinan/Operasi) - Buku Register PONEK / VK / OK
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Ketepatan Waktu Penanganan Eklamsia
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala ruang maternitas - Kepala Bidang Pelayanan

15. Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB				
Dasar pemikiran	- PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional - Strategi Nasional Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia - PEB adalah penyebab utama kematian maternal yang dapat dicegah dengan deteksi dini, pemberian MgSO4 yang tepat, dan terminasi kehamilan yang tepat waktu				
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan		☒ ☒		
Tujuan	Menurunkan angka kematian ibu bersalin dan memastikan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri berjalan optimal untuk kasus hipertensi dalam kehamilan				
Definisi Operasional	Kematian ibu bersalin karena PEB adalah kematian yang terjadi pada masa persalinan atau masa nifas (hingga 42 hari setelah persalinan) yang disebabkan oleh komplikasi dari Pre-eklamsia Berat (seperti Gagal Ginjal, Edema Paru, Stroke Hemoragik, atau HELLP Syndrome)				
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☒	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian				
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu bersalin yang didiagnosa dengan Pre-eklamsia Berat (PEB)				

Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh ibu bersalin dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat (PEB)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua ibu bersalin atau nifas dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat (PEB) yang meninggal dunia di rumah sakit Kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh penyebab lain di luar komplikasi PEB (misal: Perdarahan hebat/HPP tanpa PEB, Emboli air ketuban, atau Kecelakaan)
Formula	Jumlah kematian ibu dengan PEB
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal/AMP)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien Medis 2. Sertifikat Penyebab Kematian (Surat Kematian) 3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (Sentinel)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Formulir Laporan Kematian.
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang maternitas 2. Komite PMKP

16. Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh Eklampsia

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh eklampsia					
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional 3. PNPK Tata Laksana Eklampsia: Eklampsia adalah penyebab kematian maternal tertinggi kedua di Indonesia 4. Kematian akibat eklampsia mencerminkan kualitas penanganan kegawatdaruratan (PONEK) di rumah sakit dalam menghentikan kejang dan mencegah komplikasi fatal					
Dimensi Mutu	1. Efisiensi					
	2. Efektivitas			☑		
	3. Aksesibilitas					
	4. Keselamatan			☑		
	5. Fokus kepada pasien					
	6. Kesiambungan					
Tujuan	Tergambarnya kualitas penanganan pasien eklampsia di rumah sakit serta upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)					
Definisi Operasional	Kematian ibu bersalin karena eklampsia adalah kematian yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas yang didahului dengan gejala kejang dan/atau koma yang bukan disebabkan oleh penyakit neurologis lain (seperti epilepsi atau meningitis)					
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☑	Proses	& outcome

Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu dengan diagnosa Eklampsia
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnosa Eklampsia
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien hamil, bersalin, atau nifas yang didiagnosa Eklampsia (dengan riwayat kejang) yang meninggal dunia di rumah sakit Kematian ibu yang disebabkan oleh hal-hal di luar komplikasi eklampsia (misal: kecelakaan lalu lintas atau bunuh diri)
Formula	Jumlah kematian ibu dengan eklampsia
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal)
Sumber data	- Rekam Medis Pasien - Sertifikat Penyebab Kematian (Surat Kematian) - Laporan Insiden Keselamatan Pasien (Sentinel)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Formulir Laporan Kejadian Sentinel
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala ruang maternitas - Komite PMKP

17. Kejadian kematian ibu karena HPP

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu karena HPP
Dasar pemikiran	- PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional - PNPK Tata Laksana Perdarahan Pasca Salin: HPP adalah penyebab utama kematian maternal di Indonesia - Kematian akibat HPP mencerminkan kualitas manajemen kala III, kecepatan deteksi dini perdarahan, dan efektivitas tim PONEK dalam melakukan tindakan penyelamatan (seperti pemberian uterotonika, kompresi bimanual, hingga tindakan operatif)
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Menurunkan angka kematian ibu akibat perdarahan dan mengevaluasi kesiapsiagaan tim medis dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetri
Definisi Operasional	Kematian ibu karena HPP adalah kematian yang terjadi pada masa persalinan atau masa nifas yang disebabkan oleh kehilangan darah lebih dari 500 ml pada persalinan

	pervaginam atau lebih dari 1000 ml pada persalinan Seksio Sesarea (SC)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu bersalin dengan diagnosa Perdarahan Pasca Salin (HPP)
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnose Perdarahan Pasca Salin (HPP)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua ibu bersalin atau nifas dengan diagnosa HPP (Atonia Uteri, Robekan Jalan Lahir, Retensio Plasenta, atau Gangguan Koagulasi) yang meninggal dunia di rumah sakit Kematian ibu yang disebabkan oleh penyebab non-obstetri atau komplikasi medis lain di luar perdarahan (misal: penyakit jantung, eklampsia tanpa perdarahan)
Formula	Jumlah kematian ibu dengan HPP
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal/AMP)
Sumber data	- Rekam Medis Pasien - Buku Register Persalinan & Nifas - Laporan Kejadian Sentinel
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP)
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala ruang maternitas - Komite PMKP

18. Kejadian kematian ibu bersalin karena sepsis

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu persalinan karena sepsi
Dasar pemikiran	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PNPK Tata Laksana Sepsis dalam Kehamilan: Sepsis adalah salah satu penyebab utama kematian maternal di samping perdarahan dan hipertensi - Kematian akibat sepsis mencerminkan adanya hambatan dalam pengenalan dini gejala infeksi (<i>Early Warning System</i>) dan keterlambatan dalam memulai <i>Sepsis Bundle</i> (cairan, antibiotik, dan kontrol sumber infeksi)
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur angka kejadian kematian ibu akibat sepsis pada masa persalinan sebagai indikator keselamatan pasien dan

	mutu pelayanan kebidanan
Definisi Operasional	Kematian ibu karena sepsis adalah kematian yang terjadi selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (masa nifas), yang disebabkan oleh disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat gangguan respons tubuh terhadap infeksi (seperti sepsis nifas, peritonitis paska SC, atau korioamnionitis berat)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu bersalin dengan diagnosa Sepsis
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien maternal dengan diagnosa Sepsis
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua ibu hamil, bersalin, atau nifas yang mengalami sepsis dan meninggal dunia di rumah sakit Kematian ibu yang disebabkan oleh penyebab non-infeksi (misal: Perdarahan hebat tanpa infeksi, Eklampsia, Emboli, atau Kecelakaan
Formula	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dengan sepsis}}{\text{Jumlah total seluruh pasien dengan sepsis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal/AMP)
Sumber data	- Rekam Medis Pasien - Laporan Komite Pengendalian Infeksi (PPI)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Laporan RCA (<i>Root Cause Analysis</i>)
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala ruang maternitas - Kepala bidang pelayanan - Komite PMKP - Komite PPI

19. Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature

Judul Indikator	Kepatuhan pemberian kortikosteroid pada persalinan premature
Dasar pemikiran	- PNPK Tata Laksana Persalinan Prematur (POGI) - WHO Recommendations on Interventions to Improve Preterm Birth Outcomes - Kortikosteroid antenatal terbukti secara signifikan menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatus akibat ketidakmatangan organ (terutama paru) - Ketepatan pemberian pada jendela waktu yang sesuai sangat menentukan luaran kesehatan bayi

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan seluruh ibu hamil yang berisiko melahirkan prematur mendapatkan terapi pematangan paru janin sesuai standar prosedur operasional
Definisi Operasional	Kepatuhan pemberian kortikosteroid adalah pemberian terapi steroid (Deksametason 6 mg per 12 jam sebanyak 4 dosis atau Betametason 12 mg per 24 jam sebanyak 2 dosis) secara intramuskular kepada ibu hamil yang didiagnosa akan bersalin prematur
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ibu hamil yang melahirkan prematur dan telah mendapatkan minimal satu dosis kortikosteroid sebelum persalinan
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh ibu hamil yang melahirkan prematur (usia kehamilan 24 hingga < 34 minggu)
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Semua ibu hamil yang melahirkan pada usia kehamilan 24 minggu hingga < 34 minggu (atau sesuai kebijakan RS, beberapa protokol hingga < 37 minggu) - Inklusi - Eksklusi - Ibu dengan infeksi berat (Sepsis atau Korioamnionitis) yang merupakan kontraindikasi penundaan persalinan - Pasien yang datang dalam kondisi pembukaan lengkap (kala II) sehingga tidak sempat diberikan dosis pertama - Ibu dengan riwayat alergi kortikosteroid
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien premature yang mendapat kortikosteoid}}{\text{Jumlah total seluruh pasien persalinan prematur}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	- Rekam Medis (Lembar Pemberian Obat/CPPT) - Buku Register Persalinan (VK)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Terapi Steroid Antenatal
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala ruang maternitas - Kepala bidang pelayanan - Komite PMKP

3.3.10. Ponek

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan

1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
6.	Waktu tanggap seksio sesarea emergensi <30 mnt	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
7.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
8.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
9.	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien Pre eklamsi Berat/Eklamsi	100%	UNIT
10.	Kepatuhan Kasus hemoragi post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat	100%	UNIT
11.	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh Tim ponek yang terlatih	100%	UNIT
12.	Prosentase Ibu bersalin yang dilakukan skrining penilaian kegawatan/ severitas saat masuk ke Fasyankes	100%	UNIT
13.	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB	0 kejadian	UNIT
14.	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh	0 kejadian	UNIT

	Eklampsia		
15.	Kejadian kematian ibu karena HPP	0 kejadian	UNIT
16.	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	0 kejadian	UNIT

3.3.10.1 Profil Indikator Mutu Ponpek

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan identifikasi pasien			
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan			
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan			
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi			

Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	- Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. - Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah

	kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: - Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. - Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. - Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. - Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. - Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien Resiko Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	- Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: - Assesment awal risiko jatuh - Assesment ulang risiko jatuh - Intervensi pencegahan risiko jatuh - Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). - Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. - Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. - Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. - Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. - Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan.
• Eksklusi	1. Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. 2. Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	1. Survei langsung setelah perawatan medis selesai.

Data	2. Pengisian kuisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat,

	partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

6. Waktu Tanggap Seksio Sesarea Emergency < 30 Menit

Judul Indikator	Waktu tanggap Seksio Sesarea Emergensi ≤ 30 menit
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional (IMN) 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (PONEK 24 Jam) 4. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui percepatan penanganan kegawatdaruran obstetri di RS

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kecepatan respon tim medis dalam melakukan tindakan seksio sesarea emergensi sejak keputusan operasi ditetapkan hingga tindakan dimulai, guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi
Definisi Operasional	Prosentase tindakan seksio sesarea emergensi yang dilakukan dalam waktu ≤ 30 menit sejak keputusan operasi ditetapkan (<i>decision</i>) hingga insisi pertama dilakukan (<i>incision</i>) Kategori I: Ancaman langsung terhadap nyawa ibu atau janin (misal: <i>bradycardia</i> janin, ruptura uteri)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan seksio sesarea emergensi dengan waktu tanggap ≤ 30 menit (dari keputusan operasi sampai insisi)
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh tindakan seksio sesarea emergensi dalam periode pengamatan
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria:	Semua pasien hamil dengan indikasi SC Emergensi Kategori I (Urgency Kategori I) - Inklusi - Eksklusi
	1. SC Emergensi Kategori II, III, dan IV 2. Keterlambatan yang disebabkan oleh faktor pasien/keluarga (menolak tindakan atau menunda tanda tangan persetujuan/Informed Consent) 3. Kondisi klinis pasien yang memerlukan stabilisasi terlebih dahulu sebelum operasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah SC emergensi kategori I dengan waktu tanggap} \leq 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah total SC Emergensi Kategori I dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Review rekam medis (waktu keputusan dan waktu insisi) 2. <i>Real-time / Concurrent</i> (jika memungkinkan)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku Register Persalinan (VK) dan Register Kamar Operasi (OK) 3. Formulir Laporan Operasi dan Catatan Anestesi
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Formulir Pemantauan Waktu Tanggap SC (Checklist Jam Keputusan vs Jam Insisi)
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Petugas IGD 2. Kepala ruang IKO

	3. Kepala Bidang Pelayanan
--	----------------------------

7. Kepatuhan PPA Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (<i>Situation, Background, Assessment, Recommendation</i>) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi

	$\frac{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

8. Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Ranap

Judul Indikator	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh Petugas Ranap
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Fasilitas kesehatan wajib menjamin keamanan penggunaan obat. 2. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 3: Obat <i>High Alert</i> (risiko tinggi) dan LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius jika terjadi kesalahan pemberian. <i>Crosscheck</i> (pengecekan ganda) oleh petugas rawat inap saat menerima obat dari farmasi atau sebelum pemberian ke pasien adalah pertahanan terakhir untuk mencegah <i>medication error</i>.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketelitian petugas rawat inap dalam mengidentifikasi obat-obatan waspada tinggi guna mencegah kesalahan pemberian obat kepada pasien.
Definisi Operasional	- High Alert: Obat dengan kewaspadaan tinggi (misal: Elektrolit pekat, Insulin, Heparin). - LASA/NORUM: Obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip. - Kepatuhan Crosscheck: Tindakan petugas rawat inap melakukan verifikasi ulang bahwa setiap sediaan obat <i>High Alert</i> telah ditempel stiker merah ("<i>High Alert</i>") dan obat LASA telah ditempel stiker kuning ("<i>LASA</i>") sesuai daftar obat RS sebelum disimpan di troli/lemari obat ruangan.

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah obat <i>High Alert</i> dan LASA di ruang rawat inap yang terverifikasi telah ditempel stiker dengan benar saat audit
Denominator (penyebut)	Total seluruh obat <i>High Alert</i> dan LASA yang ditemukan di ruang rawat inap saat audit pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Semua obat yang masuk dalam daftar <i>High Alert</i> dan LASA rumah sakit yang tersedia di unit rawat inap
• Inklusi	
• Eksklusi	Obat milik pasien yang dibawa dari luar rumah sakit (namun harus tetap dikelola sesuai kebijakan RS)
Formula	$\frac{\text{Jumlah obat } \textit{High Alert} \text{ dan LASA di ruang rawat inap yang terverifikasi telah ditempel stiker dengan benar saat audit}}{\text{Total seluruh obat } \textit{High Alert} \text{ dan LASA yang ditemukan di ruang rawat inap saat audit pada bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi langsung melalui <i>spot check</i> atau audit fasilitas rutin)
Sumber data	1. Lembar Audit Kepatuhan Labeling Obat 2. Daftar Obat di Troli Emergency/Farmasi Ruangan
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> Monitoring Obat <i>High Alert</i> & LASA
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Ponek 2. Komite PMKP

9. Kepatuhan DPJP dalam Penggunaan MgSO4 pada Pasien Pre Eklamsi Berat/ Eklamsi

Judul Indikator	Kepatuhan DPJP dalam penggunaan MgSO4 pada pasien pre eklamsi/ eklamsi
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) Tata Laksana Pre-eclampsia 3. MgSO4 adalah obat pilihan utama (<i>drug of choice</i>) untuk pencegahan dan terapi kejang pada pre-eclampsia berat dan eclampsia 4. Penggunaan yang tidak tepat atau tidak sesuai dosis dapat membahayakan keselamatan pasien (risiko toksisitas atau kejang yang tidak teratasi)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiinambungan
Tujuan	Memastikan seluruh pasien dengan Pre-eclampsia Berat dan Eklampsia mendapatkan terapi MgSO4 sesuai standar

	operasional untuk mencegah komplikasi kejang dan kematian ibu.
Definisi Operasional	Kepatuhan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) dinilai dari ketepatan instruksi pemberian MgSO ₄ yang meliputi: 1. Loading Dose (Dosis Awal) yang tepat 2. Maintenance Dose (Dosis Pemeliharaan) yang tepat 3. Pemantauan syarat pemberian (RR > 16x/mnt, Reflek Patella (+), Urin > 0,5cc/kgBB/jam)
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien PEB/Eklampsia yang mendapatkan terapi MgSO ₄ sesuai dengan standar protokol RS dalam 1 bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien dengan diagnosa PEB/Eklampsia pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang didiagnosa Pre-eklampsia Berat (PEB) atau Eklampsia oleh DPJP 1. Pasien dengan kontraindikasi pemberian MgSO₄ (misal: Myasthenia Gravis, gagal ginjal berat) 2. Pasien yang datang sudah dalam keadaan <i>In Partu</i> kala II atau rujukan yang sudah mendapatkan dosis lengkap di faskes sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien PEB/eklamsi yang mendapat MgSO}_4 \text{ sesuai standar}}{\text{Jumlah total pasien PEB/eklamsi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Catatan Integrasi Penatalaksanaan Pasien / CPPT) 2. Lembar Observasi Khusus MgSO₄ 3. Register Rawat Inap / VK
Instrumen Pengambilan Data	Formulir audit kepatuhan penggunaan MgSO ₄
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

10. Kepatuhan Kasus Hemoragi Post Partum yang Ditatalaksana dengan Asam Traneksamat

Judul Indikator	Kepatuhan kasus hemorai post partum yang ditatalaksana dengan asam traneksamat
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Rekomendasi WHO (2017) tentang penggunaan Asam Traneksamat untuk perdarahan pasca salin 3. PNPK (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran) Tata Laksana Perdarahan Pasca Salin 4. Pemberian Asam Traneksamat dalam kurun waktu < 3 jam setelah perdarahan terbukti signifikan menurunkan risiko kematian akibat perdarahan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menilai tingkat kepatuhan DPJP dalam memberikan asam traneksamat pada kasus hemoragi postpartum sesuai dengan indikasi dan standar pelayanan, guna meningkatkan keselamatan ibu.
Definisi Operasional	Kepatuhan pemberian Asam Traneksamat adalah pemberian dosis pertama Asam Traneksamat (1 gram secara IV) pada setiap kasus perdarahan pasca salin (HPP) yang terjadi baik setelah persalinan pervaginam maupun seksio sesarea, diberikan dalam waktu sesegera mungkin (idealnya < 3 jam).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus perdarahan pasca salin (HPP) yang mendapatkan terapi Asam Traneksamat sesuai prosedur
Denominator (penyebut)	Jumlah total kasus perdarahan pasca salin (HPP)
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang mengalami perdarahan pasca salin (estimasi darah >500ml pada pervaginam atau >1000ml pada SC) di ruang VK, OK, maupun Nifas 1. Pasien dengan riwayat alergi Asam Traneksamat 2. Pasien dengan riwayat penyakit tromboemboli aktif (misal: DVT atau emboli paru)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kasus HPP yang mendapat Asam Traneksamat}}{\text{Jumlah total kasus HPP dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Laporan Persalinan/Laporan Operasi) 2. Catatan Pemberian Obat di CPPT 3. Buku Register Persalinan & Ruang Nifas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Checklist Audit Tata Laksana HPP
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu

Penanggung Jawab	1. Kepala ruang PONEK 2. Kepala Bidang Pelayanan
------------------	---

11. Pemberi Pelayanan Persalinan dengan Penyulit yang Dilakukan oleh Tim Ponek yang Terlatih

Judul Indikator	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit yang dilakukan oleh tim Ponek yang terlatih
Dasar pemikiran	1. Pedoman Penyelenggaraan PONEK 24 Jam di Rumah Sakit 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 3. Keberhasilan penanganan komplikasi obstetri sangat bergantung pada kompetensi tim (Dokter Obgyn, Anak, Anestesi, Bidan, dan Perawat) yang telah tersertifikasi 4. Standar Akreditasi RS mengenai Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Menjamin bahwa pasien persalinan dengan risiko tinggi/penyulit mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih secara formal dalam penanggulangan gawat darurat obstetri neonatal
Definisi Operasional	Suatu ukuran yang menunjukkan proporsi kasus persalinan dengan penyulit yang ditangani oleh tim PONEK yang telah memiliki pelatihan dan kompetensi sesuai standar
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kasus persalinan dengan penyulit yang ditangani oleh tim (dokter & bidan/perawat) yang memiliki sertifikat PONEK
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh kasus persalinan dengan penyulit
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien persalinan dengan diagnosa penyulit/komplikasi yang dirawat di kamar bersalin (VK) atau kamar operasi (OK) Persalinan normal tanpa komplikasi (fisiologis)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kasus penyulit oleh tim terlatih}}{\text{Jumlah seluruh kasus persalinan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis Pasien (Nama penolong yang tertera di partograf/laporan operasi)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kompetensi Penolong Persalinan
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang PONEK 2. Kepala Bidang Pelayanan

12. Prosentase Ibu Bersalin yang Dilakukan Skrining Penilaian Kegawatan/Severitas Saat Masuk ke Fasyankes

Judul Indikator	Prosentase ibu bersalin yang dilajukan skrining penilaian kegawatan/severitas saat masuk ke fasyankes
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Pedoman PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 3. Deteksi dini menggunakan skor kegawatan dapat menurunkan angka keterlambatan penanganan pada kasus perdarahan, eklampsia, dan sepsis 4. Standar Akreditasi Rumah Sakit mengenai pengkajian pasien secara cepat dan tepat
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam melakukan skrining kegawatan/severitas pada ibu bersalin saat pertama kali masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan
Definisi Operasional	Skrining penilaian kegawatan adalah pengisian instrumen MEOWS (Modified Early Obstetric Warning Score) atau formulir <i>triage</i> obstetri yang mencakup penilaian tanda-tanda vital (Tensi, Nadi, Suhu, RR, Kesadaran) dan tanda bahaya kebidanan lainnya saat pasien pertama kali kontak dengan petugas di IGD atau VK
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan penilaian kegawatan/skrining lengkap saat masuk
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh ibu bersalin yang masuk ke fasyankes
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua ibu hamil dengan tanda-tanda persalinan atau ibu bersalin yang masuk melalui IGD maupun Poliklinik Kebidanan
	Pasien ibu bersalin yang datang dalam kondisi <i>Death on Arrival</i> (DOA)
Formula	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang diskining kegawatdaruratan}}{\text{Jumlah total seluruh ibu bersalin yang masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis) atau <i>Concurrent</i> (Observasi langsung)
Sumber data	1. Lembar Triage IGD / Kebidanan 2. Rekam Medis (Lembar MEOWS/EWS Obstetri) 3. Buku Register Pasien Masuk
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Skrining EWS/MEOWS

Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang PONEK 2. Kepala bidang pelayanan 3. Komite PMKP

13. Kejadian Kematian Ibu Persalinan yang Disebabkan oleh PEB

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh PEB
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional 3. Strategi Nasional Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) di Indonesia 4. PEB adalah penyebab utama kematian maternal yang dapat dicegah dengan deteksi dini, pemberian MgSO₄ yang tepat, dan terminasi kehamilan yang tepat waktu
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Menurunkan angka kematian ibu bersalin dan memastikan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri berjalan optimal untuk kasus hipertensi dalam kehamilan
Definisi Operasional	Kematian ibu bersalin karena PEB adalah kematian yang terjadi pada masa persalinan atau masa nifas (hingga 42 hari setelah persalinan) yang disebabkan oleh komplikasi dari Pre-eklamsia Berat (seperti Gagal Ginjal, Edema Paru, Stroke Hemoragik, atau HELLP Syndrome)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu bersalin yang didiagnosa dengan Pre-eklamsia Berat (PEB)
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh ibu bersalin dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat (PEB)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua ibu bersalin atau nifas dengan diagnosa Pre-eklamsia Berat (PEB) yang meninggal dunia di rumah sakit Kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh penyebab lain di luar komplikasi PEB (misal: Perdarahan hebat/HPP tanpa PEB, Emboli air ketuban, atau Kecelakaan)
Formula	Jumlah kematian ibu dengan PEB
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal/AMP)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien Medis 2. Sertifikat Penyebab Kematian (Surat Kematian) 3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (Sentinel)

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Formulir Laporan Kematian.
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang Ponek 2. Komite PMKP

14. Kejadian Kematian Ibu Persalinan yang Disebabkan oleh Eklampsia

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu persalinan yang disebabkan oleh eklampsia				
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional 3. PNPK Tata Laksana Eklampsia: Eklampsia adalah penyebab kematian maternal tertinggi kedua di Indonesia 4. Kematian akibat eklampsia mencerminkan kualitas penanganan kegawatdaruratan (PONEK) di rumah sakit dalam menghentikan kejang dan mencegah komplikasi fatal				
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan				
Tujuan	Tergambarnya kualitas penanganan pasien eklampsia di rumah sakit serta upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)				
Definisi Operasional	Kematian ibu bersalin karena eklampsia adalah kematian yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas yang didahului dengan gejala kejang dan/atau koma yang bukan disebabkan oleh penyakit neurologis lain (seperti epilepsi atau meningitis)				
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☒	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian				
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu dengan diagnosa Eklampsia				
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnosa Eklampsia				
Target Pencapaian	0 kejadian				
Kriteria:	Semua pasien hamil, bersalin, atau nifas yang didiagnosa Eklampsia (dengan riwayat kejang) yang meninggal dunia di rumah sakit				
	• Inklusi • Eksklusi				
Formula	Jumlah kematian ibu dengan eklampsia				
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal)				

Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Sertifikat Penyebab Kematian (Surat Kematian) 3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (Sentinel)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Formulir Laporan Kejadian Sentinel
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang Ponek 2. Komite PMKP

15. Kejadian Kematian Ibu Karena HPP

Judul Indikator	Kejadian kematian ibu karena HPP			
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Nasional 3. PNPK Tata Laksana Perdarahan Pasca Salin: HPP adalah penyebab utama kematian maternal di Indonesia 4. Kematian akibat HPP mencerminkan kualitas manajemen kala III, kecepatan deteksi dini perdarahan, dan efektivitas tim PONEK dalam melakukan tindakan penyelamatan (seperti pemberian uterotonika, kompresi bimanual, hingga tindakan operatif)			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan			
Tujuan	Menurunkan angka kematian ibu akibat perdarahan dan mengevaluasi kesiapsiagaan tim medis dalam menangani kasus kegawatdaruratan obstetri			
Definisi Operasional	Kematian ibu karena HPP adalah kematian yang terjadi pada masa persalinan atau masa nifas yang disebabkan oleh kehilangan darah lebih dari 500 ml pada persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 ml pada persalinan Seksio Sesarea (SC)			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome ☒	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian			
Numerator (pembilang)	Jumlah kematian ibu bersalin dengan diagnosa Perdarahan Pasca Salin (HPP)			
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh pasien dengan diagnose Perdarahan Pasca Salin (HPP)			
Target Pencapaian	0 kejadian			
Kriteria:	Semua ibu bersalin atau nifas dengan diagnosa HPP (Atonia Uteri, Robekan Jalan Lahir, Retensio Plasenta, atau Gangguan Koagulasi) yang meninggal dunia di rumah sakit			
	• Inklusi • Eksklusi Kematian ibu yang disebabkan oleh penyebab non-obstetri atau komplikasi medis lain di luar perdarahan (misal: penyakit			

	jantung, eklampsia tanpa perdarahan)
Formula	Jumlah kematian ibu dengan HPP
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis & Audit Maternal Perinatal/AMP)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku Register Persalinan & Nifas 3. Laporan Kejadian Sentinel
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Maternal Perinatal (AMP)
Sampel	Total sampling atau sampling representatif sesuai jumlah kasus
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala ruang maternitas 2. Komite PMKP

16. Kejadian kematian Bayi di Rumah Sakit

Judul Indikator	Kejadian kematian bayi di rumah sakit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Negara menjamin hak kelangsungan hidup anak dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas 2. Target SDGS (Sustainable Development Goals): Menurunkan angka kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 3. Kematian bayi di rumah sakit merupakan indikator utama efektivitas pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) dan kualitas perawatan di NICU/Perinatologi
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kualitas pelayanan medis dan keperawatan di unit perinatal serta efektivitas sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan bayi
Definisi Operasional	Kematian bayi di rumah sakit adalah kematian yang terjadi pada bayi (usia 0-28 hari atau neonatal) yang dirawat di rumah sakit, tidak termasuk bayi yang datang dalam kondisi sudah meninggal (<i>Death on Arrival</i>) atau bayi dengan kelainan kongenital yang tidak memungkinkan untuk hidup (<i>Lethal Anomaly</i>)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah seluruh kematian bayi (usia 0-28 hari) yang terjadi di rumah sakit
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi (usia 0-28 hari) yang dirawat di rumah sakit

Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua bayi yang lahir di RS maupun rujukan yang meninggal saat dalam perawatan - Bayi Baru Lahir Rendah Ekstrem (BB < 1000 gr) jika RS belum memiliki fasilitas NICU Level 3 - Bayi dengan kelainan kongenital berat (misal: Anensefali) <i>Stillbirth</i> (Lahir mati/kematian janin dalam kandungan)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total seluruh bayi yang dirawat dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	- Buku Register Kematian - Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Audit Kematian (Audit Maternal Perinatal / AMP)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala Ruang Ponek - Dokter Spesialis Anak - Komite PMKP - Kepala Bidang Pelayanan

3.3.11. Neonatologi

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal

6.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional
7.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
8.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
9.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
10.	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir	0 kejadian	UNIT
11.	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha napas (< 1 menit)	100%	UNIT
12.	Prosentase Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-piece resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit	100%	UNIT
13.	Prosentase Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500- 2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari	100%	UNIT
14.	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi	100%	UNIT
15.	Kejadian kematian bayi di Rumah Sakit	0 kejadian	UNIT
16.	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	UNIT

3.3.11.1 Profil Indikator Mutu Neonatologi

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
-----------------	-------------------------------

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : a. Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. b. Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. c. Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan

	pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: Inklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia

• Eksklusi	lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan

Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

5. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan waktu visit dokter ≤14.00 WIB
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). - Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. - Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	- Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. - Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. - Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. - Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). - Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB Jumlah total visit yang dijadwalkan X 100%

Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visite dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

6. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Judul Indikator	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) - PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. - KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). - Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. - Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: - Hipertensi - Diabetes melitus - TB - HIV - Keganasan - Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	Clinical Pathway adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit.

	2. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur 1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien dalam perkembangan pelayanan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya

7. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. 1. Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. 2. Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Survei langsung setelah perawatan medis selesai. 2. Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei

Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

8. Kepatuhan Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan bidan terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (<i>Situation, Background, Assessment, Recommendation</i>) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien.

• Inklusi • Eksklusi	2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi _____ X 100% Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. <i>Review</i> rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

9. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert

Judul Indikator	Kepatuhan staf farmasi dalam penempelan stiker LASA dan high alert
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Fasilitas kesehatan wajib menjamin keamanan penggunaan obat. 2. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) 3: Obat <i>High Alert</i> dan LASA memiliki risiko tinggi menyebabkan cedera serius jika terjadi kesalahan. Farmasi adalah lini pertama dalam pelabelan. 3. Standarisasi pelabelan di farmasi memastikan perawat di ruang rawat inap mendapatkan obat yang sudah teridentifikasi risikonya dengan jelas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan seluruh obat yang masuk kategori waspada tinggi telah teridentifikasi dan diberi label yang sesuai di instalasi farmasi sebelum diserahkan ke unit lain.
Definisi Operasional	Kepatuhan staf farmasi adalah tindakan petugas farmasi (Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian) dalam menempelkan:

	1. Stiker Merah (High Alert) pada obat risiko tinggi (misal: elektrolit pekat, insulin). 2. Stiker Kuning (LASA) pada obat yang nama atau rupa sediaanannya mirip. Pelabelan dilakukan pada setiap satuan terkecil sediaan atau wadah obat sesuai kebijakan RS.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah sediaan obat <i>High Alert</i> dan LASA yang ditemukan sudah ditempel stiker dengan benar saat audit di Instalasi Farmasi
Denominator (penyebut)	Total seluruh sediaan obat <i>High Alert</i> dan LASA yang diobservasi (disampling) di Instalasi Farmasi pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh stok obat <i>High Alert</i> dan LASA yang ada di gudang farmasi, apotek rawat jalan, dan apotek rawat inap Obat yang labelnya sudah tercetak langsung dari pabrik (jika ada kebijakan khusus RS)
Formula	$\frac{\text{Jumlah sediaan obat } \textit{High Alert} \text{ dan LASA yang ditemukan sudah ditempel stiker dengan benar saat audit di Instalasi Farmasi}}{\text{Total seluruh sediaan obat } \textit{High Alert} \text{ dan LASA yang diobservasi (disampling) di Instalasi Farmasi pada bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi langsung melalui audit internal farmasi secara berkala)
Sumber data	1. Daftar Stok Obat Farmasi 2. Lembar Audit Kepatuhan Labeling
Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>Checklist</i> Monitoring Labeling Farmasi
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Farmasi 3. Komite PMKP

10. Kejadian Tidak Dilakukan IMD pada Bayi Baru Lahir

Judul Indikator	Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir
Dasar pemikiran	1. PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 3. IMD selama minimal 1 jam terbukti menurunkan risiko kematian neonatal dan membantu kontraksi uterus ibu (mencegah HPP) 4. Standar Akreditasi RS mengenai Pelayanan Ibu dan Bayi

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Menurunkan angka kegagalan IMD dan memastikan setiap bayi baru lahir mendapatkan haknya untuk segera bersentuhan kulit dengan ibu dan menyusu dalam satu jam pertama
Definisi Operasional	Kejadian tidak dilakukan IMD adalah kondisi di mana bayi baru lahir tidak diletakkan di dada ibunya (<i>skin-to-skin</i>) untuk berusaha menyusu sendiri selama minimal 60 menit segera setelah lahir, kecuali ada indikasi medis pada ibu atau bayi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah bayi baru lahir yang tidak dilakukan IMD minimal 60 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh bayi yang lahir hidup di rumah sakit
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua bayi yang lahir hidup (baik pervaginam maupun SC dengan anestesi regional) 1. Bayi dengan asfiksia berat atau memerlukan resusitasi segera 2. Bayi dengan kelainan kongenital yang mengancam nyawa 3. Ibu dengan kondisi medis tidak stabil (misal: perdarahan hebat, eklampsia, atau sedang dalam anestesi umum/total) 4. Bayi lahir mati (<i>Stillbirth</i>)
Formula	Jumlah bayi baru lahir yang tidak dilakukan IMD
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis) atau <i>Concurrent</i> (Observasi)
Sumber data	1. Rekam Medis Bayi (Lembar Asuhan Bayi Baru Lahir) 2. Register Persalinan (VK & OK)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan IMD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan

11. Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada Bayi Baru Lahir Tanpa Ada usaha Napas (<1 Menit)

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam melakukan tindakan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) pada bayi baru lahir tanpa ada usaha
-----------------	---

	napas (<1 menit)
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal guna menurunkan angka kematian bayi - Permenkes No. 25 Tahun 2014: Tentang Upaya Kesehatan Anak, di mana resusitasi neonatus yang tepat adalah kunci pencegahan asfiksia <i>The Golden Minute</i> (Menit Keemasan) adalah standar internasional di mana bayi yang tidak bernapas harus mendapatkan bantuan napas (VTP) dalam 60 detik pertama untuk mencegah kerusakan otak permanen atau kematian
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kesiapan dan kompetensi petugas (Bidan/Perawat/Dokter) dalam memberikan penanganan kedaruratan pernapasan pada bayi baru lahir secara cepat dan tepat sesuai standar resusitasi
Definisi Operasional	Kepatuhan VTP < 1 menit adalah tindakan pemberian bantuan napas menggunakan balon mengembang sendiri (<i>ambubag</i>) dan sungkup yang dilakukan oleh petugas kepada bayi baru lahir yang tidak bernapas atau megap-megap, di mana tindakan tersebut sudah dimulai sebelum bayi berusia 60 detik
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah bayi baru lahir tanpa usaha napas yang mendapatkan tindakan VTP dalam waktu kurang dari 1 menit setelah lahir
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi baru lahir tanpa usaha napas (asfiksia) yang lahir di rumah sakit
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua bayi lahir hidup yang tidak bernapas atau megap-megap segera setelah lahir - Bayi dengan kelainan kongenital berat yang tidak memungkinkan resusitasi (misal: Anensefali) - Bayi yang lahir di luar rumah sakit (datang dalam kondisi sudah asfiksia)
Formula	$\frac{\text{Jumlah bayi asfiksia dengan VTP < 1 menit}}{\text{Jumlah total seluruh bayi asfiksia yang lahir}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	- Rekam Medis Bayi (Lembar Asuhan Bayi Baru Lahir) - Register Persalinan (VK & OK)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir audit resusitasi neonatus
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Komite PMKP 3. Kepala Bidang Pelayanan

12. Prosentase Bayi Baru Lahir yang Mengalami Sesak Napas yang Mendapatkan T-Piece Resuscitator/CPAP dalam Waktu 2 Menit

Judul Indikator	Bayi baru lahir yang mengalami sesak napas yang mendapatkan T-Piece Resuscitator/CPAP dalam waktu 2 menit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mewajibkan pemberian pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat untuk menurunkan angka kematian bayi - Pedoman Resusitasi Neonatus (IDAI/PONEK): Menekankan bahwa bantuan napas yang stabil dengan tekanan akhir ekspirasi positif (PEEP) melalui CPAP atau T-Piece harus diberikan segera setelah bayi lahir dengan gangguan napas untuk mencegah kolaps paru (alveoli) - Kecepatan tindakan dalam 2 menit pertama sangat menentukan prognosis jangka panjang bayi
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya respon cepat petugas medis dalam menangani bayi dengan gangguan napas guna mencegah terjadinya gagal napas dan komplikasi lebih lanjut
Definisi Operasional	Kecepatan pemberian alat bantu napas adalah waktu yang dibutuhkan petugas (sejak bayi lahir atau sejak mulai timbul tanda sesak napas) hingga bayi terpasang alat <i>T-Piece Resuscitator</i> atau CPAP secara benar, dengan standar waktu maksimal 2 menit
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah bayi baru lahir yang mengalami sesak napas dan mendapatkan T-Piece/CPAP dalam waktu menit
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi baru lahir yang mengalami sesak napas di rumah sakit
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua bayi lahir hidup yang menunjukkan tanda sesak napas (merintih, retraksi, napas cuping hidung, atau sianosis) segera setelah lahir - Bayi dengan kelainan anatomi wajah yang tidak memungkinkan pemasangan CPAP/T-Piece - Bayi yang memerlukan intubasi segera (resusitasi lanjut)
Formula	Jumlah bayi sesak dengan penanganan dalam kurun waktu 2 menit

	$\frac{\text{Jumlah total seluruh bayi baru lahir yang sesak dalam periode pengukuran}}{\text{Jumlah total seluruh bayi baru lahir yang sesak dalam periode pengukuran}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis Pasien 2. Buku Register Perinatologi
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Audit Penanganan Gangguan Napas Neonatus
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Dokter Spesialis Anak 3. Komite PMKP 4. Kepala Bidang Pelayanan

13. Prosentase Bayi Baru Lahir Hidup Stabil Berat Lahir 1500-2000 gr yang Mendapatkan Perawatan Metode Kanguru Minimal 1 Jam per Hari

Judul Indikator	Bayi baru lahir hidup stabil berat lahir 1500-2000 gr yang mendapatkan perawatan metode kanguru minimal 1 jam per hari
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas guna menekan angka kematian neonatal - KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Tata Laksana BBLR: PMK adalah standar emas untuk mencegah hipotermia, infeksi, dan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif - PMK minimal 1 jam per hari secara kontinu (kontak kulit ke kulit) terbukti secara klinis menstabilkan denyut jantung dan pernapasan bayi serta memperpendek masa rawat di rumah sakit
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya komitmen unit perinatologi dalam memberikan asuhan perkembangan bagi BBLR guna mencegah komplikasi hipotermia dan mempercepat kemandirian orang tua dalam merawat bayi
Definisi Operasional	Perawatan Metode Kanguru (PMK) adalah kontak kulit ke kulit (<i>skin-to-skin contact</i>) antara bayi dengan ibu/ayah/anggota keluarga lainnya, di mana bayi hanya memakai popok dan topi di posisi tegak dalam dekapan. Tindakan dinyatakan patuh jika dilakukan minimal 1 jam secara terus-menerus dalam satu hari pada bayi dengan berat lahir 1500-2000 gr yang sudah dinyatakan stabil
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah bayi baru lahir hidup berat 1500-2000 gr yang stabil dan mendapatkan PMK minimal 1 jam per hari
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi baru lahir hidup dengan berat 1500-2000 gr yang dirawat dan dalam kondisi stabil
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Bayi BBLR (1500-2000 gr) yang secara klinis stabil (napas spontan, suhu stabil di inkubator, tidak ada kegawatan) - Bayi dengan gangguan pernapasan berat yang memerlukan alat bantu napas kontinu - Bayi dengan kelainan jantung bawaan atau infeksi berat (Sepsis) yang tidak stabil - Ibu dengan kondisi medis yang tidak memungkinkan melakukan PMK (misal: perdarahan hebat atau gangguan jiwa)
Formula	$\frac{\text{Jumlah bayi BBLR stabil dengan PMK} \geq 1 \text{ jam}}{\text{Jumlah total seluruh bayi BBLR stabil yang dirawat}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan harian pada lembar observasi PMK atau catatan keperawatan)
Sumber data	- Rekam medis pasien - Buku register ruang neonatologi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir audit resusitasi neonatus
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	- Kepala Ruang Neonatologi - Komite PMKP - Kepala Bidang Pelayanan

14. Kepatuhan DPJP dalam Pemberian Antibiotik pada BBL Infeksi

Judul Indikator	Kepatuhan DPJP dalam pemberian antibiotik pada BBL infeksi
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien - Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Sepsis Neonatorum: Infeksi pada bayi baru lahir adalah kegawatdaruratan medis. Pemberian antibiotik empiris yang tepat dosis, tepat jenis, dan tepat waktu (segera setelah pengambilan sampel kultur/skrining) sangat menentukan angka kelangsungan hidup bayi - Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan DPJP patuh terhadap formularium rumah sakit dan panduan praktik klinis (PPK)

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan DPJP Anak dalam menerapkan standar terapi antibiotik guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat infeksi neonatal
Definisi Operasional	Kepatuhan DPJP adalah kesesuaian instruksi pengobatan antibiotik oleh Dokter Spesialis Anak pada bayi baru lahir terdiagnosa infeksi (Sepsis/Suspek Sepsis) yang memenuhi kriteria 4 Tepat: 1. Tepat Indikasi (berdasarkan klinis/laboratorium). 2. Tepat Jenis (sesuai lini pertama/kedua PPK RS). 3. Tepat Dosis (sesuai berat badan dan usia gestasi). 4. Tepat Waktu (Antibiotik dosis pertama diberikan ≤1 jam setelah instruksi/diagnosis ditegakkan).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah BBL infeksi yang mendapatkan terapi antibiotik sesuai standar (4 Tepat) oleh DPJP
Denominator (penyebut)	Total seluruh BBL dengan diagnosa infeksi yang dirawat
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua BBL (0-28 hari) yang didiagnosa Sepsis, Suspek Sepsis, atau Infeksi Tali Pusat berat yang dirawat di Perinatologi/NICU 1. Pasien yang pulang paksa sebelum terapi lengkap 2. Pasien rujukan yang sudah mendapatkan antibiotik lengkap dari faskes sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah BBL infeksi dengan terapi tepat}}{\text{Jumlah total seluruh BBL infeksi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Rekam Medis (Lembar CPPT dan Lembar Pemberian Obat) 2. Buku Register Neonatologi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Penggunaan Antibiotik (Sesuai PPK)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Komite PPRA 3. Komite PMKP 4. Kepala Bidang Pelayanan

15. Kejadian Kematian Bayi di Rumah Sakit

Judul Indikator	Kejadian kematian bayi di rumah sakit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Negara menjamin hak kelangsungan hidup anak dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas - Target SDGS (Sustainable Development Goals): Menurunkan angka kematian neonatal hingga setidaknya 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 - Kematian bayi di rumah sakit merupakan indikator utama efektivitas pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) dan kualitas perawatan di NICU/Perinatologi
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kualitas pelayanan medis dan keperawatan di unit perinatal serta efektivitas sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan bayi
Definisi Operasional	Kematian bayi di rumah sakit adalah kematian yang terjadi pada bayi (usia 0-28 hari atau neonatal) yang dirawat di rumah sakit, tidak termasuk bayi yang datang dalam kondisi sudah meninggal (<i>Death on Arrival</i>) atau bayi dengan kelainan kongenital yang tidak memungkinkan untuk hidup (<i>Lethal Anomaly</i>)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah seluruh kematian bayi (usia 0-28 hari) yang terjadi di rumah sakit
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi (usia 0-28 hari) yang dirawat di rumah sakit
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua bayi yang lahir di RS maupun rujukan yang meninggal saat dalam perawatan - Bayi Baru Lahir Rendah Ekstrem (BB < 1000 gr) jika RS belum memiliki fasilitas NICU Level 3 - Bayi dengan kelainan kongenital berat (misal: Anensefali) <i>Stillbirth</i> (Lahir mati/kematian janin dalam kandungan)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total seluruh bayi yang dirawat dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	- Buku Register Kematian - Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Audit Kematian (Audit Maternal Perinatal / AMP)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Dokter Spesialis Anak 3. Komite PMKP 4. Kepala Bidang Pelayanan

16. Kemampuan Menangani BBLR 1500-2500 gr

Judul Indikator	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan pentingnya pelayanan kesehatan neonatal untuk menurunkan angka kematian bayi - KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 (Standar Pelayanan Kedokteran Tata Laksana BBLR): Bayi dengan berat 1500-2500 gr umumnya memiliki risiko komplikasi (hipotermia, hipoglikemia, gangguan napas) yang dapat ditangani di RS tipe C/B dengan asuhan yang tepat - Indikator ini mengukur keberhasilan rumah sakit dalam merawat BBLR hingga stabil/pulang tanpa perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kompetensi staf medis dan kecukupan sarana prasarana unit perinatologi dalam merawat bayi prematur/BBLR sesuai standar klinis
Definisi Operasional	Kemampuan menangani BBLR adalah keberhasilan perawatan bayi dengan berat lahir 1500 gr hingga 2500 gr yang dirawat di rumah sakit hingga mencapai kriteria pulang (berat badan naik, suhu stabil, refleks isap baik) tanpa mengalami kematian atau dirujuk ke RS lain karena ketidakmampuan fasilitas
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah bayi berat lahir 1500 gr – 2500 gr yang dirawat dan berhasil pulang (sembuh/stabil)
Denominator (penyebut)	Total seluruh bayi dengan berat lahir 1500 gr – 2500 gr yang dirawat di unit perinatologi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua BBLR dengan berat lahir 1500 gr s/d 2500 gr yang lahir di RS tersebut atau rujukan masuk
	- Bayi yang pulang atas permintaan sendiri (PAPS) - Bayi dengan kelainan kongenital berat yang memerlukan pembedahan segera (misal: <i>gastroschisis</i>) - Bayi yang dirujuk karena fasilitas NICU (ventilator) penuh (bukan karena ketidakmampuan medis)
Formula	$\frac{\text{Jumlah BBLR (1500-2500gr) yang pulang sembuh}}{\text{Jumlah total seluruh BBLR (1500-2500gr) yang dirawat}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	1. Buku Register Neonatologi 2. Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Pasien Pulang Unit Neonatologi
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Neonatologi 2. Dokter Spesialis Anak 3. Komite PMKP 4. Kepala Bidang Pelayanan

3.3.12. ICU

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB	≥ 80 %	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
7.	Kepatuhan crosscheck ulang penempelan stiker LASA dan High Alert oleh petugas ranap	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
8.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi di tubuh pasien	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 4 (ISKP 4)

	radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan

Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain-lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang

	digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. 3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan	Triwulan

data	
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepatuhan Waktu Visite Dokter ≤14.00 WIB

Judul Indikator	Kepatuhan Waktu Visite Dokter
Dasar pemikiran	- UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang berkesinambungan dan tepat waktu - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Visite tepat waktu penting untuk pengambilan keputusan klinis yang cepat (perubahan terapi, pemulangan pasien, atau tindakan medis lainnya). - Standar Akreditasi (STARKES) Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) wajib melakukan evaluasi pasien secara rutin dan mendokumentasikannya. - Pelayanan kesehatan harus berorientasi kepada kebutuhan pasien, bukan kepada keinginan rumah sakit.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	- Tergambarnya kepatuhan dokter melakukan visitasi kepada pasien rawat inap sesuai waktu yang ditetapkan. - Waktu yang ditetapkan untuk visite adalah pukul 06.00 – 14.00.
Definisi Operasional	Kepatuhan Waktu Visite Dokter (<14.00 WIB) adalah Prosentase jumlah visite atau pemeriksaan pasien yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit pada waktu sebelum pukul 14.00 WIB, dibandingkan dengan seluruh visite yang dijadwalkan pada hari tersebut.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dari jumlah visite yang dilakukan oleh dokter sebelum pukul 14.00 WIB
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang di-visite dokter pada pukul 06.00 – 14.00
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua pasien yang dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh dokter pada hari tertentu di rumah sakit. - Semua dokter yang dijadwalkan untuk melakukan visite pasien di rumah sakit pada hari yang sama. - Dokter yang tidak melakukan visite karena alasan sah (misalnya sakit atau ketidakhadiran yang terjadwal). - Pasien yang sudah keluar rumah sakit (pulang) sebelum dokter melakukan visite.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dokter Visit Sebelum Pukul 14.00 WIB}}{\text{Jumlah total visit yang dijadwalkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	<i>Retrospektif</i>

Data	
Sumber data	Data sekunder dari catatan pasien untuk memastikan waktu visite tercatat dengan jelas
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pencatatan waktu visit dokter
Sampel	Pasien yang menerima visite pada periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medis

5. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang

	dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	• Inklusi • Eksklusi
	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

6. Kepatuhan PPA Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan

	pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	• Inklusi 1. Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. 2. Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. • Eksklusi 1. Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. 2. Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. <i>Concurrent</i> dengan observasi langsung 2. Review rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	1. Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis 2. Rekam Medis Pasien 3. Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

7. Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas ICU

Judul Indikator	Kepatuhan Crosscheck Ulang Penempelan Stiker LASA dan High Alert oleh Petugas ICU
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin keamanan penggunaan sediaan farmasi. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) III, yaitu Meningkatkan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai (<i>High-Alert Medications</i>). - Mencegah kejadian <i>Medication Error</i> akibat kesalahan pengambilan obat yang memiliki nama/rupa mirip (LASA) atau obat dengan risiko fatal tinggi (High Alert).
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Memastikan seluruh obat kategori <i>High Alert</i> dan LASA yang diserahkan kepada pasien rawat inap telah teridentifikasi dengan benar melalui label/stiker khusus. - Membudayakan proses verifikasi ganda (<i>double check</i>) antar petugas farmasi sebelum obat diserahkan
Definisi Operasional	Kepatuhan <i>crosscheck</i> ulang adalah tindakan petugas farmasi rawat inap dalam melakukan verifikasi kedua (pemeriksaan ulang) untuk memastikan: - Obat LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) telah ditemplei stiker berwarna kuning (sesuai SPO RS). - Obat High Alert (misal: Insulin, Agonis Adrenergik, dll) telah ditemplei stiker berwarna merah. - Proses ini dilakukan oleh petugas yang berbeda dari petugas yang menyiapkan obat (prinsip <i>double check</i>).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> dan penempelan stiker secara benar saat observasi.
Denominator (penyebut)	Jumlah total resep obat rawat inap berisi LASA/High Alert yang diobservasi pada periode tersebut.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua sediaan farmasi yang masuk dalam daftar obat LASA dan High Alert sesuai Keputusan Direktur RS yang dilayani di Depo Farmasi Rawat Inap. Obat-obatan yang dibawa sendiri oleh pasien dari rumah (namun tetap harus diproses sesuai prosedur rekonsiliasi obat)
Formula	Jumlah resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang telah dilakukan <i>crosscheck</i> X 100%

	Jumlah total resep obat rawat jalan berisi LASA/High Alert yang diobservasi
Metode Pengumpulan Data	Observasi Langsung (<i>Concurrent</i>) melalui audit fasilitas dan telaah resep/etiket.
Sumber data	Lembar Checklist Monitoring Obat Beresiko Tinggi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Monitoring LASA & <i>High Alert</i> .
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rawat Inap 2. Kepala Bidang Pelayanan

8. Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi di Tubuh Pasien
Dasar pemikiran	Kesalahan lokasi operasi (<i>wrong-site surgery</i>) adalah kejadian yang tidak seharusnya terjadi (<i>never event</i>). Penandaan lokasi yang dilakukan oleh operator sangat penting untuk memastikan prosedur dilakukan pada sisi dan bagian tubuh yang benar sesuai rencana tindakan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mencegah terjadinya kesalahan lokasi operasi dan memastikan prosedur dilakukan pada pasien, lokasi, dan sisi tubuh yang benar.
Definisi Operasional	Penandaan Lokasi Operasi (Surgical Site Marking) adalah pemberian tanda menggunakan simbol/tanda yang seragam dan permanen (tidak luntur saat dicuci dengan antiseptik) pada sisi tubuh pasien yang akan dioperasi. Tanda harus dibuat oleh dokter operator yang akan melakukan tindakan saat pasien masih dalam keadaan sadar (jika memungkinkan) sebelum dipindah ke kamar operasi.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang telah dilakukan penandaan lokasi operasi secara benar oleh dokter operator sebelum tindakan dimulai dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang direncanakan menjalani prosedur operasi yang memerlukan penandaan lokasi dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: Inklusi	Semua pasien yang akan menjalani operasi yang melibatkan: - Perbedaan sisi (lateralitas: kanan/kiri). - Struktur multipel (jari tangan, jari kaki, lesi). - Tingkatan level (tulang belakang/vertebra).

Eksklusi	1. Operasi pada organ tunggal (misal: Caesar, Jantung, Apendektomi). 2. Prosedur endoskopi/intervensi radiologi. 3. Kasus gawat darurat yang mengancam nyawa. 4. Prosedur pada luka terbuka atau fraktur terbuka yang lokasinya sudah jelas.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang ditandai secara benar}}{\text{Jumlah total pasien yang wajib ditandai}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	2. Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) dan Audit Rekam Medis.
Sumber data	4. Asesmen pra bedah 5. Surgical Safety Checklist 6. Laporan Operasi
Instrumen Pengambilan Data	2. Formulir <i>Checklist</i> Kepatuhan Penandaan Lokasi Operasi.
Sampel	Total Sampling (Jika jumlah operasi < 30 per bulan) atau Sampling representatif sesuai rumus Slovin.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang ICU Kepala Ruang Instalasi Kamar Operasi

9. Angka Pasien yang Kembali ke Perawatan Intensif dengan Kasus yang Sama < 72 Jam

Judul Indikator	Angka pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017: Menjamin keselamatan pasien melalui asuhan yang berkesinambungan. 2. Standar Akreditasi (STARKES): Menilai efektivitas pelayanan unit intensif dan ketepatan pengambilan keputusan saat pasien dipindahkan ke ruang rawat inap. 3. Pemindahan pasien yang terlalu dini (<i>premature discharge</i>) dapat meningkatkan risiko kejadian tidak diharapkan (KTPD) dan memperburuk <i>outcome</i> klinis pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan ☒
Tujuan	Tergambarnya efektivitas pelayanan unit intensif dan ketepatan kriteria pemindahan pasien ke ruang rawat inap
Definisi Operasional	Kejadian pasien kembali ke ICU adalah kembalinya pasien yang telah dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap dalam waktu kurang dari 72 jam sejak dipindahkan, dengan diagnosis atau keluhan yang sama (bukan karena kondisi baru yang tidak berhubungan)
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total pasien yang dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap pada bulan yang sama

Target Pencapaian	≤ 3%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien yang dipindahkan dari ICU ke runag rawat inap 1. Pasien yang kembali ke ICU karena kasus/diagnosis baru yang berbeda sama sekali 2. Pasien yang memang direncanakan untuk tindakan tertentu (misal: paska operasi terjadwal)
Formula	Jumlah pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam $\frac{\text{Jumlah pasien yang kembali ke ICU dengan kasus yang sama dalam waktu < 72 jam}}{\text{Jumlah total pasien yang dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit rekam medis dan buku register ICU)
Sumber data	1. Rekam medis 2. SIMRS
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring pasien pindah rawat
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang ICU 2. Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Pengisian Pengkajian Form Kriteria Keluar Masuk ICU pada Pasien ICU

Judul Indikator	Kepatuhan pengisian pengkajian form kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017: Keselamatan pasien dipengaruhi oleh ketepatan penempatann pasien di unit yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Standar Akreditasi (STARKES): Rumah sakit harus menetapkan kriteria masuk dan keluar unit pelayanan intensif untuk memastikan prioritas pasien kritis terpenuhi. 3. Pengisian form yang lengkap menjadi bukti legal dan klinis bahwa pasien yang dirawat di ICU benar-benar membutuhkan observasi ketat atau intervensi agresif.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketertiban administrasi klinis dan standarisasi proses triase pasien ICU agar penggunaan sumber daya intensif tepat sasaran
Definisi Operasional	Kepatuhan pengisian adalah terisinya seluruh elemen data dalam formulir kriteria masuk dan keluar ICU secara lengkap (100%) oleh DPJP atau dokkter jaga yang diberi wewenang, mencakup: 1. Parameter fisiologis (tanda vital, kesadaran) 2. Penentuan skala prioritas (prioritas 1, 2, atau 3) 3. Kriteria penghentian perawatan intensif saat pasien pindah
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah formulir kriteria masuk dan keluar ICU yang terisi lengkap dan benar sesuai standar dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total pasien yang masuk dan keluar dari ICU pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua rekam medis pasien yang dirawat di ICU (termasuk ICU isolasi) Pasien yang meninggal dalam waktu < 2 jam setelah masuk ICU (kondisi DOA/Death on Arrival di ICU)
Formula	$\frac{\text{Jumlah form kriteria ICU yang lengkap}}{\text{Jumlah total pasien masuk dan keluar ICU dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit Dokumen Rekam Medis paska pasien keluar)
Sumber data	Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kelengkapan rekam medis ICU
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	- Kepala Ruang ICU - Kepala Bidang Pelayanan

11. Kepatuhan Waktu Pelayanan Dokter di ICU Isolasi (≤ 30 menit)

Judul Indikator	Kepatuhan waktu pelayanan dokter di ICU isolasi (≤ 30 menit)
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan hak pasien atas pelayanan yang aman, bermutu, dan cepat terutama pada kondisi kritis. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Ketepatan waktu pelayanan adalah kunci mencegah Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). - Pasien di ICU Isolasi memiliki kompleksitas tinggi (infeksius dan kritis), sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk kondisi klinis dan meningkatkan risiko kematian.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan kesiapsiagaan dokter (DPJP atau Dokter Jaga) dalam memberikan pelayanan medis di area isolasi intensif guna menjamin keselamatan pasien
Definisi Operasional	Waktu pelayanan dokter adalah durasi sejak dokter mendapatkan laporan dari perawat mengenai kondisi pasien atau kebutuhan konsultasi di ICU Isolasi, hingga dokter tiba di sisi pasien (<i>bedside</i>) dan mulai melakukan tindakan

	medis/pemeriksaan, dengan standar waktu maksimal 30 menit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pelayanan dokter di ICU Isolasi yang dilakukan dalam waktu ≤ 30 menit sejak dilaporkan/dikonsultasikan dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh kejadian pelayanan/konsultasi dokter yang dibutuhkan di ICU Isolasi pada bulan yang sama
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria:	Seluruh permintaan pelayanan dokter untuk pasien yang dirawat di ruang ICU Isolasi
• Inklusi	1. Kondisi bencana alam atau gangguan teknis Gedung 2. Dokter sedang menangani pasien lain dengan kondisi <i>Code Blue</i> (henti jantung/napas)
• Eksklusi	
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan dokter} \leq 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah total pelayanan dokter yang dibutuhkan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan langsung pada buku observasi atau lembar monitoring ICU)
Sumber data	1. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 2. Lembar Monitoring Perawa
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Respon Time Dokter ICU Isolasi
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang ICU 2. Kepala Bidang Pelayanan

12. Kepatuhan Pembersihan dan Desinfeksi Ruangan

Judul Indikator	Kepatuhan pembersihan dan desinfeksi ruangan
Dasar pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI: Lingkungan rumah sakit (lantai, dinding, dan permukaan datar) merupakan reservoir kuman 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Menjamin keamanan lingkungan bagi pasien untuk mencegah transmisi patogen 3. Pembersihan yang tidak adekuat meningkatkan risiko infeksi silang antar pasien dan petugas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mewujudkan lingkungan perawatan yang bersih, kering, dan aman guna memutus rantai penularan infeksi melalui

	kepatuhan prosedur dekontaminasi
Definisi Operasional	Kepatuhan pembersihan dan desinfeksi adalah pelaksanaan pembersihan ruangan oleh petugas (Cleaning Service/Perawat) yang memenuhi kriteria: 1. Tepat waktu: rutin (minimal 2x sehari) dan <i>terminal cleaning</i> (saat pasien pulang/pindah) 2. Tepat metode: teknik mengelap (<i>wiping</i>) satu arah, tidak menyapu kering di area klinis 3. Tepat cairan: menggunakan desinfektan (misal: klorin atau alkohol) dengan konsentrasi sesuai standar
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ruangan/area yang dibersihkan dan didesinfeksi sesuai standar prosedur operasional (SPO) dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh ruangan/area yang diobservasi pada bulan yang sama
Target Pencapaian	≥ 95%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua ruang perawatan, ruang tindakan, dan area publik (toilet/tunggu) Ruangan yang sedang dikosongkan untuk renovasi fisik
Formula	$\frac{\text{Jumlah ruangan yang patuh standar}}{\text{Jumlah ruangan yang diaudit dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi langsung menggunakan daftar tilik atau uji petik visual)
Sumber data	1. Checklist pembersihan harian 3. Laporan supervise IPCN
Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring kebersihan lingkungan
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang ICU 2. Komite PPI

3.3.13. Radiologi

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)

3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
5.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan Staf menjalankan SPO	0%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit Manajemen Risiko
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
7.	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam	≥ 80%	UNIT
8.	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi	0%	UNIT
9.	Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi	0%	UNIT
10.	Kejadian kesalahan cetak hasil radiologi	0 kejadian	UNIT

3.3.13.1 Profil Indikator Mutu Radiologi

1. Kepatuhan identifikasi pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara

	benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : - Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. - Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. - Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. - Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan kebersihan tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan

	Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (alcohol-based handrubs) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: - Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. - Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. - Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. - Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. - Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan

	tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh.

	3. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: a. Assessment awal risiko jatuh b. Assessment ulang risiko jatuh c. Intervensi pencegahan risiko jatuh 2. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya

	berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

5. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.

Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. 1. Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. 2. Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Survei langsung setelah perawatan medis selesai. 2. Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Kepala bagian humas
------------------	---------------------

6. Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan staf menjalankan SPO

Judul Indikator	Angka Kerusakan Alat Medis karena Ketidakpatuhan staf menjalankan SPO
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, termasuk dalam penggunaan alat kesehatan yang aman dan layak pakai. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit: Menyebutkan bahwa rumah sakit wajib melakukan pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan medis secara berkala untuk menjaga fungsi dan keamanan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan: Menekankan bahwa alat kesehatan harus dioperasikan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan prosedur operasional agar tidak membahayakan pasien maupun pengguna. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit: Mewajibkan rumah sakit untuk memantau indikator mutu nasional maupun unit, di mana manajemen risiko dan keselamatan peralatan medis merupakan bagian dari manajemen mutu. 5. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES): Khususnya pada bab Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), yang mensyaratkan rumah sakit memiliki program pengelolaan peralatan medis untuk mengurangi risiko klinis dan finansial akibat kerusakan alat yang tidak seharusnya terjadi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya disiplin staf dalam mengoperasikan alat medis sesuai standar guna mencegah kerusakan alat dan menjamin kelancaran pelayanan.
Definisi Operasional	1. Kerusakan Alat Medis: Kondisi di mana alat tidak dapat berfungsi atau mengalami penurunan fungsi yang dinyatakan rusak setelah dilakukan pemeriksaan teknis oleh unit IPSRS/Teknisi Medik. 2. Ketidakpatuhan SPO: Tindakan operasional yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang tertera dalam SPO penggunaan, pembersihan, atau penyimpanan alat.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kerusakan alat medis yang disebabkan oleh ketidakpatuhan staf terhadap SPO dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total jumlah kejadian kerusakan alat medis yang dilaporkan dalam satu bulan yang sama
Target Pencapaian	0%

Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua kerusakan alat medis yang setelah diinvestigasi/audit terbukti karena kesalahan prosedur (misal: salah tegangan listrik, salah sterilisasi, jatuh karena tidak dikunci)
	Kerusakan alat karena usia teknis (<i>wear and tear</i>), cacat produksi, bencana alam, atau gangguan arus listrik eksternal (PLN)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kerusakan akibat ketidakpatuhan SPO}}{\text{Total Kejadian Kerusakan Alat Medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Retrospektif dan observasi melalui audit investigasi
Sumber data	Laporan kerusakan alat dari unit kerja, Berita Acara Pemeriksaan Fisik IPSRS, dan Laporan Insiden.
Instrumen Pengambilan Data	Laporan kerusakan alat dari unit kerja, Berita Acara Pemeriksaan Fisik IPSRS, dan Laporan Insiden.
Sampel	Total Sampling (Seluruh alat medis yang dilaporkan rusak)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulanan).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Kepala Ruang Radiologi

7. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 1 jam

Judul Indikator	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto ≤ 1 jam
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menetapkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan tepat waktu sesuai dengan standar profesi. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi: Menyebutkan bahwa pelayanan radiologi harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan ketepatan hasil dan waktu pelayanan demi kepentingan diagnosis. 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES): Bab PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien): Menekankan pentingnya integrasi pelayanan penunjang dalam mendukung asuhan pasien yang cepat dan akurat
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan radiologi untuk pemeriksaan thorax foto guna mempercepat penegakan diagnosis dan tindak lanjut medis.
Definisi Operasional	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto adalah tenggang waktu mulai dari pasien selesai dilakukan penyinaran (eksposure) sampai dengan hasil keahlian (<i>expertise</i>) dokter spesialis radiologi diterima oleh unit pengirim/pasien.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah thorax foto non-kontras yang diselesaikan (sampai <i>expertise</i>) dalam waktu ≤ 1 jam dalam satu bulan.

Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pemeriksaan thorax foto non-kontras pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pemeriksaan thorax foto non-kontras (tanpa bahan kontras) baik dari pasien rawat jalan, rawat inap, maupun IGD. 1. Pemeriksaan thorax dengan kontras 2. Kerusakan alat radiologi (<i>force majeure</i>) 3. Pemeriksaan thorax foto cito (karena memiliki indikator/target waktu yang berbeda)
Formula	$\frac{\text{Jumlah thorax foto dengan waktu tunggu} \leq 1 \text{ jam}}{\text{Total seluruh pemeriksaan foto thorax}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Logbook Radiologi, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS/SIMRS), atau formulir permintaan radiologi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan waktu tunggu atau laporan data dari SIMRS.
Sampel	Total sampling atau menggunakan rumus Slovin jika jumlah populasi sangat besar.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulanan).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Radiologi Kepala Bidang Penunjang

8. Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi

Judul Indikator	Complain DPJP atas pembacaan hasil radiologi
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas diagnosis yang akurat. 2. PMK No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi: Menekankan pentingnya akurasi interpretasi radiologi untuk ketepatan terapi. 3. Keselamatan Pasien: Kesalahan interpretasi (<i>misdiagnosis</i>) dapat menyebabkan kesalahan prosedur medis atau pemberian obat. 4. Standar Akreditasi (STARKES): Fokus pada komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan (PPA) dan manajemen risiko klinis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya akurasi pembacaan hasil pemeriksaan radiologi oleh Dokter Spesialis Radiologi serta meminimalkan risiko kesalahan diagnosis klinis.
Definisi Operasional	Komplain DPJP: Adalah ketidaksesuaian (<i>discrepancy</i>) antara hasil pembacaan (<i>expertise</i>) Dokter Spesialis Radiologi dengan temuan klinis atau hasil pemeriksaan penunjang lain yang ditemukan oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang disampaikan secara resmi/terdokumentasi untuk dilakukan klarifikasi atau revisi.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah hasil <i>expertise</i> radiologi yang mendapatkan komplain/koreksi dari DPJP dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pemeriksaan radiologi yang dilakukan <i>expertise</i> pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua jenis pemeriksaan radiologi (Kontras, Non-Kontras, USG, CT-Scan, MRI) yang telah divalidasi oleh Dokter Spesialis Radiologi. - Permintaan diskusi/konsultasi biasa antara DPJP dan Radiologi (bukan komplain ketidaksesuaian). - Komplain terkait teknis (hasil cetakan buram, keterlambatan waktu) yang bukan merupakan masalah interpretasi klinis
Formula	$\frac{\text{Jumlah komplain ketidaksesuaian expertise}}{\text{Total jumlah seluruh expertise radiologi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Buku Log Komplain Radiologi, Formulir Revisi Expertise, atau Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan komplain klinis radiologi.
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulanan).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Radiologi Kepala Bidang Penunjang

9. Angka ketidaklengkapan form permintaan radiologi

Judul Indikator	Angka Ketidaklengkapan Form Permintaan Radiologi
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur tentang kewajiban dokumentasi medis yang akurat - PMK No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi: Menekankan pentingnya informasi klinis sebagai panduan pemilihan protokol radiologi yang tepat. - Keselamatan Pasien: Mencegah kesalahan identitas, lokasi anatomi yang akan difoto, dan paparan radiasi yang tidak perlu (<i>Justification</i>). - Administrasi & Klaim: Kelengkapan data (diagnosis/kode ICD-10) sangat krusial untuk validasi penagihan dan rekam medis.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketelitian dan kedisiplinan dokter pengirim dalam memberikan data klinis serta administratif agar pelayanan radiologi berjalan tepat sasaran.
Definisi Operasional	Formulir Permintaan Tidak Lengkap: Adalah formulir permintaan radiologi (baik manual maupun elektronik) yang

	diterima unit radiologi namun tidak terisi lengkap pada poin-poin wajib: identitas pasien (nama/RM), asal ruangan, keterangan klinis/diagnosis, jenis pemeriksaan, tanda tangan, dan nama dokter pengirim.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah formulir permintaan pemeriksaan radiologi yang tidak lengkap dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh formulir permintaan pemeriksaan radiologi yang masuk pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	0%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua formulir permintaan radiologi dari unit Rawat Jalan, Rawat Inap, dan IGD. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah formulir permintaan radiologi yang tidak lengkap}}{\text{Total jumlah seluruh formulir permintaan yang masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan sensus harian
Sumber data	Logbook penerimaan pasien radiologi dan Arsip formulir permintaan (hardcopy/digital)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar ceklis kelengkapan administrasi radiologi.
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulanan).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Radiologi Kepala Bidang Penunjang

10. Kejadian Kesalahan Cetak Hasil Radiologi

Judul Indikator	Kejadian kesalahan cetak hasil radiologi
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban fasyankes memberikan pelayanan yang aman bagi pasien - Keselamatan Pasien (Sasaran 1: Identifikasi Pasien): Kesalahan cetak identitas pada hasil dapat memicu kesalahan tindakan atau asuhan medis. - Efisiensi Operasional: Mengurangi biaya kerugian materiil (<i>re-print</i>) akibat penggunaan film/kertas yang tidak perlu. - Akurasi Diagnostik: Menghindari kesalahan interpretasi oleh dokter akibat kesalahan sisi (Kiri/Kanan) atau label pada hasil cetak.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketelitian petugas radiologi (Radiografer/Adm) dalam proses pencetakan hasil guna menjamin keakuratan data pasien dan efisiensi biaya.

Definisi Operasional	Kesalahan Cetak Hasil Radiologi: Adalah segala bentuk ketidaksesuaian pada hasil cetak (film, kertas laser, atau CD) yang menyebabkan hasil tersebut harus dicetak ulang. Ketidaksesuaian meliputi: kesalahan identitas (nama/no RM), kesalahan posisi/marker (L/R), kesalahan jenis pemeriksaan, atau kualitas cetakan yang buruk (terpotong/buram).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah lembar/hasil cetak radiologi yang mengalami kesalahan cetak dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh lembar/hasil cetak radiologi yang diproduksi pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua hasil cetak pemeriksaan radiologi diagnostik (X-Ray, CT-Scan, USG, MRI) baik di kertas, film, maupun media CD. Kerusakan cetak yang disebabkan oleh kerusakan mesin cetak secara mendadak (<i>technical force majeure</i>) yang sudah dilaporkan ke IPSRS.
Formula	Jumlah hasil yang salah cetak
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan sensus harian
Sumber data	Logbook kerusakan film/ re-print, laporan insiden internal radiologi, dan data inventory film
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan kesalahan cetak / Logbook
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulanan).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Radiologi Kepala Bidang Penunjang

3.3.14. Laboratorium

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
4.	Kepuasan pasien	≥76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%	Indikator Mutu Nasional

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
6.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 60 menit Kimia darah & darah rutin	100%	UNIT
7.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100%	UNIT
8.	Angka Kerusakan Sampel Darah	0%	UNIT
9.	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS	0	UNIT
10.	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO	0	UNIT
11.	Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam	0	UNIT
12.	Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium CITO ≥30menit	0 kejadian	UNIT
13.	Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam	0 kejadian	UNIT
14.	Angka Reaksi Tranfusi Darah	< 0,01%	UNIT
15.	Ketepatan waktu kalibrasi alat laboratorium	≥95%	UNIT

3.3.14.1 Profil Indikator Mutu Laboratorium

1. Kepatuhan identifikasi pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan

Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : a. Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. b. Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. c. Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. d. Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses &
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan kebersihan tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di

	lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Inklusi	-
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	- Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. - Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. - Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.

	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria:	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan.
- Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Pelaporan nilai kritis ≤30 menit

Judul Indikator	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis laboratorium ≤30 menit
-----------------	---

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil laboratorium kritis sangat penting dalam kelanjutan tata laksana pasien. Hasil kritis menunjukkan kondisi pasien yang membutuhkan keputusan klinis yang segera untuk upaya pertolongan pasien dan mencegah komplikasi akibat keterlambatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Tergambarnya kecepatan pelayanan laboratorium 2. Tergambarnya sistem yang menunjukkan bagaimana nilai kritis dilaporkan dan didokumentasikan untuk menurunkan risiko keselamatan pasien.
Definisi Operasional	1. Hasil kritis adalah hasil pemeriksaan yang termasuk kategori kritis sesuai kebijakan rumah sakit dan memerlukan penatalaksanaan segera. 2. Waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu yang dibutuhkan sejak hasil pemeriksaan keluar dan telah dibaca oleh dokter/analis yang diberi kewenangan hingga dilaporkan hasilnya kepada dokter yang meminta pemeriksaan. 3. Standar waktu lapor hasil kritis laboratorium adalah waktu pelaporan ≤ 30 menit.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Menit atau Jam: Mengukur waktu dari saat tes laboratorium dilakukan hingga hasilnya dilaporkan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan < 30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kritis
Target Pencapaian	100 %
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemeriksaan laboratorium yang memenuhi target hasil kritis Semua pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium yang bukan Kritis dan tidak termasuk <i>RED Category Condition</i> ; hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik kritis yang sudah dapat dilihat oleh DPJP/perujuk melalui sistem informasi dan sudah ditindaklanjuti.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan} < 30 \text{ menit}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium kritis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i>
Sumber data	Catatan data Instalasi Laboratorium , Rekam Medik
Instrumen Pengambilan Data	Formulir sensus harian
Sampel	Total populasi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

6. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 60 menit Kimia darah & darah rutin

Judul Indikator	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium ≤ 60 menit Kimia darah & darah rutin
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien mendapatkan pelayanan yang tepat waktu. - PMK No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik: Laboratorium wajib menjamin ketepatan waktu pemeriksaan. - Alur Pelayanan Pasien: Kecepatan hasil lab menentukan durasi tunggu pasien di IGD/Poliklinik dan mempercepat pemberian terapi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan efisiensi pelayanan laboratorium dalam proses pemeriksaan darah rutin dan kimia darah.
Definisi Operasional	- Waktu Tunggu Hasil Laboratorium ≤ 60 Menit: Adalah tenggang waktu mulai dari pasien diambil sampel darahnya (atau sampel diterima di meja pendaftaran lab) sampai dengan hasil pemeriksaan divalidasi dan siap diserahkan/diakses oleh unit pengirim. - Jenis Pemeriksaan: Terbatas pada Darah Rutin (Hematologi) dan Kimia Darah (Fungsi hati, ginjal, gula darah, dll).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pemeriksaan darah rutin dan kimia darah yang diselesaikan dalam waktu ≤ 60 menit dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pemeriksaan darah rutin dan kimia darah pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	100 %
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Pemeriksaan darah rutin (Hematologi rutin) dan Kimia Darah dari pasien rawat jalan, rawat inap, dan IGD. - Pemeriksaan laboratorium yang dikirim ke laboratorium rujukan. - Pemeriksaan khusus/canggih (misal: penanda tumor, hormon) yang membutuhkan waktu proses lama. - Kejadian <i>Force Majeure</i> (listrik padam total, alat rusak berat).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan darah rutin dan kimia darah yang diselesaikan} \leq 60 \text{ menit dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh pemeriksaan darah rutin dan kimia darah dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode	Retrospektif

Pengumpulan Data	
Sumber data	SIMRS, atau Logbook harian laboratorium.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan waktu tunggu atau laporan data otomatis dari SIMRS.
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

7. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium

Judul Indikator	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban fasyankes menjamin keselamatan pasien. 2. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 1): Ketepatan identifikasi pasien di seluruh alur pelayanan. 3. PMK No. 411 Tahun 2010: Standar mutu laboratorium klinik wajib mencakup akurasi identitas dan hasil. 4. Manajemen Risiko: Mencegah terjadinya <i>Sentinel Event</i> akibat salah asuhan medis karena tertukarnya hasil laboratorium.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian dan akurasi petugas laboratorium dalam proses verifikasi dan penyerahan hasil kepada pasien atau unit peminta.
Definisi Operasional	Kesalahan Pemberian Hasil: Adalah kejadian di mana hasil laboratorium yang diserahkan/diinput/diunggah tidak sesuai dengan identitas pasien (hasil tertukar) atau salah memasukkan nilai hasil milik pasien lain ke dalam rekam medis pasien tertentu.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberian hasil pemeriksaan laboratorium yang benar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada bulan yang sama..
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium (Patologi Klinik, Mikrobiologi, Patologi Anatomi). -
Formula	Jumlah pemberian hasil pemeriksaan laboratorium yang benar dalam satu bulan

	$\frac{\text{Total Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan}}{\text{Total Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan pelaporan insiden
Sumber data	Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dan Logbook Komplain
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan insiden
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Segera dilakukan RCA jika terjadi insiden).
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium Komite PMKP

8. Angka Kerusakan Sampel Darah

Judul Indikator	Angka Kerusakan Sampel Darah
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. - Keselamatan Pasien: Meminimalkan risiko trauma fisik (tusukan berulang) dan mental pada pasien akibat pengambilan sampel ulang. - Akurasi Diagnostik: Sampel yang rusak (lisis, beku, atau volume kurang) dapat menyebabkan hasil pemeriksaan tidak akurat atau bias. - Efisiensi: Mengurangi pemborosan alat kesehatan (sputum, tabung) dan waktu petugas.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kualitas proses pra-analitik dalam pengambilan, penanganan, dan transportasi sampel darah
Definisi Operasional	Kerusakan Sampel Darah: Adalah kondisi sampel darah yang diterima laboratorium namun tidak dapat diproses (ditolak/reject) karena: - Lisis: Kerusakan sel darah merah. - Beku: Adanya bekuan pada sampel (terutama untuk pemeriksaan Hematologi/Antikoagulan). - Volume Tidak Cukup: <i>Inadequate volume</i> (tidak sesuai rasio tabung). - Salah Tabung: Ketidaksesuaian antara jenis pemeriksaan dengan zat aditif tabung.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah sampel darah yang rusak/ditolak dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh sampel darah yang diterima laboratorium pada bulan yang sama.

Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua sampel darah dari pasien Rawat Jalan, Rawat Inap, dan IGD yang masuk ke Laboratorium. Sampel selain darah (Urin, Feses, Cairan tubuh lainnya).
Formula	$\frac{\text{Jumlah sampel darah yang rusak dalam satu bulan}}{\text{Total Jumlah seluruh sampel darah yang diterima dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan sensus harian
Sumber data	Logbook penolakan sampel
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan kerusakan sampel
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Laboratorium Kepala Instalasi Laboratorium

9. Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemindahan Hasil Laboratorium ke SIMRS
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban menjaga akurasi rekam medis elektronik - PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Data dalam RME harus akurat, lengkap, dan terintegrasi. - Keselamatan Pasien: Mencegah kesalahan diagnosis akibat ketidaksesuaian data antara mesin laboratorium dan data yang dilihat DPJP di komputer. - Manajemen Risiko: Mengidentifikasi kegagalan sistem interkoneksi (<i>interface</i>) SIMRS
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya akurasi dan integritas data hasil laboratorium yang ditayangkan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
Definisi Operasional	Kesalahan Pemindahan Hasil: Adalah ketidaksesuaian antara data hasil pemeriksaan yang divalidasi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik pada sistem laboratorium dengan data yang muncul/terbaca pada profil pasien di SIMRS. Kesalahan dapat berupa: kesalahan nilai (angka), kesalahan satuan, kesalahan rentang normal, atau hasil tertukar dengan pasien lain.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian

Numerator (pembilang)	Jumlah hasil pemeriksaan laboratorium yang mengalami kesalahan pemindahan/ketidaksesuaian data ke SIMRS dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah hasil pemeriksaan laboratorium yang mengalami kesalahan pemindahan/ketidaksesuaian data ke SIMRS dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua hasil pemeriksaan laboratorium yang memiliki fitur <i>interface</i> atau yang diinput manual ke SIMRS. Kesalahan yang berasal dari kesalahan pra-analitik (misal: salah sampel dari awal). Indikator ini fokus pada proses pemindahan data.
Formula	$\frac{\text{Jumlah hasil salah pindah ke SIMRS}}{\text{Total Jumlah seluruh hasil laboratorium di SIMRS dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan audit data (cross check antara SIMRS)
Sumber data	Laporan insiden
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kesesuaian data di SIMRS
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Laboratorium Kepala Ruang IT-SIMRS Kepala Instalasi Laboratorium

10. Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO

Judul Indikator	Kejadian Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan Alat KSO
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin alat kesehatan di fasyankes dalam kondisi layak pakai. - PMK No. 54 Tahun 2015: Kewajiban kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan secara berkala. - Standar Akreditasi (STARKES - MFK 7): Rumah sakit harus memiliki program pengelolaan peralatan medis, termasuk pemeliharaan preventif.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kedisiplinan mitra KSO dan unit terkait dalam menjaga performa alat medis agar selalu siap digunakan untuk pelayanan.
Definisi Operasional	Ketidaktepatan Waktu Pemeliharaan: Adalah pelaksanaan pemeliharaan preventif (<i>Preventive Maintenance</i>) yang dilakukan melewati batas waktu (jadwal) yang telah ditetapkan dalam jadwal pemeliharaan tahunan atau kesepakatan kontrak KSO.

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses &
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah alat medis KSO yang waktu pemeliharaannya terlambat/tidak sesuai jadwal dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah alat medis KSO yang waktu pemeliharaannya terlambat/tidak sesuai jadwal dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua alat medis dengan status KSO yang masuk dalam jadwal pemeliharaan preventif rutin (seperti alat Laboratorium, Radiologi, atau Hemodialisa) 1. Alat KSO yang sedang dalam proses perbaikan berat (<i>Breakdown</i>) di luar jadwal rutin. 2. Perubahan jadwal pemeliharaan atas permintaan rumah sakit karena beban pelayanan yang tinggi.
Formula	Jumlah alat KSO yang terlambat dipelihara
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Jadwal Pemeliharaan Alat Tahunan, Kartu Pemeliharaan Alat, dan Berita Acara Pemeliharaan dari Vendor/Mitra KSO
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan jadwal pemeliharaan preventif.
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang IPSRS Kepala Ruang ATEM Kepala Ruang IT-SIMRS Kepala Instalasi Laboratorium

11. Kejadian Keterlambatan Backup Alat Error Dalam Waktu 1x24 jam

Judul Indikator	Kejadian keterlambatan backup alat error dalam waktu 1 x 24 jam
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah sakit wajib menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan. 2. Standar Akreditasi (STARKES - MFK 7): Rumah sakit harus memiliki proses untuk memastikan ketersediaan peralatan medis jika terjadi kegagalan alat. 3. Manajemen Risiko: Ketiadaan alat pengganti dalam waktu lama meningkatkan risiko klinis bagi pasien yang membutuhkan tindakan segera. 4. Kontinuitas Pelayanan: Menghindari penumpukan antrean atau pembatalan tindakan medis
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan

Tujuan	Tergambarnya kesiapan rumah sakit (dan pihak vendor jika KSO) dalam menyediakan solusi cepat saat terjadi kerusakan alat utama guna menjaga kelangsungan pelayanan.
Definisi Operasional	Keterlambatan <i>Backup</i> : Adalah kondisi di mana alat kesehatan utama mengalami <i>error</i> atau kerusakan yang tidak bisa langsung diperbaiki, namun alat pengganti (<i>backup unit</i>) belum tersedia atau belum siap dioperasikan dalam waktu lebih dari 24 jam sejak laporan kerusakan diterima oleh petugas teknis/vendor.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kerusakan alat utama yang penyediaan alat cadangannya memakan waktu > 24 jam dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kerusakan alat utama yang penyediaan alat cadangannya memakan waktu > 24 jam dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua alat kesehatan vital (Life Saving) dan alat penunjang utama (Lab/Rad) yang memiliki perjanjian penyediaan <i>backup</i> atau stok cadangan internal. Kerusakan alat kecil/non-vital yang tidak menghambat alur pelayanan utama atau alat yang memang tidak memiliki unit cadangan dalam perencanaan RS.
Formula	Jumlah kejadian kerusakan alat utama yang penyediaan alat cadangannya memakan waktu > 24 jam dalam satu bulan
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Laporan Kerusakan Alat (Tiket IPSRS), Berita Acara Peminjaman/Penyediaan Alat Cadangan, dan Logbook Unit terkait.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan respon perbaikan dan penyediaan alat cadangan.
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang IPSRS Kepala Ruang ATEM Kepala Instalasi Laboratorium

12. Kejadian Keterlambatan Hasil Laboratorium Cito ≥30 menit

Judul Indikator	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium Cito ≥30 menit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien mendapatkan penanganan cepat pada kondisi gawat darurat. - PMK No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik: Pelayanan Cito harus didahulukan dari pemeriksaan rutin - Standar Akreditasi (STARKES - PAP 1.2): Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat yang cepat dan tepat. - Keselamatan Pasien: Keterlambatan hasil Cito dapat menunda tindakan pembedahan, resusitasi, atau

	pemberian terapi spesifik yang mengancam nyawa.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan respons instalasi laboratorium dalam mendukung penegakan diagnosis dan tata laksana pasien pada kondisi gawat darurat.
Definisi Operasional	1. Pemeriksaan Cito: Adalah permintaan pemeriksaan laboratorium dengan label "CITO" yang harus segera dikerjakan. 2. Keterlambatan (> 30 Menit): Adalah kondisi di mana hasil pemeriksaan (sejak sampel diterima di laboratorium sampai hasil divalidasi/diserahkan) memakan waktu lebih dari 30 menit.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pemeriksaan laboratorium Cito yang diselesaikan dalam waktu > 30 menit dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah pemeriksaan laboratorium Cito yang diselesaikan dalam waktu > 30 menit dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria:	
• Inklusi	Semua jenis pemeriksaan laboratorium dengan status Cito (Darah Rutin, Gula Darah Sewaktu, Elektrolit, dll) dari IGD atau ICU
• Eksklusi	1. Pemeriksaan Cito yang secara teknis membutuhkan waktu proses (preparasi) > 30 menit (misal: sediaan apus darah tepi tertentu atau pemeriksaan jaringan). 2.
Formula	Jumlah kejadian kerusakan alat utama yang penyediaan alat cadangannya memakan waktu > 24 jam dalam satu bulan
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Laporan Kerusakan Alat (Tiket IPSRS), Berita Acara Peminjaman/Penyediaan Alat Cadangan, dan Logbook Unit terkait.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan respon perbaikan dan penyediaan alat cadangan.
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang IPSRS Kepala Ruang ATEM Kepala Instalasi Laboratorium

13. Kejadian Keterlambatan Penyerahan labu darah > 1 jam

Judul Indikator	Kejadian Keterlambatan Penyerahan Labu Darah > 1 jam
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Keterlambatan penyerahan labu darah atau hasil lab Cito secara langsung berdampak pada pemenuhan hak keamanan pasien. 2. PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah. 3. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Ketepatan pemberian komponen darah pada kondisi kritis). 4. Respon cepat penyerahan darah sangat krusial pada kasus perdarahan hebat untuk mencegah syok hipovolemik dan kematian.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dalam menyediakan darah secara tepat waktu untuk kebutuhan transfusi.
Definisi Operasional	1. Waktu tunggu penyerahan labu darah adalah durasi sejak formulir permintaan darah dan sampel pasien diterima oleh BDRS sampai dengan darah siap diserahkan ke unit peminta. Dikatakan terlambat jika waktu tersebut > 1 jam (untuk permintaan rutin/ <i>non-emergency</i> yang memerlukan <i>crossmatching</i>).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah permintaan labu darah yang diserahkan/selesai > 1 jam dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah permintaan labu darah yang diserahkan/selesai > 1 jam dalam satu bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh permintaan darah (<i>Packed Red Cells, Whole Blood, dll</i>) yang memerlukan proses uji silang serasi (<i>crossmatching</i>) 1. Permintaan darah tanpa uji silang (<i>Emergency Release</i>). 2. Keterlambatan akibat stok darah kosong di BDRS dan PMI. 3. Adanya ketidakcocokan darah (<i>Incompatible</i>) yang memerlukan pemeriksaan ulang/lanjutan.
Formula	Jumlah permintaan labu darah yang diserahkan/selesai > 1 jam dalam satu bulan.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Buku Register Bank Darah atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan waktu tunggu pelayanan darah (Logbook Bank Darah)
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis bulanan dan Laporan Triwulan

Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

14. Angka Reaksi Tranfusi Darah

Judul Indikator	Angka Reaksi Transfusi Darah
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemenuhan hak pasien atas keamanan dan standar pelayanan kesehatan yang bermutu - PMK No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah: Standar teknis pelayanan transfusi darah untuk meminimalkan risiko reaksi hemolitik atau febris. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Mewajibkan RS melaporkan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) termasuk Kejadian Nyaris Cedera (KNC) atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dalam pelayanan darah. - Standar Akreditasi RS (STARKES) Bab PMKP: Mengharuskan RS memiliki indikator mutu prioritas dan melakukan pengukuran, analisis, serta validasi data terkait insiden klinis. - Reaksi transfusi merupakan salah satu indikator keselamatan pasien yang harus dipantau secara ketat untuk mencegah morbiditas dan mortalitas.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kualitas pengawasan proses transfusi dan respons rumah sakit terhadap insiden klinis guna mencegah cedera lebih lanjut pada pasien.
Definisi Operasional	Reaksi transfusi adalah kejadian tidak diinginkan yang timbul selama atau setelah transfusi darah (akut maupun lambat). Gejala dapat berupa demam, gatal, kemerahan (urtikaria), sesak napas (dyspnea), hingga syok anafilaktik atau hemolisis.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah reaksi transfusi
Denominator (penyebut)	Total jumlah pasien yang diberikan transfusi darah
Target Pencapaian	< 0,01%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh kejadian reaksi akibat transfusi komponen darah yang teridentifikasi secara klinis di semua unit pelayanan. Kejadian yang secara medis terbukti disebabkan oleh kondisi klinis dasar pasien (misal: sesak karena gagal jantung) dan bukan karena komponen darah.
Formula	$\frac{\text{Jumlah kejadian reaksi tranfusi darah}}{\text{Total seluruh pasien yang diberikan transfusi darah}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif

Sumber data	Form Monitoring transfusi, Laporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien)
Instrumen Pengambilan Data	Form Monitoring transfusi dan checklist keselamatan transfusi darah
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis bulanan dan Laporan Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

15. Ketepatan waktu kalibrasi alat laboratorium

Judul Indikator	Ketepatan waktu kalibrasi alat laboratorium			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 170 terkait kewajiban fasyankes memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan medis yang aman dan laik pakai. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Memastikan akurasi alat untuk mencegah kesalahan diagnosis (KTD/KNC). 3. STARKES Bab PMKP & MFK: Mengharuskan adanya program pemeliharaan dan kalibrasi alat medis secara berkala untuk menjamin mutu pelayanan. 4. Peraturan perundang-undangan mengenai pengujian dan kalibrasi alat kesehatan secara periodik (minimal 1 tahun sekali).			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan			
Tujuan	Terjaminnya akurasi hasil pemeriksaan laboratorium melalui ketersediaan alat ukur yang terkalibrasi tepat waktu sesuai jadwal			
Definisi Operasional	Ketepatan Waktu Kalibrasi adalah kesesuaian antara waktu pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam program tahunan pemeliharaan alat. Dikatakan tepat waktu jika kalibrasi dilakukan paling lambat pada bulan jatuh tempo sertifikat kalibrasi sebelumnya.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah reaksi transfusi			
Denominator (penyebut)	Total jumlah pasien yang diberikan transfusi darah			
Target Pencapaian	100%			
Kriteria:	• Inklusi Seluruh peralatan laboratorium yang memiliki komponen ukur dan masuk dalam daftar alat wajib kalibrasi (misal: Mikropipet, Centrifuge, Incubator).			
	• Eksklusi Alat laboratorium yang sedang rusak berat, tidak digunakan lagi (<i>discontinued</i>), atau dalam proses penghapusan aset			
Formula	Jumlah alat yang dikalibrasi tepat waktu			

	X 100% Total alat yang wajib dikalibrasi
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (telaah dokumen)
Sumber data	Jadwal Kalibrasi Tahunan, Sertifikat Kalibrasi, dan Inventaris Alat Laboratorium.
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Pemantauan Kalibrasi Alat Laboratorium.
Sampel	Total sampling (seluruh alat wajib dikalibrasi)
Periode pengumpulan data	Semesteran (dengan evaluasi progress setiap 3 – 6 bulan)
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap semester Pelaporan kepada Komite Mutu dan Direktur setiap tahun (Triwulan dalam bentuk progress laporan)
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Laboratorium

3.3.15. Rehab Medis

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
5.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 2 (ISKP 2)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
7.	Kejadian kesalahan Tindakan fisioterapi	0 kejadian	UNIT
8.	Kelengkapan pengisian pengkajian medis & protokol pasien rehab medik	100%	UNIT
9.	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien	100%	UNIT

Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak

	tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain-lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada
--	--

	rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). - Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. - Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. - Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. - Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. - Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

5. Kepuasan Pasien

6. Kepatuhan PPA Terhadap Komunikasi Efektif Menggunakan SBAR

Judul Indikator	Kepatuhan PPA terhadap komunikasi efektif menggunakan SBAR
Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 3. Keputusan direktur RSPH Sukorejo Nomor 4 tahun 2019 tentang Pedoman Komunikasi Efektif 4. Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. 5. Model komunikasi SBAR digunakan untuk meningkatkan ketepatan dan kejelasan komunikasi antar tenaga medis dan PPA dalam memberikan laporan kondisi pasien. Kepatuhan PPA dalam menggunakan SBAR menjadi indikator kunci dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepatuhan PPA dalam menggunakan metode komunikasi SBAR saat melakukan komunikasi antar tenaga medis terkait kondisi pasien, untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Sebuah angka yang menunjukkan antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA mengisi form SBAR sesuai standar

	(Situation, Background, Assessment, Recommendation) dengan lengkap pada rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap format SBAR yang benar.
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua komunikasi yang melibatkan PPA dalam pengelolaan pasien. - Semua komunikasi dengan tenaga medis lain (dokter, perawat lain, atau tim medis lainnya) yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terkait pasien. - Komunikasi yang tidak melibatkan keputusan terkait kondisi medis pasien. - Komunikasi yang dilakukan antara PPA dan pasien atau keluarga pasien (karena SBAR fokus pada komunikasi antar tenaga medis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi antar tenaga medis yang dilakukan oleh PPA menggunakan format SBAR sesuai standar (Situation, Background, Assessment, Recommendation) secara lengkap dalam periode observasi}}{\text{Jumlah total komunikasi di form SBAR yang dilakukan oleh PPA kepada tenaga medis selama periode analisis.}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung - Review rekam medis untuk memastikan apakah komunikasi SBAR dilakukan
Sumber data	- Laporan Komunikasi antar Tenaga Medis - Rekam Medis Pasien - Observasi Langsung selama proses komunikasi antar PPA & tenaga medis
Instrumen Pengambilan Data	Observasi Formulir SBAR
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

7. Kejadian Kesalahan Tindakan Fisioterapi

Judul Indikator	Kejadian kesalahan tindakan fisioterapi
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban fasyankes untuk mengutamakan keselamatan pasien. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Menekankan pentingnya ketepatan prosedur dan identifikasi pasien untuk mencegah KTD. - PMK No. 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi: Pelayanan harus dilakukan sesuai standar

	profesi dan prosedur. 4. Standar Akreditasi (STARKES): Menilai kepatuhan staf dalam menjalankan asuhan sesuai rencana terapi. 5. Kesalahan tindakan (seperti salah dosis alat medis, salah sisi anggota gerak, atau salah teknik latihan) dapat menyebabkan cedera fisik atau memperburuk kondisi klinis pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian fisioterapis dalam memberikan pelayanan sesuai dengan asesmen dan rencana asuhan guna menjamin keselamatan pasien.
Definisi Operasional	Kesalahan tindakan fisioterapis adalah setiap insiden yang terjadi selama proses pelayanan fisioterapi yang meliputi: 1. Salah Pasien: Tindakan diberikan pada orang yang salah. 2. Salah Sisi/Area: Tindakan dilakukan pada anggota gerak yang salah (misal: seharusnya bahu kiri, dilakukan pada bahu kanan). 3. Salah Jenis Tindakan: Memberikan modalitas yang tidak sesuai instruksi (misal: seharusnya <i>infrared</i>, diberikan <i>ultrasound</i>). 4. Salah Dosis/Intensitas: Pemberian beban atau dosis alat yang melebihi/kurang dari toleransi klinis pasien hingga menimbulkan keluhan/cedera.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan tindakan fisioterapi dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh tindakan fisioterapi yang dilakukan pada bulan yang sama
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria:	Seluruh tindakan fisioterapi di unit rawat jalan, rawat inap, maupun intensif
• Inklusi	
• Eksklusi	Kejadian yang bukan disebabkan oleh kesalahan prosedur (misal: reaksi alergi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya)
Formula	Jumlah kejadian kesalahan tindakan fisioterapi
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Laporan Insiden) & <i>Concurrent</i> (Supervisi Klinis)
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 2. Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rehab Medis 2. Komite PMKP

8. Kelengkapan Pengisian Pengkajian Medis & Protokol Pasien Rehab Medik

Judul Indikator	Kelengkapan pengisian pengkajian medis & protokol pasien rehab medik
Dasar pemikiran	1. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Dokumentasi yang lengkap adalah dasar komunikasi efektif antar tenaga kesehatan. 2. Standar Akreditasi (STARKES): Pengkajian awal medis harus lengkap untuk menetapkan diagnosis dan rencana terapi yang tepat 3. Protokol rehabilitasi yang terdokumentasi menjamin kesinambungan pelayanan (<i>continuity of care</i>) antara Dokter Spesialis KFR dan Fisioterapis/Okupasi Terapis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan ☒
Tujuan	Terwujudnya standar pendokumentasian asuhan rehabilitasi medik yang lengkap dan akurat untuk menjamin mutu pelayanan dan legalitas rekam medis
Definisi Operasional	Lengkap adalah terisinya seluruh elemen data pada formulir pengkajian medis dan lembar protokol rehabilitasi oleh Dokter Spesialis KFR (Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi) dalam waktu 1x24 jam setelah pasien diperiksa, meliputi: 1. Anamnesa & Pemeriksaan Fisik 2. Diagnosis Medis & Diagnosis Fungsional 3. Pemeriksaan Penunjang 4. Tata Laksana/Protokol (Jenis modalitas, frekuensi, durasi, dan tujuan terapi) 5. Tanda tangan dan nama terang dokter.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah rekam medis pasien rehabilitasi medik yang pengkajian dan protokolnya terisi lengkap dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh rekam medis pasien rehabilitasi medik pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Semua pasien baru dan pasien kontrol (sesuai siklus protokol) di unit Rehabilitasi Medik
	• Inklusi • Eksklusi Pasien yang membatalkan tindakan sebelum pengkajian dilakukan
Formula	$\frac{\text{Jumlah asesmen dan protokol yang lengkap}}{\text{Jumlah total seluruh kunjungan pasien dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit Dokumen Rekam Medis paska pelayanan)
Sumber data	Dokumen Rekam Medis (Formulir Pengkajian Awal & Protokol Rehab Medik)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kelengkapan rekam medis
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rehab Medis 2. Kepala Bidang Pelayanan

9. Kelengkapan Pengisian Pengkajian Fisioterapi Pasien Rehab Medik

Judul Indikator	Kelengkapan pengisian pengkajian fisioterapi pasien rehab medik
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban pengisian rekam medis secara lengkap dan akurat. - PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Rekam medis harus diisi segera setelah pelayanan diberikan. - PMK No. 65 Tahun 2015: Proses fisioterapi dimulai dari asesemen/pengkajian untuk menjamin asuhan yang aman. - Standar Akreditasi (STARKES-PAP): Mengharuskan setiap PPA melakukan pengkajian awal secara lengkap sesuai kompetensinya.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan ☒
Tujuan	Tergambarnya kedisiplinan fisioterapis dalam melakukan pengkajian yang komprehensif sebagai dasar pemberian asuhan rehabilitasi medik yang bermutu
Definisi Operasional	Lengkap adalah terisinya seluruh elemen data pada formulir pengkajian fisioterapi dalam rekam medis secara akurat oleh Fisioterapis, yang meliputi: - S (Subjective): Keluhan utama pasien - O (Objective): Pemeriksaan fisik fungsional (misal: MMT, <i>Range of Motion</i>, pemeriksaan nyeri/VAS). - A (Assessment): Diagnosis Fisioterapi (misal: gangguan pola jalan, keterbatasan gerak sendi). - P (Plan): Rencana intervensi, tujuan jangka pendek/Panjang, dan evaluasi hasil). - Identitas: Nama terang, tanda tangan, serta tanggal dan jam pelayanan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah formulir pengkajian awal fisioterapi yang diisi lengkap dan ditandatangani dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pasien baru yang mendapatkan asuhan fisioterapi pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua rekam medis pasien (Rawat Jalan & Rawat Inap) yang mendapatkan pelayanan fisioterapi untuk pertama kali pada episode tersebut Pasien yang menolak tindakan/pemeriksaan sebelum pengkajian selesai dilakukan (<i>Discharge Against Medical Advice</i>)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pengkajian yang lengkap}}{\text{Jumlah total kunjungan pasien baru dalam periode observasi}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit Dokumen Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis Pasien (Manual atau E-RM)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kelengkapan rekam medis
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rehab Medis 2. Kepala Bidang Pelayanan

10. Kepatuhan Pengisian Pengkajian Reassessment Setiap 2 Minggu & Akhir Terapi

Judul Indikator	Kepatuhan pengisian pengkajian reassessment setiap 2 minggu & akhir terapi				
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban dokumentasi asuhan yang berkelanjutan. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Setiap perubahan kondisi pasien harus dicatat dalam rekam medis secara kronologis. 3. Standar Akreditasi (STARKES - AP 2): Mengharuskan dilakukannya pengkajian ulang untuk menentukan respons terhadap tindakan dan merencanakan pengobatan lanjutan. 4. Manajemen Klinis: Evaluasi berkala setiap 2 minggu diperlukan untuk menyesuaikan dosis/modalitas terapi, sedangkan evaluasi akhir diperlukan untuk menentukan keberhasilan terapi (<i>discharge planning</i>)				
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒				
Tujuan	Tergambarnya kedisiplinan fisioterapis dalam melakukan evaluasi berkala dan evaluasi akhir guna memastikan efektivitas serta keamanan tindakan rehabilitasi				
Definisi Operasional	Pengkajian Ulang (<i>Reassessment</i>): Adalah evaluasi kondisi fungsional pasien yang wajib diisi pada Rekam Medis oleh fisioterapis yang mencakup: - Evaluasi Periodik: Dilakukan setiap 2 minggu (setelah minimal 6-8 kali pertemuan) untuk melihat perkembangan. - Evaluasi Akhir: Dilakukan pada saat pasien dinyatakan selesai program atau akan dipulangkan. - Kriteria Lengkap: Mencakup evaluasi objektif (pemeriksaan fisik ulang), perbandingan dengan status awal, dan keputusan apakah terapi dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan.				
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses	&
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)				

Numerator (pembilang)	Jumlah rekam medis pasien yang memiliki dokumen reassessment 2 mingguan dan akhir terapi secara lengkap pada bulan tersebut.
Denominator (penyebut)	Total seluruh rekam medis pasien rehab medik yang telah mencapai siklus 2 minggu atau selesai program pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien yang menjalani rangkaian terapi rehabilitasi medik kronis atau jangka panjang Pasien yang <i>drop out</i> (berhenti terapi tanpa pemberitahuan) atau meninggal dunia sebelum jadwal evaluasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah RM dengan assessment lengkap}}{\text{Jumlah total RM yang wajib reassessment dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit Dokumen Rekam Medis paska siklus terapi)
Sumber data	Dokumen Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kepatuhan evaluasi berkala
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Ruang Rehab Medis 2. Kepala Bidang Pelayanan

3.3.16. Farmasi

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
4.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert	100%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
7.	waktu tunggu	≥80%	Indikator Mutu Prioritas

	elayanan obat jadi ≤ 30 menit		Rumah Sakit bagian Perbaikan Sistem
8.	waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit	≥80%	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Perbaikan Sistem
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
9.	Kejadian kesalahan pemberian obat	0 kejadian	UNIT
10.	Kejadian kekosongan obat di Instalasi Farmasi	0 Kejadian	UNIT
11.	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi	0 Kejadian	UNIT
12.	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi teraupetik	0 kejadian	UNIT
13.	Ketepatan Waktu Pengiriman Obat oleh Vendor	≥95%	UNIT

3.3.16.1 Profil Indikator Mutu Farmasi

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian

	cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan

	seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan.

	7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien

	terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Penulisan Resep Sesuai Formularium

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Formularium Nasional. 3. Kepatuhan terhadap formularium dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan obat-obatan. 4. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan masukan-masukan pemberi layanan, dan pemilihannya berdasarkan kepada mutu obat, rasio risiko dan manfaat, berbasis bukti, efektivitas dan efisiensi. Pengadaan obat-obatan di rumah sakit mengacu pada formularium rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Terwujudnya pelayanan obat kepada pasien yang efektif dan efisien berdasarkan daftar obat yang mengacu pada formularium nasional
Definisi Operasional	1. Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. 2. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat di Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) penggunaan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional terhadap total obat yang digunakan
Numerator (pembilang)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional
Denominator (penyebut)	Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Resep yang dilayani di RS 1. Obat yang diresepkan di luar FORNAS tetapi dibutuhkan pasien dan telah mendapatkan persetujuan komite medik dan direktur. 2. Bila dalam resep terdapat obat di luar FORNAS karena stok obat nasional berdasarkan e-katalog habis/kosong.
Formula	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Lembar resep di Instalasi Farmasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Formulir Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi

6. Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert

Judul Indikator	Kepatuhan Staf Farmasi dalam Penempelan Stiker LASA dan High Alert
Dasar pemikiran	Kesalahan pemberian obat (<i>medication error</i>) merupakan ancaman serius bagi keselamatan pasien. Obat kategori LASA (<i>Look Alike Sound Alike</i>) dan <i>High Alert</i> memiliki risiko tinggi menyebabkan harm jika terjadi kesalahan, sehingga identifikasi visual melalui stiker sangat krusial.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian staf farmasi dalam memberikan penandaan obat untuk mencegah kesalahan pengambilan dan pemberian obat kepada pasien.
Definisi Operasional	1. Kepatuhan: Tindakan staf menempelkan stiker sesuai standar. 2. Stiker LASA: Penanda untuk obat dengan nama, ucapan, atau rupa mirip. 3. Stiker <i>High Alert</i> : Penanda untuk obat dengan risiko tinggi (misal: elektrolit pekat, insulin). 4. Penempelan: Stiker terpasang pada kemasan obat tanpa menutupi informasi penting (ED>Nama Obat).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah obat LASA dan <i>High Alert</i> yang ditemukan terpasang stiker dengan benar sesuai standar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh obat LASA dan <i>High Alert</i> yang diobservasi / disampling dalam satu bulan.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh sediaan obat yang masuk dalam daftar LASA dan <i>High Alert</i> di depo/instalasi farmasi.
• Eksklusi	Obat-obatan yang stikernya sudah tercetak langsung dari pabrik (pre-labeled).
Formula	$\frac{\text{Jumlah obat LASA dan High Alert yang ditemukan terpasang stiker dengan benar sesuai standar dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh obat LASA dan High Alert yang diobservasi / disampling dalam satu bulan}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Sumber data	Observasi langsung (<i>Concurrent</i>) atau audit stok secara berkala.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Checklist kepatuhan labeling obat
Sampel	Total sampling atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi Kepala Ruang Anestesi dan Tim Anestesi
Referensi	1. PMK No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di RS. 2. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) - Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 3).

7. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi ≤ 30 menit

Judul Indikator	Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat jadi < 30 menit
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2. Kecepatan pelayanan farmasi merupakan indikator kepuasan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit 3. Mengurangi penumpukan pasien di area tunggu farmasi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan efisiensi pelayanan farmasi dalam menyiapkan obat jadi untuk pasien.
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat jadi adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep di loket penerimaan sampai dengan pasien menerima obat jadi yang sudah siap diserahkan oleh petugas farmasi.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah resep obat jadi yang diselesaikan dalam waktu < 30 menit pada periode tersebut
Denominator	Total jumlah resep obat jadi yang masuk dan dilayani pada periode yang sama.
Target Pencapaian	$\geq 80\%$
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	1. Semua resep obat jadi (obat yang tersedia dalam bentuk siap pakai, tanpa memerlukan proses peracikan). 1. Resep obat racikan. 2. Resep yang memerlukan konfirmasi ulang kepada dokter karena ketidakjelasan penulisan atau ketersediaan stok.
Formula	$\frac{\text{Jumlah resep obat jadi yang dilayani <30 menit}}{\text{Jumlah seluruh resep obat jadi yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Retrospektif atau <i>Concurrent</i> (Real-time).

Data	
Sumber data	logbook farmasi dan Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Sampel	<i>Probability Sampling</i> (Minimal 30-50 sampel resep per bulan) atau Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi / Koordinator Farmasi Rawat Jalan

8. Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan ≤ 60 menit

Judul Indikator	Waktu Tunggu Layanan Farmasi obat racikan < 60 menit
Dasar pemikiran	- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit - Proses peracikan memerlukan ketelitian ekstra namun tetap harus memperhatikan efisiensi waktu agar pasien segera mendapatkan terapi. - Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan efisiensi petugas farmasi dalam proses peracikan obat hingga siap diserahkan kepada pasien secara tepat waktu.
Definisi Operasional	Waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah tenggang waktu mulai dari pasien menyerahkan resep di loket penerimaan sampai dengan pasien menerima obat racikan (pulveres, kapsul, salep racikan, dll) yang sudah siap diserahkan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah resep obat racikan yang diselesaikan dalam waktu < 60 menit pada bulan tersebut.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh resep obat racikan yang dilayani pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua resep yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut (seperti penggerusan tablet menjadi puyer, pengisian kapsul, atau pencampuran sediaan topikal). - Resep obat jadi. - Resep yang tertunda karena masalah administrasi/keuangan pasien - Resep yang stok obatnya sedang kosong dan harus dipesan terlebih dahulu.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Resep Racikan yang Dilayani < 60 menit}}{\text{Jumlah Total Seluruh Resep Racikan Masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif atau <i>Concurrent</i> (Real-time).

Sumber data	logbook farmasi dan Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring waktu tunggu pelayanan resep.
Sampel	<i>Probability Sampling</i> (Minimal 30-50 sampel resep per bulan) atau Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi / Koordinator Farmasi Rawat Jalan

9. Kejadian Kesalahan Pemberian Obat

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 190 mengenai penyelenggaraan keselamatan pasien sebagai prioritas pelayanan. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Kesalahan obat (<i>medication error</i>) adalah salah satu insiden keselamatan pasien yang paling sering terjadi dan dapat dicegah. - STARKES Bab PMKP & PKPO: Mewajibkan RS memantau kesalahan obat untuk meningkatkan sistem pelayanan kefarmasian yang aman (prinsip 7 Benar).
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian dalam pelayanan obat dan menjamin keselamatan pasien dari risiko bahaya akibat kesalahan pengobatan.
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian obat adalah setiap kejadian yang dapat dicegah yang menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien, yang meliputi salah pasien, salah obat, salah dosis, salah rute/cara pemberian, salah waktu, salah dokumentasi, dan salah edukasi (Prinsip 7 Benar).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah insiden kesalahan pemberian obat yang ditemukan dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah insiden kesalahan pemberian obat yang ditemukan dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Semua kesalahan yang terjadi pada tahap penyerahan (<i>dispensing</i>) dan pemberian (<i>administration</i>) obat kepada pasien baik di rawat inap, rawat jalan, maupun IGD. - Kesalahan yang terjadi pada tahap penulisan resep (<i>prescribing</i>) oleh dokter (ini masuk ke indikator <i>medication error</i> tahap peresepan).
Formula	Jumlah kejadian kesalahan pemberian obat

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan pelaporan insiden (real time)
Sumber data	Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), Catatan Keperawatan, dan Formulir Monitoring Farmasi Klinis
Instrumen Pengambilan Data	Form Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Sampel	Total Sampling (Seluruh pemberian obat)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis bulanan, Pelaporan: Triwulan. (Catatan: Jika terjadi KTD berat, laporan harus selesai dalam 2 x 24 jam).
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi Komite Keperawatan Komite PMKP

10. Kejadian Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi

Judul Indikator	Kejadian Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: asal 170 terkait ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (termasuk sediaan farmasi) yang bermutu dan terjangkau. - PMK No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit: Mewajibkan manajemen untuk menjamin ketersediaan obat sesuai formularium - STARKES Bab PKPO (Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat): Rumah sakit harus mengelola pengadaan dan ketersediaan stok obat untuk mendukung keberlangsungan terapi pasien. - Kekosongan stok obat dapat menghambat pelayanan klinis dan membahayakan keselamatan pasien akibat terputusnya terapi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya kinerja manajemen farmasi dalam menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.
Definisi Operasional	Kejadian Kekosongan Obat adalah kondisi di mana obat yang tercantum dalam Formularium Rumah Sakit tidak tersedia di stok Instalasi Farmasi pada saat dibutuhkan untuk pelayanan, sehingga pasien tidak mendapatkan obat tersebut atau harus mencari ke luar rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah jenis obat dalam formularium yang mengalami kekosongan stok dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah jenis obat dalam formularium yang mengalami kekosongan stok dalam satu bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: Inklusi	Semua sediaan farmasi (obat dan bahan medis habis pakai) yang masuk dalam daftar Formularium Rumah Sakit atau Daftar Plafon Harga Obat (DPHO)

• Eksklusi	1. Obat yang memang sedang mengalami kekosongan stok secara nasional (disertai surat keterangan dari distributor/pabrik). 2. Obat di luar daftar Formularium Rumah Sakit (obat non-formularium).
Formula	Jumlah jenis obat dalam formularium yang mengalami kekosongan stok dalam satu bulan
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan observasi
Sumber data	Laporan stok gudang farmasi, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Daftar Laporan Stok Kosong (Stock Out Report)
Sampel	Total Sampling (Seluruh jenis obat dan formularium nasional)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan, pelaporan dilakukan setiap triwulan kepada komite mutu
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Gudang Farmasi Kepala Instalasi Farmasi Komite PMKP

11. Kejadian Pemberian Antibiotik Profilaksi < 60 menit sebelum insisi

Judul Indikator	Kejadian pemberian antibiotik profilaksis < 60 menit sebelum insisi
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: asal 190 mengenai upaya keselamatan pasien dalam tindakan medis. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan Pasien: Penerapan prosedur bedah yang aman melalui <i>Surgical Safety Checklist</i> . 3. STARKES Bab PMKP & PAB (Pelayanan Anestesi dan Bedah): Fokus pada pencegahan infeksi pasca operasi melalui pemberian antibiotik yang tepat waktu. 4. Standar WHO bahwa antibiotik profilaksis harus mencapai kadar terapeutik di jaringan sebelum insisi dilakukan (optimal 30-60 menit sebelum tindakan).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan dokter bedah dan tim anestesi dalam memberikan antibiotik profilaksis sesuai standar untuk mencegah Infeksi Daerah Operasi (IDO).
Definisi Operasional	Antibiotik Profilaksis adalah antibiotik yang diberikan pada pasien yang akan menjalani operasi kategori bersih-terkontaminasi. Ketepatan waktu dinilai jika antibiotik diberikan dalam kurun waktu kurang dari 60 menit sebelum insisi kulit dimulai.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien operasi yang mendapatkan antibiotik profilaksis dalam waktu < 60 menit sebelum insisi dalam satu bulan

Denominator (penyebut)	Jumlah pasien operasi yang mendapatkan antibiotik profilaksis dalam waktu < 60 menit sebelum insisi dalam satu bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien operasi kategori bersih dan bersih-terkontaminasi yang direncanakan mendapatkan antibiotik profilaksis. 1. Pasien yang sudah mendapatkan antibiotik terapi (pengobatan) sebelum jadwal operasi. 2. Operasi kategori kotor (<i>Dirty Case</i>) atau infeksi yang sudah ada. 3. Operasi cito/darurat yang tidak memungkinkan observasi waktu 60 menit.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien dengan Profilaksis} < 60 \text{ menit}}{\text{Jumlah Total Seluruh Pasien yang mendapat profilaksis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan observasi
Sumber data	Laporan Operasi, Catatan Anestesi, dan lembar <i>Surgical Safety Checklist</i> (tahap <i>Time Out</i>).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan kepatuhan <i>Surgical Safety Checklist</i> .
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis: Bulanan; Pelaporan: Triwulan kepada Komite Mutu.
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Farmasi Komite PMKP

12. Kejadian Perubahan Pemberian Obat Profilaksis menjadi Terapeutik

Judul Indikator	Kejadian perubahan pemberian obat profilaksis menjadi terapeutik
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 190 mengenai keselamatan pasien dan Pasal 170 terkait standar pelayanan. 2. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Pencegahan kejadian tidak diharapkan dalam prosedur bedah. 3. STARKES Bab PPRA (Program Pengendalian Resistansi Antimikroba): Penggunaan antibiotik harus sesuai indikasi (profilaksis vs terapeutik) untuk mencegah resistensi bakteri. 4. STARKES Bab PAB (Pelayanan Anestesi dan Bedah): Evaluasi temuan intra-operatif yang mengubah rencana asuhan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Menilai ketepatan pemberian profilaksis dalam mencegah infeksi luka operasi (ILO). 2. Mengurangi paparan antibiotik yang tidak perlu pada pasien. 3. Menurunkan risiko munculnya bakteri resisten di

	lingkungan fasilitas kesehatan.
Definisi Operasional	Perubahan status antibiotik adalah kondisi di mana pasien yang awalnya direncanakan menerima Antibiotik Profilaksis (pencegahan) diputuskan oleh DPJP Bedah untuk menerima Antibiotik Terapeutik (pengobatan) karena ditemukannya tanda-tanda infeksi, pus, atau perforasi selama proses pembedahan berlangsung.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Angka Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami perubahan pemberian antibiotik profilaksis menjadi terapeutik berdasarkan temuan intra-operatif dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien yang mengalami perubahan pemberian antibiotik profilaksis menjadi terapeutik berdasarkan temuan intra-operatif dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua pasien operasi kategori bersih dan bersih-terkontaminasi yang direncanakan mendapatkan antibiotik profilaksis.
• Eksklusi	Pasien yang sudah terdiagnosis infeksi sebelum tindakan dilakukan (sudah masuk kategori terapeutik sejak awal)
Formula	Jumlah pasien yang mengalami perubahan pemberian antibiotik profilaksis menjadi terapeutik berdasarkan temuan intra-operatif dalam satu bulan.
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis, Catatan Pemberian Obat (CPPT), dan Lembar Observasi Infeksi.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan antibiotik / <i>Data Collection Tool</i>
Sampel	Total Sampling (seluruh populasi pasien yang mendapat profilaksis).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis: Bulanan; Pelaporan: Triwulan kepada Komite Mutu.
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Gudang Farmasi Kepala Instalasi Farmasi Komite PMKP

13. Ketepatan Waktu Pengiriman Obat oleh Vendor

Judul Indikator	Ketepatan Waktu Pengiriman Obat oleh Vendor
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: terkait ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan. 2. Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 3. Menjamin rantai pasok (<i>supply chain</i>) yang stabil guna menghindari kekosongan obat yang berisiko pada keselamatan pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan vendor mengirimkan pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam SP (Surat Pesanan) atau kontrak. 2. Meminimalisir risiko kekosongan stok obat di instalasi farmasi.
Definisi Operasional	Ketepatan waktu pengiriman adalah kesesuaian antara tanggal diterimanya obat oleh bagian logistik farmasi dengan tanggal jatuh tempo pengiriman yang tertera pada Surat Pesanan (SP) atau perjanjian kerja sama.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah Surat Pesanan (SP) yang dikirimkan oleh vendor tepat waktu sesuai kesepakatan dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah Surat Pesanan (SP) yang jatuh tempo pengiriman pada bulan tersebut.
Target Pencapaian	≥95%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh Surat Pesanan (SP) obat rutin, obat cito, maupun obat program yang jatuh tempo pada periode berjalan
• Eksklusi	1. SP untuk obat yang sedang mengalami kekosongan nasional (disertai surat keterangan resmi dari produsen). 2. Keterlambatan akibat keadaan kahar (<i>force majeure</i>)
Formula	$\frac{\text{Jumlah SP yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Total SP yang jatuh tempo}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Logbook Penerimaan Barang dan Surat Pesanan (SP)
Instrumen Pengambilan Data	Tabel pemantauan kedatangan barang di SIMRS
Sampel	Total Sampling (Semua SP yang diterbitkan kepada vendor)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis: Bulanan; Pelaporan: Triwulan kepada Komite Mutu.
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Pengadaan Farmasi Kepala Instalasi Farmasi Kepala Bidang Penunjang

3.3.17. Gizi

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)

2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
4.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
5.	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	UNIT
6.	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	UNIT
7.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0 kejadian	UNIT
8.	Angka kelengkapan pengisian asuhan gizi pasien rawat inap	100%	UNIT
9.	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien	0 kejadian	UNIT
10.	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat	100%	UNIT

3.3.17.1 Profil Indikator Mutu Gizi

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan

	yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien.

	5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan.

	4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Kepala bagian humas
------------------	---------------------

5. Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien

Judul Indikator	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan kepada Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan yang bermutu dan keselamatan pasien. 2. Permenkes No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). 3. Pelayanan gizi yang tepat waktu merupakan bagian dari terapi pasien untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi (misal: hipoglikemia).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Terwujudnya pelayanan gizi yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk menunjang proses pemulihan pasien.
Definisi Operasional	Ketepatan waktu pemberian makanan adalah kesesuaian antara jam distribusi makanan sampai ke tangan pasien (di ruang rawat inap) dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan oleh instalasi gizi rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang menerima makanan tepat waktu dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan makanan pada periode yang sama.
Target Pencapaian	≥ 90 %
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien rawat inap yang mendapatkan pesanan diet standar maupun diet khusus 1. Pasien yang baru masuk (admisi) di luar jam distribusi makanan. 2. Pasien yang sedang berpuasa untuk tindakan medis/ laboratorium. 3. Pasien yang sedang tidak berada di ruangan (misal: sedang di radiologi / hemodialisa).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang mendapat makan tepat waktu}}{\text{Total seluruh pasien yang mendapat makan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Concurrent (Observasi langsung saat distribusi) 2. Retrospektif
Sumber data	Logbook Distribusi makanan dan Formulir pemantauan ketepatan waktu gizi
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik (checklist) distribusi makanan per ruangan

Sampel	Total sampling atau random sampling (menggunakan rumus Slovin
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi Kepala Bidang Penunjang

6. Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien

Judul Indikator	Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk layanan gizi medis. 2. Permenkes No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). 3. Sisa makanan yang tinggi dapat mengindikasikan rendahnya daya terima pasien terhadap menu, yang berisiko memperlama masa penyembuhan (<i>Length of Stay</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Mengevaluasi daya terima pasien terhadap menu yang disajikan. 2. Meminimalkan pemborosan biaya makan (<i>food waste</i>). 3. Memastikan pasien mendapatkan asupan nutrisi yang optimal untuk penyembuhan.
Definisi Operasional	Sisa makanan adalah porsi makanan yang disajikan kepada pasien namun tidak habis dikonsumsi, yang diukur menggunakan metode <i>visual Comstock</i> (skala 0-100%) atau penimbangan sisa setelah waktu makan berakhir.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang menyisakan makanan lebih dari 20% dari porsi yang disajikan dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah pasien yang diobservasi sisa makanannya pada periode yang sama.
Target Pencapaian	≤ 20 %
Kriteria: • Inklusi	Semua pasien rawat inap yang mendapatkan makanan dari Instalasi Gizi sesuai dengan pesanan dietnya.

• Eksklusi	1. Pasien yang baru masuk atau pulang di tengah waktu makan. 2. Pasien yang sedang puasa atau dalam pemeriksaan medis. 3. Pasien dalam kondisi kritis atau penurunan kesadaran (makan melalui NGT).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien dengan sisa makanan} > 20\%}{\text{Total seluruh pasien di obserasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent (Observasi langsung melalui piring yang kembali)
Sumber data	Formulir Asupan Makanan / Catatan Sisa Makanan (Metode Comstock)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar kerja observasi sisa makanan harian
Sampel	<i>Total Sampling</i> atau <i>Random Sampling</i> harian
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi Kepala Bidang Penunjang

7. Kejadian Kesalahan Pemberian Diet

Judul Indikator	Kejadian Kesalahan Pemberian Diet			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai hak pasien atas keamanan dan keselamatan selama mendapat pelayanan kesehatan. 2. Permenkes No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). 3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 4. Pencegahan insiden keselamatan pasien akibat ketidaksesuaian antara diet yang dipesan dengan yang disajikan			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan	☒ ☒		
Tujuan	Terwujudnya ketepatan dan keamanan pelayanan gizi dengan memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian diet kepada pasien.			
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian diet adalah kejadian di mana makanan yang disajikan kepada pasien tidak sesuai dengan instruksi diet yang ditulis oleh Dokter (DPJP) atau Ahli Gizi dalam rekam medis. Kesalahan meliputi: salah pasien, salah jenis diet, atau salah tekstur makanan			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☒ Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Angka Kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet yang ditemukan dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet yang ditemukan dalam satu bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua jenis diet (standar, diet khusus, diet komplikasi, atau diet konsul) yang didistribusikan ke ruang rawat inap. Makanan yang dibawa dari luar rumah sakit oleh keluarga pasien tanpa sepengetahuan petugas gizi.
Formula	Jumlah kejadian kesalahan pemberian diet yang ditemukan dalam satu bulan
Metode Pengumpulan Data	Concurrent (Observasi harian dan pelaporan insiden)
Sumber data	Laporan Insiden Keselamatan Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan (dilaporkan maksimal 2 x 24 jam)
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi Komite PMKP

8. Angka Kelengkapan Pengisian Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap

Judul Indikator	Angka Kelengkapan Pengisian Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan setiap upaya kesehatan yang dilakukan secara lengkap dan benar. - Permenkes No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). - Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (termasuk Rekam Medis Elektronik). - Standar Akreditasi (STARKES/PKP) Menekankan pada kesinambungan pelayanan (Penyelenggaraan Asuhan Pasien Terintegrasi). Asuhan gizi yang tidak lengkap berisiko pada malnutrisi RS dan memperlambat masa pemulihan.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh proses asuhan gizi terdokumentasi dengan baik 2. Menjamin kestinambungan pelayanan gizi antar tenaga kesehatan. 3. Sebagai bukti legal dan tanggung jawab profesional Dietisien/Ahli Gizi.
Definisi Operasional	Kelengkapan pengisian asuhan gizi adalah terpenuhinya seluruh komponen asuhan gizi dalam rekam medis pasien yang mencakup metode ADIME (Asesmen, Diagnosis, Intervensi, Monitoring, dan Evaluasi) dalam waktu 1x24 jam setelah pasien masuk atau dirujuk
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah rekam medis pasien rawat inap yang diisi asuhan gizinya secara lengkap (ADIME) sesuai standar dalam periode satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah rekam medis pasien rawat inap yang mendapatkan asuhan gizi (berisiko malnutrisi/diet khusus) dalam bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Rekam medis pasien baru rawat inap yang masuk kategori berisiko malnutrisi (berdasarkan skrining gizi) atau pasien dengan diet khusus
• Eksklusi	Pasien yang pulang atas permintaan sendiri (PAPS) atau meninggal dunia sebelum sempat dilakukan asuhan gizi (kurang dari 24 jam).
Formula	$\frac{\text{Jumlah asuhan gizi yang lengkap}}{\text{Total sampel rekam medis yang diperiksa}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (melalui audit rekam medis setelah pasien pulang atau saat perawatan berlangsung)
Sumber data	Rekam Medis (Lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) / Lembar Asuhan Gizi)
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Audit Kelengkapan Asuhan Gizi
Sampel	Menggunakan rumus Slovin atau <i>Total Sampling</i> jika jumlah pasien sedikit. Minimal sampel disesuaikan dengan ketentuan RS (misal: 10% dari total populasi atau minimal 30 sampel per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi Komite PMKP
------------------	--------------------------------------

9. Kejadian Ditemukannya Benda Asing dalam Makanan Pasien

Judul Indikator	Kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan perlindungan pasien dari risiko kesehatan akibat pelayanan rumah sakit 2. PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan: Bahwa pangan harus bebas dari cemaran fisik yang dapat membahayakan kesehatan. 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit: Penyelenggaraan makanan harus memenuhi prinsip sanitasi dan keamanan pangan (HACCP) untuk mencegah Kejadian Nyaris Cedera (KNC) atau Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada pasien dan memastikan proses pengolahan makanan di instalasi gizi bebas dari cemaran fisik.
Definisi Operasional	Ditemukannya benda asing adalah adanya materi fisik yang tidak seharusnya ada dalam makanan (seperti rambut, kerikil, staples, plastik, serangga, potongan logam, dll) yang ditemukan sebelum atau saat makanan dikonsumsi oleh pasien
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah laporan kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien dalam satu bulan
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua jenis makanan dan minuman yang disajikan oleh Instalasi Gizi kepada pasien rawat inap. Benda asing yang ditemukan pada makanan yang dibawa dari luar rumah sakit (bukan dari instalasi gizi RS).
Formula	Jumlah laporan kejadian ditemukannya benda asing dalam makanan pasien dalam satu bulan
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Real-time melalui laporan insiden atau keluhan pasien/perawat)
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Laporan Kejadian

Sampel	Total Sampling (Seluruh makanan yang disajikan)
Periode pengumpulan data	Bulanan (namun pelaporan segera setelah ditemukan kejadian).
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (untuk dievaluasi segera jika terjadi insiden)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi

10. Tersedianya Air Panas di Tempat Cucian Alat Dapur dengan Standar 70 Derajat

Judul Indikator	Tersedianya air panas di tempat cucian alat dapur dengan standar 70 derajat
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Upaya preventif terhadap infeksi nosokomial dan jaminan hygiene sanitasi rumah sakit. - PMK No 2. Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. - Prinsip HACCP: Suhu air minimal 70°C diperlukan untuk desinfeksi termal guna membunuh mikroorganisme patogen dan melarutkan sisa lemak pada peralatan dapur.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Menjamin proses pencucian dan sanitasi alat dapur memenuhi standar kesehatan untuk mencegah kontaminasi silang melalui peralatan.
Definisi Operasional	Tersedianya air panas adalah kondisi di mana air yang mengalir pada area <i>sink</i> pencucian alat dapur memiliki suhu minimal 70°C saat diukur menggunakan termometer air pada saat proses pencucian berlangsung.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah hari dalam satu bulan di mana hasil observasi suhu air panas mencapai $\geq 70^{\circ}\text{C}$.
Denominator (penyebut)	Jumlah hari dalam satu bulan di mana hasil observasi suhu air panas mencapai $\geq 70^{\circ}\text{C}$
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh titik kran air panas di area pencucian alat dapur (Unit Gizi) Area pencucian di luar instalasi gizi.
Formula	$\frac{\text{Jumlah hari dengan suhu air } \geq 70^{\circ}\text{C}}{\text{Total hari dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode	<i>Concurrent</i> (Observasi harian)

Pengumpulan Data	
Sumber data	Logbook pemantauan suhu harian air panas
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi harian dan Termometer air digital/analog.
Sampel	Total Sampling (Dilakukan pengecekan setiap hari).
Periode pengumpulan data	Harian (Dicatat setiap pergantian <i>shift</i> atau saat jam puncak pencucian).
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan.
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi Gizi

3.3.18. Rekam Medis

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
4.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
5.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	UNIT
6.	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	UNIT
7.	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda	0 kejadian	UNIT
8.	Kejadian SEP tidak diterbitkan	0 kejadian	UNIT
9.	Kelengkapan RM pasien rawat inap (nama, TTD, jam, tgl)	100%	UNIT
10.	Angka keterlambatan pengembalian DRM Pasien umum dan asuransi > 1x24 jam	0%	UNIT
11.	Kelengkapan NIK di data pasien	100%	UNIT
12.	Kelengkapan berkas	100%	UNIT

Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan. -
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan

	kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu
--	--

Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD

Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

4. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. - Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	- Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. - Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. - Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. - Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. - Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. - Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan

Judul Indikator	Kelengkapan pengisian rekam medik poli klinik 24 jam setelah selesai pelayanan
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan pentingnya dokumentasi pelayanan kesehatan yang akurat - PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Mewajibkan pengisian rekam medis segera setelah pasien menerima pelayanan dan harus lengkap dalam waktu maksimal 24 jam. - Standar Akreditasi RS (STARKES): Terkait Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK) untuk menjamin kesinambungan asuhan
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan ☒

Tujuan	Tergambarnya disiplin PPA (Profesional Pemberi Asuhan) dalam mendokumentasikan rencana asuhan secara lengkap dan tepat waktu guna menjamin keamanan serta akurasi informasi medis pasien.
Definisi Operasional	Rekam medis rawat jalan dinyatakan lengkap dan tepat waktu apabila diisi lengkap oleh Dokter/Perawat (meliputi SOAP, diagnosa, terapi, dan tanda tangan elektronik/basah) maksimal 24 jam setelah pelayanan di poliklinik selesai.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah rekam medis pasien poliklinik yang diisi lengkap dan divalidasi dalam waktu ≤24 jam setelah pelayanan
Denominator (penyebut)	Jumlah total rekam medis pasien poliklinik yang menjadi sampel pada periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh rekam medis (fisik atau elektronik) pasien yang berkunjung ke unit rawat jalan (Poliklinik Spesialis/Umum)
• Eksklusi	Pasien yang batal pemeriksaan atau pasien yang dirujuk ke IGD sebelum pelayanan poliklinik selesai
Formula	$\frac{\text{Jumlah RM Rawat Jalan Lengkap dalam 24 jam}}{\text{Total sampel RM Rawat Jalan yang diperiksa}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Retrospektif (Audit data setelah pelayanan selesai)
Sumber data	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kelengkapan Rekam Medis
Sampel	Menggunakan metode <i>Simple Random Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rawat Jalan Kepala Ruang Rekam Medis

6. Kelengkapan Informed Consent Setelah Mendapatkan Informasi yang Jelas

Judul Indikator	Kelengkapan Informed Consent setelah Mendapatkan Informasi yang jelas
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus diberikan penjelasan yang cukup dan mendapatkan persetujuan dari pasien atau ahli warisnya. Hal ini merupakan perwujudan dari hak pasien

	atas otonomi diri dan informasi mengenai kesehatannya. 2. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran: Pasal 2 menegaskan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Penjelasan harus mencakup diagnosis, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko, komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Menyatakan bahwa berkas persetujuan tindakan kedokteran merupakan bagian integral dari rekam medis yang harus disimpan dan dijaga kelengkapannya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa proses komunikasi medis telah terjadi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter dalam memberikan informasi serta terpenuhinya hak pasien dalam menyetujui/menolak tindakan.
Definisi Operasional	<i>Informed Consent</i> dinyatakan Lengkap jika formulir ditandatangani oleh DPJP dan Pasien/Keluarga, serta memuat informasi: Diagnosis, Tata Cara, Tujuan, Risiko, Komplikasi, Prognosis, dan Alternatif tindakan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah formulir <i>Informed Consent</i> tindakan yang terisi lengkap dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang mendapatkan tindakan medik yang memerlukan <i>Informed Consent</i> dalam bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang mendapatkan tindakan invasif atau pembedahan Kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa (<i>Life Saving</i>) di mana persetujuan dapat menyusul
Formula	$\frac{\text{Jumlah formulir informed consent tindakan yang terisi lengkap}}{\text{Total seluruh pasien yang mendapatkan tindakan medik dan memerlukan } \textit{Informed Consent} \text{ dalam bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (melalui audit rekam medis)
Sumber data	Formulir <i>Checklist</i> Audit Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>Checklist</i> Audit Rekam Medis
Sampel	Menggunakan metode <i>Simple Random Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan

Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis

7. Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda

Judul Indikator	Kejadian Nomor Rekam Medis Ganda
Dasar pemikiran	1. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Menyatakan bahwa satu pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis. 2. Keselamatan Pasien: Nomor ganda berisiko pada kesalahan identifikasi, pengulangan pemeriksaan, dan kesalahan pemberian terapi karena riwayat medis yang terfragmentasi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya sistem identifikasi pasien yang tunggal (Satu Pasien Satu Nomor) untuk menjamin keakuratan data klinis.
Definisi Operasional	Nomor Rekam Medis Ganda adalah kondisi di mana satu pasien memiliki lebih dari satu nomor rekam medis yang berbeda di sistem rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah nomor rekam medis ganda yang ditemukan dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pasien yang terdaftar (kunjungan baru dan lama) di bulan yang sama.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang terdaftar di sistem informasi rumah sakit (SIRS) Tidak ada
Formula	Jumlah nomor rekam medis ganda yang ditemukan dalam satu bulan.
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (berjalan) atau Retrospektif melalui audit sistem/ database.
Sumber data	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) / Database Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Nomor RM Ganda

Sampel	Total Populasi (Semua pasien yang terdaftar dalam satu bulan)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis

8. Kejadian SEP Tidak Diterbitkan

Judul Indikator	Kejadian SEP tidak diterbitkan
Dasar pemikiran	1. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014: Setiap peserta JKN yang mendapatkan pelayanan di Faskes rujukan wajib memiliki SEP. 2. Aspek Finansial RS: Pelayanan tanpa SEP tidak dapat diklaimkan ke BPJS, yang berpotensi menjadi kerugian piutang RS. 3. Kepuasan Pasien: Mencegah pasien umum membayar biaya yang seharusnya ditanggung JKN karena kendala administrasi
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian administrasi pendaftaran dalam memproses hak pasien JKN dan menjamin kepastian klaim rumah sakit.
Definisi Operasional	Kejadian SEP tidak diterbitkan adalah kondisi di mana pasien BPJS yang sudah mendapatkan pelayanan medis, namun dokumen SEP-nya tidak terbit/tidak diproses oleh petugas karena kelalaian prosedur atau kendala teknis yang tidak terselesaikan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan namun SEP tidak terbit dalam 1 bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan namun SEP tidak terbit dalam 1 bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien peserta JKN-BPJS yang datang dengan surat rujukan atau kondisi gawat darurat yang sah 1. Pasien yang status kepesertaannya non-aktif (saat pendaftaran). 2. Pasien yang tidak dapat menunjukkan rujukan/identitas hingga batas waktu klaim berakhir.
Formula	Jumlah pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan namun SEP

	tidak terbit dalam 1 bulan
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif.
Sumber data	Laporan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
Instrumen Pengambilan Data	Daftar rekapitulasi ketidaksesuaian data antara kunjungan pasien dan penerbitan SEP.
Sampel	Total Populasi (Semua kunjungan pasien BPJS)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis Kepala Bidang Pelayanan

9. Kelengkapan RM Pasien Rawat Inap (Nama, TTD, Jam, Tanggal)

Judul Indikator	Kelengkapan RM Pasien Rawat Inap (Nama, TTD, Jam, Tanggal)
Dasar pemikiran	1. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan. 2. Aspek Legalitas: Kelengkapan administrasi adalah perlindungan hukum bagi pemberi asuhan jika terjadi sengketa medis. 3. Keselamatan Pasien: Akurasi waktu (jam dan tanggal) sangat krusial dalam kesinambungan asuhan (transfer informasi antar shift).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya pendokumentasian asuhan pasien yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Definisi Operasional	Rekam Medis dinyatakan Lengkap apabila pada setiap catatan perkembangan pasien (CPPT) maupun asuhan keperawatan memuat identitas jelas meliputi: Nama (dan gelar nakes), Tanda Tangan, serta Jam dan Tanggal saat asuhan diberikan
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas Rekam Medis pasien pulang rawat inap yang terisi lengkap (Nama, TTD, Jam, Tanggal) dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh berkas Rekam Medis pasien yang pulang rawat inap pada bulan yang sama.

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua berkas Rekam Medis pasien yang telah dinyatakan keluar dari rawat inap (baik pulang sembuh, dirujuk, maupun meninggal). Berkas Rekam Medis pasien yang masih dalam masa perawatan (belum pulang).
Formula	$\frac{\text{Jumlah RM Ranap yang lengkap}}{\text{Total seluruh berkas RM Ranap Pasien Pulang yang diobservasi dalam bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis pasca pasien pulang).
Sumber data	Berkas Rekam Medis Rawat Inap
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Audit Kelengkapan Rekam Medis
Sampel	
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis Komite Medik Kepala Bidang Pelayanan

10. Angka Keterlambatan Pengembalian DRM Pasien Umum dan Asuransi > 1X24 Jam

Judul Indikator	Angka Keterlambatan Pengembalian DRM Pasien Umum dan Asuransi > 1 x 24 jam
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai pentingnya pengelolaan informasi kesehatan yang efisien. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Mewajibkan pendokumentasian dan pengelolaan rekam medis yang tepat waktu. 3. Aspek Pelayanan: Ketersediaan Dokumen Rekam Medis yang cepat menjamin kesinambungan asuhan jika pasien datang kembali. 4. Aspek Klaim: Keterlambatan pengembalian Dokumen Rekam Medis menghambat proses coding dan penagihan biaya pelayanan ke pihak asuransi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis ke unit kerja rekam medis agar data siap diolah dan digunakan kembali.
Definisi Operasional	Keterlambatan pengembalian DRM adalah kembalinya berkas rekam medis pasien (Umum dan Asuransi) dari ruang rawat inap ke unit rekam medis lebih dari 24 jam setelah pasien dinyatakan

	pulang atau keluar dari rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas Dokumen Rekam Medis pasien pulang (Umum & Asuransi) yang dikembalikan ke unit rekam medis lebih dari 24 jam dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh berkas DRM pasien pulang (Umum & Asuransi) pada bulan yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh dokumen rekam medis pasien rawat inap (umum maupun asuransi) yang sudah menyelesaikan masa perawatan. Dokumen rekam medis pasien yang masih dalam proses audit medis atau komite etik (dengan konfirmasi tertulis).
Formula	$\frac{\text{Jumlah DRM kembali > 24 jam}}{\text{Total seluruh berkas DRM pasien pulang}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit buku ekspedisi pengembalian DRM)
Sumber data	1. Buku Ekspedisi Pengembalian DRM 2. Data Pasien Pulang dari SIMRS.
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Monitoring Keterlambatan Pengembalian DRM
Sampel	Total Sampling (Seluruh DRM pasien yang pulang).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis

11. Kelengkapan NIK di Data Pasien

Judul Indikator	Kelengkapan NIK di Data Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pengintegrasian sistem informasi kesehatan nasional. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Pasal 11 menyebutkan bahwa NIK merupakan salah satu elemen data identitas pasien yang wajib ada dalam rekam medis elektronik. 3. Integrasi satu sehat: NIK adalah kunci utama (<i>unique identifier</i>) untuk sinkronisasi data antar fasilitas kesehatan di Indonesia. 4. Validasi BPJS Kesehatan: NIK diperlukan untuk akurasi verifikasi kepesertaan

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Terwujudnya keakuratan identitas pasien dalam sistem informasi rumah sakit guna mendukung integrasi data kesehatan nasional dan mencegah terjadinya duplikasi data pasien.
Definisi Operasional	Kelengkapan data NIK adalah terisinya kolom NIK sebanyak 16 digit angka yang valid sesuai KTP/KK pada database Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk setiap pasien baru yang terdaftar
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien baru yang terdaftar dengan data NIK lengkap dan valid (16 digit) dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh pasien baru yang terdaftar dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh pasien baru yang melakukan registrasi di Rawat Jalan, Rawat Inap, maupun IGD.
• Eksklusi	1. Pasien yang data dalam kondisi tidak sadar dan tanpa identitas, serta tidak didampingi oleh keluarga 2. Pasien bencana massal 3. Bayi Baru Lahir (BBL) usia 0-28 hari 4. Pasien yang dibawa oleh pihak kepolisian atau dinas sosial yang tidak memiliki data kependudukan atau sedang dalam proses penelurusan 5. Pasien WNA (Warga Negara Asing)
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien Baru dengan NIK lengkap}}{\text{Total seluruh pasien baru terdaftar}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> atau retrospektif melalui penarikan data dari SIMRS
Sumber data	1. Buku Ekspedisi Pengembalian DRM 2. Data Pasien Pulang dari SIMRS.
Instrumen Pengambilan Data	Laporan bulanan kelengkapan data identitas pasien dari sistem.
Sampel	Total Sampling (Seluruh pasien baru).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis

Judul Indikator	Kelengkapan Berkas E-RM IGD
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas pelayanan yang aman dan terdokumentasi dengan baik. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Kewajiban penyelenggaraan rekam medis elektronik yang lengkap dan terintegrasi di faskes 3. Standar Akreditasi RS (STARKES): Terkait Pelayanan Gawat Darurat (PAP) dan Manajemen Informasi (MRMIK) yang mensyaratkan pencatatan asuhan segera setelah pelayanan diberikan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Tergambarnya kualitas dokumentasi medis digital di IGD untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat serta sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan
Definisi Operasional	Kelengkapan berkas E-RM IGD adalah terisinya seluruh elemen data wajib pada sistem elektronik IGD oleh Dokter dan Perawat dalam waktu ≤ 24 jam setelah pelayanan selesai. Elemen wajib meliputi: Triage, Asesmen Awal Keperawatan & Medis, Diagnosis, Tindakan/Terapi, dan Lembar Observasi (jika ada).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas E-RM pasien IGD yang diisi lengkap oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan) sesuai standar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah berkas E-RM pasien IGD yang menjadi sampel pada periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh rekam medis elektronik pasien yang terdaftar dan mendapatkan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat. Pasien <i>Death on Arrival</i> (DOA) atau pasien yang datang hanya untuk permintaan visum luar (tanpa pelayanan medis darurat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah E-RM IGD yang lengkap}}{\text{Total sampel E-RM IGD yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit melalui dashboard SIMRS atau Tinjauan Berkas Digital)
Sumber data	Database E-RM (<i>Electronic Medical Record</i>) pada SIMRS
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kelengkapan E-RM (<i>Checklist digital</i>).
Sampel	Menggunakan metode random sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Manajemen / Komite Mutu)

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang IGD Kepala Instalasi Gawat Darurat

13. Ketepatan Laporan dengan Pihak Eksternal

Judul Indikator	Ketepatan laporan dengan pihak eksternal
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan data dan informasi kesehatan yang akurat dan tepat waktu kepada Pemerintah. - PMK No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (terkait kewajiban laporan RS). - Standar Akreditasi RS (STARKES): Bab Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) dan Manajemen Informasi (MRMIK) yang menekankan pentingnya pelaporan data eksternal untuk pemantauan kinerja kesehatan nasional.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Tergambarnya disiplin rumah sakit dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada instansi luar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerjasama.
Definisi Operasional	Tepat waktu adalah laporan yang dikirimkan/diserahkan kepada pihak eksternal (Dinkes, Kemenkes, BPJS, Asuransi Lain, atau DLH) tidak melebihi batas tanggal (deadline) yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis laporan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah jenis laporan eksternal yang dikirimkan tepat waktu dalam periode satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total jumlah seluruh jenis laporan eksternal yang wajib dikirimkan dalam periode satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua laporan wajib seperti: Laporan RS Online (SIRS), Laporan Penyakit Menular/Wabah, Laporan Kematian, Laporan Klaim BPJS, Laporan Limbah B3, dan laporan rutin ke Dinas Kesehatan Laporan insidental (tidak rutin) yang tidak memiliki batas waktu formal dalam regulasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Total laporan yang wajib dikirim}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit buku kendali laporan atau log pengiriman dokumen)
Sumber data	- Buku ekspedisi pengiriman laporan - Tanda terima/log pengiriman elektronik

	3. SIMRS
Instrumen Pengambilan Data	Tabel Monitoring Jadwal Pelaporan Eksternal
Sampel	Total sampling (seluruh laporan rutin bulanan/ triwulan)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Manajemen / Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang Rekam Medis

3.3.19. Limbah K3RS

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Baku mutu limbah cair	a.BOD < 12 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9 e. Faecal coli 200	UNIT
2.	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100 %	UNIT
3.	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	100%	UNIT
4.	Kejadian pelaporan kecelakaan kerja ≤ 48 jam	0 kejadian	UNIT

3.3.19.1 Profil Indikator Mutu K3RS

1. Baku Mutu Limbah Cair

Judul Indikator	Baku mutu limbah cair
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 170 terkait standar prasarana rumah sakit yang aman bagi lingkungan. 2. Permen LHK No. P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 3. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Upaya mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketepatan dan keamanan pelayanan gizi dengan memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pemberian diet kepada pasien.
Definisi Operasional	Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke badan air. Pengukuran dilakukan melalui uji laboratorium terakreditasi terhadap parameter kunci.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka capaian 2. BOD, COD, TSS: mg/l 3. Ph: angka satuan 4. Faecal Coli: MPN/100ml
Numerator (pembilang)	Angka capaian parameter baku mutu limbah cair
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	1. BOD < 12 mg/l 2. COD < 80 mg/l 3. TSS < 30 mg/l 4. PH 6-9 5. Faecal coli 200
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Hasil uji laboratorium lingkungan untuk parameter: BOD, COD, TSS, pH, dan Faecal coli Hasil uji yang terganggu karena bencana alam (banjir besar) yang merusak sistem IPAL secara total
Formula	Angka capaian parameter baku mutu limbah cair
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Laporan hasil pengujian dari laboratorium lingkungan
Instrumen Pengambilan Data	Tabel evaluasi hasil uji laboratorium IPAL
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite K3RS Komite PPI

5. Pengelolaan Limbah Padat Infeksius Sesuai dengan Aturan

Judul Indikator	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan
-----------------	---

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur mengenai kesehatan lingkungan dan pengelolaan limbah medis. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 3. Permen LHK No. P.56/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Mencegah terjadinya infeksi nosokomial, kecelakaan kerja (tertusuk jarum), dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah medis yang tidak standar.
Definisi Operasional	Limbah Padat Infeksius adalah limbah yang terkontaminasi darah, cairan tubuh, atau berasal dari isolasi pasien menular. Pengelolaan dikatakan patuh jika memenuhi prinsip: Pemilahan, Pewadahan (Kantong Kuning), Penyimpanan Sementara (< 2 hari pada suhu > 0 derajat celcius), dan Pengolahan Akhir.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah limbah yang diolah dan dibuang dengan benar
Denominator (penyebut)	Jumlah total limbah yang dihasilkan RS secara keseluruhan
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Seluruh unit penghasil limbah infeksius (Ruang Rawat Inap, IGD, Laboratorium, Ruang Tindakan, Kamar Operasi).
• Inklusi	
• Eksklusi	Unit administratif yang hanya menghasilkan limbah domestik (sampah kantor).
Formula	$\frac{\text{Jumlah limbah yang diolah dan dibuang dengan benar}}{\text{Jumlah total limbah yang dihasilkan RS secara keseluruhan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi lapangan menggunakan <i>checklist</i>)
Sumber data	Laporan audit lingkungan
Instrumen Pengambilan Data	Daftar tilik (checklist) monitoring kepatuhan pengelolaan limbah medis
Sampel	Total sampling atau random sampling (menggunakan rumus Slovin)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung Jawab	Komite K3RS Komite PPI
------------------	---------------------------

6. Angka Kepatuhan Staf dalam Mengikuti Kegiatan MCU Satu Tahun Sekali

Judul Indikator	Angka kepatuhan staf dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur perlindungan kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. - Permenkes No. 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (K3 Fasyankes). - Deteksi dini terhadap penyakit akibat kerja (PAK) dan kecelakaan kerja guna menjamin produktivitas dan keselamatan staf.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Memantau status kesehatan seluruh staf secara berkala guna melakukan pencegahan, deteksi dini penyakit, serta memastikan staf layak bekerja di unit masing-masing.
Definisi Operasional	Kepatuhan mengikuti MCU adalah kehadiran dan keikutsertaan staf (medis, keperawatan, penunjang, dan administrasi) dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan berkala yang diselenggarakan oleh institusi setahun sekali sesuai jadwal yang ditetapkan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah staf mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh staf yang wajib mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh staf tetap, staf kontrak, dan tenaga harian lepas yang telah bekerja minimal 1 tahun di fasilitas kesehatan. - Staf yang sedang menjalani cuti besar (melahirkan/ Pendidikan) - Staf yang mengundurkan diri atau memasuki masa pension sebelum jadwal MCU dilaksanakan
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang mengikuti MCU}}{\text{Jumlah total Staf yang wajib MCU}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Laporan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Data Kepegawaian (SDM), dan Rekapitulasi Hasil MCU
Instrumen Pengambilan Data	Daftar hadir MCU Staf dan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan

Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Tahunan (dengan monitoring progress setiap bulan)
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite K3RS Bagian SDM

7. Kejadian Pelaporan Kecelakaan Kerja ≤ 48 jam

Judul Indikator	Kejadian Pelaporan Kecelakaan Kerja ≤ 48 jam
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengatur perlindungan kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. 2. Permenkes No. 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (K3 Fasyankes). 3. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan: Batas waktu pelaporan kerja untuk klaim jaminan adalah maksimal 2x24 jam. 4. Respon cepat diperlukan untuk investigasi dini guna mencegah kejadian serupa
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan setiap kecelakaan kerja dilaporkan segera untuk penanganan medis dan administrative 2. Memungkinkan tim K3 melakukan investigasi segera (Quick Response)
Definisi Operasional	Pelaporan Kecelakaan Kerja < 48 jam adalah pelaporan resmi yang dilakukan oleh korban atau saksi kepada unit K3 atau bagian SDM dalam waktu tidak lebih dari 48 jam setelah kejadian kecelakaan di lingkungan kerja atau saat perjalanan dinas.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kecelakaan kerja yang masuk ke unit K3 dalam waktu < 48 jam sejak waktu kejadian dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria:	Seluruh insiden yang masuk kategori kecelakaan kerja (termasuk tertusuk jarum, terpeleset, atau kecelakaan saat berangkat/pulang kerja)
• Inklusi • Eksklusi	Kejadian yang dilaporkan oleh pihak luar (bukan staf/karyawan instansi)

Formula	Jumlah kejadian pelaporan kecelakaan kerja < 48 jam
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pelaporan langsung saat kejadian)
Sumber data	1. Laporan Insiden K3 2. Formulir Klaim Kecelakaan Kerja
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan kecelakaan kerja
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite K3RS Komite PMKP

3.3.20. SDM

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staff	100 %	UNIT
2.	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	UNIT
3.	Angka turn over staff	≤10% / bulan	UNIT
4.	Angka keterlambatan staff ≥10 menit	0%	UNIT
5.	Angka staff tersertifikasi khusus a. IGD : BLS/PPGD/GELS/ALS b. PONEK : PPGD c. ICU d. HD e. IKO f. Hiperkes NICU/PICU	100%	UNIT
6.	Kepuasan karyawan	≥ 90 %	UNIT

3.3.20.1 Profil Indikator Mutu Rekam Medis

1. Kelengkapan Pelaporan Penilaian Kinerja Staff

Judul Indikator	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja staff
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta evaluasi kinerja berkala.

	2. Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Standar KPS/Kualifikasi dan Pendidikan Staf). 3. Perlunya dokumentasi kinerja yang lengkap sebagai dasar pemberian insentif, sanksi, dan perencanaan pelatihan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan setiap staf memiliki dokumen penilaian kinerja yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik di dalam file kepegawaian
Definisi Operasional	Kelengkapan pelaporan penilaian kinerja adalah terpenuhinya seluruh unsur dalam dokumen penilaian kinerja yang meliputi: identitas staf, sasaran kerja/target, capaian kinerja, penilaian perilaku, tanda tangan atasan langsung, dan tanda tangan staf yang bersangkutan
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah penilaian kinerja staf yang lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah total laporan penilaian kinerja staff
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Seluruh staf (Medis, Keperawatan, Penunjang, dan Administrasi) yang telah bekerja minimal 1 tahun atau sesuai masa kontrak
• Inklusi	Staf yang sedang menjalani tugas belajar atau cuti di luar tanggungan negara selama periode penilaian berlangsung
• Eksklusi	
Formula	$\frac{\text{Jumlah penilaian kinerja staf yang lengkap}}{\text{Jumlah total laporan penilaian kinerja staff}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i> (audit dokumen kepegawaian)
Sumber data	File kepegawaian
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> kelengkapan dokumen penilaian kinerja
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

2. Karyawan yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Setahun

Judul Indikator	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan bahwa tenaga medis dan tenaga

	kesehatan wajib mengikuti pengembangan kompetensi berkelanjutan. 2. Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Standar KPS). 3. Pentingnya pemenuhan jam pengembangan kompetensi untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan pengembangan diri dan pembaruan kompetensi minimal 20 jam dalam satu tahun
Definisi Operasional	Karyawan yang mendapat pelatihan adalah staf (medis, keperawatan, penunjang, dan administrasi) yang mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan (diklat), workshop, seminar, atau <i>in-house training</i> dengan total durasi kumulatif minimal 20 jam pelajaran (JP) dalam satu tahun kalender
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan ≥ 20 JP dalam setahun
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan karyawan
Target Pencapaian	$\geq 60\%$
Kriteria:	Seluruh staf tetap dan staf kontrak yang telah bekerja minimal satu tahun - Inklusi - Eksklusi 1. Staf yang sedang cuti di luar tanggungan negara. 2. Staf yang sedang menjalani tugas belajar formal (S1/S2/Spesialis). 3. Staf yang baru masuk kerja di pertengahan semester kedua.
Formula	$\frac{\text{Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan } \geq 20 \text{ JP dalam setahun}}{\text{Jumlah keseluruhan karyawan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	1. Rekapitulasi sertifikat pelatihan 2. Laporan unit diklat 3. Database kepegawaian
Instrumen Pengambilan Data	Logbook pelatihan karyawan/portofolio diklat
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

3. Angka Turn Over Staff

Judul Indikator	Angka turn over staf
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. - Permenkes No. 12 Tahun 2020: Standar Akreditasi terkait Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS). - Tingginya angka <i>turnover</i> dapat mengganggu stabilitas pelayanan, menurunkan kualitas asuhan pasien, dan meningkatkan biaya rekrutmen serta pelatihan ulang.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Memantau stabilitas tenaga kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. - Mengevaluasi efektivitas kebijakan kesejahteraan dan lingkungan kerja staf.
Definisi Operasional	<i>Turnover</i> staf adalah berhentinya staf (keluar) dari institusi secara sukarela (<i>resign</i>) maupun tidak sukarela (pemutusan hubungan kerja/pensiun dini) dalam kurun waktu satu tahun yang memerlukan penggantian posisi.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah staf yang resign
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan karyawan
Target Pencapaian	≤ 10%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh staf tetap dan staf kontrak yang berhenti bekerja atas kemauan sendiri atau kebijakan perusahaan - Staf yang berhenti karena memasuki masa pensiun normal. - Staf yang meninggal dunia. - Staf yang habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang oleh institusi (bukan atas keinginan staf).
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang resign}}{\text{Jumlah keseluruhan karyawan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	- Data kepegawaian - Laporan resign

Instrumen Pengambilan Data	Tabel rekapitulasi data masuk dan keluar staf
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

4. Angka Keterlambatan Staff ≥ 10 menit

Judul Indikator	Angka keterlambatan staff ≥ 10 menit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar profesi dan etika kerja. 2. Peraturan Internal/Peraturan Perusahaan: Terkait jam kerja dan kedisiplinan pegawai. 3. Kedisiplinan waktu berdampak pada ketepatan waktu pelayanan (misal: dimulainya poli spesialis atau pergantian <i>shift</i> perawat) dan kepuasan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memantau tingkat kedisiplinan staf dalam mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan. 2. Memastikan tidak terjadi kekosongan pelayanan akibat keterlambatan staf.
Definisi Operasional	Keterlambatan staf adalah kondisi di mana staf melakukan pencatatan kehadiran (<i>fingerprint</i> atau presensi lainnya) lebih dari 10 menit dari jadwal jam masuk yang seharusnya, tanpa alasan yang sah atau tanpa izin pimpinan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah staf yang terlambat ≥ 10 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan karyawan
Target Pencapaian	0%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh staf (Pelayanan, Penunjang, Umum, Manajemen) yang wajib melakukan presensi kehadiran. 1. Staf yang terlambat karena penugasan dinas luar (disertai bukti). 2. Keterlambatan akibat gangguan sistem presensi (error mesin). 3. Staf yang memiliki jadwal kerja fleksibel (jika ada kebijakan

	husus).
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang terlambat } \geq 10 \text{ menit}}{\text{Jumlah keseluruhan karyawan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	Laporan kehadiran bulanan (fingerprint)
Instrumen Pengambilan Data	Rekapitulasi presensi kehadiran dari bagian SDM
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

5. Angka Staff Tersertifikasi Khusus

Judul Indikator	Angka staff tersertifikasi khusus
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang dibuktikan dengan sertifikat. - Permenkes No. 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Standar KPS/Kualifikasi dan Pendidikan Staf). - Menjamin bahwa unit kerja risiko tinggi (ICU, Kamar Operasi, Hemodialisa, dll) dilayani oleh staf yang memiliki kompetensi teknis khusus guna menjaga keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Memastikan staf yang bertugas di unit pelayanan khusus memiliki sertifikasi keahlian yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan kompetensi unit tersebut.
Definisi Operasional	Staf tersertifikasi khusus adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan/keahlian khusus di luar ijazah pendidikan formal yang diterbitkan oleh lembaga resmi/organisasi profesi (misal: Sertifikat ICU, Kamar Bedah, Dialisis, BTCLS/ACLS, Manajemen Bangsal, dsb) dan sertifikat tersebut masih dalam masa berlaku.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan	Prosentase (%)

Pengukuran	
Numerator (pembilang)	Jumlah staf yang memiliki sertifikasi khusus
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan karyawan
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh staf yang ditempatkan di unit khusus (Unit Gawat Darurat, ICU, ICCU, Kamar Operasi, Hemodialisa, Ruang Isolasi, CSSD, Radiologi, Laboratorium). Staf administrasi atau tenaga pendukung yang tidak terlibat langsung dalam tindakan pelayanan klinis khusus.
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang memiliki sertifikasi khusus}}{\text{Jumlah keseluruhan karyawan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	File kepegawaian SDM
Instrumen Pengambilan Data	Profil matriks kompetensi staf
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

6. Kepuasan Karyawan

Judul Indikator	Kepuasan karyawan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung pengembangan profesi. 2. Karyawan yang puas cenderung memiliki loyalitas tinggi dan memberikan pelayanan yang lebih empati kepada pasien (<i>Happy Staff = Happy Patient</i>). 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (KKS) mewajibkan adanya evaluasi terhadap budaya kerja dan kesejahteraan staf.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiinambungan
Tujuan	1. Mengukur sejauh mana rumah sakit memenuhi ekspektasi dan kebutuhan karyawan 2. Mengidentifikasi area perbaikan dalam manajemen SDM (misal: kompensasi, lingkungan kerja, atau komunikasi) 3. Menurunkan angka perputaran karyawan (<i>turnover rate</i>)

Definisi Operasional	Kepuasan karyawan adalah hasil penilaian subjektif staf terhadap lingkungan kerja, kompensasi, hubungan antar-rekan, kepemimpinan, dan peluang karir.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah karyawan yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	90%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh karyawan tetap dan kontrak yang telah bekerja minimal 3 bulan Karyawan yang sedang dalam masa orientasi (< 3 bulan) dan mahasiswa praktik
Formula	$\frac{\text{Total karyawan yang puas}}{\text{Total keseluruhan karyawan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner kepuasan karyawan
Sampel	<i>Total sampling</i> (seluruh karyawan)
Periode pengumpulan data	Semesteran
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian SDM

3.3.21. Kesekretariatan

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Ketepatan Pengumpulan UMANDOK 1 X 24 jam setelah selesai kegiatan	100 %	UNIT
2.	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan	100%	UNIT
3.	Ketepatan pendistribusian surat masuk	100%	UNIT
4.	Ketepatan pendistribusian surat keluar	100%	UNIT

3.3.21.1 **Profil Indikator Mutu Kesekretariatan**

1. Ketepatan Pengumpulan UMANDOK 1X24 Jam setelah selesai Kegiatan

Judul Indikator	Ketepatan pengumpulan UMANDOK 1X24 jam setelah selesai kegiatan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Manajemen fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan efisien. 2. Standar Akreditasi Rumah Sakit (Bab TKRS - Tata Kelola Rumah Sakit): Mengharuskan setiap rapat koordinasi, pelatihan, dan kegiatan mutu terdokumentasi dengan bukti fisik yang lengkap (telusur dokumen). 3. Unit Kesekretariatan berfungsi sebagai <i>gatekeeper</i> dan pengendali mutu dokumen organisasi. Keterlambatan pengumpulan menghambat proses tindak lanjut rekomendasi rapat (<i>action plan</i>) dan berisiko hilangnya bukti otentik kegiatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan setiap kegiatan resmi di RS terdokumentasi secara terstruktur, sah, dan tepat waktu. 2. Memudahkan pemantauan tindak lanjut keputusan rapat oleh jajaran direksi. 3. Menjamin ketersediaan dokumen telusur yang siap kapan saja saat audit internal maupun survei akreditasi.
Definisi Operasional	UMANDOK adalah kesatuan berkas bukti pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari: 1. Undangan (resmi/memo internal) 2. Materi (bahan presentasi/<i>handout</i>/draf regulasi) 3. Notulen (catatan jalannya rapat, keputusan, dan rencana tindak lanjut) 4. Dokumentasi (foto/bukti visual kegiatan) Dinyatakan PATUH jika kelima unsur tersebut dikumpulkan lengkap ke unit kesekretariatan dalam waktu maksimal 24 jam setelah jam kegiatan berakhir.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas UMANDOK yang diserahkan tepat waktu (1x24 jam)
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh berkas UMANDOK yang wajib dikumpulkan pada periode tersebut
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua kegiatan resmi rumah sakit: Rapat Koordinasi Bulanan, Rapat Komite (Medis/Keperawatan/Nakes), <i>In-House Training</i> (Diklat), Pertemuan Mutu/Audit Klinis, dan Rapat Direksi.
• Eksklusi	Kegiatan yang bersifat mendadak (<i>Cito / emergency meeting</i>) atau <i>briefing</i> harian operasional ruangan yang durasinya < 15 menit.

Formula	$\frac{\text{Jumlah berkas UMANDOK yang diserahkan tepat waktu (1x24 jam)}}{\text{Jumlah seluruh berkas UMANDOK yang wajib dikumpulkan pada periode tersebut}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit buku register penerimaan dokumen sekretariat atau <i>timestamp</i> unggahan pada sistem digital)
Sumber data	1. Register Kegiatan Rumah Sakit 2. Buku Serah Terima Dokumen (Sekretariat/PMKP/Diklat).
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Kelengkapan dan Ketepatan Waktu UMANDOK
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Sekretaris rumah sakit

2. Ketepatan Waktu Pengumpulan Laporan Bulanan Unit ke Sekretariatan

Judul Indikator	Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan unit ke sekretariatan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Manajemen fasyankes wajib menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala dan terintegrasi. 2. Standar Akreditasi RS (Bab TKRS & PMKP): Pimpinan rumah sakit memerlukan data capaian indikator mutu dan laporan operasional bulanan yang tepat waktu untuk pengambilan keputusan klinis maupun manajerial. 3. Keterlambatan pengumpulan laporan dari unit kerja akan menyebabkan efek domino, yaitu keterlambatan rilis laporan eksekutif rumah sakit kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh unit kerja tertib dan disiplin dalam melaporkan capaian kinerjanya. 2. Menyediakan data yang <i>up-to-date</i> bagi Direksi untuk melakukan evaluasi bulanan. 3. Mempercepat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit.
Definisi Operasional	Ketepatan Waktu Pengumpulan Laporan adalah diserahkannya berkas laporan bulanan (baik fisik maupun digital) secara lengkap oleh kepala unit kerja/instalasi dan diterima oleh Unit Kesekretariatan maksimal pada tanggal 5 setiap bulannya untuk melaporkan kinerja bulan sebelumnya.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah karyawan yang tepat waktu mengumpulkan laporan bulanan ke sekretariat
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan unit di RS
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh unit kerja di bawah struktur organisasi RS (Unit Pelayanan Klinis, Unit Penunjang, hingga Unit Administrasi/Manajerial). Unit kerja yang baru dibentuk (kurang dari 1 bulan berjalan) atau unit kerja yang sedang digabung/dinonaktifkan sementara.
Formula	$\frac{\text{Jumlah karyawan yang tepat waktu mengumpulkan laporan bulanan ke sekretariat}}{\text{Jumlah keseluruhan unit di RS}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit logbook penerimaan atau <i>timestamp</i> sistem)
Sumber data	Buku Register Penerimaan Laporan Bulanan di Sekretariat
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Lembar Kendali Pengumpulan Laporan Bulanan Unit
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Sekretaris rumah sakit

3. Ketepatan Pendistribusian Surat Masuk

Judul Indikator	Ketepatan pendistribusian surat masuk
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menuntut tata kelola administrasi fasyankes yang tanggap, efisien, dan transparan. - Surat masuk sering kali bersifat krusial dan memiliki batas waktu respons (<i>deadline</i>), seperti surat dinas dari Kemenkes/Dinkes, dokumen hukum (somasi/gugatan), undangan rapat penting, atau komplain eksternal. - Keterlambatan distribusi surat oleh sekretariat dapat mengakibatkan fasyankes terlambat mengambil keputusan strategis atau melewati batas waktu hukum yang krusial.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Memastikan seluruh surat masuk diproses dan diteruskan ke tujuan secara cepat dan tepat - Menghilangkan penundaan (zero-delay) dalam birokrasi komunikasi rumah sakit

	3. Mempermudah pelacakan posisi dokumen (<i>tracking</i>) di lingkungan manajemen
Definisi Operasional	Ketepatan Pendistribusian Surat Masuk adalah kondisi di mana surat masuk yang diterima oleh Unit Kesekretariatan berhasil dicatat, dikategorikan, dan diteruskan ke meja Direksi (atau unit tujuan sesuai disposisi) dalam kurun waktu yang ditentukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah surat keluar yang terdistribusi tepat
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan surat yang keluar
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua surat keluar resmi rumah sakit yang ditandatangani oleh Direksi/Manajemen untuk pihak eksternal maupun internal Surat keluar yang penyerahannya sengaja ditunda atas instruksi tertulis langsung dari Direktur (karena alasan strategis/negosiasi)
Formula	$\frac{\text{Jumlah surat keluar yang terdistribusi tepat}}{\text{Jumlah keseluruhan surat yang keluar}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit pencatatan tanggal/jam nomor keluar vs tanggal/jam resi pengiriman)
Sumber data	Log Outbox Aplikasi E-Office
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Ketepatan Pengiriman Surat Keluar
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Sekretaris rumah sakit

4. Ketepatan Pendistribusian Surat Keluar

Judul Indikator	Ketepatan pendistribusian surat keluar
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menuntut efisiensi operasional dan akuntabilitas dalam tata kelola administrasi fasyankes. 2. Surat keluar (seperti surat balasan dinas, laporan berkala ke Dinkes/Kemenkes, surat perjanjian kerjasama/PKS, atau jawaban somasi) memiliki batas waktu kritis (<i>deadline</i>). 3. Keterlambatan pengiriman surat keluar dapat menurunkan kredibilitas rumah sakit di mata mitra, menyebabkan sanksi administratif dari regulator, atau merugikan RS secara hukum.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan seluruh surat masuk diproses dan diteruskan ke tujuan secara cepat dan tepat 2. Menghilangkan penundaan (zero-delay) dalam birokrasi komunikasi rumah sakit 3. Mempermudah pelacakan posisi dokumen (tracking) di lingkungan manajemen
Definisi Operasional	Ketepatan Pendistribusian Surat Masuk adalah kondisi di mana surat masuk yang diterima oleh Unit Kesekretariatan berhasil dicatat, dikategorikan, dan diteruskan ke meja Direksi (atau unit tujuan sesuai disposisi) dalam kurun waktu yang ditentukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah surat masuk yang terdistribusi tepat
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan surat yang masuk
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua surat masuk resmi dari instansi pemerintah, organisasi profesi, mitra kerja, lembaga hukum, maupun internal rumah sakit Surat penawaran barang/jasa dari vendor (marketing/brosur), majalah/katalog, dan surat pribadi/personal yang ditujukan langsung untuk staf tertentu
Formula	$\frac{\text{Jumlah surat masuk yang terdistribusi tepat}}{\text{Jumlah keseluruhan surat yang masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit pencatatan jam terima vs jam kirim/disposisi)
Sumber data	Log Histori/Sistem Pelacakan pada Aplikasi E-Office
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> Ketepatan Arus Surat Masuk
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Sekretaris rumah sakit

3.3.22. Driver

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Angka ketersediaan ambulance sesuai	100%	UNIT

	kebutuhan ≤30 menit		
2.	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance	100%	UNIT
3.	Response time sopir ambulance < 5 menit	100%	UNIT

3.3.22.1 Profil Indikator Mutu Driver

1. Angka Ketersediaan Ambulance sesuai Kebutuhan ≤30 Menit

Judul Indikator	Angka ketersediaan ambulance sesuai ≤30 menit			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin akses pelayanan kegawatdaruratan yang cepat dan terintegrasi untuk menyelamatkan nyawa. 2. Keterlambatan penyediaan ambulans dapat memperburuk kondisi klinis pasien gawat darurat (<i>golden period</i>) atau menunda tindakan definitif di fasyankes rujukan. 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (Starkes) mensyaratkan adanya kepastian sistem transportasi medis yang andal dan siap pakai.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan			
Tujuan	1. Meminimalkan waktu tunggu pasien yang membutuhkan transportasi medis 2. Memastikan kesiapan armada ambulance beserta kru (driver dan perawat pendamping) 3. Meningkatkan efisiensi sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan			
Definisi Operasional	Ketersediaan Ambulans ≤30 Menit adalah durasi waktu yang dihitung sejak adanya instruksi resmi/permintaan ambulance (dari ruangan/IGD/telepon evakuasi) hingga ambulance siap berangkat di depan pintu lobi (kru siap, mesin menyala, dan peralatan medis lengkap). Dinyatakan patuh jika waktu tunggu ≤30 menit.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah driver ambulance yang mengantar ≤30 menit setelah diberikan pesanan			
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan pesanan driver ambulance			
Target Pencapaian	100%			
Kriteria:	• Inklusi Seluruh permintaan ambulans untuk evakuasi penjemputan, rujukan pasien keluar RS, maupun transfer pasien antar-fasilitas. • Eksklusi Permintaan ambulans terjadwal (misal: rencana pulang pasien kontrol/paliatif yang sudah dipesan 1 hari sebelumnya).			
Formula	$\frac{\text{Jumlah driver ambulance mengantar } \leq 30 \text{ menit setelah diberikan pesanan}}{\text{Jumlah keseluruhan pesanan driver ambulance}} \times 100\%$			

Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit lembar catatan logbook ambulans)
Sumber data	3. Logbook unit driver 4. Form permintaan transport medis pada rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring <i>Response Time</i> Ambulans
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian driver

2. Kepatuhan Pelaksanaan Dekontaminasi Ambulance

Judul Indikator	Kepatuhan pelaksanaan dekontaminasi ambulance
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan perlindungan pasien dan petugas dari risiko penularan infeksi di fasyankes. 2. Permenkes No. 2 Tahun 2023: Tentang Peraturan Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan. 3. Ambulans adalah ruang tertutup yang digunakan secara bergantian oleh berbagai jenis pasien (termasuk kasus infeksius seperti TBC, Covid-19, dll). 4. Kegagalan proses dekontaminasi berisiko menjadikan ambulans sebagai vektor penyebaran penyakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memutus rantai penularan mikroorganisme patogen di dalam armada transpor medis. 2. Memastikan kondisi ambulans selalu dalam keadaan steril/bersih secara mikrobiologis sebelum digunakan oleh pasien berikutnya. 3. Melindungi kru ambulans (driver dan perawat) dari paparan biologis.
Definisi Operasional	Dekontaminasi Ambulans adalah proses pembersihan dan disinfeksi secara menyeluruh pada interior kendaraan (termasuk stretcher, tabung oksigen, dinding, lantai, dan peralatan medis di dalamnya) menggunakan cairan disinfektan yang sesuai (misal: klorin atau alkohol) segera setelah ambulans selesai mengantar/menjemput pasien.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelaksana yang patuh terhadap dekontaminasi ambulance
Denominator (penyebut)	Jumlah driver ambulance

Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Setiap penggunaan ambulans untuk transpor pasien (rujukan, penjemputan, maupun evakuasi kasus darurat) Penggunaan ambulans untuk keperluan non-pasien (misal: servis berkala kendaraan ke bengkel, uji emisi, atau simulasi)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelaksana yang patuh terhadap dekontaminasi ambulance}}{\text{Jumlah driver ambulance}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent dan Retrospektif (Audit lembar logbook dekontaminasi)
Sumber data	- Logbook pelayanan ambulance - Checklist PPI dekontaminasi ambulance
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Audit Kepatuhan Dekontaminasi
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian driver

3. Response Time Sopir Ambulance < 5 Menit

Judul Indikator	Response time sopir ambulance < 5 menit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menuntut fasyankes menyediakan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, tepat, dan tanggap. - Dalam kondisi darurat (<i>true emergency</i>), setiap detik sangat berharga. Keterlambatan sopir dalam bersiap dapat menunda <i>golden period</i> penyelamatan nyawa pasien. - Pemisahan indikator sopir dengan kesiapan medis bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik hambatan kelancaran dari sisi logistik/personel transportasi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas ☒ - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Memastikan sopir ambulans selalu berada dalam posisi siap siaga (<i>standby</i>) selama jam dinas. - Meminimalkan waktu jeda (<i>delay</i>) antara instruksi medis dan mobilisasi kendaraan. - Meningkatkan disiplin dan ketanggapan personel pengemudi RS.
Definisi Operasional	Response Time Sopir Ambulans adalah rentang waktu yang dihitung sejak sopir menerima instruksi/panggilan resmi dari unit pemesan (IGD/Rawat Inap/Call Center) hingga sopir sudah berada di dalam kemudi, mesin mobil menyala, dan siap bergerak di area lobi/IGD. Dinyatakan patuh jika waktu respons < 5 menit.

Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah driver ambulance yang merespon < 5 menit terkait kebutuhan
Denominator (penyebut)	Jumlah total driver ambulance
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh panggilan ambulans yang bersifat segera/darurat (penjemputan pasien kritis, rujukan darurat, rujukan intra-hospital darurat) Panggilan ambulans untuk agenda terjadwal (misal: mengantar pasien pulang kontrol pasca-rawat, jemputan rutin non-darurat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah driver ambulance yang merespon < 5 menit terkait kebutuhan}}{\text{Jumlah total driver ambulance}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif dan <i>Concurrent</i> (melalui catatan manifes/log digital)
Sumber data	1. Logbook driver 2. Log panggilan/WhatsApp group driver
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Catatan Waktu Respons Pengemudi
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian driver

3.3.23. Pemulasaraan Jenazah

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
3.	Kepatuhan Transit Jenazah di Kamar Jenazah	100%	UNIT
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian	100%	UNIT

	alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. - Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan - Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. - Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan - Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. - Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. - Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. - Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). - Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. - Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.

Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
------------------	--

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)			
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan			
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.			
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi			
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kepatuhan Transit Jenazah di Kamar Jenazah

Judul Indikator	Kepatuhan transit jenazah di kamar jenazah
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pelayanan kesehatan harus menghormati harkat dan martabat manusia hingga akhir hayat. 2. PMK No. 11 Tahun 2017: Identifikasi pasien yang benar harus dilakukan sampai pasien meninggal dunia (identifikasi jenazah). 3. Standar PPI: Jenazah harus dikelola untuk mencegah risiko penularan infeksi bagi petugas, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya ketertiban prosedur transit jenazah mulai dari penerimaan hingga penyerahan kepada keluarga guna mencegah tertukarnya jenazah dan penyebaran infeksi
Definisi Operasional	Kepatuhan Transit adalah pelaksanaan proses di Kamar Jenazah yang memenuhi kriteria: 1. Identifikasi: Memastikan kesesuaian identitas pada gelang jenazah, label jenazah, dan surat kematian (Minimal 2 identitas). 2. Ketepatan Waktu: Jenazah segera dipindahkan dari ruang

	rawat dalam waktu maksimal 2 jam setelah dinyatakan meninggal. 3. Pencatatan: Pengisian buku register kamar jenazah secara lengkap (Waktu masuk, waktu keluar, identitas penyerah/penerima). 4. APDs: Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai risiko (terutama pada jenazah infeksius).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah jenazah yang dikelola (transit) sesuai prosedur di kamar jenazah dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh jenazah pada bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Seluruh jenazah yang berasal dari ruang rawat inap, IGD, maupun jenazah yang datang dari luar rumah sakit (DOA).
• Inklusi	-
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah jenazah yang dikelola (transit) sesuai prosedur di kamar jenazah dalam satu bulan}}{\text{Jumlah seluruh jenazah pada bulan yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	1. Buku register kamar jenazah 2. Formulir serah Terima jenazah 3. Lembar observasi PPI
Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring prosedur kamar jenazah
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala unit kamar jenazah 2. Komite PPI

4. Kepatuhan Petugas dalam Melakukan Pendokumentasian Jenazah

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam melakukan pendokumentasian jenazah
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mewajibkan pendokumentasian medis yang akurat untuk setiap pelayanan, termasuk pemulasaraan. 2. PMK No. 11 Tahun 2017: Dokumentasi adalah bukti otentik identifikasi pasien/jenazah untuk mencegah kesalahan penyerahan jenazah. 3. Aspek Medikolegal: Dokumen yang lengkap (Surat Kematian, Lembar Serah Terima) melindungi rumah sakit

	dan petugas dari tuntutan hukum di masa depan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Terwujudnya ketertiban administrasi dan keakuratan data jenazah guna menjamin legalitas proses serah terima dan mencegah terjadinya tertukarnya jenazah
Definisi Operasional	Pendokumentasian Jenazah yang Lengkap adalah pengisian seluruh berkas terkait jenazah oleh petugas (Perawat/Petugas Kamar Jenazah) yang meliputi: 1. Formulir Serah Terima: Mencakup identitas jenazah, barang milik jenazah, dan tanda tangan penyerah serta penerima. 2. Surat Keterangan Kematian: Terisi lengkap (penyebab kematian, waktu kematian, tanda tangan dokter). 3. Buku Register Kamar Jenazah: Terisi jam masuk, jam keluar, dan identitas pengambil jenazah (keluarga/ekspedisi). 4. Label Jenazah: Terpasang dengan data yang sesuai dengan rekam medis.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas/dokumen jenazah yang terisi lengkap dan benar
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh jenazah yang masuk ke kamar jenazah
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	Seluruh dokumen jenazah (Rawat Inap, IGD, dan DOA)
• Inklusi	Jenazah tanpa identitas (Mr. X) yang prosesnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian/dinas sosial (namun tetap didokumentasikan sesuai prosedur khusus)
• Eksklusi	
Formula	$\frac{\text{Jumlah berkas/dokumen jenazah yang terisi lengkap dan benar}}{\text{Jumlah seluruh jenazah yang masuk ke kamar jenazah pada periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	1. Rekam medis 2. Buku register kamar jenazah 3. Lembar serah terima jenazah
Instrumen Pengambilan Data	Checklist kelengkapan dokumentasi jenazah
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Tahunan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala unit kamar jenazah

3.3.24. ATEM-IPSRs

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT ATEM			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Waktu tanggap kerusakan alat medis non critical 1x24 jam	≥ 80%	UNIT
2.	Waktu tanggap kerusakan alat medis critical < 15 menit	100%	UNIT
3.	Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis	100%	UNIT
4.	Ketepatan kalibrasi alat sesuai dengan jadwal	100%	UNIT
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT IPSRS			
1.	Waktu pelayanan perbaikan alat non medis ≤ 24 jam	≥ 80%	UNIT
2.	Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset < 10 detik	100%	UNIT
3.	Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)	100%	UNIT

3.3.24.1 Profil Indikator Mutu ATEM-IPSRs

A. Indikator Mutu ATEM

1. Waktu Tanggap Kerusakan Alat Medis *Non Critical* 1x24 jam

Judul Indikator	Waktu Tanggap Kerusakan Alat Medis Non Critical 1 x 24 jam
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 175 mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2023: Tentang Standar Pemeliharaan Alat Kesehatan, yang menekankan pentingnya respon perbaikan untuk menjamin akurasi dan fungsi alat. 3. Standar MFK (Manajemen Fasilitas & Keselamatan): Alat medis yang rusak harus segera ditanggapi agar tidak menghambat pelayanan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Terjaminnya ketersediaan alat medis yang berfungsi dengan baik melalui respon perbaikan yang cepat oleh tim Teknisi Medik (Elektromedik)

Definisi Operasional	1. Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) adalah durasi sejak laporan kerusakan alat diterima oleh unit IPSRS/Teknisi Medik (melalui formulir, telepon, atau aplikasi) hingga teknisi tiba di lokasi atau mulai melakukan pemeriksaan awal terhadap alat tersebut. 2. Alat Medis <i>Non - Critical</i> adalah alat kesehatan yang tingkat risikonya rendah dan tidak berdampak langsung pada kelangsungan hidup pasien seketika (contoh: Timbangan digital, Tensimeter, Nebulizer, Lampu periksa) 3. Target: Maksimal 1 x 24 jam (hari kerja).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kerusakan alat medis non-critical yang mendapatkan respon/tanggapan teknisi dalam waktu ≤24 jam
Denominator (penyebut)	Total seluruh laporan kerusakan alat medis non-critical dalam satu bulan.
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua kerusakan alat kesehatan kategori non-critical di seluruh unit pelayanan 1. Alat medis yang masih dalam masa garansi pihak ketiga (vendor) 2. Kerusakan sarana prasarana non-medis (misal: AC, kran air, lampu ruangan). 3. Alat kategori <i>Life Support</i> atau <i>Critical</i> (karena memiliki indikator respon time tersendiri yang lebih cepat).
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan ditanggapi } \leq 24 \text{ jam}}{\text{Total Laporan Kerusakan Non Critical dalam 1 bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospective
Sumber data	Laporan kerusakan barang
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Waktu Tanggap Perbaikan Alat Medis
Sampel	Total Populasi (Semua laporan kerusakan alat medis <i>non critical</i>).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan, pelaporan dilakukan setiap triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Atem Kepala Bagian Umum

2. Waktu Tanggap Kerusakan Alat Medis *Critical* < 15 menit

Judul Indikator	Waktu Tanggap Kerusakan Alat Medis Critical < 15 menit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjamin keamanan dan kelaikan fungsi alat kesehatan, terutama

	pada kondisi kegawatdaruratan. 2. PMK No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan: Menekankan bahwa alat medis dengan risiko tinggi (seperti alat <i>life support</i>) harus diprioritaskan dalam sistem pemeliharaan dan perbaikan. 3. PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: kegagalan fungsi alat medis kritis yang mengakibatkan kematian atau cedera serius dikategorikan sebagai Kejadian Sentinel (<i>Sentinel Event</i>). Respon cepat teknisi (< 15 menit) adalah bentuk tindakan preventif untuk mencegah terjadinya insiden tersebut 4. Standar MFK (Manajemen Fasilitas & Keselamatan): Menuntut respon cepat teknisi untuk alat-alat yang berdampak langsung pada nyawa pasien guna menjamin <i>zero downtime</i> pada alat kritis
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan setiap kerusakan alat medis kritikal mendapatkan penanganan awal secara instan oleh teknisi guna mencegah kegagalan tindakan medis dan menjaga keselamatan jiwa pasien.
Definisi Operasional	1. Alat Medis Critical adalah perangkat kesehatan pendukung hidup (<i>Life Support</i>) atau alat yang kegagalannya berdampak langsung pada keselamatan nyawa pasien (Contoh: Ventilator, Defibrillator, <i>Anesthesia Machine</i>, <i>Infusion/Syringe Pump</i> di ICU/IGD). 2. Waktu Tanggap < 15 Menit adalah durasi sejak laporan kerusakan diterima oleh teknisi/IPSRS hingga teknisi tiba di lokasi alat tersebut berada
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kerusakan alat medis critical yang ditanggapi/didatangi teknisi dalam waktu < 15 menit.
Denominator (penyebut)	Total seluruh laporan kerusakan alat medis critical dalam satu bulan.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Kerusakan pada seluruh alat medis kategori <i>Life Support</i> dan alat di area pelayanan intensif (IGD, ICU, ICCU, NICU, Kamar Operasi) 1. Kerusakan alat yang disebabkan oleh gangguan eksternal di luar teknis alat (misal: pemadaman listrik total atau gangguan suplai gas medis sentral). 2. Alat yang sedang dalam proses kalibrasi rutin oleh pihak eksternal.
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan ditanggapi} \leq 15 \text{ menit}}{\text{Total Laporan Kerusakan Alat Critical dalam 1 bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan langsung saat panggilan masuk dan saat kedatangan teknisi)
Sumber data	Logbook Kerusakan Alat di Unit

Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Respon Time Alat Medis Kritis
Sampel	Total Populasi (Semua laporan kerusakan alat medis <i>critical</i>).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan, pelaporan dilakukan setiap triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Atem Kepala Bagian Umum

3. Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Medis

Judul Indikator	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat Medis			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 175 mewajibkan Fasyankes melakukan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan secara berkala. 2. PMK No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan: Mengatur bahwa pemeliharaan preventif harus dilakukan sesuai jadwal untuk menjamin usia pakai dan akurasi alat. 3. Standar MFK (Manajemen Fasilitas & Keselamatan): Mencegah terjadinya kerusakan mendadak (<i>breakdown</i>) yang dapat mengganggu pelayanan pasien.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan			
Tujuan	Terwujudnya kondisi alat medis yang siap pakai, akurat, dan aman melalui pelaksanaan pemeliharaan preventif yang disiplin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.			
Definisi Operasional	Ketepatan Waktu Pemeliharaan adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan preventif (inspeksi, pembersihan, pelumasan, dan pengujian fungsi) terhadap alat medis sesuai dengan bulan/jadwal yang tertera pada Rencana Tahunan Pemeliharaan IPSRS. Dikatakan "Tepat Waktu" jika dilakukan pada bulan yang dijadwalkan.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses ☒	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah alat medis yang dilakukan pemeliharaan preventif tepat waktu sesuai jadwal dalam satu bulan.			
Denominator (penyebut)	Total seluruh alat medis yang dijadwalkan untuk dipelihara pada bulan tersebut.			
Target Pencapaian	100%			
Kriteria:	• Inklusi Seluruh inventaris alat medis yang terdaftar dalam program pemeliharaan preventif tahunan (IPSRS)			
	• Eksklusi 1. Alat medis yang sedang dalam perbaikan besar (<i>overhaul</i>). 2. Alat medis yang sedang ditarik oleh produsen (<i>recall</i>). 3. Alat medis yang dinyatakan rusak permanen/dalam proses penghapusan aset			

Formula	$\frac{\text{Jumlah alat yang dipelihara tepat waktu}}{\text{Total Alat yang masuk jadwal pemeliharaan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit dokumen/logbook pemeliharaan)
Sumber data	Kartu Pemeliharaan Alat & Jadwal Tahunan Pemeliharaan IPSRS
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Pemeliharaan Preventif
Sampel	Total Populasi (Semua alat yang masuk jadwal bulanan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan, pelaporan dilakukan setiap triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Atem Kepala Bagian Umum

4. Ketepatan Kalibrasi Alat Sesuai dengan Jadwal

Judul Indikator	Ketepatan Kalibrasi Alat Sesuai dengan Jadwal
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan bahwa alat kesehatan yang digunakan harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelaikan pakai. - PMK No. 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Alat Kesehatan: Menekankan kewajiban pengujian dan kalibrasi secara berkala untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja alat. - Standar Akreditasi (MFK 8): Fasilitas kesehatan harus memiliki sistem untuk memastikan semua alat medis yang digunakan telah dikalibrasi sesuai aturan yang berlaku.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Memastikan seluruh alat medis yang memiliki parameter ukur memiliki akurasi yang tinggi, legalitas penggunaan yang sah, dan aman bagi pasien maupun petugas.
Definisi Operasional	- Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (<i>traceable</i>) ke standar nasional/internasional. - Tepat Jadwal berarti kalibrasi dilakukan paling lambat pada bulan jatuh tempo masa berlaku sertifikat kalibrasi sebelumnya (biasanya 1 tahun sekali).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah alat medis yang dilakukan kalibrasi tepat waktu sesuai dengan jadwal/masa berlaku sertifikat.

Denominator (penyebut)	Total seluruh alat medis yang wajib kalibrasi dan telah jatuh tempo pada periode tersebut.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh alat medis yang memiliki parameter ukur dan termasuk dalam daftar alat wajib kalibrasi sesuai regulasi Kemenkes. 1. Alat medis yang statusnya sudah dinyatakan "Rusak Berat" atau dalam proses penghapusan aset.
Formula	$\frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi tepat waktu}}{\text{Total Alat yang jatuh tempo kalibrasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit dokumen sertifikat kalibrasi)
Sumber data	Sertifikat kalibrasi, Label/Stiker Kalibrasi pada alat, dan Master Inventaris Alat Medis (IPSRs)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Status Kalibrasi Alat Medis
Sampel	Total Populasi (Semua alat medis wajib dikalibrasi)
Periode pengumpulan data	Tahunan (dengan pemantauan/rekapitulasi setiap bulan).
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap triwulan dan tahunan.
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Atem Kepala Bagian Umum

- B. Indikator Mutu IPSRS
1. Waktu pelayanan perbaikan alat non medis ≤ 24 jam

Judul Indikator	Waktu Pelayanan Perbaikan Alat Non Medis ≤ 24 jam
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamankan rumah sakit untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan laik pakai. 2. Standar MFK (Manajemen Fasilitas & Keselamatan): Mengharuskan pemeliharaan sistem utilitas dan prasarana guna mendukung lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien dan staf. 3. Kepuasan Pelanggan: Kerusakan fasilitas non-medis yang lama tidak diperbaiki dapat menurunkan mutu pelayanan dan kenyamanan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Menjamin ketersediaan prasarana dan alat non-medis dalam kondisi berfungsi baik melalui respon perbaikan yang cepat guna mendukung operasional pelayanan.
Definisi Operasional	1. Waktu Pelayanan Perbaikan adalah durasi sejak laporan kerusakan diterima oleh unit IPSRS/Pemeliharaan hingga teknisi mulai melakukan tindakan perbaikan atau memberikan solusi teknis di lokasi kejadian. 2. Alat Non-Medis adalah sarana penunjang yang tidak

	digunakan langsung untuk tindakan medis (contoh: AC, tempat tidur pasien/manual, kursi roda, kebocoran kran, kerusakan lampu, atau pintu) 3. Target: Maksimal 1 x 24 jam sejak laporan masuk.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan kerusakan alat non-medis yang mendapatkan tindakan perbaikan dalam waktu ≤24 jam.
Denominator (penyebut)	Total seluruh laporan kerusakan alat non-medis yang diterima dalam satu bulan.
Target Pencapaian	≥ 80%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua kerusakan sarana dan prasarana penunjang non-medis di seluruh area fasilitas pelayanan kesehatan. 1. Perbaikan yang membutuhkan penggantian <i>sparepart</i> khusus yang tidak tersedia di gudang (<i>indent</i>). 2. Perbaikan yang membutuhkan jasa pihak ketiga/kontraktor luar. 3. Kerusakan akibat bencana alam besar yang melumpuhkan sistem utilitas secara luas.
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan diperbaiki} \leq 24 \text{ jam}}{\text{Total laporan kerusakan non medis}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit logbook laporan kerusakan/LKB)
Sumber data	Logbook Laporan Kerusakan Barang (LKB) atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) modul <i>Maintenance</i> .
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Waktu Tanggap Perbaikan Prasarana.
Sampel	Total Populasi (Seluruh laporan kerusakan non-medis)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan dan pelaporan dilakukan triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit IPSRS Kepala Bagian Umum

2. Waktu tanggap kesiapan fungsi alat genset < 10 detik

Judul Indikator	Waktu Tanggap Kesiapan Fungsi Alat Genset < 10 detik
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mewajibkan Fasyankes menyediakan prasarana yang aman dan selalu siap guna. 2. PMK No. 40 Tahun 2022: Tentang prasarana RS, yang mewajibkan ketersediaan sistem kelistrikan darurat pada area pelayanan kritis. 3. Standar MFK 9: Rumah sakit harus memastikan bahwa sistem utilitas (listrik) tersedia 24 jam sehari, 7 hari

	seminggu, tanpa terputus untuk area kritis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Menjamin ketersediaan aliran listrik cadangan secara cepat saat terjadi pemutusan arus dari sumber utama (PLN), guna menjaga keselamatan pasien di area yang bergantung pada peralatan medis bertenaga listrik
Definisi Operasional	1. Waktu Tanggap Genset adalah durasi waktu (jeda) sejak aliran listrik utama (PLN) padam hingga mesin Genset menyala secara otomatis melalui sistem ATS (<i>Automatic Transfer Switch</i>) dan mendistribusikan daya ke panel distribusi rumah sakit 2. Target: Aliran listrik cadangan harus tersedia dalam waktu < 10 detik.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian pemutusan listrik (uji coba maupun riil) di mana Genset dapat mem-back up listrik dalam waktu < 10 detik.
Denominator (penyebut)	Total seluruh kejadian pemutusan listrik (uji coba rutin mingguan maupun kejadian padam listrik riil) dalam satu bulan.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua kejadian pemutusan aliran listrik utama, baik saat dilakukan uji coba rutin (<i>Running Test</i>) maupun saat terjadi gangguan dari PLN.
• Eksklusi	Pemutusan listrik yang direncanakan untuk pemeliharaan jaringan internal di mana sistem distribusi sudah dialihkan secara manual sebelumnya.
Formula	$\frac{\text{Jumlah respon genset < 10 detik}}{\text{Total kejadian pemutusan listrik}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (pencatatan langsung saat pengujian atau kejadian).
Sumber data	Logbook Pemeliharaan Genset, Logbook Panel ATS, atau Laporan Kejadian Padam Listrik Unit IPSRS.
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Uji Coba Genset dan Sistem ATS
Sampel	Total Populasi (Seluruh kejadian listrik padam)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan dan pelaporan dilakukan triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit IPSRS Kepala Bagian Umum

3. Ketepatan Uji Coba Alat Genset (1 bulan sekali)

Judul Indikator	Ketepatan uji coba alat genset (1 bulan sekali)
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai standar sarana prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (yang mewajibkan ketersediaan sistem penunjang yang andal). 3. Standar Akreditasi (Fasilitas dan Keselamatan/MFK): Menjamin keandalan sistem kelistrikan darurat agar tidak terjadi kegagalan sistem saat dibutuhkan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Memastikan genset dalam kondisi siap pakai (standby) setiap saat dan mendeteksi lebih awal jika terdapat kerusakan teknis pada mesin.
Definisi Operasional	Ketepatan uji coba genset adalah pelaksanaan <i>running test</i> (pemanasan mesin tanpa beban atau dengan beban) yang dilakukan secara rutin satu bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh bagian pemeliharaan sarana prasarana.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah uji coba alat genset yang dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal (1 bulan sekali)
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh unit genset yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber listrik cadangan (utama maupun <i>backup</i>) -
Formula	Jumlah uji coba alat genset yang dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal (1 bulan sekali)
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi jadwal) dan Retrospektif (Audit logbook)
Sumber data	Logbook Pemeliharaan Genset (Formulir pemeriksaan rutin)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Uji Coba Genset dan Sistem ATS
Sampel	Total Sampling (Semua unit genset)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Analisis dilakukan setiap bulan dan pelaporan dilakukan triwulanan

	kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: f. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. g. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. h. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain- lain. i. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. j. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	- Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. - Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) - Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	- Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD - Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	- Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. - Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas

	dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kejadian Linen yang Hilang

Judul Indikator	Kejadian linen yang hilang
Dasar pemikiran	1. Efisiensi Operasional: Linen merupakan aset rumah sakit yang memiliki biaya pengadaan dan pemeliharaan tinggi. 2. Manajemen Logistik: Kehilangan linen yang tinggi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem kontrol distribusi antara laundry dan unit pelayanan. 3. Ketersediaan Pelayanan: Kehilangan linen yang tidak terkendali dapat mengganggu kesiapan tempat tidur pasien (<i>bed availability</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan rumah sakit dalam mengelola dan mengendalikan inventaris linen secara efektif guna menekan kerugian finansial.
Definisi Operasional	Linen Hilang adalah selisih kurang antara jumlah fisik linen yang ada (saat inventarisasi/stok opname) dibandingkan dengan jumlah saldo buku/catatan inventaris resmi, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Termasuk di dalamnya: 1. Hilang di unit pelayanan 2. Hilang saat proses pencucian/laundry 3. Terbawa oleh pasien/keluarga
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah linen yang dinyatakan hilang pada periode observasi
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua jenis linen (sprei, sarung bantal, selimut, perlak, baju pasien, kain pembungkus alat) Linen yang dinyatakan rusak/afkir (karena robek atau noda permanen) dan telah dibuatkan berita acara pemusnahannya
Formula	Jumlah linen yang dinyatakan hilang pada periode observasi
Metode Pengumpulan Data	<i>Restrospektif</i>
Sumber data	1. Laporan stok opname linen 2. Buku register inventaris laundry
Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekapitulasi inventaris linen
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala ruang laundry

4. Kejadian Terdapat Benda Asing di Linen

Judul Indikator	Kejadian terdapat benda asing di linen			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai keselamatan pasien dan perlindungan dari bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (terkait pengelolaan linen). 3. Pencegahan risiko cedera (seperti luka tusuk atau iritasi kulit) pada pasien akibat tertinggalnya benda tajam/berbahaya pada linen bersih.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan			
Tujuan	Terwujudnya pelayanan linen yang aman bagi pasien dengan memastikan tidak terdapat benda asing (sampah, alat medis tajam, dll) pada linen siap pakai.			
Definisi Operasional	Kejadian terdapat benda asing adalah ditemukannya benda yang seharusnya tidak berada pada linen bersih saat proses penyortiran di unit <i>laundry</i> atau saat akan digunakan oleh petugas di ruang rawat inap. Contoh: jarum, gunting, kassa, sisa plastik, atau benda lainnya.			
Jenis Indikator	Struktur ☒	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian			
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian ditemukannya benda asing pada linen dalam satu bulan			
Denominator (penyebut)	-			
Target Pencapaian	0 kejadian			
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua linen yang sudah diproses oleh unit laundry (bersih dan steril) baik di unit laundry maupun di unit perawatan			
	Benda yang bukan berasal dari area pelayanan(misal: kotoran akibat kontaminasi di ruang penyimpanan yang bukan salah proses laundry)			
Formula	Jumlah kejadian ditemukannya benda asing pada linen dalam satu bulan			
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pelaporan insiden segera setelah ditemukan)			
Sumber data	1. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 2. Formulir Laporan Kejadian Unit Laundry			
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pelaporan insiden keselamatan pasien			
Sampel	Total sampling			

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala ruang laundry

5. Tingkat Kebersihan dan Sterilitas Linen yang Disediakan

Judul Indikator	Tingkat kebersihan dan sterilitas linen yang disediakan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengenai standar pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 3. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang PPI: Linen adalah media transmisi kuman jika tidak dikelola dengan standar sterilitas yang tepat.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan
Tujuan	Memastikan linen yang didistribusikan ke unit pelayanan telah melalui proses pencucian dan sterilisasi yang memenuhi standar mikrobiologi.
Definisi Operasional	Linen bersih adalah linen yang telah melalui proses pencucian, pengeringan, dan pelipatan dengan hasil uji angka kuman < 20 koloni/cm ² dan tidak ditemukan adanya kuman patogen (seperti <i>Staphylococcus aureus</i> atau <i>Escherichia coli</i>).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah sampel linen yang dinyatakan memenuhi standar mikrobiologi (bersih/steril) berdasarkan hasil uji laboratorium
Denominator (penyebut)	Total jumlah sampel linen yang diambil untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada periode yang sama
Target Pencapaian	≥ 95%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Linen yang telah diproses di unit <i>laundry</i> dan siap didistribusikan ke unit rawat inap, kamar operasi, atau ruang tindakan Linen yang rusak secara fisik (sobek/bolong) sebelum sempat diambil sampelnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah sampel linen memenuhi standar kuman}}{\text{Jumlah sampel linen yang diperiksa}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> (Hasil uji laboratorium berkala).
Sumber data	Laporan hasil uji laboratorium
Instrumen Pengambilan Data	Formulir hasil pemeriksaan angka kuman linen
Sampel	<i>Random Sampling</i> (Pengambilan sampel linen secara acak dari

	unit <i>laundry</i> secara berkala)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala ruang laundry

3.3.26. CSSD

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
3.	Kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar	0 kejadian	UNIT
4.	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman	100%	UNIT
5.	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse: 1. Begging 2. LMA 3. JR	100%	UNIT
6.	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen	0 kejadian	UNIT
7.	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP	100%	UNIT
8.	Kepatuhan petugas unit terkait penulisan serah terima alat pada buku sertir CSSD baik bersih dan kotor	100%	UNIT
9.	Kepatuhan unit dalam melakukan proses pengiriman dan pengambilan alat sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan CSSD (kecuali cito)	100%	UNIT
10.	Kejadian	0 kejadian	UNIT

	tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor		
--	---	--	--

3.3.26.1 **Profil Indikator Mutu CSSD**

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di

	lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan tool yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Presentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kejadian Kertas Steam Indikator Tidak Berubah Warna Sesuai Standar

Judul Indikator	Kejadian kertas steam indikator tidak berubah warna sesuai standar
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan standar pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): Mewajibkan sterilisasi alat medis untuk memutus rantai penularan infeksi. 3. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Mengatur pengelolaan sarana dan prasarana termasuk unit sterilisasi. 4. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit: Persyaratan mutlak dalam elemen penilaian MFK (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan) dan PPI terkait jaminan sterilitas instrumen medis.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan

Tujuan	1. Mencegah penggunaan alat medis yang tidak steril di ruang tindakan/kamar operasi. 2. Melakukan kontrol kualitas segera terhadap mesin sterilisasi (autoklaf).
Definisi Operasional	Indikator <i>steam</i> (internal/eksternal) adalah alat monitoring proses sterilisasi yang sensitif terhadap parameter fisik (suhu, tekanan, waktu). Kejadian "tidak berubah warna" adalah kegagalan perubahan warna indikator ke warna target setelah melalui siklus sterilisasi, yang menandakan kegagalan proses.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar dalam satu bulan.
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua kemasan instrumen yang melalui proses sterilisasi uap (autoklaf) -
Formula	Jumlah kejadian kertas steam indikator tidak berubah sesuai standar
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (ditemukan saat pembongkaran autoklaf)
Sumber data	Laporan logbook sterilisasi dan formulir monitoring autoklaf
Instrumen Pengambilan Data	Checklist verifikasi sterilisasi CSSD
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

4. Kepatuhan Waktu Pengembalian Instrumen dari *User* ke CSSD dalam Bentuk Rendaman

Judul Indikator	Kepatuhan waktu pengembalian instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman
Dasar pemikiran	1. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Instrumen kotor harus segera direndam/dibersihkan untuk mencegah pengeringan zat organik. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang PPI: Instrumen bedah yang telah dipakai harus segera diproses agar tidak menjadi media tumbuh kuman. 3. Mencegah korosi pada instrumen akibat menempelnya sisa cairan tubuh yang mengeras.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Memastikan instrumen bedah segera diproses setelah digunakan agar kondisi kotoran tetap basah (<i>pre-cleaning/soaking</i>), sehingga proses dekontaminasi lebih efektif.
Definisi Operasional	Pengembalian instrumen dalam bentuk rendaman adalah pengiriman instrumen bekas pakai dari unit pengguna (kamar operasi/ruang tindakan) ke CSSD yang dilakukan segera setelah penggunaan, dengan kondisi instrumen terendam cairan enzimatis/disinfektan dalam wadah tertutup. Batas maksimal waktu pengembalian adalah ≤ 2 jam setelah tindakan selesai.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang mengembalikan instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan petugas yang mengembalikan instrumen dari user ke CSSD
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua instrumen bedah/tindakan yang telah digunakan di Kamar Operasi, IGD, atau Poli Tindakan Instrumen yang tidak digunakan dalam tindakan medis
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang mengembalikan instrumen dari user ke CSSD dalam bentuk rendaman}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas yang mengembalikan instrumen dari user ke CSSD}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan waktu di Buku Serah Terima Instrumen)
Sumber data	Buku Ekspedisi/Logbook Serah Terima Instrumen (kotor) di CSSD
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> waktu pengiriman dan kondisi instrumen
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

5. Kepatuhan Hasil Biological Test Negative pada BMHP Reuse (Begging, LMA, JR)

Judul Indikator	Kepatuhan hasil biological test negative pada BMHP reuse (Begging, LMA, JR)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No. 27 Tahun 2017: Standar PPI dalam penggunaan alat medis kembali. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019: Standar sterilisasi alat medis. 3. Risiko transmisi infeksi silang sangat tinggi pada alat <i>reusable</i> seperti Baging (Ambu Bag), LMA (<i>Laryngeal Mask Airway</i>), dan JR (<i>Jackson Rees</i>) yang berkontak langsung dengan jalan napas pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Memastikan bahwa proses sterilisasi BMHP <i>reusable</i> berhasil mematikan seluruh mikroorganisme, termasuk spora bakteri, sehingga aman digunakan kembali.
Definisi Operasional	<i>Biological Test</i> adalah metode pengujian sterilitas menggunakan spora bakteri (<i>Geobacillus stearothermophilus</i>) yang sangat tahan panas. Hasil "Negatif" berarti tidak ada pertumbuhan bakteri setelah masa inkubasi, yang menandakan proses sterilisasi berhasil.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah BMHP reuse yang hasil <i>biological test</i> -nya negatif setelah dilakukan proses sterilisasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh BMHP reuse yang dilakukan biological test-nya setelah proses sterilisasi dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua BMHP kategori <i>reusable</i> (Baging, LMA, JR) yang disterilkan menggunakan autoklaf BMHP yang hanya melalui proses disinfeksi tingkat tinggi (DTT) bukan sterilisasi autoklaf
Formula	$\frac{\text{Jumlah BMHP reuse yang hasil biological test-nya negative setelah dilakukan proses sterilisasi}}{\text{Jumlah seluruh BMHP reuse yang dilakukan biological test-nya setelah proses sterilisasi dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> (berdasarkan hasil pembacaan inkubator)
Sumber data	Logbook hasil uji biologi (inkubator)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring sterilisasi
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

6. Kejadian Tidak Terpasangnya Label LED pada Instrumen

Judul Indikator	Kejadian tidak terpasangnya label LED pada instrumen
Dasar pemikiran	1. Permenkes No. 7 Tahun 2019: Tentang sterilisasi alat medis di rumah sakit. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017: Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 3. Risiko penggunaan alat medis yang sudah melewati masa sterilitas (kedaluwarsa) dapat menyebabkan infeksi pada pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Memastikan seluruh instrumen medis memiliki penanda masa kedaluwarsa yang jelas, sehingga tidak ada alat yang digunakan setelah batas masa sterilitasnya berakhir
Definisi Operasional	Label LED adalah penanda pada kemasan instrumen yang mencantumkan tanggal sterilisasi dan tanggal kedaluwarsa. Kejadian "tidak terpasangnya label" adalah ditemukannya <i>pack</i> instrumen siap pakai yang tidak dilengkapi label tersebut di area penyimpanan atau unit pelayanan
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian Label ED yang tidak terpasang pada instrumen
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua instrumen yang telah melalui proses sterilisasi di CSSD -
Formula	Jumlah kejadian Label ED yang tidak terpasang pada instrumen
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi saat pengambilan alat dari gudang steril/distribusi)
Sumber data	Laporan hasil audit sterilisasi harian dan temuan saat distribusi
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist</i> verifikasi kemasan instrumen
Sampel	<i>Total Sampling</i>

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

7. Terpasangnya Label Frekuensi Pemakaian pada BMHP

Judul Indikator	Terpasangnya label frekuensi pemakaian pada BMHP
Dasar pemikiran	1. Permenkes No. 7 Tahun 2019: Tentang sterilisasi alat medis. 2. Pedoman Pabrikan: Setiap alat medis memiliki batas maksimal siklus pemrosesan (seperti jumlah sterilisasi maksimal). 3. Menjamin fungsi alat tetap optimal dan mencegah kegagalan material akibat proses sterilisasi berulang.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiinambungan ☒
Tujuan	Memastikan BMHP dengan masa pakai terbatas tidak digunakan melebihi batas jumlah pemrosesan yang ditetapkan, sehingga kualitas klinis alat tetap terjaga
Definisi Operasional	Label frekuensi adalah penanda (stiker/kartu) yang ditempel pada BMHP untuk mencatat setiap kali alat tersebut selesai melalui proses sterilisasi. Kejadian "terpasang" adalah kondisi di mana BMHP memiliki catatan (coretan/tanda) yang menunjukkan jumlah siklus yang telah dilalui
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah label frekuensi yang terpasang pada pemakaian BMHP
Denominator (penyebut)	Jumlah total BMHP yang ada
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua BMHP kategori <i>reusable</i> (Baging, LMA, JR) yang disterilkan menggunakan autoklaf BMHP yang hanya melalui proses disinfeksi tingkat tinggi (DTT) bukan sterilisasi autoklaf
Formula	$\frac{\text{Jumlah BMHP reuse yang hasil biological test-nya negative setelah dilakukan proses sterilisasi}}{\text{Jumlah seluruh BMHP reuse yang dilakukan biological test-nya setelah proses sterilisasi dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode	<i>Retrospektif</i> (berdasarkan hasil pembacaan inkubator)

Pengumpulan Data	
Sumber data	Logbook hasil uji biologi (inkubator)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir monitoring sterilisasi
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Analisis) dan Triwulanan (Laporan ke Komite Mutu)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

8. Kepatuhan Petugas Unit Terkait Penulisan Serah Terima Alat pada Buku Sertir CSSD Baik Bersih dan Kotor

Judul Indikator	Kepatuhan Petugas Unit Terkait Penulisan Serah Terima Alat pada Buku Sertir CSSD Baik Bersih dan Kotor
Dasar pemikiran	1. Standar Akreditasi RS (STARKES) Bab PPI dan Bab TKRS. 2. Pencegahan kehilangan atau kerusakan alat medis. 3. Menjamin ketertelusuran (<i>traceability</i>) proses sterilisasi alat dari unit asal hingga kembali ke unit
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Terselenggaranya pendokumentasian serah terima alat medis yang akurat dan lengkap untuk mencegah terjadinya kesalahan identitas alat, kehilangan, serta mendukung keselamatan pasien melalui proses sterilisasi yang terpantau
Definisi Operasional	Kepatuhan penulisan serah terima adalah kegiatan petugas unit (pengirim/penerima) dalam mengisi buku sertir/serah terima alat CSSD secara lengkap, meliputi: Tanggal, Nama Unit, Nama/Jenis Alat, Jumlah Alat, Kondisi Alat (Bersih/Kotor), serta Tanda Tangan petugas pengirim dan petugas CSSD.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah buku sertir serah terima alat yang diisi secara lengkap dan benar dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh transaksi serah terima alat (bersih dan kotor) di CSSD dalam bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi	Seluruh kegiatan serah terima alat medis antara unit pelayanan (OK, VK, IGD, Poliklinik, dll) dengan unit CSSD.

Eksklusi	Pengambilan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) baru yang bukan merupakan alat <i>reuse</i> .
Formula	$\frac{\text{Jumlah serah terima yang diisi lengkap}}{\text{Jumlah total seluruh serah terima}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Observasi dokumen)
Sumber data	Buku Sertim/Buku Register Serah Terima Alat CSSD.
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Form Observasi Kepatuhan Dokumentasi (Checklist)
Sampel	Total Sampel (Saturasi) jika jumlah transaksi sedikit, atau menggunakan rumus Slovin jika transaksi sangat banyak
Periode pengumpulan data	Bulanan.
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali)
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

9. Kepatuhan Unit dalam Melakukan Proses Pengiriman dan Pengambilan Alat Sesuai dengan Waktu yang Sudah Ditentukan CSSD (Kecuali Cito)

Judul Indikator	Kepatuhan Unit dalam Melakukan Proses Pengiriman dan Pengambilan Alat Sesuai dengan Waktu yang Sudah Ditentukan CSSD (Kecuali <i>Cito</i>)			
Dasar pemikiran	1. Optimalisasi jadwal sterilisasi untuk mencegah penumpukan alat medis. 2. Memastikan ketersediaan alat siap pakai tepat waktu di unit pelayanan. 3. Efisiensi beban kerja petugas CSSD agar proses dekontaminasi hingga sterilisasi berjalan sesuai standar.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒		
Tujuan	Mewujudkan ketepatan waktu distribusi alat medis agar pelayanan pasien tidak terhambat dan proses sterilisasi di CSSD berjalan lebih terorganisir.			
Definisi Operasional	Kepatuhan waktu adalah kedisiplinan petugas unit pelayanan dalam menyerahkan alat kotor dan mengambil alat bersih sesuai dengan jadwal <i>shifting</i> atau jam operasional yang telah ditetapkan oleh unit CSSD .			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	☒	Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			

Numerator (pembilang)	Jumlah transaksi pengiriman dan pengambilan alat yang dilakukan tepat waktu sesuai jadwal dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah total seluruh transaksi pengiriman dan pengambilan alat (kecuali kasus Cito) dalam bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Inklusi: Seluruh unit pelayanan yang menggunakan jasa sterilisasi CSSD (OK, VK, IGD, Rawat Inap, Poliklinik). Eksklusi: Pengiriman atau permintaan alat dalam kondisi Cito (darurat/segera).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pengiriman dan pengembalian tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh pengiriman dan pengambilan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent (Langsung saat kegiatan berlangsung) atau Retrospektif.
Sumber data	Logbook/Buku Register Penerimaan dan Penyerahan Alat CSSD (yang mencantumkan jam transaksi)
Instrumen Pengambilan Data	Form Checklist Pemantauan Waktu Distribusi.
Sampel	Total Sampel (Semua transaksi dalam 1 bulan)
Periode pengumpulan data	Bulanan.
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Ruang CSSD

10. Kejadian Tercampurnya Benda Tajam dengan Instrumen Kotor

Judul Indikator	Kejadian tercampurnya benda tajam dengan instrumen kotor
Dasar pemikiran	1. Standar Akreditasi RS (STARKES) Bab PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi). 2. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Mencegah terjadinya <i>Needle Stick Injury</i> (Luka Tusuk Jarum) pada petugas CSSD saat melakukan proses dekontaminasi dan pencucian alat
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Menjamin keselamatan petugas kesehatan dengan memastikan tidak ada benda tajam berbahaya yang tertinggal dalam set instrumen kotor yang dikirim ke CSSD
Definisi Operasional	Tercampurnya benda tajam adalah ditemukannya benda tajam (seperti mata pisau bedah/scapel blade, jarum suntik, jarum jahit/heacting, atau pecahan kaca) di dalam wadah/bak instrumen kotor yang dikirim dari unit pelayanan ke CSSD, yang seharusnya sudah dibuang ke dalam <i>safety box</i> di unit asal

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah Kejadian (Insiden)
Numerator (pembilang)	Jumlah temuan benda tajam yang tercampur di dalam instrumen kotor dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Tidak ada (Indikator ini bersifat <i>incident report</i> atau laporan kejadian). <i>Catatan: Jika ingin dipersentasekan, penyebutnya adalah total set instrumen kotor yang diterima.</i>
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Inklusi: Semua jenis benda tajam medis yang ditemukan di dalam kontainer/bak instrumen kotor. Eksklusi: Benda tajam yang memang merupakan bagian dari instrumen (misal: gunting tajam, trocar) namun dalam kondisi standar
Formula	Jumlah kejadian temuan benda tajam di bak instrumen kotor
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif & Laporan Insiden (Real-time saat ditemukan).</i>
Sumber data	Logbook Penerimaan Barang CSSD. Formulir Laporan Insiden Keselamatan (jika terjadi paparan).
Instrumen Pengambilan Data	Form Checklist Serah Terima Instrumen / Form Laporan Temuan Benda Tajam.
Sampel	Total sampling (Seluruh pengiriman instrumen dari unit ke CSSD).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan (Segera dilakukan <i>Root Cause Analysis / RCA</i> jika ditemukan kejadian).
Penyajian data	Tabel frekuensi atau Diagram Garis (untuk memantau tren penurunan kejadian menuju target nol).
Penanggung Jawab	Kepala Unit CSSD dan IPCN (Infection Prevention and Control Nurse).

3.3.27. Cleaning Service

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
3.	Kepatuhan <i>cleaning service</i> dalam	100%	UNIT

	membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius		
4.	<i>Respon time</i> petugas kebersihan ≤ 15 menit	100%	UNIT
5.	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis $\leq 3/4$ Tempat sampah	100%	UNIT
6.	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari	100%	UNIT

3.3.27.1 Profil Indikator Mutu Cleaning Service

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum

	melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, suctioning, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung

Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit.

	5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria :	
• Inklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Kepatuhan *Cleaning Service* dalam Membersihkan Ruangan Pasien Setiap 2x dalam Sehari untuk Pasien Non Infeksius

Judul Indikator	Kepatuhan cleaning service dalam membersihkan ruangan pasien setiap 2x dalam sehari untuk pasien non infeksius
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah Sakit wajib menyediakan lingkungan pelayanan yang bersih, sehat, dan aman bagi pasien. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Mewajibkan standar kebersihan ruang perawatan untuk meminimalisir risiko infeksi dan menjaga kenyamanan. 3. Standar Akreditasi RS (PPI & MFK): Pembersihan lingkungan secara rutin adalah elemen kunci dalam pengendalian infeksi nosokomial dan kenyamanan pasien.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesinambungan
Tujuan	1. Menjamin konsistensi kebersihan ruangan selama masa perawatan. 2. Menciptakan lingkungan perawatan yang bersih, rapi, dan nyaman bagi pasien. 3. Mencegah risiko infeksi yang bersumber dari lingkungan.
Definisi Operasional	Pembersihan ruangan pasien adalah kegiatan sanitasi rutin (menyapu, mengepel, pembersihan debu pada furnitur, dan pembersihan toilet) yang dilakukan minimal 2 kali dalam sehari (biasanya pada <i>shift</i> pagi dan sore). Dinyatakan patuh jika seluruh komponen pembersihan dilakukan dan tercatat pada lembar kontrol
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas CS yang membersihkan ruangan pasien non infeksius setiap 2x dalam sehari
Denominator (penyebut)	Jumlah petugas CS yang bertugas
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh kamar/ruang rawat inap pasien non-isolasi (non-infeksius) yang terisi pasien.
• Eksklusi	Ruang isolasi infeksius (memiliki standar PPI berbeda) dan ruangan yang sedang kosong (dalam status pembersihan total/mop-up)
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas CS yang membersihkan ruangan pasien non infeksius}}{\text{Jumlah petugas CS yang bertugas}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi harian melalui verifikasi lembar <i>checklist</i> di setiap ruangan)
Sumber data	
Instrumen Pengambilan Data	Formulir audit kepatuhan pembersihan ruangan
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Cleaning Service Kepala Bidang Umum Komite PPI

4. Respon Time Petugas Kebersihan ≤ 15 Menit

Judul Indikator	Respon time petugas kebersihan ≤ 15 Menit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah Sakit wajib menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman. 2. Standar Akreditasi RS (MFK): Kecepatan respon terhadap insiden kebersihan adalah bagian dari manajemen fasilitas untuk mencegah kecelakaan (seperti lantai licin) dan penyebaran infeksi. 3. Manajemen Risiko: Penundaan pembersihan pada area yang terpapar cairan tubuh atau kotoran berisiko tinggi menimbulkan <i>incident patient safety</i> (pasien/staf terpeleset atau infeksi).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memastikan setiap laporan kebutuhan kebersihan ditangani dengan cepat. 2. Meminimalisir risiko bahaya akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis atau berbahaya (licin/kotor).
Definisi Operasional	<i>Response time</i> adalah waktu yang dihitung sejak petugas kebersihan menerima panggilan/laporan permintaan kebersihan dari unit kerja hingga petugas sampai di lokasi kejadian dan siap melakukan tindakan kebersihan. Target waktu adalah kurang dari atau sama dengan 15 menit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas CS yang merespon tugasnya ≤ 15 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah petugas CS yang bertugas
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua permintaan kebersihan yang bersifat <i>urgent</i> (seperti tumpahan darah, cairan tubuh, sampah infeksius, atau lantai licin) Pekerjaan rutin (seperti jadwal pembersihan rutin) dan permintaan di saat petugas sedang dalam kondisi darurat yang lebih tinggi (seperti bantuan <i>Code Red</i>)
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas CS yang merespon tugasnya} \leq 15 \text{ menit}}{\text{Jumlah petugas CS yang bertugas}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Melihat catatan waktu panggilan di <i>logbook</i> atau sistem komunikasi/grup WhatsApp)
Sumber data	<i>Logbook</i> permintaan kebersihan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir response time
Sampel	<i>Total Sampling</i>

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Cleaning Service Kepala Bidang Umum Komite PPI

5. Ketepatan Waktu Jadwal Pengambilan Sampah Medis dan Non Medis $\leq 3/4$ Tempat Sampah

Judul Indikator	Ketepatan waktu jadwal pengambilan sampah medis dan non medis Medis $\leq 3/4$ Tempat Sampah
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 164 & 165: Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah secara aman, bermutu, dan sesuai standar untuk menjamin keselamatan pasien, staf, dan pengunjung serta mencegah pencemaran lingkungan. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit: Mengatur standar teknis pengelolaan limbah medis dan non-medis secara detail di lingkungan rumah sakit. 3. Standar PPI (Pencegahan & Pengendalian Infeksi): Ketentuan teknis mengenai pengelolaan limbah infeksius (termasuk aturan kapasitas maksimal $3/4$) untuk memutus rantai penularan penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Standar Akreditasi (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan/MFK): Mewajibkan rumah sakit memiliki sistem pengelolaan limbah yang konsisten dan terpantau untuk mendukung keselamatan fasilitas secara menyeluruh.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mencegah penumpukan sampah yang melebihi kapasitas tempat sampah. 2. Menjamin limbah medis dan non-medis segera diangkut ke TPS sesuai jadwal untuk meminimalkan risiko infeksi.
Definisi Operasional	Ketepatan waktu adalah kegiatan pengambilan sampah dari tempat sampah di ruangan/unit ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) yang dilakukan sebelum atau saat isi sampah mencapai kapasitas maksimal $3/4$ dari volume tempat sampah
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas CS yang tepat waktu dalam pengambilan sampah medis dan non medis $\leq 3/4$ tempat sampah

Denominator (penyebut)	Jumlah petugas CS yang bertugas
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pengambilan sampah medis dan non-medis di seluruh unit pelayanan Kejadian luar biasa (bencana/kedaruratan) yang menghambat akses petugas kebersihan
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas CS yang tepat waktu dalam pengambilan sampah medis dan non medis} \leq 3/4 \text{ tempat sampah}}{\text{Jumlah petugas CS yang bertugas}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi oleh Kepala Ruang/Perawat atau petugas PPI)
Sumber data	<i>Checklist</i> pemantauan kebersihan unit
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Ketepatan Pengangkutan Sampah
Sampel	<i>Simple Random Sampling</i> pada jam-jam puncak (shift pagi/siang)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Cleaning Service Kepala Bidang Umum Komite PPI

6. Kepatuhan Petugas dalam Membersihkan Area Umum 3x dalam Sehari

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam membersihkan area umum 3x dalam sehari
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 164 & 165: Rumah sakit wajib menyediakan lingkungan pelayanan yang bersih, sehat, dan aman. 2. Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Menetapkan standar kebersihan fasilitas umum di RS untuk menjamin kenyamanan dan mencegah penularan penyakit. 3. Standar Akreditasi RS (MFK): Area umum dengan lalu lintas orang yang tinggi wajib dipelihara kebersihannya secara berkala untuk mendukung keselamatan fasilitas.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan

Tujuan	1. Menjaga standar kebersihan dan higienitas area publik rumah sakit agar tetap nyaman. 2. Mencegah risiko penularan infeksi melalui permukaan benda di area dengan mobilitas tinggi. 3. Memastikan area publik tetap bebas dari kotoran/sampah yang dapat menyebabkan kecelakaan (lantai licin).
Definisi Operasional	Pembersihan area umum adalah kegiatan sanitasi rutin (menyapu, mengepel, membersihkan kursi tunggu, kaca, dan <i>railing</i>) yang dilakukan minimal 3 kali dalam sehari (misal: shift pagi, siang, dan sore). Kepatuhan adalah keterlaksanaan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang terdokumentasi dalam lembar <i>checklist</i> .
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh membersihkan area umum 3x dalam sehari
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan petugas dalam membersihkan area umum
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Lobi utama, ruang tunggu poliklinik, koridor utama, dan selasar rumah sakit. Area khusus yang memerlukan prosedur sterilisasi berbeda (seperti area OK atau ruang isolasi).
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh membersihkan area umum 3x dalam sehari}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam membersihkan area umum}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi harian atau verifikasi lembar kontrol kebersihan)
Sumber data	<i>Checklist</i> pembersihan area umum
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Ketepatan Pengangkutan Sampah
Sampel	<i>Total sampling</i> (seluruh titik area umum)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Cleaning Service Kepala Bidang Umum Komite PPI

3.3.28. Keamanan

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung dan karyawan	0 kejadian	UNIT
2.	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift	100%	UNIT
3.	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan	100%	UNIT
4.	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di Rumah sakit	0 kejadian	UNIT
5.	Kejadian merokok di Area Rumah Sakit	0 kejadian	UNIT
6.	Kepatuhan penggunaan id card pengunjung di area rumah sakit	100%	UNIT

3.3.28.1 Profil Indikator Mutu Keamanan

1. Kejadian Kehilangan Barang Milik Pasien, Pengunjung, dan Karyawan

Judul Indikator	Kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung, dan karyawan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah Sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan kesehatan. 2. Standar Akreditasi RS (MFK): Rumah sakit wajib menyediakan lingkungan yang aman, termasuk pengamanan terhadap aset milik pasien, pengunjung, dan staf untuk meminimalisir risiko kehilangan atau pencurian. 3. Manajemen Risiko: Kehilangan barang merupakan insiden keselamatan yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Menurunkan angka kejadian kehilangan barang di lingkungan rumah sakit. 2. Meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di area publik/ruang rawat inap.
Definisi Operasional	Kejadian kehilangan barang adalah setiap laporan resmi mengenai hilangnya barang pribadi milik pasien, pengunjung, atau karyawan yang terjadi di area lingkungan rumah sakit, yang dibuktikan dengan Laporan Kejadian (IKP) atau laporan kepada bagian keamanan (Satpam).

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung, dan karyawan
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Kehilangan barang yang terjadi di dalam area/lingkungan Rumah Sakit Kehilangan barang yang terjadi di luar area rumah sakit (misal: di area parkir umum atau jalan menuju rumah sakit)
Formula	Jumlah kejadian kehilangan barang milik pasien, pengunjung, dan karyawan
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (berdasarkan buku laporan bagian keamanan/Satpam dan unit KPRS)
Sumber data	Laporan bagian keamanan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir laporan kehilangan
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Keamanan

2. Kepatuhan Petugas Keamanan Melaksanakan Pengawasan Keliling RS 2x dalam Setiap Shift

Judul Indikator	Kepatuhan petugas keamanan melaksanakan pengawasan keliling 2x dalam setiap shift
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah sakit wajib menjamin keamanan lingkungan bagi seluruh pengguna layanan. - Standar Akreditasi RS (MFK): Rumah sakit wajib memiliki program pengamanan fasilitas yang meliputi inspeksi/patrol rutin untuk memastikan area tetap aman dari gangguan atau kehilangan aset. - Manajemen risiko: Patroli rutin adalah langkah preventif utama untuk mendeteksi dini celah keamanan.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan area rumah sakit terpantau secara rutin oleh petugas keamanan. 2. Mencegah terjadinya tindak criminal atau insiden keselamatan di area rumah sakit.
Definisi Operasional	Pengawasan keliling adalah kegiatan patroli fisik yang dilakukan oleh petugas keamanan menyusuri area-area strategis rumah sakit (seperti area rawat inap, ruang tunggu, dan area staf) minimal sebanyak 2 kali dalam satu shift kerja, yang dibuktikan dengan catatan di buku control patroli atau check clock patroli.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas keamanan yang melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift
Denominator (penyebut)	Jumlah petugas keamanan yang bertugas
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua <i>shift</i> (Pagi, Siang, Malam) yang dilaksanakan oleh tim keamanan
• Eksklusi	<i>Shift</i> yang terganggu karena situasi darurat yang mengharuskan petugas fokus pada satu titik kejadian (misal: kebakaran/bencana), sehingga patroli tidak memungkinkan dilakukan
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas keamanan yang melaksanakan pengawasan keliling RS 2x dalam setiap shift}}{\text{Jumlah petugas keamanan yang bertugas}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (audit dokumen buku patroli)
Sumber data	Buku patroli
Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan keamanan
Sampel	Menggunakan sampel minimal sesuai kaidah statistik (minimal 30 sampel per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Keamanan

3. Kepatuhan Jam Berkunjung Sesuai dengan Ketentuan

Judul Indikator	Kepatuhan jam berkunjung sesuai dengan ketentuan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah sakit wajib menjamin lingkungan yang aman dan nyaman bagi proses penyembuhan pasien. 2. Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang PPI: Pembatasan jumlah dan waktu pengunjung diperlukan untuk menekan risiko transmisi infeksi nosokomial dari luar ke dalam area perawatan. 3. Standar Akreditasi RS (MFK): Pengaturan akses masuk ke area terbatas rumah sakit untuk menjamin keamanan aset dan keselamatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	1. Memberikan waktu istirahat yang cukup bagi pasien agar proses penyembuhan optimal. 2. Mengurangi risiko penyebaran infeksi dari pengunjung ke pasien. 3. Memudahkan petugas dalam melakukan tindakan medis/keperawatan tanpa terganggu pengunjung.
Definisi Operasional	Jam berkunjung adalah waktu yang diperbolehkan bagi pengunjung untuk menjenguk pasien. Kepatuhan adalah kondisi dimana pengunjung tidak berada di dalam area perawatan di luar jam yang telah ditentukan (kecuali penunggu pasien yang memiliki kartu akses resmi)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pengunjung yang patuh terkait jam pengunjung sesuai dengan ketentuan
Denominator (penyebut)	Jumlah pengunjung yang datang
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh area rawat inap di rumah sakit Keluarga penunggu pasien (pendamping) yang memiliki kartu identitas penunggu resmi dan petugas medis/non-medis yang berkepentingan
Formula	Jumlah pengunjung yang patuh terkait jam pengunjung sesuai dengan ketentuan _____ X 100% Jumlah pengunjung yang datang
Metode Pengumpulan Data	Concurrent (Observasi langsung oleh petugas keamanan/perawat di jam tutup kunjungan)
Sumber data	Checklist pemantauan kepatuhan pengunjung
Instrumen Pengambilan Data	Formulir checklist monitoring keamanan & ketertiban ruangan

Sampel	Menggunakan sampel minimal sesuai kaidah statistik (minimal 30 sampel per bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Keamanan

4. Kejadian Kekerasan Staf, Pasien, & Pengunjung di Rumah Sakit

Judul Indikator	Kejadian kekerasan staf, pasien, & pengunjung di rumah sakit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Rumah sakit wajib menjamin lingkungan kerja yang aman bagi SDM Kesehatan serta lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien. 2. Standar Akreditasi RS (MFK): Rumah sakit wajib memiliki sistem perlindungan terhadap kekerasan fisik, verbal, atau pelecehan di area rumah sakit. 3. Manajemen risiko: Kekerasan merupakan insiden keselamatan yang berdampak pada psikologis, hukum, dan reputasi RS.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Meminimalisir dan mengeliminasi tindakan kekerasan (fisik maupun verbal) di lingkungan RS. 2. Menjamin rasa aman bagi seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit.
Definisi Operasional	Kekerasan adalah setiap tindakan atau perilaku yang mengancam, membahayakan, atau mencederaikan orang lain, baik secara fisik (pemukulan, pendorongan) maupun verbal (ancaman, kata-kata kasar, pelecehan) yang terjadi di lingkungan RS dan dilaporkan secara resmi.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian kekerasan staff, pasien & pengunjung di rumah sakit
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: • Inklusi	Semua bentuk kekerasan yang terjadi di area rumah sakit yang melibatkan staf, pasien, atau pengunjung

• Eksklusi	Konflik yang berhasil diselesaikan secara damai di tempat tanpa adanya laporan insiden resmi
Formula	Jumlah kejadian kekerasan staff, pasien & pengunjung di rumah sakit
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (berdasarkan laporan insiden / IKP)
Sumber data	Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / Laporan Keamanan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir checklist monitoring keamanan & ketertiban ruangan
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Keamanan

5. Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

Judul Indikator	Kejadian merokok di area rumah sakit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) - PP No. 109 Tahun 2012: Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan - Permenkes No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS: Mewajibkan lingkungan RS bebas dari asap rokok untuk melindungi pasien dan staf - Standar Akreditasi RS (MFK): Larangan merokok bagi staf, pasien, dan pengunjung sebagai bagian dari proteksi kebakaran dan kesehatan lingkungan
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	- Mewujudkan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. - Menghilangkan risiko paparan asap rokok (perokok pasif) bagi pasien, pengunjung, dan staf. - Mengurangi risiko bahaya kebakaran yang dipicu oleh puntung rokok.
Definisi Operasional	Kejadian merokok adalah ditemukannya individu (staf, pasien, atau pengunjung) yang sedang merokok (rokok konvensional maupun elektrik/vape) atau ditemukannya bukti puntung rokok yang masih baru di area gedung maupun halaman dalam lingkungan rumah sakit.

Jenis Indikator	Struktur ☑	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian			
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian merokok di area RS			
Denominator (penyebut)	-			
Target Pencapaian	0 kejadian			
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua area di dalam pagar rumah sakit (seluruh gedung, taman, tempat parkir, dan kantin)			
	Area di luar pagar atau batas kepemilikan lahan rumah sakit			
Formula	Jumlah kejadian merokok di area RS			
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi rutin oleh tim keamanan/K3RS dan laporan dari unit kerja)			
Sumber data	Laporan inspeksi harian petugas keamanan (Satpam)			
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Patroli Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			
Sampel	Total sampling			
Periode pengumpulan data	Bulanan			
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan			
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu			
Penanggung Jawab	Kepala Keamanan			

6. Kepatuhan Penggunaan ID Card Pengunjung di Area Rumah Sakit

Judul Indikator	Kepatuhan penggunaan ID Card pengunjung di area rumah sakit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib menjamin keamanan dan keselamatan pasien (termasuk sterilitas area perawatan). 2. Standar Akreditasi RS (MFK): Rumah sakit wajib memiliki sistem pengamanan akses masuk ke area terbatas (seperti ruang rawat inap) untuk membatasi orang yang tidak berkepentingan. 3. Manajemen Risiko: <i>ID Card</i> adalah sarana verifikasi untuk mencegah akses ilegal atau tindak kriminal di lingkungan RS.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Menjaga ketertiban dan keamanan di area rawat inap. 2. Memastikan hanya pengunjung/penunggu yang terdaftar yang berada di area perawatan. 3. Meminimalisir risiko kehilangan barang dan ancaman terhadap keselamatan pasien/staf.
Definisi Operasional	<i>ID Card</i> pengunjung adalah kartu akses resmi yang diberikan oleh rumah sakit kepada keluarga pasien atau penunggu saat melakukan pendaftaran. Kepatuhan penggunaan adalah kondisi di mana pengunjung/penunggu mengalungkan/menampilkan kartu tersebut selama berada di lingkungan rawat inap rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pengunjung yang patuh menggunakan ID Card di area RS
Denominator (penyebut)	Jumlah pengunjung yang diobservasi secara keseluruhan (minimal 30 pengunjung)
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pengunjung atau penunggu pasien yang berada di dalam area/bangsal rawat inap Tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf rumah sakit yang sedang bertugas
Formula	$\frac{\text{Jumlah pengunjung yang patuh menggunakan ID Card di area RS}}{\text{Jumlah pengunjung yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi rutin oleh tim keamanan)
Sumber data	Laporan inspeksi harian petugas keamanan (Satpam)
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Kepatuhan ID Card pengunjung
Sampel	Menggunakan sampel minimal sesuai kaidah statistik (minimal 30 sampel per bulan)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung	Kepala Keamanan

Jawab	
-------	--

3.3.29. Gudang Umum

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang	100%	UNIT
2.	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)	0%	UNIT
3.	Kejadian komplain dari user	0 kejadian	UNIT

3.3.29.1 Profil Indikator Mutu Gudang Umum

1. Kepatuhan Unit dalam Pengambilan Barang

Judul Indikator	Kepatuhan unit dalam pengambilan barang			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 164 & 175: Rumah Sakit wajib mengelola sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya secara teratur, akuntabel, dan transparan untuk mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan. 2. Standar Akreditasi RS (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan/MFK): Rumah sakit wajib memiliki sistem pengelolaan logistik yang efektif untuk memastikan ketersediaan barang operasional guna mendukung keselamatan dan kenyamanan lingkungan pelayanan.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan ☒			
Tujuan	Mewujudkan tata kelola barang yang disiplin dan terjadwal untuk menghindari permintaan mendadak yang tidak terencana, dan menjamin kebutuhan unit terpenuhi sesuai jadwal.			
Definisi Operasional	Tingkat kedisiplinan unit kerja adalah ketepatan waktu unit dalam melakukan dua tahapan proses logistik, yaitu: (1) Pengajuan permintaan barang sesuai dengan jadwal <i>cutoff</i> (batas waktu) yang ditetapkan, dan (2) Pengambilan barang ke gudang logistik sesuai dengan jadwal distribusi yang telah ditentukan.			
Jenis Indikator	Struktur ☒	Proses	Outcome	Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas unit yang patuh dalam pengambilan barang			
Denominator (penyebut)	Jumlah petugas yang melakukan pengambilan barang di Gudang umum			
Target Pencapaian	100%			

Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Input barang dan mengambil barang sesuai jadwal yang ditentukan 2. Mencantumkan spesifikasi barang dengan jelas (untuk barang tertentu)
	Permintaan barang yang tidak di stok dan permintaan darurat (Cito) yang telah mendapat persetujuan karu dan kabit
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas unit yang patuh dalam pengambilan barang}}{\text{Jumlah petugas yang melakukan pengambilan barang di Gudang umum}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit data sistem atau buku ekspedisi gudang)
Sumber data	Buku Register/Ekspedisi Gudang
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Audit Kelengkapan Logistik
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Staf Gudang Umum Unit Terkait

2. Selisih Barang Fisik dengan Inputan SIMRS (SO dan Kartu Stock)

Judul Indikator	Selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 175: Kewajiban pengelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menyelenggarakan tata kelola manajemen yang akuntabel dan transparan. 2. Standar Akreditasi RS (MFK): Manajemen risiko fasilitas mencakup perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan aset rumah sakit. 3. Prinsip Akuntansi: Sinkronisasi antara aset fisik dan catatan administratif untuk mencegah kerugian finansial RS.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menilai ketelitian petugas Gudang dalam pengelolaan keluar masuk barang dan pencatatan data
Definisi Operasional	Kesesuaian data logistik adalah akurasi antara keberadaan fisik barang (meliputi kesesuaian jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis) yang tersimpan di rak penyimpanan dengan data saldo akhir yang tercatat dalam sistem informasi rumah sakit (SIMRS) pada waktu yang bersamaan

Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)
Denominator (penyebut)	Jumlah barang fisik keseluruhan
Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Barang stok aktif - Barang baru diterima - Barang dalam kemasan utuh - Barang titipan - Barang in transit - Sampel atau hadiah - Barang milik proyek tertentu
Formula	$\frac{\text{Jumlah selisih barang fisik dengan inputan SIMRS (SO dan kartu stock)}}{\text{Jumlah barang fisik keseluruhan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (setelah proses <i>Stock Opname</i> selesai)
Sumber data	Laporan Hasil Stock Opname
Instrumen Pengambilan Data	Lembar kerja perhitungan fisik dan data SIMRS
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Staf Gudang Umum

3. Kejadian Komplain dari User

Judul Indikator	Kejadian komplain dari user
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 175: Manajemen RS wajib dikelola secara akuntabel untuk menjamin mutu layanan internal. - Standar Akreditasi (TKRS/MFK): Kelancaran operasional rumah sakit sangat bergantung pada efektivitas rantai pasok (logistik). Komplain merupakan umpan balik krusial untuk perbaikan sistem logistik.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Menilai respons Gudang terhadap kebutuhan unit
Definisi Operasional	Komplain adalah keluhan resmi yang disampaikan oleh unit kerja (ruangan/instalasi) kepada bagian gudang, baik tertulis maupun melalui sistem informasi, terkait: (1) Keterlambatan pengiriman, (2) Kerusakan barang saat diterima, (3) Ketidaksesuaian jenis/spesifikasi barang, atau (4) Ketidaksiapan stok yang seharusnya tersedia
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah kejadian komplain dari user
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua permintaan barang yang diselesaikan tepat waktu 1. Permintaan barang yang statusnya memang kosong/barang tidak di stok 2. Permintaan darurat diluar jam kerja (Cito) 3. Permintaan barang yang membutuhkan pengadaan khusus (indent)
Formula	Jumlah kejadian komplain dari user
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Review <i>logbook</i> atau <i>ticketing system</i>)
Sumber data	Surat Pesanan (SP) dan Log penerimaan di SIMRS
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Verifikasi Komplain
Sampel	Total sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Staf Gudang Umum

3.3.30. PPI

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
3.	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	100 %	UNIT
4.	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75 %	UNIT
5.	Angka infeksi daerah operasi	≤ 1,5%	KOMITE
6.	Kepatuhan Penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	100%	KOMITE
7.	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam	0 kejadian	KOMITE
8.	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	100%	KOMITE
9.	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	100%	KOMITE
10.	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	100%	KOMITE
11.	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh	100%	KOMITE
12.	Kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok terkait PPI	100%	KOMITE

3.3.30.1 **Profil Indikator Mutu PPI**

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

	3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien. b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah

	penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindungan Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi

Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Concurrent dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

3. Tersedia APD di Setiap Instalasi/Departemen

Judul Indikator	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen
Dasar Pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 2. Menjamin perlindungan bagi petugas kesehatan dari risiko paparan infeksi dan bahan berbahaya (K3RS). 3. Standar Akreditasi RS mengenai Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kestinambungan ☐
Tujuan	Memastikan seluruh unit pelayanan memiliki stok APD yang cukup dan siap pakai untuk mendukung praktik keselamatan kerja dan pencegahan infeksi.
Definisi Operasional	Tersedianya APD adalah kondisi di mana instalasi/departemen memiliki stok APD yang sesuai dengan standar jenis tindakan di unit tersebut (seperti masker, sarung tangan, gaun/apron, pelindung mata) dan tidak mengalami kekosongan stok (<i>out of stock</i>) saat dibutuhkan.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah instalasi/departemen yang memiliki stok APD lengkap dan tersedia sesuai standar kebutuhan unitnya pada saat dilakukan pemeriksaan/supervisi.
Denominator	Total jumlah seluruh instalasi/departemen yang ada di Rumah Sakit.

Target Pencapaian	100%
Kriteria : - Inklusi	Seluruh instalasi pelayanan medis, penunjang medis (Laboratorium, Radiologi), dan unit pendukung yang berisiko paparan (Linen, Gizi, Farmasi)
-Ekslusi	Unit administrasi/manajemen yang tidak memiliki risiko paparan klinis (misal: Bagian Keuangan, SDM).
Formula	$\frac{\text{Jumlah Instalasi dengan APD yang tersedia}}{\text{Total jumlah Instalasi di Rumah Sakit}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Observasi Langsung dan Telaah Laporan Logistik.
Sumber data	Laporan Stok Inventaris Unit dan Hasil Supervisi IPCN/K3RS.
Instrumen Pengambilan	Formulir Checklist Ketersediaan Logistik APD Bulanan
Sampel	Total Sampling (Seluruh Instalasi/Departemen yang dipersyaratkan).
Periode Pengumpulan	Bulanan
Analisis & Pelaporan	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi / Kepala Unit / Penanggung Jawab Logistik Ruangan.

4. Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)

Judul Indikator	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (min 1 parameter)
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 2. Kewajiban Rumah Sakit untuk melakukan surveilans infeksi guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi di RS.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kestinambungan ☐
Tujuan	Tersedianya data surveilans HAIs yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan program PPI di RS.
Definisi Operasional	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAIs adalah aktivitas pengumpulan data infeksi (seperti IDO, ISK, PLABSI, atau VAP) yang dilakukan oleh IPCLN di setiap unit, yang kemudian divalidasi dan dilaporkan kepada IPCN/Komite PPI sesuai format standar setiap bulannya.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator	Jumlah unit pelayanan yang melakukan pencatatan dan menyerahkan laporan HAIs secara lengkap dan tepat waktu kepada Komite PPI dalam satu bulan
Denominator	Total jumlah unit pelayanan yang diwajibkan melakukan surveilans HAIs di Rumah Sakit.
Target Pencapaian	75%
Kriteria Inklusi	Seluruh unit rawat inap, rawat jalan dengan tindakan (misal: Hemodialisa), ICU, dan Kamar Operasi.
Kriteria Eksklusi	Unit non-pelayanan klinis (Manajemen, Keuangan, SDM).
Formula	$\frac{\text{Jumlah unit yang melaporkan HAIs tepat waktu}}{\text{Total seluruh unit yang wajib surveilans}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	<i>Retrospektif</i> : pengumpulan data yang diambil dari data masa lalu (Telaah Dokumen Laporan).
Sumber data	Buku Register Surveilans Unit, Formulir Harian Surveilans, dan Laporan Bulanan IPCLN
Instrumen Pengambilan	Logbook penerimaan laporan bulanan PPI.
Sampel	Total Sampling (Seluruh unit yang wajib lapor).
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Komite PPI / IPCN

5. Angka Infeksi Daerah Operasi

Judul Indikator	Angka Infeksi Daerah Operasi
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. IDO merupakan salah satu jenis infeksi yang paling sering terjadi di RS (HAIs) yang dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesinambungan ☐
Tujuan	1. Memantau kualitas prosedur pembedahan dan perawatan pasca operasi 2. Menurunkan angka kejadian infeksi pada pasien pasca tindakan pembedahan.
Definisi Operasional	Infeksi yang terjadi pada kurun waktu 30 hari pasca operasi (tanpa implan) atau sampai 90 hari pasca operasi (dengan implan), yang mengenai lokasi pembedahan (superfisial, profunda, atau ruang/organ).

Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☒ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah pasien yang mengalami Infeksi Daerah Operasi (IDO) dalam satu bulan
Denominator	Total jumlah pasien yang dilakukan tindakan operasi dalam bulan tersebut
Target Pencapaian	≤ 1,5%
Kriteria Inklusi	Seluruh pasien yang menjalani tindakan pembedahan di Rumah Sakit (baik operasi bersih maupun bersih terkontaminasi).
Kriteria Eksklusi	Pasien yang sudah mengalami infeksi pada lokasi operasi sebelum tindakan dilakukan (infeksi pra-bedah)
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien terinfeksi IDO}}{\text{Jumlah Pasien Operasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Surveilans aktif (observasi langsung dan telaah rekam medis) serta tindak lanjut pasca rawat (<i>post-discharge surveillance</i>).
Sumber data	Rekam Medis, Catatan Keperawatan, Form Surveilans PPI, dan Laporan Dokter Bedah
Instrumen Pengambilan	Formulir Surveilans HAIs (Indikator IDO).
Sampel	Total Sampling (Semua pasien operasi).
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Bulanan & Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Komite PPI / IPCN / Kepala Instalasi Bedah Sentral.

6. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius (Kewaspadaan Transmisi)

Judul Indikator	Angka Infeksi Daerah Operasi
Dasar Pemikiran	3. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. IDO merupakan salah satu jenis infeksi yang paling sering terjadi di RS (HAIs) yang dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan.
Dimensi Mutu	7. Efisiensi ☐ 8. Efektivitas ☐ 9. Aksesibilitas ☐ 10. Keselamatan ☒ 11. Fokus kepada pasien ☐ 12. Kesiambungan ☐
Tujuan	3. Memantau kualitas prosedur pembedahan dan perawatan pasca operasi 4. Menurunkan angka kejadian infeksi pada pasien pasca tindakan pembedahan.
Definisi	Infeksi yang terjadi pada kurun waktu 30 hari pasca operasi

Operasional	(tanpa implan) atau sampai 90 hari pasca operasi (dengan implan), yang mengenai lokasi pembedahan (superfisial, profunda, atau ruang/organ).
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☒ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah pasien yang mengalami Infeksi Daerah Operasi (IDO) dalam satu bulan
Denominator	Total jumlah pasien yang dilakukan tindakan operasi dalam bulan tersebut
Target Pencapaian	$\leq 1,5\%$
Kriteria Inklusi	Seluruh pasien yang menjalani tindakan pembedahan di Rumah Sakit (baik operasi bersih maupun bersih terkontaminasi).
Kriteria Eksklusi	Pasien yang sudah mengalami infeksi pada lokasi operasi sebelum tindakan dilakukan (infeksi pra-bedah)
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pasien terinfeksi IDO}}{\text{Jumlah Pasien Operasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Surveilans aktif (observasi langsung dan telaah rekam medis) serta tindak lanjut pasca rawat (<i>post-discharge surveillance</i>).
Sumber data	Rekam Medis, Catatan Keperawatan, Form Surveilans PPI, dan Laporan Dokter Bedah
Instrumen Pengambilan	Formulir Surveilans HAls (Indikator IDO).
Sampel	Total Sampling (Semua pasien operasi).
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Bulanan & Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Komite PPI / IPCN / Kepala Instalasi Bedah Sentral.

7. Kejadian Pelaporan Tertusuk Jarum ≤ 48 jam

Judul Indikator	Kejadian pelaporan tertusuk jarum ≤ 48 jam
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Risiko penularan penyakit melalui darah (HIV, HBV, HCV) pasca pajanan sangat tinggi. 3. Efektivitas <i>Post Exposure Prophylaxis</i> (Profilaksis Pasca Pajanan) sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan tindakan medis (ideal < 4 jam, maksimal 48-72 jam)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Memastikan setiap petugas yang mengalami insiden tertusuk

	jarum segera melapor agar mendapatkan penanganan medis dan profilaksis secara tepat untuk mencegah infeksi kronis.
Definisi Operasional	Pelaporan tertusuk jarum adalah tindakan petugas kesehatan melaporkan insiden luka tusuk benda tajam bekas pakai pasien kepada IPCN/K3RS dalam waktu tidak lebih dari 48 jam setelah kejadian.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Jumlah Kejadian (Angka Riil)
Numerator	Jumlah insiden tertusuk jarum yang dilaporkan oleh petugas dalam waktu ≤48 jam setelah kejadian
Denominator	Total seluruh insiden tertusuk jarum yang terjadi/ditemukan di Rumah Sakit pada periode tersebut.
Target Pencapaian	0 kejadian yang dilaporkan lebih dari 48 jam
Kriteria Inklusi	Semua petugas (medis, perawat, penunjang, hingga petugas kebersihan) yang mengalami insiden tertusuk jarum atau benda tajam lainnya di lingkungan RS.
Kriteria Eksklusi	Kejadian tertusuk jarum yang terjadi di luar lingkungan Rumah Sakit atau tidak terkait tugas kedinasan
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan tertusuk jarum} \leq 48 \text{ jam}}{\text{Total jumlah seluruh kejadian tertusuk jarum}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Retrospektif (Pencatatan Insiden)
Sumber data	Laporan Insiden Kecelakaan Kerja, Laporan K3RS, atau <i>Form</i> Investigasi Kontak PPI.
Instrumen Pengambilan	Formulir Laporan Pajanan/Kecelakaan Kerja.
Sampel	Total Sampling (Seluruh kasus yang terjadi).
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Komite K3RS / IPCN / Tim PPI.

8. Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Judul Indikator	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI. 2. Lingkungan rumah sakit (permukaan datar dan benda di sekitar pasien) merupakan reservoir potensial bagi patogen penyebab HAIs. 3. Pembersihan yang efektif dapat menurunkan risiko transmisi silang melalui tangan petugas atau kontak pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐

	6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Memastikan permukaan lingkungan di ruang rawat inap dibersihkan dan didisinfeksi secara rutin sesuai standar untuk menciptakan lingkungan perawatan yang aman
Definisi Operasional	Kepatuhan kebersihan permukaan adalah kesesuaian pelaksanaan pembersihan permukaan yang sering disentuh (high-touch surfaces seperti bed rail, nakas, saklar lampu, gagang pintu) menggunakan metode, cairan disinfektan, dan waktu yang tepat sesuai daftar tilik
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah permukaan/titik observasi yang dinyatakan bersih (lulus uji visual atau uji objektif) sesuai standar dalam satu periode.
Denominator	Total jumlah seluruh titik permukaan yang diobservasi dalam periode yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria Inklusi	Semua area perawatan pasien di ruang rawat inap (ruang pasien, kamar mandi pasien, nurse station).
Kriteria Eksklusi	Area non-perawatan (ruang administrasi, gudang logistik kering).
Formula	$\frac{\text{Jumlah titik permukaan yang bersih}}{\text{Total titik permukaan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Observasi Langsung
Sumber data	Laporan Audit Kebersihan Lingkungan Ruangan oleh IPCN/IPCLN atau petugas K3
Instrumen Pengambilan	Formulir Daftar Tilik (Ceklis) Audit Kebersihan Permukaan.
Sampel	<i>Probability Sampling</i> (Minimal 10-20 titik per ruangan per bulan)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	IPCN / Kepala Instalasi Rawat Inap / Penanggung Jawab <i>Cleaning Service</i> .

9. Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standar (2/3 Wadah)

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI. 2. Mencegah terjadinya infeksi silang dan paparan patogen dari linen kotor ke petugas, pasien, maupun lingkungan. 3. Pedoman Laundry di RS
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒

	3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kestinambungan ☐
Tujuan	Memastikan proses pengumpulan dan pengangkutan linen kotor dilakukan secara aman dengan memisahkan linen sesuai jenisnya (Infeksius, Non-Infeksius, dan Linen Ternoda/Cair) menggunakan wadah tertutup
Definisi Operasional	Kepatuhan petugas dalam mengambil linen adalah tindakan memisahkan linen kotor saat di ruangan menggunakan minimal 2 wadah (Infeksius & Non-Infeksius) atau 3 wadah (Infeksius, Non-Infeksius, & Sangat Ternoda) yang memiliki tutup dan kantong plastik berwarna sesuai standar.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah proses pengambilan linen yang dilakukan sesuai standar (pemisahan tepat & wadah tertutup) selama periode observasi.
Denominator	Total jumlah seluruh proses pengambilan linen yang diobservasi dalam periode yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria Inklusi	Seluruh aktivitas pengumpulan dan pengambilan linen kotor dari ruang rawat inap, kamar operasi, dan unit pelayanan lainnya.
Kriteria Eksklusi	Pengiriman linen bersih dari laundry ke ruangan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pengambilan linen sesuai standar}}{\text{Total pengambilan linen yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Observasi Langsung
Sumber data	Laporan Audit PPI / Audit Manajemen Linen.
Instrumen Pengambilan	Formulir Ceklis Audit Manajemen Linen (Monitoring Pengambilan Linen).
Sampel	<i>Probability Sampling atau Minimal 10-15 observasi per bulan.</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	IPCN / IPCLN / Kepala Unit Laundry.

10. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

Judul Indikator	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI. 2. Kecepatan analisis data surveilans HAIs bergantung pada ketepatan waktu pengiriman data dari unit (IPCLN) ke tingkat pusat (IPCN). 3. Standar Akreditasi RS terkait pelaporan data mutu dan PPI.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Terkumpulnya data surveilans PPI dari seluruh unit secara tepat waktu untuk segera dilakukan analisis dan tindak lanjut oleh Komite PPI.
Definisi Operasional	Kepatuhan waktu pelaporan adalah penyerahan laporan bulanan surveilans PPI (HAIs, KKT, APD, dll) oleh IPCLN (Infection Prevention and Control Link Nurse) di unit kepada IPCN (Infection Prevention and Control Nurse) paling lambat setiap tanggal 5 (atau sesuai kebijakan RS) pada bulan berikutnya.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah laporan bulanan PPI dari unit yang diterima tepat waktu sesuai batas tanggal yang ditentukan.
Denominator	Total jumlah seluruh unit/instalasi yang diwajibkan mengirimkan laporan PPI kepada IPCN.
Target Pencapaian	100%
Kriteria Inklusi	Seluruh unit pelayanan yang memiliki perwakilan IPCLN (Rawat Inap, Rawat Jalan, Kamar Operasi, ICU, Penunjang Medis).
Kriteria Eksklusi	Unit yang sedang tidak beroperasi (tutup sementara) atau unit administratif yang tidak diwajibkan surveilans PPI.
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan unit yang diterima tepat waktu}}{\text{Total laporan yang seharusnya diterima}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	<i>Retrospektif</i> (Telaah dokumen melalui buku ekspedisi laporan)
Sumber data	Logbook penerimaan laporan bulanan PPI
Instrumen Pengambilan	Daftar Tilik Monitoring Ketepatan Waktu Laporan Bulanan.
Sampel	Total Sampling (Seluruh laporan IPCLN unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	IPCN (<i>Infection Prevention and Control Nurse</i>) / Ketua Komite PPI.

11. Kepatuhan Penggunaan Spill Kit dala Tumpahan B3 & DUH Tubuh

Judul Indikator	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI. 2. Standar Akreditasi RS terkait Manajemen Fasilitas dan

	Keselamatan (MFK) mengenai penanganan bahan berbahaya.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Mencegah terjadinya infeksi silang dan paparan zat kimia berbahaya terhadap petugas, pasien, serta mencegah kontaminasi lingkungan akibat tumpahan.
Definisi Operasional	Kepatuhan penggunaan spill kit adalah tindakan petugas dalam menangani tumpahan (cairan tubuh atau B3) dengan menggunakan set peralatan <i>spill kit</i> secara lengkap dan benar sesuai SPO (meliputi penggunaan APD, pembatasan area, penyerapan tumpahan, hingga dekontaminasi)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah kejadian tumpahan B3 atau cairan tubuh yang ditangani petugas menggunakan <i>spill kit</i> sesuai standar.
Denominator	Total jumlah seluruh kejadian tumpahan B3 atau cairan tubuh yang terjadi/diobservasi.
Target Pencapaian	100%
Kriteria Inklusi	Semua insiden tumpahan cairan tubuh (darah, urin, muntahan, dll) dan tumpahan B3 (zat kimia, reagen, merkuri) di seluruh area rumah sakit.
Kriteria Eksklusi	Tumpahan air bersih (non-infeksius dan non-B3).
Formula	$\frac{\text{Jumlah penanganan tumpahan sesuai standar}}{\text{Total kejadian tumpahan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Observasi langsung (jika ditemukan saat kejadian) atau <i>Retrospektif</i> melalui Laporan Insiden
Sumber data	Laporan Logbook Tumpahan Unit, Laporan Insiden K3RS, atau Formulir Audit PPI
Instrumen Pengambilan	Formulir Ceklis Monitoring Penggunaan <i>Spill Kit</i> .
Sampel	Total Sampling (Seluruh laporan IPCLN unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	IPCN (<i>Infection Prevention and Control Nurse</i>) / Ketua Komite PPI / Komite K3RS

12. Kepatuhan Petugas dalam Memberikan Edukasi Kelompok Terkait PPI

Judul Indikator	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 & DUH tubuh
Dasar Pemikiran	1. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman PPI.

	2. Standar Akreditasi RS terkait Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) mengenai penanganan bahan berbahaya.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Mencegah terjadinya infeksi silang dan paparan zat kimia berbahaya terhadap petugas, pasien, serta mencegah kontaminasi lingkungan akibat tumpahan.
Definisi Operasional	Kepatuhan penggunaan spill kit adalah tindakan petugas dalam menangani tumpahan (cairan tubuh atau B3) dengan menggunakan set peralatan <i>spill kit</i> secara lengkap dan benar sesuai SPO (meliputi penggunaan APD, pembatasan area, penyerapan tumpahan, hingga dekontaminasi)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah kejadian tumpahan B3 atau cairan tubuh yang ditangani petugas menggunakan <i>spill kit</i> sesuai standar.
Denominator	Total jumlah seluruh kejadian tumpahan B3 atau cairan tubuh yang terjadi/diobservasi.
Target Pencapaian	100%
Kriteria Inklusi	Semua insiden tumpahan cairan tubuh (darah, urin, muntahan, dll) dan tumpahan B3 (zat kimia, reagen, merkuri) di seluruh area rumah sakit.
Kriteria Eksklusi	Tumpahan air bersih (non-infeksius dan non-B3).
Formula	$\frac{\text{Jumlah penanganan tumpahan sesuai standar}}{\text{Total kejadian tumpahan yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Observasi langsung (jika ditemukan saat kejadian) atau <i>Retrospektif</i> melalui Laporan Insiden
Sumber data	Laporan Logbook Tumpahan Unit, Laporan Insiden K3RS, atau Formulir Audit PPI
Instrumen Pengambilan	Formulir Ceklis Monitoring Penggunaan <i>Spill Kit</i> .
Sampel	Total Sampling (Seluruh laporan IPCLN unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 Bulan Sekali)
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	IPCN (<i>Infection Prevention and Control Nurse</i>) / Ketua Komite PPI / Komite K3RS

3.3.31. PKRS

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi Kelompok	100%	TIM
2.	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	TIM
3.	Angka pelaksanaan survei ketepatan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA	100%	TIM
4.	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)	100%	TIM
5.	Kepatuhan Komunikasi efektif terkait SBAR-TBAK (Konsul DPJP, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab)	100%	TIM
6.	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (prognas dan geriatri)	100%	TIM

3.3.31.1 Profil Indikator Mutu PKRS

1. Angka Pelaksanaan Survei Kepatuhan PPA dalam Memberikan Edukasi Kelompok	
Judul Indikator	Angka pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi kelompok
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 164 & 166: Setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan edukasi mengenai tindakan/asuhan yang akan diterima. 2. Standar Akreditasi RS (HPK - Hak Pasien dan Keluarga): RS wajib memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga agar mereka mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses asuhan. 3. Keselamatan Pasien: Edukasi yang efektif meningkatkan pemahaman, kepatuhan pengobatan, dan hasil klinis yang lebih baik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Mengetahui tingkat kepatuhan PPA dalam melaksanakan

	edukasi kelompok sesuai standar pelayanan rumah sakit.
Definisi Operasional	Edukasi kelompok adalah pemberian informasi atau pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh PPA (Dokter, Perawat, Apoteker, Gizi, dll) kepada minimal 2 pasien/keluarga dalam satu waktu dengan topik yang sama (misal: edukasi diabetes, edukasi pencegahan jatuh, edukasi nutrisi). Pelaksanaan dikatakan patuh jika edukasi didokumentasikan dalam Formulir Edukasi Terintegrasi.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi kelompok yang dilakukan sesuai standar
Denominator	Jumlah seluruh pelaksanaan edukasi kelompok yang seharusnya disurvei dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Seluruh kegiatan edukasi kelompok yang dilakukan oleh PPA - Edukasi yang terdokumentasi dalam rekam medis atau formulir edukasi - Edukasi individu - Edukasi yang tidak terdokumentasi - Kegiatan non-edukasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam memberikan edukasi kelompok yang dilakukan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh pelaksanaan edukasi kelompok yang seharusnya disurvei dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	Audit dokumen dan observasi pelaksanaan edukasi kelompok
Sumber data	Rekam medis, formulir edukasi kelompok, dan lembar survei kepatuhan
Instrumen Pengambilan	Checklist/lembar observasi survei kepatuhan edukasi kelompok
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Bulanan dan Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Komite PKRS Tim mutu Kepala ruangan terkait

2. Angka Pelaksanaan PPA dalam Pengisian Form Edukasi Kolaborasi

Judul Indikator	Angka pelaksanaan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas informasi dan edukasi yang diberikan secara komprehensif oleh tim tenaga kesehatan.

	2. Standar Akreditasi RS (MKE & HPK): Edukasi harus diberikan secara kolaboratif oleh PPA (Dokter, Perawat, Dietisien, Farmasi, dll.) dan didokumentasikan dalam satu formulir terintegrasi untuk menjamin kesinambungan asuhan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesinambungan ☐
Tujuan	Mengetahui tingkat kepatuhan PPA dalam mengisi form edukasi kolaborasi sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit.
Definisi Operasional	Pengisian formulir edukasi kolaboratif adalah tindakan pendokumentasian pemberian edukasi oleh PPA dalam satu lembar Formulir Edukasi Terintegrasi.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi yang dilakukan sesuai standar
Denominator	Jumlah seluruh kegiatan edukasi kolaborasi yang seharusnya dilakukan survei dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Seluruh kegiatan edukasi kolaborasi yang dilakukan oleh PPA 2. Form edukasi kolaborasi yang terisi dan terdokumentasi
• Eksklusi	1. Form edukasi yang tidak lengkap/tidak terbaca 2. Edukasi individu (non kolaborasi) 3. Kegiatan yang tidak terdokumentasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan PPA dalam pengisian PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi yang dilakukan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan edukasi kolaborasi yang seharusnya dilakukan survei dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen (rekam medis/form edukasi kolaborasi) dan/atau observasi
Sumber data	Rekam medis pasien dan <i>form</i> edukasi kolaborasi
Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan pengisian form edukasi kolaborasi
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan

Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala ruangan Tim mutu Komite PKRS

3. Angka Pelaksanaan Survei Ketepatan Pengisian Form Edukasi Terintegrasi oleh PPA

Judul Indikator	Angka pelaksanaan survei ketepatan pengisian form edukasi oleh PPA
Dasar Pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023: Kewajiban tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan setiap tindakan pelayanan (termasuk edukasi) secara benar. - Standar Akreditasi (MKE): RS wajib mendokumentasikan edukasi yang diberikan sebagai bukti nyata bahwa hak pasien atas informasi telah dipenuhi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☐ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas ☐ - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☐ - Kesinambungan ☐
Tujuan	Menilai tingkat kepatuhan PPA dalam melakukan pengisian <i>form</i> edukasi terintegrasi sesuai standar yang berlaku di rumah sakit.
Definisi Operasional	Kepatuhan pengisian formulir edukasi terintegrasi adalah Prosentase jumlah formulir edukasi yang diisi lengkap dan benar oleh PPA sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, dibandingkan dengan total seluruh formulir edukasi yang dilakukan audit dalam periode waktu tertentu.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator	Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA yang sesuai standar
Denominator	Jumlah seluruh <i>form</i> edukasi terintegrasi oleh PPA yang seharusnya dilakukan survei dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Seluruh form edukasi terintegrasi yang diisi oleh PPA - Form edukasi yang terdokumentasi dalam rekam medis <i>Form</i> yang tidak lengkap karena pasien pulang paksa/meninggal sebelum edukasi <i>Form</i> yang tidak tersedia atau hilang - Kegiatan edukasi yang tidak menggunakan <i>form</i> terintegrasi
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepatuhan pengisian form edukasi terintegrasi oleh PPA yang sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh form edukasi terintegrasi oleh PPA yang seharusnya dilakukan survei dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode	Audit dokumen rekam medis dan checklist survei kepatuhan

Pengumpulan Data	
Sumber data	Rekam medis pasien dan form edukasi terintegrasi
Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan pengisian form edukasi terintegrasi
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala ruangan Tim mutu Komite PKRS

4. Kepatuhan Staff dalam Menggunakan Media Edukasi Melalui Elektronik (Barcode Leaflet)

Judul Indikator	Kepatuhan staff dalam menggunakan media edukasi melalui elektronik (barcode leaflet)
Dasar Pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023: Kewajiban RS menyediakan informasi kesehatan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. - Standar Akreditasi (MKE - Manajemen Komunikasi & Edukasi): Edukasi harus diberikan menggunakan metode dan media yang efektif agar mudah dipahami pasien/keluarga. - Efisiensi & Inovasi: Penggunaan media digital/barcode mendukung efektivitas penyampaian informasi secara cepat, akurat, dan ramah lingkungan.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas ☐ - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☐
Tujuan	Mengetahui tingkat kepatuhan staf dalam menggunakan media edukasi elektronik (barcode leaflet) dalam proses pemberian edukasi kepada pasien/keluarga.
Definisi Operasional	Kepatuhan penggunaan media edukasi elektronik adalah Prosentase pemberian edukasi oleh staf kepada pasien/keluarga dengan menggunakan media <i>barcode leaflet</i> yang dibuktikan dengan pencantuman metode/media tersebut pada Formulir Edukasi Terintegrasi, sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit dalam periode waktu tertentu.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)

Numerator (pembilang)	Jumlah staf yang menggunakan media edukasi elektronik (barcode leaflet) sesuai standar saat memberikan edukasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh staf yang memberikan edukasi kepada pasien/keluarga dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Seluruh staf (PPA) yang memberikan edukasi kepada pasien/keluarga 2. Edukasi yang dilakukan dengan media yang seharusnya menggunakan <i>barcode leaflet</i> 3. Edukasi yang terdokumentasi 1. Edukasi yang tidak memerlukan media <i>barcode leaflet</i> 2. Edukasi yang tidak terdokumentasi 3. Staf yang tidak memberikan edukasi pada periode pengukuran
Formula	$\frac{\text{Jumlah staf yang menggunakan media edukasi elektronik (barcode leaflet) sesuai standar saat memberikan edukasi}}{\text{Jumlah seluruh staf yang memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung dan audit dokumentasi edukasi pasien
Sumber data	Rekam medis form edukasi dan sistem/media barcode leaflet
Instrumen Pengambilan Data	Checklist kepatuhan penggunaan media edukasi elektronik (barcode leaflet)
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala ruangan Komite PMKP Komite PKRS

5. Kepatuhan Komunikasi Efektif terkait SBAR-TBAK (Konsul DPJP, HO, Rujuk Internal, Rujuk Eksternal, Konsultasi Antar Spesialis, Pelaporan Nilai Kritis Lab)

Judul Indikator	Kepatuhan komunikasi efektif terkait SBAR-TBAK (konsul DPJP, HO, rujuk internal, rujuk eksternal, konsultasi antar spesialis, pelaporan nilai kritis lab)
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023: Kewajiban tenaga kesehatan memberikan asuhan yang aman dengan komunikasi yang terdokumentasi dengan baik. 2. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP 2): Meningkatkan komunikasi yang efektif antar PPA untuk mengurangi risiko <i>medical error</i> .
Dimensi Mutu	1. Efisiensi □

	2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan komunikasi efektif SBAR-TBAK pada situasi klinis penting
Definisi Operasional	Kepatuhan komunikasi efektif adalah Prosentase kegiatan komunikasi klinis (meliputi konsul DPJP, handover, rujukan, dan pelaporan nilai kritis laboratorium) yang dilakukan dengan menggunakan metode SBAR secara terstruktur dan menerapkan prosedur TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi), yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumentasi pada formulir terintegrasi (CPPT/Formulir TBAK) sesuai standar prosedur rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah komunikasi klinis yang dilakukan sesuai standar SBAR-TBAK secara lengkap dan benar
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh komunikasi klinis yang seharusnya menggunakan SBAR-TBAK dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Konsultasi DPJP 2. Handover (HO) pasien 3. Rujukan internal dan eksternal 4. Konsultasi antar spesialis 5. Pelaporan nilai kritis laboratorium
	1. Komunikasi non-klinis 2. Komunikasi yang tidak terdokumentasi 3. Kondisi darurat ekstrem yang tidak memungkinkan dokumentasi lengkap
Formula	$\frac{\text{Jumlah komunikasi klinis yang dilakukan sesuai standar SBAR-TBAK secara lengkap dan benar}}{\text{Jumlah seluruh komunikasi klinis yang seharusnya menggunakan SBAR-TBAK dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Audit rekam medis, observasi langsung, dan telaah formulir komunikasi SBAR-TBAK
Sumber data	Rekam medis, formulir <i>handover</i> , catatan konsultasi, laporan laboratorium nilai kritis
Instrumen Pengambilan Data	Checklist audit kepatuhan komunikasi SBAR-TBAK
Sampel	Menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Bulanan dan Triwulanan

dan pelaporan data	
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala ruangan Komite PMKP Komite Medik

6. Kepatuhan Pembinaan Komunitas Berbasis RSPH (Prognas dan Geriatri)

Judul Indikator	Kepatuhan pembinaan komunitas berbasis RSPH (Prognas dan Geriatri)
Dasar Pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023: RS berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program promotif dan preventif. - Standar Akreditasi (Prognas): RS wajib menjalankan program nasional (seperti KIA, stunting, HIV, TBC, dan penyakit tidak menular) serta pelayanan geriatri secara terintegrasi di komunitas.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☐ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas ☐ - Keselamatan ☐ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	Menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pembinaan komunitas berbasis RSPHS sesuai dengan standar yang diterapkan
Definisi Operasional	Kepatuhan pembinaan komunitas adalah Prosentase jumlah kegiatan pembinaan (edukasi/sosialisasi/pemeriksaan kesehatan) yang dilaksanakan oleh tim Prognas dan Geriatri sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, serta memenuhi kriteria standar pelaksanaan, dibandingkan dengan total rencana kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kegiatan pembinaan komunitas berbasis RSPHS (prognas dan geriatri) yang dilaksanakan sesuai standar
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh kegiatan pembinaan komunitas berbasis RSPHS (prognas dan geriatri) yang direncanakan dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	- Seluruh kegiatan pembinaan komunitas berbasis RSPHS (prognas dan geriatri) yang telah direncanakan - Kegiatan yang terdokumentasi (laporan kegiatan, daftar hadir, materi edukasi) - Kegiatan yang tidak terlaksana karena force majeure (bencana, kebijakan nasional, dll) - Kegiatan yang tidak terdokumentasi

Formula	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan komunitas berbasis RSPHS (prognas dan geriatri) yang dilaksanakan sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pembinaan komunitas berbasis RSPHS (prognas dan geriatri) dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Audit dokumen dan verifikasi laporan kegiatan pembinaan komunitas
Sumber data	Laporan kegiatan, dokumen perencanaan program, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan
Instrumen Pengambilan Data	<i>Checklist monitoring pembinaan komunitas RSPHS</i>
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis : digunakan untuk menampilkan Data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Tim PKRS Koordinator Prognas dan Geriatri

3.3.32. Verifikator

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5 setiap bulan	UNIT
2.	Prosentase Klaim Pending Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)	<0,1% dari total klaim	UNIT
3.	Prosentase Klaim Pending Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)	<1% dari total klaim	UNIT
4.	Prosentase Klaim Tidak Layak	0% dari total klaim	UNIT
5.	Nilai Pengembalian Audit Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)	< Rp 1.000.000	UNIT
6.	Nilai Pengembalian Audit Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)	< Rp 5.000.000	UNIT
7.	Nilai Selisih Negatif Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)	< Rp 50.000.000	UNIT
8.	Nilai Selisih Negatif Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RJTL)	< Rp 100.000.000	UNIT

3.3.32.1 Profil Indikator Mutu Verifikator

1. Waktu Pengajuan Klaim

Judul Indikator	Waktu Pengajuan klaim
Dasar pemikiran	1. Optimalisasi <i>Cash Flow</i> Rumah Sakit: Ketepatan waktu pengajuan klaim merupakan faktor penentu utama dalam siklus penerimaan pendapatan rumah sakit. Semakin cepat berkas klaim diajukan (sesuai ketentuan), semakin cepat pula proses verifikasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yang pada akhirnya mempercepat pencairan dana. Keterlambatan pengajuan akan berdampak langsung pada terganggunya arus kas (<i>cash flow</i>) dan kemampuan rumah sakit dalam membiayai operasional harian. 2. Kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPJS: Dalam perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdapat batasan waktu (<i>deadline</i>) pengajuan klaim yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Ketidakpatuhan terhadap batas waktu tersebut berisiko menyebabkan klaim menjadi kedaluwarsa atau tidak dapat diproses (ditolak permanen). Indikator ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses administratif dilakukan secara disiplin sesuai dengan ketentuan regulasi JKN yang berlaku. 3. Implementasi Budaya Kerja Efektif dan Terukur: Berdasarkan Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026 tentang Penetapan Indikator Mutu, rumah sakit berkomitmen untuk menciptakan sistem manajemen yang efisien. Pengukuran waktu pengajuan klaim membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas alur kerja unit <i>Asuransi Center</i>, mulai dari pengumpulan berkas dari unit pelayanan, proses coding, hingga pengiriman data ke aplikasi E-Klaim. 4. Mitigasi Risiko Penumpukan Berkas: Pengajuan klaim yang dilakukan secara bertahap dan tepat waktu dapat mencegah terjadinya penumpukan berkas di akhir bulan (<i>bottleneck</i>). Penumpukan berkas yang berlebihan sering kali memicu kesalahan coding, ketidaktepatan verifikasi internal, dan stres kerja yang tinggi bagi staf administrasi. Indikator ini mendorong terciptanya ritme kerja yang stabil, teratur, dan minim kesalahan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksebilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Tujuan	memastikan proses administrasi berjalan tertib, cepat, dan akuntabel , sekaligus mendukung mutu pelayanan kesehatan Klaim yang diajukan tepat waktu → pembayaran lebih cepat caseflow rumah sakit terjaga
Definisi Operasional	Ketepatan waktu pengajuan klaim sesuai dengan batas yang telah ditetapkan setiap bulannya
Jenis Indikator	Struktur Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Waktu pengajuan sesuai dengan tanggal yang telah di tetapkan setiap bulannya
Numerator (pembilang)	Jumlah berkas klaim bulan sebelumnya yang berhasil di- <i>submit</i> (diajukan) ke aplikasi E-Klaim BPJS Kesehatan tepat waktu (sebelum atau pada tanggal 5 setiap bulan).
Denominator (penyebut)	Total seluruh berkas klaim pada bulan pelayanan yang harus diajukan ke BPJS Kesehatan.

Target Pencapaian	Tanggal 5 setiap bulan
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Klaim pelayanan pasien BPJS Kesehatan Klaim yang diajukan melalui sistem resmi BPJS Klaim dengan berkas klaim/adminsitrasi yang lengkap dan sesuai Klaim asuransi lain Klaim khusus (misalnya dispute/keberatan) Klaim pending
Formula	Tanggal pengajuan klaim
Metode Pengumpulan Data	Pengambilan data setiap bulan
Sumber data	E-klaim
Instrumen Pengambilan Data	SIMRS dan E-Klaim
Sampel	seluruh berkas yang diajukan
Periode pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center

2. Prosentase Klaim Pending Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Judul Indikator	Prosentase Klaim Pending RJTL
Dasar pemikiran	1. Efisiensi Pengelolaan Volume Klaim Tinggi: Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) memiliki volume kunjungan harian yang jauh lebih tinggi dibandingkan rawat inap. Akumulasi klaim berstatus <i>pending</i> (tertunda) di unit rawat jalan, meskipun per kasus memiliki nominal lebih kecil, dapat menyebabkan beban administrasi yang berat bagi staf <i>Asuransi Center</i> dan menghambat siklus pembayaran klaim secara keseluruhan. Pemantauan ini krusial untuk menjaga kelancaran operasional keuangan rumah sakit. 2. Evaluasi Efektivitas Sistem Verifikasi Internal (Pre-Audit): Status <i>pending</i> pada klaim RJTL umumnya disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen administratif (seperti SEP tidak valid, rujukan kedaluwarsa, atau ketidaksesuaian input kode diagnosa). Dengan memantau indikator ini, rumah sakit dapat mengidentifikasi kelemahan pada sistem <i>pre-audit</i> internal, sehingga perbaikan dapat difokuskan pada titik-titik krusial sebelum data dikirimkan ke BPJS Kesehatan. 3. Kepatuhan terhadap Tata Kelola JKN: Berdasarkan Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026, rumah sakit wajib menjamin tertib administrasi dalam penyelenggaraan JKN. Pengendalian jumlah klaim <i>pending</i> adalah manifestasi dari komitmen rumah sakit dalam menyajikan data klaim yang akurat, lengkap, dan memenuhi standar regulasi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya <i>good corporate governance</i> di rumah sakit. 4. Mitigasi Risiko Penumpukan <i>Dispute</i>: Klaim yang dibiarkan dalam status <i>pending</i> terlalu lama memiliki risiko tinggi untuk tidak dapat diproses lebih lanjut karena melampaui batas waktu verifikasi atau masa berlaku <i>E-Klaim</i>. Pemantauan aktif terhadap Prosentase klaim <i>pending</i> RJTL bertujuan sebagai langkah preventif untuk memastikan penyelesaian berkas klaim dilakukan secara cepat, akurat, dan tepat waktu, sehingga meminimalkan risiko kehilangan

	pendapatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Menilai kualitas klaim pelayanan rawat jalan agar sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.
Definisi Operasional	1. Klaim Rawat Jalan Klaim atas pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit yang telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pending Klaim Status klaim yang ditunda pembayarannya dan dikembalikan oleh BPJS kesehatan dari hasil verifikasi bekas klaim untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Rumah Sakit 3. Penyebab Pending (contoh) Ketidak sesuaian indikasi medis pasien selama dirawat dengan penergakan diagnosa utama Kesalahan koding diagnosis/tindakan (INA-CBGs) Pemeriksaan penunjang dan tatalaksana diagnosa tidak sesuai 4. Total Klaim Seluruh klaim rawat jalan yang telah dikirimkan oleh fasilitas kesehatan ke BPJS dalam periode pengukuran, baik yang sudah dibayar, pending, maupun ditolak/tidak layak
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Jumlah klaim pending rawat jalan dibandingkan dengan seluruh klaim rawat jalan
Numerator (pembilang)	Jumlah Klaim Pending Rawat Jalan
Denominator (penyebut)	Total Keseluruhan Klaim Rawat Jalan
Target Pencapaian	<0,1% dari total klaim
Kriteria:	Seluruh klaim rawat jalan yang diajukan dalam periode tertentu
• Inklusi	Klaim yang sudah melalui proses verifikasi oleh BPJS
• Eksklusi	Klaim yang tidak layak Klaim yang masih dalam proses pengajuan (belum diverifikasi) Klaim luaran INA CBG
Formula	$\frac{\sum \text{Jumlah Klaim Pending Rawat Jalan}}{\sum \text{Total Keseluruhan Klaim Rawat Jalan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	retrospektif dari hasil verifikasi
Sumber data	Berita acara hasil verifikasi klaim
Instrumen Pengambilan Data	Laporan hasil verifikasi BPJS kesehatan
Sampel	Seluruh klaim pending rawat jalan pada periode tertentu
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan

Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC mutu
------------------	----------------------------------

3. Prosentase Klaim Pending Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Judul Indikator	Prosentase Klaim Pending RITL
Dasar pemikiran	1. Optimasi Kecepatan Perputaran Modal (Turnover Klaim): Klaim yang berstatus <i>pending</i> merupakan klaim yang terhenti proses pembayarannya karena adanya ketidaklengkapan dokumen atau data yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Tingginya angka <i>pending</i> pada Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) menghambat kecepatan rumah sakit dalam menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan, sehingga pemantauan indikator ini krusial untuk menjaga stabilitas <i>cash flow</i> operasional rumah sakit. 2. Peningkatan Efektivitas Verifikasi Internal (Pre-Audit): Status <i>pending</i> sering kali menjadi indikator bahwa sistem <i>pre-audit</i> atau verifikasi internal di Unit Asuransi Center belum berjalan secara optimal. Dengan memantau indikator ini, rumah sakit dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses pengecekan berkas sebelum dikirim ke BPJS, guna memastikan bahwa kendala administratif dapat diselesaikan sebelum berkas meninggalkan rumah sakit. 3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Penetapan Indikator Mutu: Merujuk pada Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026, rumah sakit berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola JKN yang akuntabel. Pengendalian jumlah klaim <i>pending</i> adalah bentuk kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan JKN, yang menekankan pada tertib administrasi dan kecepatan penyelesaian proses klaim sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan berkelanjutan. 4. Mitigasi Risiko <i>Dispute</i> dan Penolakan Klaim: Klaim yang dibiarkan dalam status <i>pending</i> dalam waktu lama berisiko berkembang menjadi <i>dispute</i> (perselisihan) klaim atau bahkan berujung pada penolakan permanen jika batas waktu verifikasi telah terlampaui. Pemantauan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko untuk memastikan setiap berkas klaim mendapatkan resolusi yang cepat dan tepat, sehingga meminimalkan potensi hilangnya pendapatan rumah sakit akibat kelalaian administratif
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Akseibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kestinambungan ☐
Tujuan	Menilai kualitas klaim pelayanan rawat inap agar sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.
Definisi Operasional	1. Klaim Rawat Inap Klaim atas pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit yang telah diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pending Klaim Status klaim yang ditunda pembayarannya dan dikembalikan oleh BPJS kesehatan dari hasil verifikasi bekas klaim untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut kepada Rumah Sakit 3. Penyebab Pending (contoh) Ketidak sesuaian indikasi medis pasien selama dirawat dengan penergakan diagnosa utama

	Kesalahan koding diagnosis/tindakan (INA-CBGs) Pemeriksaan penunjang dan tatalaksana diagnosa tidak sesuai 4. Total Klaim Seluruh klaim rawat inap yang telah dikirimkan oleh fasilitas kesehatan ke BPJS dalam periode pengukuran, baik yang sudah dibayar, pending, maupun ditolak/tidak layak
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Jumlah klaim pending rawat inap dibandingkan dengan seluruh klaim rawat inap
Numerator (pembilang)	Jumlah Klaim Pending Rawat Inap
Denominator (penyebut)	Total Keseluruhan Klaim Rawat Inap
Target Pencapaian	< 1% dari total klaim
Kriteria:	Seluruh klaim rawat inap yang diajukan dalam periode tertentu
• Inklusi	Klaim yang sudah melalui proses verifikasi oleh BPJS
• Eksklusi	Klaim yang tidak layak Klaim yang masih dalam proses pengajuan (belum diverifikasi) Klaim luaran INA CBG
Formula	$\frac{\sum \text{Jumlah Klaim Pending Rawat Inap}}{\sum \text{Total Keseluruhan Klaim Rawat Inap}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	retrospektif dari hasil verifikasi
Sumber data	Berita acara hasil verifikasi klaim
Instrumen Pengambilan Data	Laporan hasil verifikasi BPJS kesehatan
Sampel	Seluruh klaim pending rawat inap pada periode tertentu
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC mutu

4. Prosentase Klaim Tidak Layak

Judul Indikator	Prosentase Klaim Tidak Layak
Dasar pemikiran	1. Efisiensi dan Kelancaran Arus Kas Rumah Sakit: Klaim yang dinyatakan "tidak layak" oleh verifikator BPJS Kesehatan menyebabkan tertundanya proses pembayaran, yang berdampak langsung pada arus kas (<i>cash flow</i>) rumah sakit. Pemantauan indikator ini merupakan langkah preventif untuk memastikan bahwa berkas klaim yang dikirimkan telah memenuhi persyaratan administratif dan klinis sejak pengajuan awal, sehingga mempercepat realisasi pendapatan rumah sakit. 2. Peningkatan Budaya Tertib Administrasi dan Akurasi Data: Tingginya Prosentase klaim tidak layak merupakan cerminan dari ketidaktertiban administrasi dan ketidaklengkapan dokumen pendukung di tingkat unit pelayanan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong komitmen seluruh staf, baik klinis maupun tenaga administrasi, dalam meningkatkan ketelitian penulisan <i>resume</i> medis dan kelengkapan dokumen pendukung klaim sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Mutu:

	Sesuai dengan Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026, rumah sakit wajib menjalankan sistem kendali mutu dan kendali biaya. Pemantauan klaim tidak layak menjadi salah satu instrumen utama untuk mengukur sejauh mana efektivitas sistem <i>pre-audit</i> internal rumah sakit dalam menyaring berkas sebelum dikirim ke verifikator eksternal. 4. Mitigasi Risiko <i>Dispute</i> dan <i>Denied Claim</i>: Pengembalian berkas klaim yang berulang-ulang berisiko menjadi temuan audit yang lebih serius, termasuk potensi <i>dispute</i> klaim atau klaim yang ditolak permanen (<i>denied claim</i>). Dengan menetapkan target Prosentase yang rendah (< 1%), rumah sakit berupaya meminimalisir potensi kerugian finansial akibat kesalahan administratif yang sebenarnya dapat dihindari melalui koordinasi yang baik antar unit
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Akseibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Mengukur kualitas pengelolaan klaim Mengetahui sejauh mana klaim yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan administratif dan medis. 2. Mengidentifikasi kesalahan klaim Ketidaksesuaian coding diagnosa/tindakan, Ketidaktepatan indikasi medis, Kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat 3. Mencegah potensi kecurangan (fraud) 4. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu layanan 5. Meningkatkan kompetensi SDM (coder/verifikator)
Definisi Operasional	1. Prosentase Klaim Tidak Layak merupakan jumlah klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan yang dinyatakan tidak layak bayar (reject/dispute) setelah proses verifikasi, dibandingkan dengan seluruh klaim yang diajukan dalam periode tertentu. 2. Klaim tidak layak Tidak memenuhi persyaratan administrasi (misalnya dokumen tidak lengkap) Tidak sesuai dengan indikasi medis atau standar pelayanan yang telah ditetapkan Terindikasi kecurangan (<i>fraud</i>) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Jumlah klaim tidak layak dibandingkan dengan seluruh klaim baik rawat jalan maupun rawat inap pada periode tertentu
Numerator (pembilang)	Jumlah Klaim Tidak Layak
Denominator (penyebut)	Total Keseluruhan Klaim Rawat Jalan & Rawat Inap
Target Pencapaian	0% dari total keseluruhan klaim
Kriteria:	Seluruh klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan dalam periode pengukuran Klaim pelayanan: Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Klaim yang masih dalam proses pengajuan (belum diverifikasi) Klaim luaran INA CBG
Formula	$\frac{\sum \text{Jumlah seluruh klaim tidak layak rawat jalan \& rawat inap}}{\sum \text{Total Keseluruhan Klaim rawat jalan \& rawat inap}} \times 100\%$

Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> dari hasil verifikasi bpjs kesehatan
Sumber data	Berita acara hasil verifikasi klaim
Instrumen Pengambilan Data	Laporan hasil verifikasi BPJS kesehatan
Sampel	Seluruh klaim yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan termasuk pending baik rawat jalan maupun rawat inap pada periode tertentu
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC mutu

5. Nilai Pengembalian Audit Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Judul Indikator	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL
Dasar pemikiran	1. Pengendalian Risiko pada Volume Layanan Tinggi: Rawat Jalan Tingkat Lanjut memiliki frekuensi transaksi klaim yang sangat tinggi. Meskipun nilai per klaim mungkin lebih kecil dibandingkan rawat inap, akumulasi pengembalian klaim (akibat <i>dispute</i> atau audit) dapat menimbulkan dampak finansial yang signifikan bagi rumah sakit. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan efisiensi pengelolaan keuangan pada unit rawat jalan. 2. Akurasi <i>Clinical Coding</i> pada Layanan Spesialis: Ketidaksesuaian klaim RJTL sering kali terjadi akibat ketidaktelitian dalam penginputan kode diagnosa sekunder (komorbid) atau prosedur tindakan yang diberikan dokter spesialis. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan klinis dalam memberikan resume medis yang lengkap agar sesuai dengan aturan <i>koding</i> JKN yang berlaku. 3. Kepatuhan dan Transparansi (Keputusan Direktur Nomor 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026): Sesuai dengan komitmen rumah sakit dalam penetapan indikator mutu, pemantauan nilai pengembalian audit adalah bentuk nyata dari kepatuhan terhadap regulasi JKN. Hal ini bertujuan menjaga integritas data rumah sakit di mata verifikator BPJS dan mencegah terjadinya temuan audit yang berulang. 4. Optimalisasi Proses <i>Billing</i> dan Administrasi: Tujuan akhir dari indikator ini adalah meminimalkan hambatan dalam proses klaim. Dengan memonitor nilai pengembalian di bawah target yang ditentukan, unit <i>Asuransi Center</i> didorong untuk melakukan <i>pre-audit</i> internal sebelum klaim dikirimkan, sehingga proses pembayaran oleh BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Menilai tingkat ketidaksesuaian klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) yang diajukan fasilitas kesehatan terhadap hasil audit 2. Mengetahui besaran nilai klaim yang harus dikembalikan akibat hasil audit. 3. Meningkatkan kualitas pengajuan klaim serta mendorong untuk dapat meningkatkan ketepatan dalam klinis, koding maupun administrasi

	4. Mencegah potensi fraud (kecurangan) 5. Monitoring internal rumah sakit
Definisi Operasional	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL adalah Prosentase nilai finansial klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) yang dinyatakan tidak layak bayar atau harus dikembalikan berdasarkan hasil audit/verifikasi BPJS Kesehatan dibandingkan dengan total nilai klaim yang diajukan dalam periode tertentu.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Besaran biaya pengembalian audit rawat jalan periode tertentu
Numerator (pembilang)	Total nilai nominal (Rupiah) klaim RJTL yang dinyatakan tidak layak bayar atau harus dikembalikan berdasarkan hasil audit/verifikasi BPJS Kesehatan.
Denominator (penyebut)	Tidak ada (diukur berdasarkan nilai absolut).
Target Pencapaian	< Rp. 1.000.000
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Klaim yang telah diajukan dan memlalui peroses verifikasi/audit oleh BPJS kesehatan 2. Klaim yang dikembalikan dikarenakan ketidak sesuaian administrasi, ketidak sesuaian kode diagnosa maupun tindakan, ketidak sesuaian indikasi medis 1. Klaim yang belum diaudit/diverifikasi oleh BPJS kesehatan 2. Klaim yang tidak layak 3. Klaim dengan kendala yang tidak disebabkan oleh rumah sakit (misal aplikasi eror)
Formula	$\sum\{\text{Nilai Klaim RJTL yang Sudah Dibayar}\} - \sum\{\text{Nilai Klaim Hasil Audit RJTL}\}$
Metode Pengumpulan Data	retrospektif telaah dari hasil verifikasi pasca klaim
Sumber data	Verifikasi pasca klaim
Instrumen Pengambilan Data	Laporan audit pasca klaim
Sampel	Seluruh berkas yang diajukan yang telah melalui verifikasi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC mutu

6. Nilai Pengembalian Audit Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Judul Indikator	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL
Dasar pemikiran	1. Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas: Sebagai rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, efisiensi dalam pengelolaan klaim adalah kunci keberlangsungan finansial. Pengembalian klaim (<i>dispute</i> atau <i>denied claim</i>) akibat hasil audit menunjukkan adanya celah dalam proses administrasi maupun klinis. Pemantauan indikator ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian finansial rumah sakit yang timbul dari klaim yang dinyatakan tidak layak bayar 2. Peningkatan Kualitas Dokumentasi Klinis dan Koding (Clinical Documentation Improvement): Ketidaksesuaian klaim sering kali

	berakar pada ketidaksinkronan antara pendokumentasian rekam medis, ketepatan koding diagnosa/tindakan, dengan indikasi medis yang diberikan di lapangan. Indikator ini menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah terdokumentasi dengan benar, akurat, dan sesuai dengan standar klinis yang berlaku. 3. Mitigasi Risiko <i>Fraud</i> dan Kepatuhan Regulasi: Sesuai dengan Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026, rumah sakit berkomitmen untuk menjaga integritas layanan. Pengembalian klaim yang tinggi dapat menjadi indikator adanya potensi <i>fraud</i> atau kesalahan sistemik. Pemantauan ketat terhadap nilai pengembalian audit adalah upaya preventif rumah sakit dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi JKN serta standar akreditasi rumah sakit. 4. Monitoring Internal dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan: Indikator ini berfungsi sebagai <i>early warning system</i> bagi manajemen rumah sakit terkait efektivitas kerja unit <i>Asuransi Center</i> dan kualitas dukungan dari komite medis/unit terkait. Dengan membatasi nilai pengembalian audit di bawah Rp 5.000.000, rumah sakit mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih teliti, tertib administrasi, dan berorientasi pada ketepatan asuhan pasien yang berujung pada kelancaran pembayaran klaim.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Menilai tingkat ketidaksesuaian klaim Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) yang diajukan fasilitas kesehatan terhadap hasil audit 2. Mengetahui besaran nilai klaim yang harus dikembalikan akibat hasil audit. 3. Meningkatkan kualitas pengajuan klaim serta mendorong untuk dapat meningkatkan ketepatan dalam klinis, koding maupun administrasi 4. Mencegah potensi fraud (kecurangan) 5. Monitoring internal rumah sakit
Definisi Operasional	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL adalah Prosentase nilai finansial klaim Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) yang dinyatakan tidak layak bayar atau harus dikembalikan berdasarkan hasil audit/verifikasi BPJS Kesehatan dibandingkan dengan total nilai klaim yang diajukan dalam periode tertentu.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Besaran biaya pengembalian audit rawat inap periode tertentu
Numerator (pembilang)	Total nilai nominal (Rupiah) klaim RITL yang dinyatakan tidak layak bayar atau harus dikembalikan berdasarkan hasil audit/verifikasi BPJS Kesehatan.
Denominator (penyebut)	Tidak ada (diukur berdasarkan nilai akumulasi total Rupiah).
Target Pencapaian	< Rp. 5.000.000
Kriteria:	• Inklusi • Eksklusi
	1. Klaim yang telah diajukan dan memlalui peroses verifikasi/audit oleh BPJS kesehatan 2. Klaim yang dikembalikan dikarenakan ketidak sesuaian administrasi, ketidak sesuaian kode diagnosa maupun tindakan, ketidak sesuaian indikasi medis 1. Klaim yang belum diaudit/diverifikasi oleh BPJS kesehatan 2. Klaim yang tidak layak 3. Klaim dengan kendala yang tidak disebabkan oleh rumah sakit (misal

	aplikasi eror)
Formula	$\sum\{\text{Nilai Klaim RITL yang Sudah Dibayar}\} - \sum\{\text{Nilai Klaim Hasil Audit RITL}\}$
Metode Pengumpulan Data	retrospektif telaah dari hasil verifikasi pasca klaim
Sumber data	Hasil verifikasi pasca klaim
Instrumen Pengambilan Data	Laporan audit pasca klaim
Sampel	Seluruh berkas yang diajukan yang telah melalui verifikasi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center Tim mutu / PMKP rumah sakit

7. Nilai Selisih Negatif Klaim Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Judul Indikator	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL
Dasar pemikiran	1. Pentingnya Efisiensi Biaya pada Layanan Rawat Jalan: Sebagai penyedia layanan kesehatan, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) memiliki volume kunjungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rawat inap. Akumulasi selisih negatif dalam layanan rawat jalan, meskipun per kasus terlihat kecil, dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas finansial rumah sakit jika tidak dikendalikan dengan ketat. 2. Optimalisasi Proses <i>Coding</i> dan <i>Billing</i> RJTL: Selisih negatif pada klaim RJTL sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara prosedur medis yang diberikan dengan kode diagnosa dan tindakan yang diinput ke dalam sistem INA-CBG. Dengan memantau indikator ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa setiap layanan medis terakomodasi dalam pengkodean yang akurat, sehingga meminimalkan potensi kerugian akibat <i>under-coding</i>. 3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Mutu: Pemantauan ini merupakan implementasi dari Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/II/2026. Hal ini menunjukkan komitmen rumah sakit untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana klaim JKN, serta memastikan bahwa manajemen operasional di unit rawat jalan berjalan sesuai dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. 4. Peningkatan Efektivitas Layanan dan Proses Klaim: Pengendalian selisih negatif bertujuan untuk memastikan bahwa proses klaim berjalan lancar dan efisien. Dengan menargetkan selisih negatif di bawah Rp 50.000.000, rumah sakit didorong untuk memperkuat koordinasi antara tenaga medis, unit <i>coding</i>, dan asuransi center guna memastikan diagnosa yang ditegakkan telah memenuhi indikasi medis yang kuat dan terdokumentasi dengan benar sesuai regulasi BPJS Kesehatan.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Menurunkan dan mengendalikan nilai selisih negatif klaim rawat jalan 2. Meningkatkan pengkodean diagnosa dan tindakan 3. Meningkatkan proses klaim yang efektif dan efisien
Definisi Operasional	Nilai selisih negatif klaim RJTL BPJS Kesehatan adalah nilai selisih antara tarif INA CBG yang diajukan dengan total tagihan rumah sakit pada periode tertentu
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Selisih jumlah tarif INA CBG dengan Tarif RS
Numerator (pembilang)	Total akumulasi nilai selisih negatif (Rupiah) antara biaya riil rumah sakit dengan tarif INA-CBG yang diterima dari BPJS Kesehatan dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Tidak ada (karena indikator ini berupa nilai absolut/total rupiah, bukan Prosentase).
Target Pencapaian	< Rp. 50.000.000
Kriteria:	1. Klaim yang akan diajukan kepada BPJS Kesehatan 2. Klaim dalam periode tertentu
• Inklusi	1. Klaim luaran INA CBG
• Eksklusi	2. Klaim dengan nilai positif
Formula	$\sum\{\text{Tarif INA-CBGs RJTL yang diterima}\} - \sum\{\text{Total Billing Riil RJTL}\}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif hasil keluaran
Sumber data	Output keluaran INA CBG Sim RS
Instrumen Pengambilan Data	Data output INA-CBG's
Sampel	Seluruh klaim RJTL BPJS Kesehatan pada periode tertentu
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC Mutu

8. Nilai Selisih Negatif Klaim Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RJTL)

Judul Indikator	Nilai Selisih Negatif Klaim RJTL
Dasar pemikiran	1. Pentingnya Efisiensi Biaya pada Layanan Rawat Jalan: Sebagai penyedia layanan kesehatan, Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) memiliki volume kunjungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan rawat inap. Akumulasi selisih negatif dalam layanan rawat jalan, meskipun per kasus terlihat kecil, dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas finansial rumah sakit jika tidak dikendalikan dengan ketat. 2. Optimalisasi Proses <i>Coding</i> dan <i>Billing</i> RJTL: Selisih negatif pada klaim RJTL sering kali bersumber dari ketidaksesuaian antara prosedur medis yang diberikan dengan kode diagnosa

	dan tindakan yang diinput ke dalam sistem INA-CBG. Dengan memantau indikator ini, rumah sakit dapat memastikan bahwa setiap layanan medis terakomodasi dalam pengkodean yang akurat, sehingga meminimalkan potensi kerugian akibat <i>under-coding</i>. 3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Mutu: Pemantauan ini merupakan implementasi dari Keputusan Direktur RS Prima Husada Sukorejo Nomor: 070.2/RSPHS/I-PER/DIR/I/2026. Hal ini menunjukkan komitmen rumah sakit untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana klaim JKN, serta memastikan bahwa manajemen operasional di unit rawat jalan berjalan sesuai dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya. 4. Peningkatan Efektivitas Layanan dan Proses Klaim: Pengendalian selisih negatif bertujuan untuk memastikan bahwa proses klaim berjalan lancar dan efisien. Dengan menargetkan selisih negatif di bawah Rp 50.000.000, rumah sakit didorong untuk memperkuat koordinasi antara tenaga medis, unit <i>coding</i>, dan asuransi center guna memastikan diagnosa yang ditegakkan telah memenuhi indikasi medis yang kuat dan terdokumentasi dengan benar sesuai regulasi BPJS Kesehatan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Menurunkan dan mengendalikan nilai selisih negatif klaim rawat jalan 2. Meningkatkan pengkodean diagnosa dan tindakan 3. Meningkatkan proses klaim yang efektif dan efisien
Definisi Operasional	Nilai selisih negatif klaim RJTL BPJS Kesehatan adalah nilai selisih antara tarif INA CBG yang diajukan dengan total tagihan rumah sakit pada periode tertentu
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☐ Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Selisih jumlah tarif INA CBG dengan Tarif RS
Numerator (pembilang)	Total akumulasi nilai selisih negatif (Rupiah) antara biaya riil rumah sakit dengan tarif INA-CBG yang diterima dari BPJS Kesehatan dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Tidak ada (karena indikator ini berupa nilai absolut/total rupiah, bukan Prosentase).
Target Pencapaian	< Rp. 50.000.000
Kriteria:	1. Klaim yang akan diajukan kepada BPJS Kesehatan
	2. Klaim dalam periode tertentu
• Inklusi	1. Klaim luaran INA CBG
	2. Klaim dengan nilai positif
• Eksklusi	
Formula	$\sum\{\text{Tarif INA-CBGs RJTL yang diterima}\} - \sum\{\text{Total Billing Riil RJTL}\}$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif hasil keluaran
Sumber data	Output keluaran INA CBG Sim RS
Instrumen Pengambilan Data	Data output INA-CBG's
Sampel	Seluruh klaim RJTL BPJS Kesehatan pada periode tertentu

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Triwulan
Penanggung Jawab	Unit Asuransi Center PIC Mutu

3.3.33. Humas & Marketing

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepuasan Pasien MCU	≥ 76,61%	UNIT
2.	Ketidakpatuhan perbaharuan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal	0%	UNIT
3.	Kenaikan jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal	10% / bulan	UNIT

3.3.33.1 **Profil Indikator Mutu Humas & Marketing**

1. Kepuasan Pasien MCU

Judul Indikator	Kepuasan pasien MCU
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan peserta MCU terhadap alur, kecepatan layanan, kenyamanan fasilitas, dan keramahan staf, sebagai dasar peningkatan mutu layanan MCU
Definisi Operasional	Kepuasan peserta MCU adalah penilaian subjektif peserta terhadap kualitas layanan pemeriksaan kesehatan (fisik, penunjang, dan administrasi) yang diterima. Unsur survei disesuaikan dengan alur MCU (pendaftaran, pengambilan sampel, pemeriksaan dokter, hingga pengambilan hasil)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☒ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien MCU yang puas
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan pasien MCU yang mengisi kuesioner kepuasan
Target Pencapaian	≥ 76,61%

Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh peserta MCU (perorangan mauput korporat) yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai pakatnya
	1. Peserta MCU yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan 2. Peserta yang tidak mampu berkomunikasi/mengisi kuesioner tanpa pendamping
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien MCU yang puas}}{\text{Jumlah keseluruhan pasien MCU yang mengisi kuesioner kepuasan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Survei langsung setelah MCU selesai
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner
Sampel	Pasien yang mengisi <i>form</i> kepuasan pasien
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

2. Ketidakpatuhan Perbaharuan Dokumen Kerjasama dengan Instansi Eksternal

Judul Indikator	Ketidakpatuhan perbaharuan dokumen kerjasama dengan instansi eksternal
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023: RS wajib melakukan tata kelola yang akuntabel dalam menjalin kemitraan. 2. Standar Akreditasi (TKRS): RS wajib memastikan bahwa seluruh kontrak kerjasama (vendor, rujukan, dll) masih berlaku dan memiliki <i>review</i> berkala untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Memastikan tidak ada dokumen kerjasama yang <i>expired</i> (kedaluwarsa). 2. Menjamin kesiambungan operasional RS melalui mitra yang sah secara hukum.
Definisi Operasional	Kepatuhan perbaruan dokumen adalah Prosentase dokumen kerjasama (MOU/PKS) yang telah diperbarui atau dilakukan adendum sebelum masa berlaku berakhir, dibandingkan dengan total dokumen kerjasama yang jatuh tempo dalam periode tersebut
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah dokumen kerja sama yang tidak update
Denominator (penyebut)	Jumlah kerja sama secara keseluruhan
Target Pencapaian	0%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh kontrak kerjasama dengan pihak ketiga (Vendor, RS Rujukan, Lab, Penunjang) Kerjasama yang diputuskan untuk tidak dilanjutkan/dihentikan
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokumen kerja sama yang tidak update}}{\text{Jumlah kerja sama secara keseluruhan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit database kontrak)
Sumber data	Database (register) kontrak kerjasama RS
Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring masa berlaku kontrak
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

3. Kenaikan Jumlah Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Judul Indikator	Kenaikan jumlah kerjasama dengan pihak eksternal
Dasar Pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023: RS perlu menjalin jejaring dengan berbagai pihak untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan. - Pengembangan Strategis: Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang, RS harus memperluas ekosistem mitra (vendor, instansi rujukan, penyedia penunjang).
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas ☒ - Keselamatan ☐ - Fokus kepada pasien ☐ - Kesinambungan ☐
Tujuan	- Meningkatkan cakupan layanan melalui perluasan jejaring mitra. - Menjamin ketersediaan sumber daya eksternal untuk mendukung operasional RS yang berkelanjutan.
Definisi Operasional	Pertumbuhan kerjasama adalah penambahan jumlah dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru yang disepakati dengan

	instansi eksternal (termasuk mitra medis maupun non-medis) dalam periode tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☒ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kerja sama baru dengan pihak eksternal
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan kerja sama dengan pihak eksternal
Target Pencapaian	10%/Tahun
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua PKS baru (medis, non-medis, vendor, rujukan) Adendum (perubahan) dari PKS yang sudah ada sebelumnya
Formula	$\frac{\text{Jumlah kerja sama baru dengan pihak eksternal}}{\text{Jumlah keseluruhan kerja sama dengan pihak eksternal}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Review register kontrak)
Sumber data	Laporan bagian umum
Instrumen Pengambilan Data	Register kontrak
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

3.3.34. CSO

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Respon time CSO <30 menit (WhatsApp)	100%	UNIT

3.3.34.1 Profil Indikator Mutu CSO

1. Respon time CSO < 30 menit (WhatsApp)

Judul Indikator	Respon time CSO < 30 menit (WhatsApp)
Dasar Pemikiran	1. Fokus pada Pasien: Kecepatan respon menentukan persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. 2. Efisiensi Layanan: WhatsApp adalah kanal komunikasi utama; respon yang lambat berisiko menurunkan kepercayaan pasien/keluarga.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒

	3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi antara RS dan pasien/keluarga 2. Memastikan seluruh pertanyaan/keluhan pasien direspon dengan cepat dalam jam kerja
Definisi Operasional	<i>Respon time</i> adalah waktu yang dihitung sejak pesan pertama pasien masuk (diterima sistem) hingga CSO memberikan jawaban/balasan pertama, dengan batas maksimal 30 menit pada jam kerja
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas CSO dalam membalas pesan dari <i>WhatsApp</i> <30 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pesan dari pelanggan yang masuk dari <i>WhatsApp</i> petugas CSO
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Pesan masuk selama jam kerja operasional CSO (misal: 08.00 – 16.00) Pesan yang masuk di luar jam kerja, spam, atau pesan yang bersifat broadcast/bot (bukan interaksi manual)
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas CSO dalam membalas pesan dari WhatsApp <30 menit}}{\text{Jumlah seluruh pesan dari pelanggan yang masuk dari WhatsApp petugas CSO}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit log chat/WhatsApp Business)
Sumber data	Laporan sistem WhatsApp Business
Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring waktu balas (log chat)
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian CSO

3.3.35. MOD-MPP-PIPP

INDIKATOR MUTU NASIONAL			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	UNIT
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
2.	<i>Respon time</i> penanganan komplain	100%	UNIT

	< 5 menit		
3.	Angka kelengkapan Form A & Form B pada pasien sesuai kriteria MPP	100%	UNIT
4.	Angka kelengkapan form Discharge planning	100%	UNIT

3.3.35.1 Profil Indikator Mutu MOD

1. Kepuasan Pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

2. Respon Time Penanganan Komplain < 5 Menit

Judul Indikator	Respon time penanganan komplain < 5 menit
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan & UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Mengamanatkan perlindungan hak pasien atas pelayanan yang aman dan bermutu, serta kewajiban fasilitas kesehatan untuk menyediakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan responsif. - Standar Akreditasi RS (STARKES) Bab HPK (Hak Pasien dan Keluarga): Elemen Penilaian (EP) mewajibkan rumah sakit memiliki proses yang seragam, terdokumentasi, dan cepat dalam merespon serta menyelesaikan keluhan, konflik, atau perbedaan pendapat pasien/keluarga. - Mitigasi Risiko Proaktif: Tanggapan awal yang cepat dalam waktu < 5 menit adalah alat bukti bahwa rumah sakit melakukan penanganan risiko sejak dini guna mencegah eskalasi komplain minor menjadi sengketa medik, tuntutan hukum, atau krisis reputasi (viral di media sosial).

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektifitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan setiap keluhan pasien direspon secara cepat, tepat, dan proaktif guna meminimalkan risiko ketidakpuasan dan menjaga reputasi pelayanan rumah sakit.
Definisi Operasional	Waktu tanggap (<i>respon time</i>) adalah total durasi yang dibutuhkan oleh petugas sejak komplain pertama kali diterima/masuk ke kanal resmi (tatap muka, telepon, atau chat/ <i>WhatsApp</i>) hingga petugas memberikan tanggapan awal yang berarti (<i>responsive</i> , <i>solutif</i> , dan bukan pesan otomatis/bot)
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (100%)
Numerator (pembilang)	Jumlah respon time penanganan komplain < 5 menit
Denominator (penyebut)	Jumlah penanganan komplain yang masuk
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua komplain/keluhan resmi yang disampaikan oleh pasien, keluarga, atau pengunjung melalui kanal komunikasi resmi rumah sakit pada jam pelayanan Pertanyaan umum/informasi, pesan spam/prank, dan komplain yang masuk di luar jam operasional resmi (kecuali unit pelayanan 24 jam)
Formula	$\frac{\text{Jumlah respon time penanganan komplain} < 5 \text{ menit}}{\text{Jumlah penanganan komplain yang masuk}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Riwayat pesan WhatsApp, log panggilan telepon, buku register komplain
Instrumen Pengambilan Data	<i>Form</i> laporan harian capaian mutu MOD-MPP-PIPP
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala MPP

3. Angka Kelengkapan Form A & Form B pada Pasien Sesuai Kriteria MPP

Judul Indikator	Angka kelengkapan form A & form B pada pasien sesuai kriteria
-----------------	---

	MPP
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. 2. Standar Akreditasi RS (STARKES): Elemen Penilaian (EP) tentang peran MPP dalam mengoordinasikan asuhan pasien melalui dokumentasi yang lengkap. 3. Dokumentasi <i>Form A</i> dan <i>B</i> adalah alat bukti bahwa proses evaluasi dan perencanaan pulang pasien telah dilakukan untuk mencegah <i>re-admission</i> dan memastikan keselamatan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektifitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	1. Memastikan proses asuhan pasien dikeola secara terintegrasi oleh MPP 2. Menjamin keberlanjutan asuhan pasien <i>pasca</i>-rawat inap 3. Memenuhi standar legalitas rekam medis terkait peran PPA (Profesional Pemberi Asuhan)
Definisi Operasional	Form A (Evaluasi Awal MPP) adalah lembar dokumentasi yang berisi identifikasi, skrining, dan pengkajian awal pasien yang masuk kriteria MPP. Form B (Catatan Implementasi MPP) adalah lembar dokumentasi yang berisi rencana asuhan, koordinasi, edukasi, dan tindak lanjut asuhan. Lengkap artinya seluruh kolom esensial terisi, bertanda tangan, dan mencantumkan waktu (jam/tanggal)
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (100%)
Numerator (pembilang)	Jumlah form A & form B yang lengkap sesuai kriteria MPP
Denominator (penyebut)	Jumlah form A & form B pada pasien
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien yang memenuhi kriteria MPP (misal: diagnosa kompleks, biaya tinggi, risiko tinggi, kasus anak/lansia, atau atas permintaan DPJP) Pasien yang pulang paksa atau meninggal sebelum sempat dilakukan pengkajian oleh MPP (dalam waktu < 24 jam)
Formula	$\frac{\text{Jumlah form A \& form B yang lengkap sesuai Kriteria MPP}}{\text{Jumlah form A \& form B pada pasien}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis Pasien (Lembar MPP – Form A & Form B)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar checklist audit dokumentasi MPP
Sampel	<i>Total sampling</i> atau menggunakan rumus Slovin jika populasi

	besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala MPP

4. Angka Kelengkapan Form Dischard Planning

Judul Indikator	Angka kelengkapan Form Dischard Planning
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien atas kesinambungan pelayanan dan edukasi kesehatan yang memadai. 2. Standar Akreditasi RS (STARKES): Standar PAP (Pelayanan dan Asuhan Pasien) yang mewajibkan perencanaan pemulangan dimulai sejak pasien masuk rawat inap. 3. Perencanaan pulang yang tidak lengkap berisiko menyebabkan kegagalan terapi di rumah dan komplikasi <i>pasca-rawat</i>.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektifitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesinambungan ☒
Tujuan	1. Memastikan pasien dan keluarga memiliki informasi yang cukup untuk perawatan mandiri di rumah 2. Menjamin transisi asuhan yang aman dan terkoordinasi 3. Mengurangi angka perawatan kembali (readmission rate) untuk diagnosa yang sama
Definisi Operasional	Dischard Planning adalah proses interdisiplin untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasien setelah pulang. Lengkap artinya formulir diisi sejak awal pasien masuk (skrining), diperbarui selama perawatan, dan dilengkapi saat pulang, mencakup: kriteria pulang, bantuan yang diperlukan di rumah, edukasi obat, jadwal kontrol, dan tanda tangan PPA serta pasien/keluarga
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ketidaklengkapan form Dischard Planning
Denominator (penyebut)	Jumlah total form Dischard Planning
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi • Eksklusi	Semua pasien rawat inap (umum, kebidanan, anak, bedah) 1. Pasien yang meninggal dunia 2. Pasien yang melarikan diri (escape) 3. Pasien yang pulang paksa (APS) sebelum proses

	perencanaan selesai dilakukan
Formula	$\frac{\text{Jumlah ketidaklengkapan form Dischard Planning}}{\text{Jumlah total form Dischard Planning}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i> (Audit Rekam Medis <i>pasca</i> -pasien pulang)
Sumber data	Rekam Medis Pasien (Lembar Dischard Planning/Perencanaan Pemulangan
Instrumen Pengambilan Data	Lembar checklist audit kelengkapan berkas rekam medis
Sampel	<i>Total sampling</i> atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala MPP

3.3.36. TB di IRJA

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	100%	TIM
2.	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB	≥ 90%	TIM

3.3.36.1 **Profil Indikator Mutu TB di IRJA**

1. Angka Kepatuhan Pasien Mengambil Obat di Rumah Sakit

Judul Indikator	Angka kepatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit		
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai penanggulangan penyakit menular, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kewajiban pasien untuk mematuhi upaya kesehatan. 2. Permenkes No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 3. Strategi DOTS (<i>Directly Observed Treatment Short-course</i>) untuk memutus rantai penularan di komunitas. 4. Risiko munculnya MDR-TB (kuman kebal obat) yang dapat mengancam ketahanan kesehatan nasional.		
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒		

	6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Memastikan pasien menyelesaikan regimen pengobatan secara tuntas sesuai standar. 2. Mencegah terjadinya putus obat (<i>loss to follow up</i>) yang berakibat pada kegagalan terapi. 3. Melindungi masyarakat dari risiko penularan kuman TB yang lebih ganas.
Definisi Operasional	Kepatuhan adalah kedatangan pasien TB atau Pengawas Menelan Obat (PMO) ke unit farmasi/poli DOTS untuk mengambil OAT sesuai jadwal.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien TB yang mengambil obat sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam periode tertentu (misalnya bulanan)
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien TB yang dijadwalkan untuk mengambil obat dalam periode yang sama, terlepas dari kepatuhan mereka
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien TB yang terdaftar dalam buku register TB.03 dan sedang dalam masa pengobatan aktif. 1. Pasien yang meninggal dunia. 2. Pasien yang sudah pindah faskes (<i>Transfer Out</i>). 3. Pasien yang telah dinyatakan sembuh/pengobatan lengkap pada bulan tersebut.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien TB yang mengambil obat sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam periode tertentu (misalnya bulanan)}}{\text{Jumlah total pasien TB yang dijadwalkan untuk mengambil obat dalam periode yang sama, terlepas dari kepatuhan mereka}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Real-time melalui buku kontrol) & Retrospektif (Audit bulanan)
Sumber data	Kartu TB.01 (Kartu Pengobatan), Buku Register TB.03, dan aplikasi SITB (Sistem Informasi TB)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir pemantauan harian kepatuhan kunjungan pasien DOTS
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Prognas TB

2. Angka Kepatuhan Petugas dalam Mengedukasi Terkait Pencegahan Penularan ke Pasien TB

Judul Indikator	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien TB
-----------------	---

Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan perlindungan masyarakat dari penyakit menular dan pentingnya komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) kesehatan. 2. Permenkes No. 67 Tahun 2016: Penanggulangan TB memerlukan edukasi etika batuk dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah. 3. Mencegah terjadinya kluster penularan keluarga (TB Anak/Kontak Serumah).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Memastikan setiap pasien TB dan keluarganya memahami serta mampu mempraktikkan cara pencegahan penularan TB secara mandiri
Definisi Operasional	Kepatuhan edukasi adalah tindakan petugas kesehatan (perawat/dokter/konselor) yang memberikan materi edukasi pencegahan penularan secara lengkap kepada pasien baru atau saat kunjungan ulang, meliputi: Etika batuk, penggunaan masker, ventilasi rumah, dan pentingnya pemeriksaan kontak serumah
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas kesehatan yang telah memberikan edukasi kepada pasien TB terkait pencegahan penularan dalam periode tertentu
Denominator (penyebut)	Jumlah total petugas kesehatan yang seharusnya memberikan edukasi kepada pasien TB dalam periode yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien TB (baru maupun kontrol rutin) yang dilayani di fasilitas kesehatan -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas kesehatan yang telah memberikan edukasi kepada pasien TB terkait pencegahan penularan dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah total petugas kesehatan yang seharusnya memberikan edukasi kepada pasien TB dalam periode yang sama}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi langsung) dan <i>Retrospektif</i> (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Lembar Edukasi Terintegrasi dalam Rekam Medis, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), atau Buku Monitoring TB.01
Instrumen Pengambilan Data	Checklist kepatuhan pemberian materi edukasi
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan

Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Prognas TB

3.3.37. Tim HIV

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV	≥ 90%	TIM

3.3.37.1 Profil Indikator Mutu Tim HIV

1. Angka Kepatuhan Petugas dalam Mengedukasi terkait Pencegahan Penularan ke Pasien HIV

Judul Indikator	Angka kepatuhan petugas dalam mengedukasi terkait pencegahan penularan ke pasien HIV
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menekankan pada perlindungan privasi pasien, pencegahan penyakit menular, dan penghapusan stigma melalui edukasi yang tepat 2. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan PIMS. 3. Konsep U=U (<i>Undetectable = Untransmittable</i>): Edukasi mengenai kepatuhan ARV dapat menurunkan beban virus hingga tidak menularkan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	1. Memutus rantai penularan HIV ke pasangan, keluarga, atau masyarakat 2. Meningkatkan pemahaman pasien mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi orang dengan HIV (ODHIV)
Definisi Operasional	Kepatuhan petugas adalah tindakan pemberian edukasi secara komprehensif oleh petugas kesehatan (dokter/perawat/konselor) kepada pasien HIV, yang meliputi: Kepatuhan minum ARV, penggunaan pengaman (kondom), tidak berbagi jarum suntik, dan pola hidup sehat
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas kesehatan yang telah memberikan edukasi kepada pasien HIV terkait pencegahan penularan dalam periode tertentu
Denominator	Jumlah total petugas kesehatan yang bertanggung jawab

(penyebut)	untuk memberikan edukasi kepada pasien HIV dalam periode tertentu
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua pasien HIV (baik pasien baru maupun pasien <i>on-ARV</i> yang sedang kontrol) yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Pasien yang dalam kondisi gawat darurat atau tidak sadar sehingga tidak memungkinkan diberikan edukasi (ditunda hingga kondisi stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas kesehatan yang telah memberikan edukasi kepada pasien HIV terkait pencegahan penularan dalam periode tertentu}}{\text{Jumlah total petugas kesehatan yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada pasien HIV dalam periode tertentu}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi) dan Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Lembar Edukasi Terintegrasi, Catatan Konseling VCT/CST, atau Rekam Medis Elektronik
Instrumen Pengambilan Data	Checklist pemberian edukasi pencegahan HIV
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Prognas HIV

3.3.38. KB

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Angka kepatuhan pengisian kartu K4 KB	100%	TIM
2.	Angka terlaksananya program KB pasca persalinan & pasca Keguguran	50%	TIM
3.	Semua ibu melahirkan dan curret mendapatkan KIE KB	100%	TIM
4.	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB	30%	TIM

3.3.38.1 Profil Indikator Mutu KB

1. Angka Kepatuhan Pengisian Kartu K4 KB

Judul Indikator	Angka kepatuhan pengisian kartu K4 KB
-----------------	---------------------------------------

Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai pelayanan kesehatan reproduksi dan pendokumentasian rekam medis. 2. Permenkes No. 21 Tahun 2021: Tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan. 3. Pentingnya data akurat untuk pemantauan efek samping, kegagalan kontrasepsi, dan kesinambungan pelayanan KB.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesinambungan ☒
Tujuan	Terwujudnya pendokumentasian pelayanan KB yang lengkap dan akurat di setiap fasilitas kesehatan guna menjamin mutu pelayanan bagi akseptor
Definisi Operasional	Kepatuhan pengisian Kartu K4 adalah tindakan petugas (bidan/perawat/dokter) dalam mengisi seluruh item data pada Kartu K4 secara lengkap dan benar, meliputi: Identitas, Anamnesa, Pemeriksaan Fisik, Status Kesehatan, dan Tindakan Medis yang dilakukan
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Kartu K4 KB yang terisi lengkap
Denominator (penyebut)	Jumlah kartu K4 KB yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh akseptor KB yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi (hormonal, non-hormonal, maupun jangka panjang/MKJP) Pasien yang hanya datang untuk konsultasi tanpa melakukan tindakan/pengambilan alat kontrasepsi
Formula	$\frac{\text{Kartu K4 KB yang terisi lengkap}}{\text{Jumlah kartu K4 KB yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit dokumen kartu K4/Rekam Medis)
Sumber data	Register KB, Kartu K4 KB, dan Rekam Medis Poli KIA/KB
Instrumen Pengambilan Data	Lembar audit kelengkapan rekam medis
Sampel	<i>Total sampling</i> atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke

	waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program KB

2. Angka Terlaksananya Program KB Pasca Persalinan & Pasca Keguguran

Judul Indikator	Angka terlaksananya program KB Pasca Persalinan & Pasca Keguguran
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak kesehatan reproduksi dan akses terhadap alat kontrasepsi. 2. Permenkes No. 21 Tahun 2021: Tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan. 3. Strategi Nasional penurunan AKI: Kehamilan yang terlalu dekat setelah persalinan atau keguguran berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Meningkatkan capaian peserta KB baru <i>pasca</i> persalinan (dalam kurun waktu 0-42 hari) dan <i>pasca</i> keguguran untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau terlalu dekat jaraknya
Definisi Operasional	KB Pasca Persalinan (KBPP): pelayanan KB yang diberikan kepada ibu setelah melahirkan sampai kurun waktu 42 hari KB Pasca Keguguran (KBPK): pelayanan KB yang diberikan kepada ibu segera setelah penanganan keguguran (sebelum ovulasi terjadi kembali, biasanya dalam 14 hari)
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☐ Outcome ☒ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah program KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang terlaksana
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien pasca persalinan dan pasca keguguran
Target Pencapaian	50%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh ibu yang melakukan persalinan (normal/SC) dan ibu yang mendapatkan penanganan keguguran di RS 1. Ibu dengan kontraindikasi medis terhadap semua alat kontrasepsi 2. Ibu yang belum menikah (dalam kasus tertentu sesuai regulasi lokal)
Formula	$\frac{\text{Jumlah program KB pasca persalinan dan pasca keguguran yang terlaksana}}{\text{Jumlah pasien pasca persalinan dan pasca keguguran}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Register persalinan (kamar bersalin), register VK, rekam medis, dan register KB

Instrumen Pengambilan Data	Formulir rekapitulasi bulanan pelayanan KB
Sampel	<i>Total sampling</i> atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program KB

3. Semua Ibu Melahirkan dan Curret Mendapatkan KIE KB

Judul Indikator	Semua ibu melahirkan dan current mendapatkan KIE KB
Dasar Pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. - Permenkes No. 21 Tahun 2021: Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan wajib memuat konseling KB. - Edukasi yang adekuat merupakan kunci keberhasilan peningkatan cakupan KB <i>Pasca</i> Persalinan untuk mengatur jarak kehamilan.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☐ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas ☐ - Keselamatan ☐ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☐
Tujuan	Memastikan seluruh ibu nifas memiliki pemahaman yang benar mengenai pilihan metode kontrasepsi sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan
Definisi Operasional	Pemberian KIE KB adalah proses komunikasi dua arah antara petugas (bidan/dokter) dengan ibu melahirkan (dan suami/keluarga) mengenai jenis, manfaat, efek samping, dan prosedur alat kontrasepsi yang dilakukan selama masa nifas (0-42 hari), dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar edukasi.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah ibu yang melahirkan dan mendapatkan KIE KB
Denominator (penyebut)	Jumlah ibu melahirkan & curretage
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh ibu yang melakukan persalinan (baik normal maupun <i>Sectio Caesarea</i>) di rumah sakit Ibu dengan gangguan jiwa berat yang tidak memungkinkan dilakukan edukasi

	2. Ibu yang meninggal dunia saat atau segera setelah persalinan
Formula	$\frac{\text{Jumlah ibu yang melahirkan dan mendapatkan KIE KB}}{\text{Jumlah ibu melahirkan \& curretage}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi harian) dan <i>Retrospektif</i> (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Lembar Edukasi Terintegrasi, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT), dan Buku Register Persalinan
Instrumen Pengambilan Data	Checklist pemberian edukasi KB
Sampel	<i>Total sampling</i> atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar (disarankan minimal 30 item/bulan per unit)
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program KB

4. Angka Pelaksanaan Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta dan Peserta Program KB

Judul Indikator	Angka pelaksanaan pelayanan konseling KB bagi calon peserta program
Dasar Pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menjamin hak pasien atas informasi yang lengkap sebelum dilakukan tindakan medis (Persetujuan Tindakan) 2. Permenkes No. 21 Tahun 2021: Pelayanan kontrasepsi harus didahului dengan konseling yang berkualitas menggunakan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) 3. Mencegah terjadinya <i>drop out</i> (putus pakai) akibat ketidaktahuan pasien mengenai efek samping.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☐ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Memastikan calon peserta KB mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga mampu memilih metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhannya
Definisi Operasional	Konseling KB adalah proses interaksi antara petugas kesehatan dengan calon peserta program KB untuk membantu klien mengenali kebutuhannya dan mengambil keputusan metode KB. Konseling dinyatakan terlaksana jika petugas menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK) atau lembar balik KB dan mendokumentasikannya
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome ☐

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan calon peserta dan peserta program KB
Target Pencapaian	30%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua calon akseptor baru yang datang untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi Calon akseptor yang hanya datang untuk mendapatkan informasi tanpa niat menjadi peserta program pada saat itu (hanya tanya-tanya)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan konseling KB bagi calon peserta dan peserta program KB}}{\text{Jumlah keseluruhan calon peserta dan peserta program KB}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Observasi) dan Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Lembar Edukasi Terintegrasi, Catatan Konseling VCT/CST, atau Rekam Medis Elektronik
Instrumen Pengambilan Data	Checklist pemberian edukasi pencegahan HIV
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Prognas HIV

3.3.39. Stunting

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	0%	TIM
2.	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan	100%	TIM
3.	Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali	100%	TIM
4.	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	100%	TIM

3.3.39.1 Profil Indikator Mutu Stunting

1. Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita

Judul Indikator	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengatur hak setiap anak untuk mendapatkan asupan gizi yang adekuat dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengetahui gambaran status gizi kronis balita di wilayah kerja serta efektivitas program intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Definisi Operasional	Stunting adalah status gizi balita yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dengan ambang batas (z-score) < -2 SD (Standar Deviasi) menurut standar WHO.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah balita (0-59 bulan) yang ditemukan pendek (Z-score -3 SD s/d < -2 SD) dan sangat pendek (Z-score < -3 SD) di RS dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh balita (0-59 bulan) yang diukur tinggi/panjang badannya di RS dalam satu bulan
Target Pencapaian	0%
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	1. Semua balita usia 0-59 bulan yang tinggal di wilayah kerja 1. Balita yang pindah domisili atau tidak hadir saat pengukuran setelah dilakukan kunjungan rumah (<i>lost to follow up</i>)
Formula	$\frac{\text{Jumlah balita yang ditemukan pendek dan sangat pendek dalam satu bulan}}{\text{Jumlah Total balita yang diukur di RS dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi langsung melalui pengukuran antropometri (TB atau PB) menggunakan alat ukur yang terstandar
Sumber data	Buku Register KIA
Instrumen Pengambilan Data	Alat ukur standar (Antropometri kit: <i>Stadiometer</i> atau <i>Infantometer</i>) yang telah terkalibrasi
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu

Penanggung Jawab	Penanggung jawab Program Stunting
------------------	-----------------------------------

2. Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu balita 1x dalam sebulan

Judul Indikator	Kepatuhan petugas melakukan KIE kelompok pada ibu 1x dalam sebulan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi masyarakat. 2. Permenkes No. 21 Tahun 2021: Pelayanan kesehatan ibu dan anak wajib mencakup edukasi kelompok (Kelas Ibu). 3. Edukasi kelompok lebih efektif dalam mengubah perilaku dan membangun dukungan antar sesama ibu (<i>peer support</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan ☒
Tujuan	Memastikan petugas kesehatan melaksanakan kegiatan edukasi kelompok secara rutin guna meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu, anak, dan gizi.
Definisi Operasional	KIE Kelompok adalah pemberian informasi kesehatan kepada sekumpulan ibu (minimal 5-10 orang) dalam bentuk kelas atau penyuluhan. Kepatuhan dinilai dari terlaksananya minimal satu kali kegiatan KIE kelompok setiap bulannya di setiap unit/wilayah kerja yang ditentukan.
Jenis Indikator	Struktur ☐ Proses ☒ Outcome ☐ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah kelompok ibu yang mendapat KIE dalam 1 bulan 1 kali
Denominator (penyebut)	Jumlah kelompok ibu yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Kegiatan Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, atau penyuluhan kelompok di Poli KIA/Puskesmas/Rumah Sakit
• Eksklusi	Edukasi perorangan (<i>bedside teaching</i> atau konseling privat)
Formula	$\frac{\text{Jumlah kelompok ibu yang mendapat KIE dalam 1 bulan 1 kali}}{\text{Jumlah kelompok ibu yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit laporan bulanan)
Sumber data	Laporan bulanan Program KIA, Daftar hadir Peserta, Notulen Kegiatan, dan Dokumentasi (Foto)
Instrumen Pengambilan Data	Lembar verifikasi laporan bulanan kegiatan KIE
Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Stunting

3. Kepatuhan Pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali

Judul Indikator	Kepatuhan pembinaan jejaring pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal mengenai penguatan jejaring pelayanan kesehatan dan upaya perbaikan gizi masyarakat. - Perpres No. 72 Tahun 2021: Percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor dan faskes. - Perlunya kesinambungan asuhan gizi (<i>Continuity of Care</i>) bagi pasien pasca-rawat inap atau rujukan balik agar tidak terjadi kegagalan terapi gizi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan ☒
Tujuan	Memastikan pengawasan dan pembinaan terhadap jejaring rujukan (Puskesmas/Klinik/Posyandu) dilakukan secara rutin guna menjamin kualitas penanganan balita stunting dan wasting tetap sesuai standar
Definisi Operasional	Pembinaan jejaring adalah kegiatan koordinasi/supervisi yang dilakukan oleh tim ahli gizi/dokter spesialis anak terhadap fasilitas kesehatan di bawahnya atau mitra rujukannya. Pembinaan meliputi evaluasi kasus, audit asuhan gizi, dan pemantauan stok pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK). Kepatuhan dinilai dari terlaksananya kegiatan minimal 1x dalam kurun waktu 3 bulan (triwulan)
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pembina yang patuh dalam pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali
Denominator (penyebut)	Jumlah pembina program stunting
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Pertemuan jejaring rujukan stunting/wasting, kunjungan supervisi lapangan, atau audit kasus gizi secara daring/luring Pertemuan internal rumah sakit yang tidak melibatkan jejaring luar
Formula	$\frac{\text{Jumlah pembina yang patuh dalam pengelolaan gizi pasien Stunting dan wasting tiap 3 bulan sekali}}{\text{Jumlah pembina program stunting}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit dokumen laporan triwulanan)
Sumber data	Laporan Triwulanan Program Gizi, Daftar Hadir, Undangan, Notulen (MOM), dan Foto Kegiatan
Instrumen Pengambilan Data	Lembar kendali monitoring pembinaan jejaring

Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Stunting

4. Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan

Judul Indikator	Kepatuhan pencatatan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mandat integrasi data gizi nasional untuk percepatan penurunan stunting. - Perpres No. 72 Tahun 2021: Menuntut ketersediaan data yang cepat dan akurat untuk audit kasus stunting. - Keterlambatan data berakibat pada keterlambatan intervensi gizi spesifik (PMT/suplemen) yang dapat memperburuk kondisi balita.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan
Tujuan	Memastikan ketersediaan data stunting yang mutakhir (<i>up-to-date</i>) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan kebijakan program gizi secara cepat.
Definisi Operasional	Pelaporan program stunting adalah penginputan hasil pengukuran antropometri (TB/U, BB/U, BB/TB) ke dalam aplikasi e-PPGBM dan pengiriman laporan manual/digital rutin. Dinyatakan tepat waktu jika laporan dikirim maksimal tanggal 5 setiap bulan berikutnya (atau sesuai kebijakan lokal).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pencatatan pelaporan yang tepat waktu
Denominator (penyebut)	Jumlah keseluruhan pelaporan
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Laporan rutin e-PPGBM, Laporan Cakupan Penimbangan, dan Laporan Distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Laporan audit kasus stunting bersifat khusus (bukan laporan rutin)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pencatatan pelaporan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan pelaporan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit aplikasi dan buku ekspedisi laporan)
Sumber data	Dashboard e-PPGBM, SITB (jika terkait TB-Stunting), dan Logbook pengiriman laporan Gizi
Instrumen Pengambilan Data	Checklist monitoring pelaporan program gizi

Sampel	<i>Total sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Penanggung Jawab Program Stunting

3.3.40. Geriatri

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Rata-rata Lama Perawatan Pasien Geriatri	≤10 Hari	TIM
2.	Prosentase Pasien Geriatri yang Dilakukan Pengukuran Status Fungsional	100%	TIM
3.	Angka <i>Rehospitalisasi</i> Pasien Geriatri dalam Waktu ≤30 Hari	≤5%	TIM
4.	Kepuasan Pasien Geriatri dan Keluarga	≥85%	TIM

3.3.40.1 Profil Indikator Geriatri

1. Rata – Rata Lama Perawatan Pasien Geriatri

Judul Indikator	Rata-rata Lama Perawatan Pasien Geriatri			
Dasar pemikiran	1. PMK No. 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri: Pelayanan geriatri harus dilakukan secara terpadu dan efisien. 2. Karakteristik Pasien: Pasien geriatri sering memiliki multipatologi yang memerlukan perawatan lama, namun rawat inap yang terlalu lama berisiko menyebabkan infeksi nosokomial, penurunan fungsional (<i>deconditioning</i>), dan peningkatan biaya.			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan			
Tujuan	Tergambarnya efisiensi dan efektivitas pelayanan medis serta keperawatan bagi pasien geriatri di ruang rawat inap.			
Definisi Operasional	Rata-rata lama perawatan adalah jumlah hari perawatan pasien geriatri (usia ≥ 60 tahun) yang keluar hidup maupun mati dari ruang rawat inap dalam satu periode tertentu.			
Jenis Indikator	Struktur	Proses	Outcome	☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Hari			
Numerator (pembilang)	Jumlah total rata - rata hari perawatan pasien geriatri yang keluar (hidup atau mati) dalam satu bulan.			
Denominator (penyebut)	Jumlah total rata – rata pasien geriatri yang keluar (hidup atau mati) dalam satu bulan yang sama.			

Target Pencapaian	≤ 10 Hari (Disesuaikan dengan kebijakan RS dan jenis kasus geriatri)
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien berusia 60 tahun ke atas yang menjalani rawat inap. 1. Pasien geriatri yang pulang atas permintaan sendiri 2. Pasien yang dirujuk ke faskes lain sebelum perawatan selesai
Formula	$\frac{\text{Jumlah Total Rata – Rata Hari Perawatan Pasien Geriatri}}{\text{Jumlah Total Pasien Geriatri yang Keluar (Hidup + Mati)}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Rekam Medis Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Rekapitulasi Data ALOS Ruang Geriatri.
Sampel	Total Sampling.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Program Nasional Geriatri

2. Prosentase Pasien Geriatri yang Dilakukan Pengukuran Status Fungsional

Judul Indikator	Prosentase Pasien Geriatri yang Dilakukan Pengukuran Status Fungsional
Dasar pemikiran	1. PMK No. 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri: Pasien geriatri wajib mendapatkan asesmen geriatri komprehensif. 2. Karakteristik Pasien: Penurunan fungsi fisik adalah risiko utama pada lansia yang dapat menyebabkan ketergantungan. 3. Rencana Asuhan: Pengukuran (misalnya dengan Indeks Barthel) diperlukan untuk menentukan tingkat bantuan yang dibutuhkan selama perawatan dan saat pemulangan (<i>discharge planning</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan staf medis/keperawatan dalam melakukan asesmen awal guna menentukan derajat kemandirian pasien geriatri.
Definisi Operasional	Pengukuran status fungsional adalah proses penilaian kemampuan pasien geriatri dalam melakukan aktivitas sehari-hari (<i>Activity of Daily Living</i>) menggunakan instrumen baku (seperti Indeks Barthel atau Katz Index) yang dilakukan saat pasien masuk rawat inap.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome

Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien geriatri (≥ 60 tahun) yang dilakukan pengukuran status fungsional secara lengkap dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh pasien geriatri (≥ 60 tahun) yang dirawat inap dalam satu bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien berusia 60 tahun ke atas yang masuk ke ruang rawat inap (khususnya ruang geriatri) 1. Pasien geriatri yang datang dalam kondisi gawat darurat (tidak stabil) atau tidak sadar (penilaian ditunda hingga kondisi stabil)
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien geraitri yang diukur status fungsionalnya}}{\text{Jumlah Total seluruh pasien geriatri yang dirawat}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Asesmen Geriatri.
Sampel	Total Sampling (jika populasi sedikit) atau menggunakan rumus Slovin jika populasi besar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Program Nasional Geriatri

3. Angka Rehospitalisasi Pasien Geriatri dalam Waktu ≤ 30 Hari

Judul Indikator	Angka Rehospitalisasi Pasien Geriatri dalam Waktu
Dasar pemikiran	1. PMK No. 79 Tahun 2014 tentang Pelayanan Geriatri: Pasien geriatri wajib mendapatkan asesmen geriatri komprehensif. 2. Karakteristik Pasien: Penurunan fungsi fisik adalah risiko utama pada lansia yang dapat menyebabkan ketergantungan. 3. Rencana Asuhan: Pengukuran (misalnya dengan Indeks Barthel) diperlukan untuk menentukan tingkat bantuan yang dibutuhkan selama perawatan dan saat pemulangan (<i>discharge planning</i>).
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya keberhasilan asuhan medis terpadu, edukasi keluarga, dan perencanaan pemulangan (<i>discharge planning</i>) yang adekuat bagi pasien geriatri.

Definisi Operasional	Rehospitalisasi adalah kembalinya pasien geriatri (≥60 tahun) untuk dirawat inap kembali dengan diagnosis yang sama atau berkaitan dengan penyakit sebelumnya dalam kurun waktu 30 hari atau kurang sejak tanggal pasien keluar rumah sakit
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien geriatri yang masuk rawat inap kembali dengan diagnosis yang sama/berkaitan dalam waktu ≤ 30 hari sejak pulang
Denominator (penyebut)	Total seluruh pasien geriatri yang keluar rumah sakit (hidup) dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	< 5%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua pasien geriatri yang pernah dirawat inap sebelumnya dan kembali dirawat dalam periode 30 hari. 1. Rawat inap ulang yang sudah direncanakan sebelumnya (misal: jadwal operasi rutin, kemoterapi, atau prosedur terjadwal). 2. Pasien yang pada perawatan sebelumnya pulang atas permintaan sendiri
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien geraitri yang dirawat inap ulang} \leq 30 \text{ hari}}{\text{Jumlah Total seluruh pasien geriatri yang keluar hidup}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Audit Rekam Medis)
Sumber data	Rekam Medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Audit Kepatuhan Asesmen Geriatri.
Sampel	Total Sampling
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan (3 bulan sekali).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Ketua Program Nasional Geriatri

4. Kepuasan Pasien Geriatri dan Keluarga

Judul Indikator	Kepuasan Pasien Geriatri dan Keluarga
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 79 Tahun 2014: Pelayanan geriatri harus berfokus pada pasien dan keluarga (<i>Family-Centered Care</i>). 3. Evaluasi Mutu: Kepuasan adalah indikator akhir dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh pengguna jasa.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. 4. Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. 6. Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: a. Persyaratan. b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. c. Waktu Penyelesaian. d. Biaya/Tarif. e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. f. Kompetensi Pelaksana. g. Perilaku Pelaksana. h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: • Inklusi • Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. 1. Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. 2. Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan	1. Survei langsung setelah perawatan medis selesai.

Data	2. Pengisian kuisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi form kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas Ketua Program Nasional Geriatri

3.3.41. IT

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1x	100%	TIM
2.	Respon time penanganan internet dan billing error < 10 menit	100%	TIM
3.	Respon Time untuk penanganan computer < 10 menit	100%	TIM
4.	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan computer dan perlengkapannya sebulan 1x	100%	TIM

3.3.41.1 Profil Indikator Mutu IT

1. Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan 1x

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam memonitoring jaringan sebulan sekali
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait Keandalan sistem informasi kesehatan. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Kewajiban RS menyediakan infrastruktur pendukung rekam medis elektronik yang stabil. 3. Stabilitas jaringan adalah tulang punggung operasional RS (pendaftaran, billing, hingga pelaporan data pasien)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Menjamin ketersediaan dan stabilitas jaringan komunikasi data secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan klinis dan administrasi

Definisi Operasional	Kepatuhan adalah pelaksanaan inspeksi visual dan teknis terhadap seluruh perangkat jaringan (router, switch, kabel, access point) yang dilakukan minimal sebulan sekali sesuai jadwal yang ditetapkan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah titik/area jaringan yang selesai dimonitoring tepat waktu sesuai jadwal dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh titik/area jaringan yang wajib dimonitoring berdasarkan daftar aset/inventaris jaringan dalam satu bulan
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua perangkat keras jaringan aktif (<i>Switch, Router, Server</i>) dan jalur kabel utama di area pelayanan maupun administrasi 1. Perangkat jaringan yang sedang dalam status perbaikan total oleh pihak ketiga atau masa garansi vendor
Formula	$\frac{\text{Jumlah titik jaringan yang dimonitoring}}{\text{Jumlah Total titik jaringan yang wajib dimonitoring}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (melalui pemeriksaan <i>checklist</i> bulanan)
Sumber data	<i>Checklist</i> Monitoring Jaringan
Instrumen Pengambilan Data	Formulir <i>Checklist</i> Monitoring Jaringan Bulanan.
Sampel	Total Sampling (seluruh titik jaringan dipantau)
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Unit IT

2. Respon time penanganan internet dan billing error < 10 menit

Judul Indikator	<i>Respon time</i> penanganan internet dan <i>billing error</i> < 10 menit
Dasar pemikiran	1. Stabilitas Pelayanan: Gangguan internet dan billing menghambat proses registrasi, transaksi pembayaran, hingga penginputan data klinis (Rekam Medis Elektronik) 2. Efisiensi Operasional: Meminimalisir <i>downtime</i> sistem informasi rumah sakit.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan dan responsivitas petugas IT dalam menanggapi laporan gangguan infrastruktur jaringan dan aplikasi <i>billing</i> untuk menjamin kelancaran operasional.

Definisi Operasional	Respon time adalah rentang waktu (dalam menit) sejak petugas IT menerima laporan gangguan (melalui telepon, grup pesan, atau sistem <i>helpdesk</i>) sampai petugas melakukan tindakan awal perbaikan (intervensi) di lokasi atau secara <i>remote</i> .
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan gangguan internet dan <i>billing</i> yang mendapatkan respon awal dalam waktu < 10 menit dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh laporan gangguan internet dan <i>billing</i> yang masuk ke unit IT dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua laporan gangguan terkait koneksi internet (WiFi/LAN) dan <i>error</i> aplikasi <i>billing</i> di unit pelayanan (Kasir, Pendaftaran, Farmasi, Gawat Darurat) 1. Gangguan massal dari pihak provider luar (ISP) yang sedang <i>maintenance</i> . 2. Permintaan pengembangan fitur baru (bukan perbaikan <i>error</i>).
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan internet dan } \textit{billing error} \text{ dengan respon } < 10 \text{ menit}}{\text{Total seluruh laporan gangguan internet dan billing dalam 1 bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif
Sumber data	Logbook Laporan Gangguan IT
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Sensus Harian Laporan Gangguan IT.
Sampel	Total Sampling (Seluruh laporan dihitung).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan & Triwulan.
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Unit IT 2. Kepala Bidang Umum

3. Respon Time untuk penanganan komputer < 10 menit

Judul Indikator	<i>Respon Time</i> untuk Penanganan Komputer < 10 menit
Dasar pemikiran	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU ini mengamanatkan transformasi teknologi kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Komputer merupakan alat kerja utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Gangguan pada komputer yang tidak segera ditangani dapat menghambat akses pasien terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Kelancaran pengisian RME sangat bergantung pada kesiapan perangkat keras (komputer). <i>Response time</i> yang cepat (< 10 menit) memastikan kontinuitas penginputan data klinis, pemberian resep elektronik, dan pengiriman order penunjang tidak terputus,

	sehingga menjaga keselamatan pasien (<i>patient safety</i>)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya kecepatan petugas IT dalam merespon permintaan perbaikan atau kendala teknis pada perangkat komputer unit kerja
Definisi Operasional	Respon time adalah waktu yang dibutuhkan (dalam menit) mulai dari laporan kerusakan komputer diterima oleh petugas IT hingga petugas memberikan tindakan awal (seperti pengecekan unit, <i>remote desktop</i> , atau tiba di lokasi kejadian).
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah laporan gangguan komputer yang mendapatkan respon awal dalam waktu ≤10 menit dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh laporan gangguan komputer yang masuk ke unit IT dalam bulan tersebut.
Target Pencapaian	100%
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	1. Semua laporan gangguan perangkat keras (CPU, monitor, keyboard) dan perangkat lunak (hang, aplikasi tidak terbuka) pada komputer di seluruh unit rumah sakit 1. Perbaikan yang memerlukan penggantian suku cadang yang harus dipesan terlebih dahulu (<i>indent</i>)
Formula	$\frac{\text{Jumlah laporan dengan respon} \leq 10 \text{ menit}}{\text{Jumlah total laporan gangguan komputer dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif.
Sumber data	Laporan gangguan IT
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Sensus Harian
Sampel	Total Sampling.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	1. Kepala Unit IT

4. Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan komputer dan perlengkapannya sebulan 1x

Judul Indikator	Kepatuhan petugas dalam melakukan pemeliharaan komputer dan perlengkapannya sebulan sekali
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Perlunya keandalan sarana prasarana pendukung pelayanan. 2. PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis:

	Infrastruktur IT (Komputer) harus dalam kondisi prima untuk mendukung Rekam Medis Elektronik (RME). 3. Efisiensi Biaya: Pemeliharaan rutin mencegah kerusakan berat yang memerlukan biaya perbaikan tinggi.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Terjaganya performa dan masa pakai (<i>life cycle</i>) perangkat komputer serta perlengkapannya guna menjamin kelancaran operasional pelayanan di seluruh unit rumah sakit.
Definisi Operasional	Kepatuhan pemeliharaan adalah pelaksanaan pemeriksaan rutin (fisik dan sistem) terhadap unit komputer, monitor, keyboard, mouse, dan printer yang dilakukan oleh petugas IT minimal sebulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah unit komputer dan perlengkapannya yang selesai dilakukan pemeliharaan sesuai jadwal dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh unit komputer dan perlengkapannya yang wajib dipelihara berdasarkan daftar inventaris dalam satu bulan yang sama.
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	1. Semua perangkat komputer (PC / Laptop) dan perlengkapannya (UPS, Printer) yang aktif digunakan di unit pelayanan maupun administrasi.
• Eksklusi	1. Perangkat yang sedang dalam status rusak berat (rusak permanen), sedang dalam proses penghapusan aset, atau perangkat baru yang masih dalam masa garansi vendor
Formula	$\frac{\text{Jumlah perangkat yang dipelihara}}{\text{Jumlah Total komputer dan perlengkapan yang wajib dipelihara}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Retrospektif (Pemeriksaan checklist pemeliharaan)
Sumber data	Checklist Pemeliharaan Komputer Bulanan.
Instrumen Pengambilan Data	Checklist Pemeliharaan Komputer Bulanan.
Sampel	Total Sampling (Seluruh perangkat yang terdaftar di inventaris).
Periode pengumpulan data	Bulanan.
Periode analisis dan pelaporan data	Bulanan dan Triwulanan (3 bulan sekali).
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu
Penanggung Jawab	Kepala Unit IT

3.3.42. Hemodialisa

INDIKATOR MUTU NASIONAL

No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 1 (ISKP 1)
2.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85 %	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 5 (ISKP 5)
3.	Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh	100%	Indikator Mutu Nasional & Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 6 (ISKP 6)
4.	Kepuasan pasien	≥ 76,61%	Indikator Mutu Nasional & Standar Pelayanan Minimal
5.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri	100%	Indikator Mutu Nasional
INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS			
6.	Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat	0 kejadian	Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit bagian Sasaran Keselamatan Pasien 3 (ISKP 3)
INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
7.	Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler	0 kejadian	UNIT
8.	Kejadian Hipotensi Intra Dialisis	0 kejadian	UNIT
9.	Kepatuhan Teknik Steril Perawat HD dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial	≥80%	UNIT
10.	Ketepatan Jadwal Hemodialisa	≥95%	UNIT
11.	Kejadian Clotting Durante HD	0 kejadian	UNIT
12.	Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang sampai proses HD berjalan < 15 menit	≥80%	UNIT

3.3.42.1 Profil Indikator Mutu Hemodialisa

1. Kepatuhan identifikasi pasien

Judul Indikator	Kepatuhan Identifikasi Pasien
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. Ketepatan identifikasi menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan pasien selama proses pelayanan dan mencegah insiden keselamatan pasien. 3. Untuk menjamin ketepatan identifikasi pasien maka diperlukan indikator yang mengukur dan memonitor tingkat kepatuhan pemberi pelayanan dalam melakukan proses identifikasi. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan pemberi pelayanan akan menjadikan identifikasi sebagai

	proses rutin dalam proses pelayanan.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan.
Definisi Operasional	1. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. 2. Identifikasi pasien secara benar adalah proses identifikasi yang dilakukan pemberi pelayanan dengan menggunakan minimal dua penanda identitas seperti: nama lengkap, tanggal lahir, nomor rekam medik, NIK sesuai dengan yang ditetapkan di Rumah Sakit. 3. Identifikasi dilakukan dengan cara visual (melihat) dan atau verbal (lisan). 4. Pemberi pelayanan melakukan identifikasi pasien secara benar pada setiap keadaan terkait tindakan intervensi pasien seperti : • Pemberian pengobatan: pemberian obat, pemberian cairan intravena, pemberian darah dan produk darah, radioterapi, dan nutrisi. • Prosedur tindakan: tindakan operasi atau tindakan invasif lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. • Prosedur diagnostik: pengambilan sampel, pungsi lumbal, endoskopi, kateterisasi jantung, pemeriksaan radiologi, dan lain-lain. • Kondisi tertentu: pasien tidak dapat berkomunikasi (dengan ventilator), pasien bayi, pasien tidak sadar, bayi kembar. 5. Identifikasi pasien dianggap benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase
Numerator (pembilang)	Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan.
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi pasien secara benar dalam periode observasi}}{\text{Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Observasi Kepatuhan Identifikasi Pasien
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

2. Kepatuhan kebersihan tangan

Judul Indikator	Kepatuhan Kebersihan Tangan
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Rumah sakit harus memperhatikan kepatuhan seluruh pemberi pelayanan dalam melakukan cuci tangan sesuai ketentuan WHO
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi layanan kesehatan sebagai dasar untuk memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan agar dapat menjamin keselamatan petugas dan pasien dengan cara mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
Definisi Operasional	1. Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan tampak kotor atau terkena cairan tubuh, atau menggunakan alkohol (<i>alcohol-based handrubs</i>) dengan kandungan alkohol 60- 80% bila tangan tidak tampak kotor. 2. Kebersihan tangan yang dilakukan dengan benar adalah kebersihan tangan sesuai indikasi dan langkah kebersihan tangan sesuai rekomendasi WHO. 3. Indikasi adalah alasan mengapa kebersihan tangan dilakukan pada saat tertentu sebagai upaya untuk menghentikan penularan mikroba selama perawatan 4. Lima indikasi kebersihan tangan: a. Sebelum kontak dengan pasien yaitu sebelum menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien atau pakaian pasien, sebelum menangani obat-obatan dan sebelum menyiapkan makanan pasien.

	b. Sesudah kontak dengan pasien yaitu setelah menyentuh tubuh/permukaan tubuh pasien. c. Sebelum melakukan prosedur aseptik adalah kebersihan tangan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan steril atau aseptik, contoh: pemasangan intra vena kateter (infus), perawatan luka, pemasangan kateter urin, <i>suctioning</i>, pemberian suntikan dan lain- lain. d. Setelah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien seperti muntah, darah, nanah, urin, feces, produksi drain, setelah melepas sarung tangan steril dan setelah melepas APD. e. Setelah bersentuhan dengan lingkungan pasien adalah melakukan kebersihan tangan setelah tangan petugas menyentuh permukaan, sarana prasarana, dan alat kesehatan yang ada di lingkungan pasien, meliputi: menyentuh tempat tidur pasien, linen yang terpasang di tempat tidur, alat-alat di sekitar pasien atau peralatan lain yang digunakan pasien. 5. Peluang adalah periode di antara indikasi di mana tangan terpapar kuman setelah menyentuh permukaan (lingkungan atau pasien) atau tangan menyentuh zat yang terdapat pada permukaan 6. Tindakan kebersihan tangan yang dilakukan adalah kebersihan tangan yang dilakukan sesuai peluang yang diindikasikan. 7. Pemberi pelayanan terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan 8. Penilaian kepatuhan kebersihan tangan adalah penilaian kepatuhan pemberi pelayanan yang melakukan kebersihan tangan dengan benar. 9. Observer adalah orang yang melakukan observasi atau penilaian kepatuhan dengan metode dan <i>tool</i> yang telah ditentukan. 10. Periode observasi adalah kurun waktu yang digunakan untuk mendapatkan minimal 200 peluang kebersihan tangan di unit sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan observasi dalam satu bulan. 11. Sesi adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan observasi maksimal 20 menit (rerata 10 menit). 12. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi adalah jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam satu periode observasi. 13. Jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi pada waktu observasi tidak boleh lebih dari 3 orang agar dapat mencatat semua indikasi kegiatan yang dilakukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan
Denominator (penyebut)	Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥85%
Kriteria:	
• Inklusi	Seluruh peluang yang dimiliki oleh pemberi pelayanan terindikasi harus melakukan kebersihan tangan
• Eksklusi	-

Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan kebersihan tangan yang dilakukan}}{\text{Jumlah total peluang kebersihan tangan yang seharusnya dilakukan dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	formulir monitoring kebersihan tangan (hand hygiene)
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung jawab	Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

3. Kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh

Judul Indikator	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjaga keselamatan pasien. - PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien: Standar Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) ke-6: Pengurangan Risiko Pasien Jatuh. - PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional (IMN) yang wajib dilaporkan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas ☒ - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Mengukur kepatuhan pemberi pelayanan dalam menjalankan upaya pencegahan jatuh agar terselenggara asuhan pelayanan yang aman dan mencapai pemenuhan sasaran keselamatan pasien.
Definisi Operasional	- Upaya pencegahan risiko jatuh meliputi: - Assessment awal risiko jatuh - Assessment ulang risiko jatuh - Intervensi pencegahan risiko jatuh - Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh adalah pelaksanaan ketiga upaya pencegahan jatuh pada pasien rawat inap yang berisiko tinggi jatuh sesuai dengan standar yang ditetapkan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) kepatuhan terhadap upaya pencegahan risiko pasien jatuh yang diterapkan di rumah sakit.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh
Denominator (penyebut)	Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria: Inklusi	Pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi medis yang membuat mereka berisiko untuk jatuh (misalnya, usia

• Eksklusi	lanjut, gangguan keseimbangan, penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi koordinasi atau keseimbangan). 2. Pasien yang telah menjalani penilaian risiko jatuh di awal perawatan. 3. Pasien yang menerima perawatan medis dengan kebijakan rumah sakit yang mengutamakan pencegahan risiko jatuh. 1. Pasien yang tidak dapat dinilai risikonya akibat keterbatasan fisik atau kognitif. 2. Pasien yang berada dalam perawatan jangka pendek, misalnya pasien yang menjalani prosedur operasi minor atau perawatan jangka sangat pendek yang tidak terpapar risiko jatuh. 3. Pasien yang tidak memenuhi kriteria penilaian risiko jatuh (misalnya, mereka yang sudah berada dalam kondisi sangat terkontrol atau stabil).
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan risiko jatuh}}{\text{Jumlah pasien rawat inap berisiko tinggi jatuh yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospektif</i>
Sumber data	Data sekunder menggunakan data dari rekam medis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh
Sampel	Pasien yang dirawat selama periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Bidang Keperawatan dan komite keselamatan pasien

4. Kepuasan pasien

Judul Indikator	Kepuasan Pasien
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan manusiawi. 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan. 3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017: Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan ☒
Tujuan	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar upaya-upaya peningkatan mutu dan terselenggaranya pelayanan di semua unit yang mampu memberikan kepuasan pasien.
Definisi Operasional	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang

	berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan. - Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan. - Survei Kepuasan Pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. - Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variabel penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan. - Unsur survei kepuasan pasien dalam peraturan ini meliputi: - Persyaratan. - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. - Waktu Penyelesaian. - Biaya/Tarif. - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. - Kompetensi Pelaksana. - Perilaku Pelaksana. - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. - Sarana dan prasarana. Indeks Kepuasan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Skala Likert (1-5) atau Prosentase kepuasan.
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang memberikan penilaian kepuasan positif (skor ≥ 3 pada skala Likert).
Denominator (penyebut)	Jumlah total pasien yang disurvei.
Target Pencapaian	$\geq 76.61\%$
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien yang menerima pelayanan medis dalam periode yang ditentukan. - Pasien yang tidak kompeten dalam mengisi kuesioner dan/atau tidak ada keluarga yang mendampingi. - Pasien yang tidak menyelesaikan proses perawatan.
Formula	$\frac{\text{Total nilai persepsi seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	- Survei langsung setelah perawatan medis selesai. - Pengisian kuisisioner berbasis skala Likert.
Sumber data	Hasil Survei
Instrumen Pengambilan Data	Kuesioner (terlampir)
Sampel	Pasien yang mengisi <i>form</i> kepuasan pasien
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Semesteran, Tahunan

Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala bagian humas

5. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Judul Indikator	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Dasar pemikiran	1. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 2. PMK No. 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) 6. Rumah Sakit harus memperhatikan kepatuhan pemberi pelayanan dalam menggunakan APD sesuai dengan prosedur.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Mengukur kepatuhan petugas Rumah Sakit dalam menggunakan APD 2. Menjamin keselamatan petugas dan pengguna layanan dengan cara mengurangi risiko infeksi.
Definisi Operasional	1. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 2. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 3. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan kesehatan pada periode observasi 4. Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau transmisi infeksi atau penyakit. 5. Kepatuhan penggunaan APD adalah kepatuhan petugas dalam menggunakan APD dengan tepat sesuai dengan indikasi ketika melakukan tindakan yang memungkinkan tubuh atau membran mukosa terkena atau terpercik darah atau cairan tubuh atau cairan infeksius lainnya berdasarkan jenis risiko transmisi (kontak, droplet dan airborne). 6. Penilaian kepatuhan penggunaan APD adalah penilaian terhadap petugas dalam menggunakan APD sesuai indikasi dengan tepat saat memberikan pelayanan

	kesehatan pada periode observasi
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua petugas yang terindikasi harus menggunakan APD -
Formula	$\frac{\text{Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai indikasi dalam periode observasi}}{\text{Jumlah seluruh petugas yang terindikasi menggunakan APD dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Hasil observasi
Instrumen Pengambilan Data	Formulir observasi Kepatuhan Penggunaan APD
Sampel	Sampling dihitung dan dipilih sesuai dengan kaidah sampling yang benar
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Komite PPI RS

6. Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat

Judul Indikator	Kejadian Tidak Adanya Label High Alert pada Obat
Dasar Pemikiran	1. Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Manajemen Mutu Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mewajibkan penerapan pengendalian risiko termasuk pada obat <i>high alert</i> . 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 3. KMK No.HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi RS Tahun 2024, Bab Pencegahan dan Pengendalian Risiko (PPR), mewajibkan identifikasi dan penandaan obat <i>high alert</i> .
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☐ 2. Efektivitas ☐ 3. Aksesibilitas ☐ 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☐ 6. Kesiambungan ☐
Tujuan	Memastikan seluruh obat <i>high alert</i> diberi label sesuai standar untuk mencegah kesalahan penggunaan dan meningkatkan keselamatan pasien

Definisi Operasional	- Kejadian tidak adanya label <i>High Alert</i> adalah ditemukannya obat yang masuk dalam daftar <i>High Alert</i> rumah sakit di unit pelayanan atau saat penyerahan, namun tidak ditempel stiker "<i>High Alert</i>" sesuai standar prosedur operasional (SPO). - Obat high alert adalah obat-obatan yang memiliki risiko menyebabkan cedera serius pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat. - Label <i>High Alert</i> adalah penandaan khusus pada obat high alert dengan warna mencolok atau simbol peringatan sesuai kebijakan rumah sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Angka kejadian
Numerator (pembilang)	-
Denominator (penyebut)	Jumlah kejadian kesalahan penempelan label pada obat high alert di gudang farmasi, depo farmasi rawat inap, dan depo farmasi rawat jalan pada periode waktu yang sama
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria: - Inklusi - Eksklusi	Semua jenis obat yang masuk dalam daftar <i>High Alert</i> (Elektrolit konsentrat, LASA/NORUM, Sitostatika, Insulin, Heparin, dll) di instalasi farmasi maupun ruang rawat. Obat-obatan yang bukan termasuk dalam daftar SK Direktur tentang daftar obat <i>High Alert</i>.
Formula	Jumlah Kejadian tidak adanya label high alert pada obat
Metode pengumpulan	<i>Retrospektif</i> dan Observasi Langsung
Sumber Data	- Sistem pelaporan - Hasil audit farmasi dan inspeksi mutu pada unit penyimpanan dan distribusi obat
Instrumen pengambilan	Lembar ceklis observasi (<i>Checklist</i>).
Sampel	Total sampling (seluruh obat <i>High Alert</i> yang diperiksa) atau <i>Random Sampling</i> jika volume sangat besar.
Periode Pengumpulan	Bulanan
Periode Analisis	Triwulanan (3 bulan sekali)
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Instalasi farmasi

7. Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler

Judul Indikator	Kejadian Ketidaktepatan Pemasangan Akses Vaskuler
-----------------	---

Dasar pemikiran	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. KMK No.HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi RS Tahun 2024. Standar akreditasi nasional mencakup bab pencegahan dan pengendalian risiko, menegaskan bahwa semua prosedur berisiko tinggi (misalnya akses vaskuler) harus sesuai standar keselamatan dan terdokumentasi penuh. 3. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Tergambarnya kepatuhan staf medis/perawat dalam melakukan prosedur pemasangan akses vaskuler sesuai SPO untuk mencegah komplikasi klinis.
Definisi Operasional	Ketidaktepatan pemasangan akses vaskuler adalah kondisi di mana pemasangan jalur intravena (perifer/sentral) tidak memenuhi standar, meliputi: 1. Kegagalan kanulasi lebih dari 2 kali percobaan pada pasien yang sama oleh petugas yang sama. 2. Salah lokasi penusukan (misal: area fleksi tanpa fiksasi adekuat). 3. Terjadi hematoma atau infiltrasi segera setelah pemasangan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan pemasangan akses vaskuler yang ditemukan tidak tepat dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Tidak ada (ditetapkan 1 sebagai laporan frekuensi mandiri)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	1. Semua tindakan pemasangan akses vaskuler 2. Kegagalan kanulasi Cimino > 2 kali oleh petugas yang sama. 3. Kesalahan lokasi penusukan pada area infeksi atau aneurisma. 4. Ekstravasasi atau perdarahan hebat akibat teknik penusukan yang tidak tepat. 1. Kondisi pasien darurat/gelisah (<i>uncooperative</i>). 2. Akses Cimino yang memang sudah rusak/thrombosis sebelum tindakan.
Formula	Jumlah kejadian ketidaktepatan pemasangan akses vaskuler
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Laporan Insiden Internal, Logbook Unit HD, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Akses Vaskuler HD
Sampel	<i>Total Sampling</i> (Semua tindakan akses vaskuler di unit HD).

Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Penanggungjawab data unit Kepala Unit Hemodialisa Komite PMKP Kepala Bidang Pelayanan Medik

8. Kejadian Hipotensi Intra Dialisis

Judul Indikator	Kejadian Hipotensi Intra Dialisis
Dasar pemikiran	1. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien 2. Permenkes No. 34 Tahun 2022 tentang Manajemen Mutu Pelayanan 3. KMK No.HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi RS Tahun 2024 4. Hipotensi saat proses HD dapat menyebabkan pusing, mual, kram otot, hingga kehilangan kesadaran. Jika tidak dikelola, hal ini meningkatkan risiko kardiovaskular dan ketidakadekuatan dosis dialisis (Kt/V tidak tercapai)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Menurunkan angka komplikasi hipotensi selama proses dialisis guna memastikan kenyamanan dan keselamatan pasien serta ketercapaian target dialisis.
Definisi Operasional	Hipotensi Intra Dialisis adalah penurunan tekanan darah sistolik ≥ 20 mmHg atau penurunan <i>Mean Arterial Pressure</i> (MAP) ≥ 10 mmHg dari tekanan awal, yang disertai dengan gejala klinis (seperti pusing, mual, muntah, keringat dingin, atau kram otot) dan memerlukan intervensi medis segera (seperti pemberian bolus cairan normal salin, penurunan kecepatan <i>ultrafiltrasi</i> , atau posisi Trendelenburg).
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mengalami hipotensi selama Hemodialisa
Denominator (penyebut)	Tidak ada (ditetapkan 1 sebagai laporan frekuensi mandiri)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	1. Semua pasien gagal ginjal kronik (GGK) yang menjalani sesi hemodialisa rutin maupun cito di unit HD 1. Pasien yang sudah datang dengan kondisi hipotensi sebelum sesi HD dimulai (Tekanan Sistolik < 90 mmHg). 2. Pasien dengan kondisi syok kardiogenik atau sepsis berat sebelum tindakan dialisis.
Formula	Jumlah kejadian hipotensi intra dialisis

Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> dengan observasi langsung
Sumber data	Lembar Monitoring Hemodialisa (Logbook HD) dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Observasi Tanda-Tanda Vital.
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Unit Hemodialisa 2. Kepala bidang pelayanan

9. Kepatuhan Teknik Steril Perawat HD dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial

Judul Indikator	Kepatuhan Teknik Steril Perawat Hemodialisa dalam Pengendalian Infeksi Nosokomial
Dasar pemikiran	1. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien. 2. Pasien Hemodialisa sangat rentan terhadap infeksi nosokomial (<i>Hospital Acquired Infections/HAls</i>) karena prosedur invasif yang berulang. Penggunaan teknik aseptik yang konsisten (seperti <i>hand hygiene</i> dan penggunaan APD steril) terbukti menurunkan angka sepsis dan infeksi lokal pada akses vaskuler.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Memastikan seluruh perawat di Unit HD melaksanakan prosedur penusukan (<i>cannulation</i>) dan penyambungan/pelepasan akses vaskuler sesuai standar steril untuk mencegah infeksi nosokomial
Definisi Operasional	Kepatuhan teknik steril adalah perilaku perawat yang memenuhi seluruh butir instrumen audit saat melakukan tindakan invasif, meliputi: 1. Melakukan <i>Hand Hygiene</i> (6 langkah) sebelum tindakan. 2. Menggunakan APD lengkap (masker, sarung tangan steril/bersih sesuai prosedur). 3. Melakukan desinfeksi area penusukan (Cimino) atau <i>hub</i> kateter (CDL) dengan teknik sirkular/gesek sesuai standar 4. Menjaga sterilitas alat (set dialisis) selama proses penyambungan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan perawat yang diobservasi dan dinyatakan patuh (memenuhi semua kriteria steril) dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Total seluruh tindakan perawat yang diobservasi dalam bulan yang sama
Target Pencapaian	100%
Kriteria : • Inklusi	1. Semua perawat yang melakukan tindakan penyambungan (<i>initiating</i>) dan pengakhiran (<i>terminating</i>) sesi hemodialisa.

• Eksklusi	1. Petugas non-medis atau perawat yang sedang tidak melakukan tindakan invasif langsung ke pasien
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan perawat yang patuh selama diobservasi}}{\text{Total seluruh tindakan perawat yang diobservasi dalam satu bulan}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Observasi Langsung (Audit klinis oleh IPCN atau Kepala Ruangan secara mendadak/sidak).
Sumber data	Lembar Audit Kepatuhan Prosedur (Formulir PPI)
Instrumen Pengambilan Data	Daftar Tilik (<i>Checklist</i>) Kepatuhan Teknik Aseptik/Steril.
Sampel	Menggunakan rumus minimal sampel (misal: 30 observasi per bulan) atau <i>Total Sampling</i> jika jumlah staf sedikit.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Unit Hemodialisa 2. IPCN (<i>Infection Prevention and Control Nurse</i>)

10. Ketepatan Jadwal Hemodialisa

Judul Indikator	Ketepatan Jadwal Pelaksanaan Hemodialisa.
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan efisien 2. Pemenuhan jadwal pelayanan yang tepat waktu merupakan perwujudan dari hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Keterlambatan jadwal dialisis berdampak pada efektivitas terapi (adekuasi dialisis) dan efisiensi sumber daya rumah sakit. Indikator ini disusun untuk mengevaluasi manajemen unit HD dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu (<i>timeliness</i>) sesuai dengan prinsip tata kelola rumah sakit yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>)
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan hemodialisa yang disiplin dan sesuai jadwal guna menjamin kepuasan pasien serta tercapainya adekuasi dialisis yang optimal.
Definisi Operasional	Ketepatan jadwal pelaksanaan adalah dimulainya proses penusukan (<i>cannulation</i>) atau penyambungan akses vaskuler ke mesin HD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam jadwal rutin pasien,
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien yang mendapatkan tindakan tepat waktu dari jadwal yang ditentukan dalam satu bulan.

Denominator (penyebut)	Total seluruh pasien yang datang sesuai jadwal untuk menjalani sesi hemodialisa pada bulan tersebut
Target Pencapaian	≥95%
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	1. Seluruh pasien HD rutin (jadwal tetap) yang menjalani tindakan di Unit Hemodialisa. 1. Pasien yang datang terlambat dari jam jadwal yang ditentukan. 2. Terjadi kondisi kedaruratan medis pada pasien sebelum tindakan dimulai.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien yang dilayani tepat waktu}}{\text{Total seluruh pasien yang datang sesuai jadwal untuk pelayanan hemodialisa}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Retrospective</i> (Audit melalui buku register atau logbook harian)
Sumber data	Daftar Register Tindakan Hemodialisa, Jadwal Pasien
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pemantauan Ketepatan Waktu Pelayanan.
Sampel	<i>Total Sampling</i> (Semua pasien terjadwal dalam 1 bulan).
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit Hemodialisa

11. Kejadian Clotting Durante HD

Judul Indikator	Kejadian Clotting Durante Hemodialisa
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu dan keselamatan pasien. 2. Pemantauan ini penting untuk mengevaluasi ketepatan dosis antikoagulan (heparin) dan teknis pemantauan oleh staf selama tindakan
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien 6. Kesenambungan
Tujuan	Tergambarnya keberhasilan pengelolaan antikoagulan dan pemantauan sirkuit darah untuk mencegah kehilangan darah pasien akibat pembekuan di mesin Hemodialisa.
Definisi Operasional	<i>Clotting Durante</i> Hemodialisa adalah terjadinya pembekuan darah sebagian atau seluruhnya pada <i>dialyzer</i> (ginjal buatan) atau <i>blood tubing set</i> selama proses dialisis berlangsung, yang ditandai dengan perubahan warna darah menjadi gelap, peningkatan tekanan vena/arteri pada mesin, atau tampak bekuan pada <i>bubble trap</i> .
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Jumlah kejadian
Numerator (pembilang)	Jumlah sesi hemodialisa yang mengalami kejadian <i>clotting</i> dalam satu bulan

Denominator (penyebut)	Tidak ada (ditetapkan 1 sebagai laporan frekuensi mandiri)
Target Pencapaian	0 kejadian
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	1. Seluruh sesi hemodialisa baik rutin maupun cito 1. Pasien dengan kontraindikasi heparin (risiko perdarahan berat/operasi baru). 2. Pasien dengan gangguan pembekuan darah bawaan yang sangat berat yang sudah teridentifikasi
Formula	
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan langsung pada lembar observasi/logbook mesin setiap kali terjadi <i>clotting</i>).
Sumber data	Lembar Monitoring Hemodialisa
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Hemodialisa
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit Hemodialisa

12. Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang sampai proses HD berjalan < 15 menit

Judul Indikator	Waktu Pelayanan perawat dari pasien datang sampai proses HD berjalan < 15 menit
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ketepatan waktu memulai tindakan hemodialisis merupakan bagian dari pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang efisien guna mencapai derajat kesehatan yang optimal 2. Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES) - Bab PMKP: Sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), unit kerja wajib memilih dan menetapkan indikator mutu unit. Kecepatan inisiasi HD menunjukkan kesiapan staf keperawatan dan keandalan sarana prasarana mesin, yang berkontribusi pada pencegahan insiden keselamatan pasien
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menilai efisiensi pelayanan awal perawat dalam menyiapkan pasien sehingga terapi hemodialisa dapat dimulai dalam waktu optimal (< 15 menit setelah kedatangan pasien)
Definisi Operasional	1. Waktu pelayanan dihitung sejak pasien mendaftar/melapor ke ruang hemodialisa sampai mesin hemodialisa aktif melakukan dialisis (<i>start</i> hemodialisa). 2. Pelayanan dianggap tepat waktu jika proses ini memakan waktu ≤ 15 menit. 3. Pasien dianggap datang saat dicatat di buku kunjungan

	atau sistem antrean hemodialisa
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah tindakan hemodialisa yang dimulai ≤ 15 menit dari waktu kedatangan pasien
Denominator (penyebut)	Seluruh jumlah pasien hemodialisis rutin yang dilayani dalam periode observasi
Target Pencapaian	≥80%
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua pasien rutin yang datang sesuai jadwal shift-nya Pasien dengan penyulit darurat (sesak berat/instabilitas hemodinamik saat datang).
Formula	$\frac{\text{Jumlah tindakan hemodialisa yang dimulai } \leq 15 \text{ menit dari waktu kedatangan pasien}}{\text{Seluruh jumlah pasien hemodialisis rutin yang dilayani dalam periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	<i>Concurrent</i> (Pencatatan langsung pada lembar observasi/logbook mesin setiap kali terjadi <i>clotting</i>).
Sumber data	Sensus harian
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Monitoring Hemodialisa
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Unit Hemodialisa

3.3.43. BPJS

INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT			
No	Indikator	Standar	Keterangan
1.	Kesesuaian jadwal praktik dokter atau tenaga kesehatan	• Jadwal praktik 100% sesuai = 100 • Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75 • Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50 • Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25 • Jadwal praktik <20% sesuai = 0 • Tidak ada kunjungan = 100	UNIT
2.	Tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan	• Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100 • Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75 • Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun	UNIT

		sebelumnya = 50 • Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0	
3.	Umpan balik peserta (<i>customer feedback</i>)	• Σ responden 100% target = 100 • Σ responden 75 - 99% target = 75 • Σ responden 50 - 74% target = 50 • Σ responden 25 - 49% target = 25 • Σ responden <25% target = 0	UNIT
4.	<i>Update</i> data ketersediaan tempat tidur	• Σ update $\geq$ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100 • Σ update $\geq$ 25 hari = 75 • Σ update 15 - 24 hari = 50 • Σ update 10 - 14 hari = 25 • Σ update < 10 hari = 0	UNIT
5.	Update jadwal tindakan medis operatif	• Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100 • Tidak menginput jadwal TMO = 0	
6.	Pemanfaatan antrean online terintegrasi MJKN dan waktu tunggu rawat jalan	• Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100 • Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75 • Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50 • Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25 • Pemanfaatan MJKN $\leq$ 70% target = 0	UNIT
7.	Penerbitan surat kontrol	• Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100 • Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75 • Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50 • Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25 • Surat Kontrol terbit $\leq$50% sesuai = 0	UNIT
8.	Interoperabilitas rekam medis elektronik	• RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100 • RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75 • RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50	UNIT
9.	% approval SEP	0%	UNIT
10.	Angka capaian iterasi	<i>Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di wilayah masing-masing, lalu dibuat standar bulanan</i>	UNIT
11.	Angka capaian PRB	<i>Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di</i>	UNIT

		<i>wilayah masing-masing, lalu dibuat standar bulanan</i>	
12.	Kepatuhan CP sesuai PPK yang berdampak pada mutu dan biaya	100%	UNIT

3.3.42.1 Profil Indikator Mutu BPJS

1. Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan

Judul Indikator	Kesesuaian jadwal praktik dokter atau tenaga kesehatan
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, transparan, dan efisien. 2. Standar Akreditasi (STARKES - TKRS & PMKP): Manajemen fasyankes wajib memantau kinerja klinis staf medis. 3. Kualitas Pelayanan: Keterlambatan dokter berdampak domino pada peningkatan waktu tunggu pasien di ruang poliklinik, penumpukan antrean, dan menurunkan tingkat kepuasan pasien.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kestinambungan
Tujuan	Terwujudnya pelayanan rawat jalan yang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dipublikasikan kepada masyarakat
Definisi Operasional	Kesesuaian jadwal praktik adalah kondisi dimana dokter (atau nakes) memulai pelayanan di poliklinik sesuai dengan waktu mulainya jam praktik yang telah ditetapkan oleh rumah sakit
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dan Kategorikal
Numerator (pembilang)	Jumlah dokter yang sesuai jadwal
Denominator (penyebut)	Jumlah jadwal dokter pada periode observasi
Target Pencapaian	Jadwal praktik 100% sesuai (100)
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	Semua dokter yang memiliki jadwal praktik reguler di rawat jalan 1. Dokter tidak praktik karena alasan dinas resmi rumah sakit, cuti yang disetujui, atau sakit (dengan pemberitahuan H-1 atau ada dokter pengganti) 2. Dokter terlambat karena ada tindakan operasi cito atau visite pasien kritis di ICU (dibuktikan dengan catatan klinis)
Formula	$\frac{\text{Jumlah dokter yang sesuai jadwal}}{\text{Jumlah jadwal dokter pada periode observasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif

Sumber data	Data Fingerprint
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi kesesuaian jadwal dokter poli
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	1. Kepala Unit Rawat Jalan 2. Bagian SDM Rumah Sakit

2. Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan

Judul Indikator	Tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk mendapatkan transparansi dan penanganan keluhan atas pelayanan. - Peraturan Menteri Kesehatan tentang IMN (Indikator Mutu Nasional): Rumah sakit wajib mengukur persentase pengaduan yang diselesaikan. - Standar Akreditasi (STARKES - HPK & TKRS): Manajemen harus memiliki proses untuk merespon dan menyelesaikan keluhan/konflik pasien secara adil dan tepat waktu.
Dimensi Mutu	- Efisiensi - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Terselenggaranya penanganan pengaduan/komplain yang cepat, adil, dan tuntas guna menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan
Definisi Operasional	Penyelesaian pengaduan adalah proses penanganan komplain (baik lisan maupun tertulis) mulai dari pencatatan, investigasi, tindakan perbaikan, hingga penyampaian jawaban resmi kepada pengadu Kategori Waktu Penyelesaian (Sesuai Regulasi Kemenkes): - Komplain Merah (Gawat/Media): Harus direspon segera, diselesaikan maksimal 1 x 24 jam. - Komplain Kuning (Poli/RWI): Diselesaikan maksimal 3 hari. - Komplain Hijau (Fasilitas/Umum): Diselesaikan maksimal 7 hari. Top 10 Pengaduan - Akses pelayanan - Penundaan pelayanan operasi - Waktu tunggu rawat jalan - Sikap dan ramah tamah - Ketersediaan kamar rawat inap - Penyalahgunaan wewenang - Kualitas pelayananan medis dan safety - Sarana dan prasarana - Kepatuhan visite dokter - Registrasi dan informasi BPJS

Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal
Numerator (pembilang)	Jumlah pengaduan
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pengaduan yang masuk resmi melalui Humas, Customer Service, Kotak Saran, Media Sosial Resmi, Kessan, SIPP, maupun SMS/WhatsApp Pengaduan anonim (tanpa identitas/kontak yang jelas) yang setelah diinvestigasi tidak membutuhkan umpan balik langsung karena tidak dapat dihubungi
Formula	Jumlah pengaduan
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Logbook pengaduan, Kessan, SIPP, SMS/WhatsApp
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	MOD Komite PMKP

3. Umpan Balik Peserta (*Customer Feedback*)

Judul Indikator	Umpan balik peserta (<i>customer feedback</i>)
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak pasien untuk memberikan masukan demi perbaikan mutu pelayanan. 2. Standar Akreditasi (STARKES - HPK 2.1 & 2.2): Rumah sakit wajib memiliki proses untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti umpan balik dari pasien serta melibatkan keluarga dalam proses asuhan. 3. Peningkatan Mutu Berkelanjutan: Umpan balik (baik positif maupun negatif) adalah cermin nyata kualitas pelayanan di lapangan dari sudut pandang pengguna.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan ☒ 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	Tergambarnya komitmen rumah sakit dalam mendengarkan suara pasien/keluarga serta melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diterima

Definisi Operasional	Umpun balik peserta merupakan pengukuran yang dinilai berdasarkan jumlah responden yang memberikan umpun balik/customer feedback, baik masukan, saran, kritik, maupun apresiasi. Target rumah sakit adalah 370 feedback setiap bulan pada website Kessan BPJS.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Prosentase (%) dan Kategorikal
Numerator (pembilang)	Jumlah responden yang memberikan umpun balik dalam satu bulan
Denominator (penyebut)	Target rumah sakit (370 feedback)
Target Pencapaian	Jumlah responden 100% sesuai target (100)
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua masukan/umpun balik dari pasien rawat jalan, rawat inap, IGD, atau penunjang yang tercatat di website Kessan BPJS. Umpun balik yang sifatnya tidak logis, berbau SARA, atau serangan personal tanpa dasar pelayanan klinis yang jelas.
Formula	$\frac{\text{Jumlah responden yang memberikan umpun balik dalam satu bulan}}{\text{Target rumah sakit (370 feedback)}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Website Kessan
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi umpun balik peserta
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	MOD Komite PMKP

4. Update Data Ketersediaan Tempat Tidur

Judul Indikator	Update data ketersediaan tempat tidur
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Hak masyarakat atas informasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Kebijakan Kemenkes (Siranap): Rumah sakit wajib mengintegrasikan dan memperbarui data <i>bed</i> secara <i>real-time</i> untuk sistem rujukan nasional. 3. Standar Akreditasi (STARKES - ARK): Rumah sakit harus mengatur alur pasien (<i>patient flow</i>) termasuk ketersediaan tempat tidur untuk mengurangi penumpukan di IGD. 4. Efisiensi & Keselamatan Pasien: Mempercepat proses transfer pasien dari IGD ke ruang rawat inap guna menghindari penundaan terapi.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kestinambungan
Tujuan	Terwujudnya sistem koordinasi dan informasi jadwal operasi yang akurat, dinamis, dan tepat waktu guna mengoptimalkan utilitas kamar bedah
Definisi Operasional	Update Data Tempat Tidur adalah proses memperbarui status tempat tidur di SIMRS (dari terisi menjadi kosong/siap pakai, atau sebaliknya) segera setelah ada perubahan fisik di ruangan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal
Numerator (pembilang)	Jumlah hari dilakukan update dan ada atau tidaknya pengaduan tempat tidur
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100
Kriteria : • Inklusi • Eksklusi	Semua tempat tidur rawat inap reguler, isolasi, maupun intensif (ICU/NICU/PICU/ICCU) di rumah sakit Tempat tidur yang dinonaktifkan sementara karena kerusakan fasilitas (misal: bed rusak, renovasi ruangan, atau sterilisasi ruangan pasca-infeksi berat).
Formula	Jumlah hari dilakukan update dan ada atau tidaknya pengaduan tempat tidur
Metode Pengumpulan Data	Concurrent
Sumber data	Mobile JKN
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi update ketersediaan tempat tidur
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	MOD Komite PMKP

5. Update Jadwal Tindakan Medis Operatif

Judul Indikator	Update jadwal tindakan medis operatif
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Menuntut efisiensi alokasi sumber daya fasyankes dan transparansi pelayanan kepada pasien. 2. Standar Akreditasi RS (Bab PAB & TKRS): Pengelolaan jadwal operasi yang buruk berdampak pada tingkannya angka pembatalan operasi elektif (<i>cancelled surgery</i>) dan memperpanjang Lama Perawatan (ALOS) pasien. 3. Kesekretariatan/Bagian Penjadwalan berperan vital memperbarui slot operasi secara <i>real-time</i> agar tim

	anestesi, perawat instrumen, dan ruangan siap, serta dokter bedah tidak mengalami bentrok jadwal.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan jadwal operasi selalu dalam kondisi mutakhir (<i>up-to-date</i>) dan transparan. 2. Meminimalkan waktu tunggu pasien pra-operasi di ruang rawat inap. 3. Optimalisasi utilitas dan efisiensi penggunaan Kamar Operasi (IBS/IKO).
Definisi Operasional	Update jadwal tindakan operatif adalah tindakan memperbarui status, jam, urutan, atau pembatalan rencana operasi pada MJKN.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome Proses & outcome ☒
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal
Numerator (pembilang)	Jadwal tindakan medis operatif rutin diperbarui pada MJKN
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100
Kriteria :	
• Inklusi	Semua permintaan penjadwalan, pembatalan, <i>reschedule</i> (perubahan waktu/hari) operasi elektif dari seluruh Kelompok Staf Medis (KSM) Bedah
• Eksklusi	Operasi darurat (<i>Cito</i> / Emergensi) yang alurnya langsung memotong antrean sistem via IGD/PONEK
Formula	Jadwal tindakan medis operatif rutin diperbarui pada MJKN
Metode Pengumpulan Data	Concurrent
Sumber data	Mobile JKN
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi update jadwal tindakan medis operatif
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	MOD IKO Komite PMKP

6. Pemanfaatan Antrean Online Terintegrasi MJKN dan Waktu Tunggu Rawat Jalan

Judul Indikator	Pemanfaatan antrean online terintegrasi MJKN dan waktu tunggu rawat jalan			
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamankan fasyankes untuk mengintegrasikan teknologi digital guna memotong birokrasi dan mempercepat waktu pelayanan bagi pasien. 2. Janji Layanan JKN: Mengharuskan fasyankes memangkas waktu tunggu di poliklinik dengan mengoptimalkan sistem <i>bridging</i> aplikasi Mobile JKN (MJKN). 3. Pemanfaatan teknologi MJKN tidak akan berdampak maksimal jika dokter di poliklinik tidak datang tepat waktu, sehingga kedua aspek ini (sistem pendaftaran digital + waktu tunggu klinis) harus diukur dalam satu kesatuan garis waktu (<i>timeline</i>).			
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas ☒ 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan			
Tujuan	1. Memastikan pasien memanfaatkan pendaftaran berbasis digital untuk mengurangi penumpukan di loket. 2. Menjamin pasien yang sudah mendaftar via MJKN mendapatkan kepastian pelayanan di bawah 60 menit sejak mereka tiba di RS.			
Definisi Operasional	Pemanfaatan adalah jumlah kunjungan yang menggunakan sistem antrian terintegrasi MJKN dibagi total kunjungan dan waktu yang melalui sistem antrian yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada area pendaftaran peserta saat peserta kontak dengan pendaftaran sampai dengan mendapat pelayanan.			
Jenis Indikator	Struktur outcome ☒	Proses	Outcome	Proses &
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal			
Numerator (pembilang)	Jumlah kunjungan yang terintegrasi dengan MJKN			
Denominator (penyebut)	Total kunjungan			
Target Pencapaian	100 Target pemanfaatan antrean online = 60% Target waktu tunggu rawat jalan > 80%			
Kriteria :	• Inklusi Seluruh pasien JKN (BPJS) yang melakukan pendaftaran rawat jalan reguler / elektif 1. Pasien non-BPJS (Umum/Asuransi Swasta). 2. Pasien BPJS yang terlambat datang >15 menit dari estimasi jam pelayanan yang tertera pada aplikasi MJKN. 3. Dokter spesialis mendadak dipanggil untuk penanganan kasus darurat medis (<i>Cito</i> / Resusitasi) di IGD atau Kamar Operasi pada jam pelayanan tersebut.			
	• Eksklusi			
Formula	$\frac{\text{Jumlah kunjungan yang terintegrasi dengan MJKN}}{\text{Total kunjungan}} \times 100\%$			

Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Laporan Elektronik Integrasi Antrean JKN
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi pemanfaatan antrean online terintegrasi MJKN
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Pendaftaran IRJA

7. Penerbitan Surat Kontrol

Judul Indikator	Penerbitan surat kontrol
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan integrasi sistem informasi kesehatan dan kemudahan akses pelayanan berkelanjutan bagi pasien. - Regulasi BPJS Kesehatan: Pasien kronis atau pasca-tindakan yang memerlukan evaluasi ulang wajib memiliki Surat Rencana Kendali Pelayanan (Surat Kontrol) yang diterbitkan secara elektronik (<i>bridging</i> Vclaim/Sinka) agar kuota pendaftaran terjaga dan klaim rumah sakit aman. - Ketidakpatuhan atau keterlambatan penerbitan surat kontrol mengakibatkan pasien harus kembali meminta rujukan baru ke FKTA (Puskesmas/Klinik Pratama), yang memicu keluhan pasien dan penumpukan alur administrasi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan ☒
Tujuan	- Memastikan setiap pasien yang secara klinis memerlukan kontrol ulang mendapatkan Surat Kontrol sebelum meninggalkan rumah sakit. - Mencegah terjadinya penolakan klaim BPJS akibat ketiadaan atau kedaluwarsanya Surat Kontrol. - Mempermudah pasien dalam melakukan pemesanan nomor antrean online (MJKN) untuk kunjungan berikutnya.
Definisi Operasional	Kepatuhan penerbitan surat kontrol jika jumlah SEP yang sesuai dibanding jumlah seluruh SEP. Jumlah SEP yang sesuai sama dengan tanggal terbit SEP lebih besar dari tanggal terbit surat kontrol yakni surat kontrol lebih dulu terbit dari SEP.
Jenis Indikator	Struktur ☒ Proses ☒ Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal
Numerator (pembilang)	Jumlah SEP yang sesuai
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh SEP

Target Pencapaian	>90% (100)
Kriteria : - Inklusi - Eksklusi	Seluruh pasien JKN (BPJS) rawat jalan yang mendapatkan instruksi kontrol ulang dari DPJP (baik pasien pasca-rawat inap maupun evaluasi rutin poliklinik). - Pasien yang secara klinis dinyatakan sudah sembuh/stabil dan dikembalikan ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). - Pasien Non-BPJS (Umum/Asuransi Swasta) yang alur kontrolnya tidak memerlukan regulasi surat kontrol elektronik BPJS.
Formula	$\frac{\text{Jumlah SEP yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh SEP}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Modul E-RM (Electronic Medical Record) bagian rencana tindak lanjut, Log data ekspor Surat Kontrol SIMRS, dan Aplikasi Vclaim BPJS.
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi penerbitan surat kontrol
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Pendaftaran IRJA

8. Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik

Judul Indikator	Interoperabilitas rekam medis elektronik
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan integrasi sistem informasi kesehatan nasional dan kewajiban setiap fasyankes untuk menyelenggarakan RME yang terhubung dengan jejaring nasional. - PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis: Mewajibkan seluruh fasyankes melakukan integrasi sistem RME lokal dengan platform SatuSehat Kementerian Kesehatan RI. - Data klinis yang tidak interoperabel menyebabkan fragmentasi informasi, duplikasi pemeriksaan penunjang (lab/radiologi) yang tidak perlu, serta menghambat penanganan darurat jika pasien berpindah fasyankes.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan ☒ - Fokus kepada pasien ☒ - Kesinambungan
Tujuan	Menjamin seluruh data kunjungan dan resume medis pasien terkirim secara <i>real-time</i> dan akurat ke sistem kesehatan nasional.

	2. Memudahkan akses bagi tenaga medis di fasyankes lain untuk melihat riwayat klinis esensial pasien demi keselamatan asuhan. 3. Memenuhi standar kepatuhan regulasi digitalisasi kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Definisi Operasional	Kepatuhan Interoperabilitas RME adalah tingkat keberhasilan pengiriman (<i>bridging/inkorporasi</i>) variabel data klinis dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) lokal ke sistem informasi BPJS kesehatan
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Nilai kategorikal
Numerator (pembilang)	Tingkat integrasi RME
Denominator (penyebut)	-
Target Pencapaian	100
Kriteria :	
• Inklusi	Seluruh data kunjungan pasien resmi di rumah sakit, baik pasien dengan penjaminan (BPJS/Asuransi Swasta) maupun pasien Umum
• Eksklusi	Transaksi kunjungan yang batal (pasien mendaftar lalu pulang sebelum dilayani/tidak jadi berobat).
Formula	Tingkat integrasi RME
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	SIMRS
Instrumen Pengambilan Data	Lembar observasi interoperabilitas RME
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	IT Kepala Bidang Pelayanan

9. % Approval SEP

Judul Indikator	% Approval SEP
Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamankan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola pembiayaan kesehatan. 2. Keamanan Finansial RS: SEP yang ditolak atau tidak disetujui (<i>unapproved</i>) oleh sistem BPJS menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak dapat diklaimkan (menjadi kerugian/piutang macet rumah sakit). 3. Target 0% ditetapkan untuk memastikan validasi administrasi di loket depan (<i>frontliner</i>) berjalan sempurna tanpa toleransi kesalahan yang merugikan fasyankes.

Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien 6. Kesiambungan
Tujuan	Menjamin seluruh pasien BPJS yang dilayani di rumah sakit memiliki keabsahan penjaminan yang 100% disetujui, sehingga tidak ada berkas klaim yang kedaluwarsa atau ditolak di kemudian hari.
Definisi Operasional	Kegagalan/Penolakan SEP adalah kondisi di mana pengajuan penerbitan SEP untuk pasien BPJS (Rawat Jalan, Rawat Inap, maupun IGD) mengalami penolakan tetap atau tidak mendapatkan persetujuan (<i>unapproved</i>) dari sistem Vclaim BPJS Kesehatan hingga batas waktu penutupan klaim bulan berjalan, baik disebabkan oleh masalah status kepesertaan, kesalahan input petugas, maupun kedaluwarsa rujukan.
Jenis Indikator	Struktur Proses Outcome ☒ Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pengajuan SEP yang ditolak tetap / tidak mendapatkan approval dari BPJS Kesehatan dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Total seluruh permintaan/pengajuan penerbitan SEP yang diproses pada bulan yang sama
Target Pencapaian	0%
Kriteria :	- Inklusi - Eksklusi
Formula	$\frac{\text{Jumlah pengajuan SEP yang ditolak}}{\text{Jumlah seluruh permintaan/pengajuan penerbitan SEP}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Laporan Defisit/Reject Vclaim BPJS, Log Transaksi <i>Bridging</i> SIMRS, dan Data Rekonsiliasi Tim Casemix
Instrumen Pengambilan Data	Dasbor Elektronik Penolakan SEP
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	TPP

10. Angka Capaian Iterasi

Judul Indikator	Angka capaian iterasi
-----------------	-----------------------

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan integrasi kemudahan akses obat bagi masyarakat. 2. Regulasi Kepatuhan Faskes BPJS Kesehatan: Rumah sakit diwajibkan menyelenggarakan program iterasi obat untuk mengoptimalkan kendali mutu dan kendali biaya JKN. 3. Pelayanan berulang (<i>iterasi</i>) pada resep obat kronis (misal: penyakit jantung, diabetes, hipertensi yang stabil) dapat memangkas waktu tunggu rawat jalan, mengurangi beban kerja dokter spesialis di poliklinik, dan meningkatkan kepuasan peserta.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesiambungan
Tujuan	1. Memastikan pasien kronis stabil mendapatkan pelayanan obat berkelanjutan secara cepat tanpa antre dokter. 2. Mengurangi penumpukan fisik (<i>fragmentasi pelayanan</i>) di area poliklinik rawat jalan. 3. Memenuhi target indikator komitmen kepatuhan rumah sakit yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Definisi Operasional	Iterasi Obat adalah proses perulangan pengambilan obat kronis di FKRTL/Aptek jaringan BPJS menggunakan salinan resep atau modul elektronik resep sebelumnya (maksimal dilakukan 2 kali perulangan, yaitu bulan ke-2 dan bulan ke-3), sehingga pada bulan berjalan pasien langsung menuju Instalasi Farmasi RS / Aptek tanpa perlu mengantre untuk bertatap muka dengan Dokter Spesialis. Capaian Iterasi adalah tingkat keberhasilan rumah sakit dalam merealisasikan potensi pasien yang layak masuk alur iterasi dan menagihkannya secara sukses melalui aplikasi <i>Aptek Online</i> BPJS pada bulan berjalan.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah lembar resep obat kronis peserta JKN yang sukses dilayani dan ditagihkan melalui mekanisme Iterasi Obat (tanpa tatap muka DPJP) di Aplikasi Aptek Online dalam satu bulan.
Denominator (penyebut)	Jumlah target/potensi peserta iterasi obat kronis yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan untuk rumah sakit tersebut pada bulan yang sama.
Target Pencapaian	<i>Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di wilayah masing-masing, lalu di buat standar bulanan</i>
Kriteria :	• Inklusi • Eksklusi
	Pasien JKN dengan diagnosis penyakit kronis (sesuai regulasi PRB/Non-PRB) yang secara klinis dinyatakan stabil oleh DPJP Bedah/Medik dan mendapatkan resep dengan tanda iterasi. Pasien kronis yang mengalami eksaserbasi akut (kondisinya memburuk) sehingga memerlukan penyesuaian dosis obat atau perubahan terapi langsung oleh dokter spesialis.

Formula	$\frac{\text{Jumlah realisasi resep iterasi yang sukses ditagihkan}}{\text{Jumlah seluruh target resep iterasi dari BPJS}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif
Sumber data	Aplikasi Apotek Online BPJS Kesehatan, Modul Farmasi/SIMRS Rumah Sakit, dan Dashboard Monitoring Klaim JKN.
Instrumen Pengambilan Data	Laporan Bulanan Realisasi Iterasi Obat (Data tarikan txt/excel dari BPJS)
Sampel	<i>Total Sampling</i>
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Farmasi Komite PMKP

11. Angka Capaian PRB

Judul Indikator	Angka capaian PRB
Dasar pemikiran	- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan penguatan pelayanan kesehatan primer (FKTP) dan optimalisasi sistem rujukan berjenjang. - Permenkes tentang Sistem Rujukan: Rumah sakit (FKRTL) berfungsi menangani fase akut dan <i>sub-akut</i>. Jika kondisi pasien kronis sudah stabil, asuhan wajib dikembalikan ke FKTP guna efisiensi pembiayaan kesehatan. - Menumpuknya pasien kronis stabil di poliklinik spesialis menyebabkan antrean panjang dan menurunkan mutu pelayanan untuk pasien baru atau pasien dengan tingkat keparahan tinggi.
Dimensi Mutu	- Efisiensi ☒ - Efektivitas - Aksesibilitas - Keselamatan - Fokus kepada pasien - Kesinambungan ☒
Tujuan	- Mengoptimalkan peran FKTP dalam mengelola pasien kronis di komunitas. - Mengurangi beban kerja dan kepadatan antrean rawat jalan di rumah sakit. - Memenuhi komitmen kepatuhan fasyankes sesuai standar kontrak BPJS Kesehatan.
Definisi Operasional	Capaian PRB adalah tingkat keberhasilan rumah sakit dalam mendaftarkan dan menyerahkan kembali pasien peserta JKN dengan 9 penyakit kronis yang secara klinis sudah dinyatakan stabil oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) ke program Rujuk Balik BPJS. Pasien dinyatakan Sukses PRB jika petugas rumah sakit telah menginput data kelayakan pasien ke aplikasi <i>Vclaim/P-Care</i>, menerbitkan Surat Rujuk Balik (SRB), dan membekali pasien dengan buku/konten edukasi PRB untuk dibawa ke FKTP asal.

Jenis Indikator	Struktur outcome ☒	Proses	Outcome	Proses &
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)			
Numerator (pembilang)	Jumlah pasien JKN dengan penyakit kronis stabil yang berhasil diregistrasikan ke dalam sistem PRB dan diterbitkan Surat Rujuk Balik-nya (SRB) dalam satu bulan.			
Denominator (penyebut)	Total target/potensi jumlah pasien penyakit kronis yang dinyatakan layak PRB berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan pada bulan yang sama.			
Target Pencapaian	<i>Mengacu pada angka target tahunan BPJS periode 2025 di wilayah masing-masing, lalu di buat standar bulanan</i>			
Kriteria :				
• Inklusi	Pasien JKN dengan diagnosis 9 penyakit kronis yang stabil (Diabetes Melitus, Hipertensi, Jantung, Asma, PPOK, Epilepsi, Skizofrenia, Stroke, dan Lupus).			
• Eksklusi	Pasien penyakit kronis yang masih dalam kondisi tidak stabil, mengalami komplikasi akut, atau memerlukan pemantauan ketat/tindakan medis spesialis berkala di faskes sekunder.			
Formula	$\frac{\text{Jumlah pasien penyakit kronis yang sukses terdaftar PRB (Terbit PRB)}}{\text{Total target potensi pasien PRB dari BPJS (Target = 127)}} \times 100\%$			
Metode Pengumpulan Data	Restrospektif			
Sumber data	Aplikasi Vclaim/Apotek Online BPJS Kesehatan (Dasbor Monitoring Kepatuhan Faskes), Modul E-RM SIMRS, dan data internal Tim Casemix.			
Instrumen Pengambilan Data	Laporan Bulanan Capaian Program Rujuk Balik (Data tarikan Excel BPJS).			
Sampel	<i>Total Sampling</i>			
Periode pengumpulan data	Bulanan			
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan			
Penyajian data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.			
Penanggung Jawab	Farmasi			

12. Kepatuhan CP Sesuai PPK yang Berdampak pada Mutu dan Biaya

Judul Indikator	Kepatuhan CP Sesuai PPK yang Berdampak pada Mutu dan Biaya
-----------------	--

Dasar pemikiran	1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Mengamanatkan pemberian pelayanan kesehatan yang standar dan bermutu (Pasal 172) 2. PMK No. 30 Tahun 2022: Tentang Indikator Mutu Nasional Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya. 3. KMK No. HK.01.07/MENKES/1128/2022: Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (Staf Medis wajib patuh pada Panduan Praktik Klinis/PPK dan <i>Clinical Pathway</i>). 4. Kepatuhan terhadap alur klinis/clinical pathway adalah kepatuhan seluruh Profesional Pemberi Asuhan terhadap alur klinis/clinical pathway yang telah ditetapkan. 5. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> sesuai dengan prioritas nasional adalah: a. Hipertensi b. Diabetes melitus c. TB d. HIV e. Keganasan 6. Pemilihan penyakit yang akan dilakukan pengukuran kepatuhan terhadap alur klinis/<i>clinical pathway</i> untuk RS khusus disesuaikan dengan program prioritas nasional yang ada dan pelayanan prioritas di rumah sakit tersebut.
Dimensi Mutu	1. Efisiensi ☒ 2. Efektivitas ☒ 3. Aksesibilitas 4. Keselamatan 5. Fokus kepada pasien ☒ 6. Kesenambungan ☒
Tujuan	Untuk menjamin kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di rumah sakit terhadap standar pelayanan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis di rumah sakit
Definisi Operasional	<i>Clinical Pathway</i> adalah suatu perencanaan pelayanan terpadu/terintegrasi yang merangkum setiap langkah yang diberikan pada pasien, berdasarkan standar pelayanan medis, standar pelayanan keperawatan dan standar pelayanan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) lainnya yang berbasis bukti dengan hasil terukur, pada jangka waktu tertentu selama pasien dirawat di Rumah Sakit. Kepatuhan terhadap clinical pathway adalah proses pelayanan secara terintegrasi yang diberikan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) kepada pasien yang sesuai dengan clinical pathway yang ditetapkan Rumah Sakit.
Jenis Indikator	Struktur Proses ☒ Outcome Proses & outcome
Satuan Pengukuran	Prosentase (%)
Numerator (pembilang)	Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway
Denominator (penyebut)	Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi
Target Pencapaian	100%
Kriteria:	
• Inklusi	Pasien yang menderita penyakit sesuai batasan ruang lingkup <i>clinical pathway</i> yang diukur
• Eksklusi	1. Pasien yang pulang atas permintaan sendiri selama perawatan. 2. Pasien yang meninggal 3. Variasi yang terjadi sesuai dengan indikasi klinis pasien

	dalam perkembangan pelayanan.
Formula	$\frac{\text{Jumlah pelayanan oleh PPA yang sesuai dengan clinical pathway}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan oleh PPA pada clinical pathway yang diobservasi}} \times 100\%$
Metode Pengumpulan Data	1. Form CP (Form Clinical Pathway) 2. Audit Rekam Medis Pasien 3. Pemantauan SIM RS
Sumber data	Data sekunder dari rekam medis pasien dan ERM
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Kepatuhan Clinical Pathway
Sampel	Pasien yang dirawat dan diperiksa dalam periode pengumpulan data yang memenuhi kriteria inklusi.
Periode pengumpulan data	Bulanan
Periode analisis dan pelaporan data	Triwulan
Penyajian Data	Diagram garis digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu.
Penanggung Jawab	Kepala Bidang pelayanan medik, komite medik, komite keperawatan dan komite tenaga kesehatan lainnya